



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA DE DOUTORADO

Linha de Pesquisa: Educação, Culturas e Humanidades

Gabriela de Abreu Oliveira

**A Necropedagogia e seus pilares constituidores: uma
análise do gerenciamento letal da Pandemia no
Governo de Jair Bolsonaro (2020 a 2021)**

Porto Alegre
Março de 2026

Gabriela de Abreu oliveira

**A Necropedagogia e seus pilares constituidores:
uma análise do gerenciamento letal da Pandemia no
Governo de Jair Bolsonaro (2020 a 2021)**

Tese de doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação
da Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, como
requisito para a obtenção do Título de
Doutor em Educação.

Orientador: Prof. Dr. Jaime José Zitkoski

Porto Alegre
Março de 2026

BANCA EXAMINADORA:

Prof^a. Dr^a. Carla Beatriz Meinerz

Prof^a. Dr^a. Maria Elly Herz Genro

Prof. Dr. Aragon Érico Dasso Júnior

Prof. Dr. Renato Levin-Borges

Prof. Dr. Jaime José Zitkoski /PPGEDU-UFRGS (Orientador)

CIP - Catalogação na Publicação

de Abreu Oliveira, Gabriela

A necropedagogia e seus pilares constituidores: uma análise do gerenciamento letal da Pandemia no governo de Jair Bolsonaro (2020 a 2021) / Gabriela de Abreu Oliveira. -- 2026.

276 f.

Orientadora: Jaime José Zitkoski.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Necropedagogia. 2. Pandemia de COVID-19. 3. Bolsonarismo. 4. Necropolítica. 5. Pedagogia da Submissão.. I. Zitkoski, Jaime José, orient. II. Título.

Sumário

1. Apresentação da temática	18
2. Ultraliberalismo: o modelo reconfigurado	24
2.1. A racionalidade ultraliberal posta como teoria	28
2.1.1. Teorias gerenciais: a racionalidade da Administração Pública brasileira	32
2.2. A antidemocracia no regime de Estado Ultraliberal	50
2.2.1. Milícia como uma faceta da crise democrática: a constituição da subjetividade da morte	56
2.3. O sujeito idiosubjetivado: o indivíduo necessário	60
3. A Necropolítica na pandemia: a disputa entre biossistemas e o projeto da morte	68
3.1. O SUS como Prática Pedagógica Antagônica	69
3.1.2. O SUS: um projeto de (re)construção de existências	74
3.2. A Necropedagogia: um projeto de morte	97
3.2.1. Necropolítica, Estado ultraliberal e o fascismo no Brasil: a construção de uma Necropedagogia	105
3.2.2. A Operacionalização da Necropedagogia: desvendando seus três eixos estruturantes	108
4. Trajetória política e gestão pandêmica: uma análise descritiva do período bolsonarista	114
4.1. A Trajetória de Jair Bolsonaro (1988 a 2018)	116
4.2. Pandemia de COVID-19 no Brasil e a descrição cronológica dos fatos (2020 a 2021)	121
4.2.1. De Wuhan para o Brasil: o primeiro semestre de 2020 da Pandemia	124
4.2.2. O esperar através das vacinas: o segundo semestre de 2020.	137
4.2.3. Crise epidemiológica e tensões institucionais: o cenário brasileiro no primeiro semestre de 2021	143
4.2.4. Proteção populacional pelas vacinas e fenômenos de recusa: segundo semestre de 2021	149
5. Análise da Necropedagogia em Ação: a Pandemia de COVID-19 sob a lente dos Três Pilares	154
5.1. O preço do negacionismo: como o desprezo às pesquisas nacionais alçou o Brasil à condição de epicentro da COVID-19	155
5.2. Análise do Pilar 1: O Estado Ultraliberal na Pandemia	161
5.3. Análise do Pilar 2: A Necropolítica na Pandemia	190
5.3.1. Análise dos fatos ocorridos durante a Pandemia sob o viés da necropolítica	194
5.4. Análise do Pilar 3: A Pedagogia da Submissão na Pandemia	207
5.4.1 Análise dos fatos ocorridos durante a Pandemia sob o viés da Pedagogia da submissão	212

5.5 – Os três pilares como fundamento da necropedagogia.....	222
6. Considerações finais	224
Referencial Bibliográfico.....	229

Lista de figuras

Figura 1 - A música que a necropedagogia não calou: Dead Fish.....	21
Figura 2 - É indiferente a escolha entre um regime democrático a um não democrático - dados de 2023	52
Figura 3 - Apoio a um governo militar na América Latina dados de 2023 .	53
Figura 4 - Em 16 anos, milícias viram maior grupo criminoso do Rio (Crescimento de 387%)	58
Figura 5 - Conceitos constituidores da necropedagogia utilizada na condução da pandemia brasileira	109
Figura 6 - Diagrama temporal do primeiro semestre de 2020 da Pandemia de COVID-19.....	123
Figura 7 - Diagrama temporal do segundo semestre de 2020 da Pandemia de COVID-19.....	136
Figura 8 -Diagrama temporal do primeiro semestre de 2021 da Pandemia de COVID-19.....	142
Figura 9 - Diagrama temporal do segundo semestre de 2021 da Pandemia de COVID-19.....	148
Figura 10 - Posição do Brasil no ranking dos países com maior número de mortes por COVID- 19 em dezembro de 2021	158
Figura 11 - Posição da China no ranking dos países com maior número de mortes por COVID- 19 em dezembro de 2021	158
Figura 12 - Comparação Brasil e China nos casos de novas morte por dia de COVID-19 período até dezembro de 2021	159
Figura 13 - A origem do vírus no Brasil de acordo com os resultados das pesquisas da Fiocruz	160
Figura 14 - É indiferente a escolha entre um regime democrático a um não democrático: dados de 2024	164
Figura 15 - Satisfação com a democracia de 1995 a 2024.....	165
Figura 16 - Cronologia dos ministros da saúde (2019 a 2022).....	181
Figura 17 - Aquisição de Hidroxicloquina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020	185
Figura 18 - Aquisição de Azitromicina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020.....	185
Figura 19 - Aquisição de Ivermectina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020	186
Figura 20 - Postagem do ex-presidente Bolsonaro no Twitter sobre o tratamento da Prevent Senior em 2020	187
Figura 21 - Postagem de Eduardo Bolsonaro no Twitter sobre o tratamento precoce 2020	187
Figura 22 - Cemitério de Nossa senhora Aparecida em Manaus.....	195

Figura 23 - Bolsonaro e a frase “não sou coveiro” proferida em 20 de abril de 2020	198
Figura 24 - Caminhão do osso e a luta de famílias brasileiras contra a fome.....	200
Figura 25 - Ato pró-bolsonaro, sem o uso de máscaras, promoveu discurso anticonstitucional em 31 de maio de 2020.....	217

Lista de tabelas

Tabela 1 - Apoiadores do PDRAE	39
Tabela 2 - Alguns dos apoiadores da ANGP	42
Tabela 3 - Comparativo de propostas de reformas administrativas	49

“A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

Paulo Freire.

*Sim, foi GOLPE!
Orquestrado
Por sorrisos velhos e apertos de mão
Rumo ao passado*

*A esperança das ruas de 2013
Catalisou aquele grande acordo nacional
Com o supremo
E com tudo
Pra estancar uma sangria*

*Em nome da família
E de um torturador*

*Motivo de vergonha
Indignação!
Os gritos que ecoam das janelas
O lado certo da história
Não tem sangue nas mãos*

*Uma jovem
Democracia
Acorrentada nos porões
Pra que velhos ratos
Possam voltar a reinar*

*Comprando a justiça
Não há corrupção
Entre brancos e ricos
Pois ninguém é julgado
E a vida segue*

*Motivo de vergonha
Indignação!
A cumplicidade das panelas
O lado certo da história
Não tem sangue nas mãos*

*Em cada casa, um ponto cego, um cidadão se levantou
Abriu a porta do armário e o preconceito se espalhou
Quando o passado volta à moda em nome de um torturador
O sonho médio é vestir a carapuça do opressor*

*E achar que tem poder
Buscando um inimigo
Fomenta a paranoia e o faz pra confundir
Buscando um inimigo*

*Aponta a arma pra si
E é assim que começa*

*Motivo de vergonha
Indignação!
Os gritos que ecoam das janelas
O lado certo da história
Não tem sangue nas mãos*

“Sangue nas mãos” – Álbum Ponto Cego. Dead Fish.

Agradecimentos

Em primeiro lugar, expresso minha gratidão ao meu orientador, Professor Dr. Jaime José Zitkoski, por ter abraçado meu problema de pesquisa. Sua orientação foi importante para que eu chegasse até esta etapa conclusiva.

Agradeço calorosamente aos meus colegas de curso, que se tornaram companheiros de jornada. Obrigado pelo suporte nos momentos mais desafiadores e, especialmente, pelo incentivo para "pintar o galo". Um agradecimento especial a Fabiana Ribeiro, Veleda Dobke, Márcia Adriana, Sérgio Trombetta, Luciane Ely e Kelly Gularte pela cumplicidade e amizade.

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS, reconheço a excelência da formação. Deixo meus sinceros agradecimentos aos servidores Roseli e Maicon, cujo trabalho diligente e prestativo foi essencial para o andamento de todos os processos.

Aos meus amigos Cristian, Laura, Patrícia, Sibebe, Elida, Renato, Eliane, Janaína, Juliana, Benhur, Eduardo obrigado pelo carinho, pela escuta e pelo apoio constante, que transcendia o âmbito acadêmico.

Um agradecimento muito especial ao meu ídolo que se tornou amigo, Rodrigo Lima (Dead Fish), por ter gentilmente permitido que sua arte musical integrasse a playlist que acompanha este trabalho, enriquecendo-o de forma singular.

Ao Professor e amigo Aragon, minha eterna gratidão. Sua disponibilidade para auxiliar nos momentos de maior dificuldade acadêmica e sua capacidade de despertar uma consciência crítica e questionadora foram um verdadeiro farol em minha trajetória.

À minha família, base de todo o meu esforço: à minha mãe Ana Cristina, aos meus irmãos Bianca e Tiago, ao meu afilhado Gael e ao meu avô Alziro que deixa saudades. Obrigado pelo amor incondicional e por serem meu porto seguro.

Por fim, estendo meus agradecimentos a todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte desta longa trajetória. Se o nome de alguém não foi mencionado aqui, saiba que seu apoio não foi esquecido.

RESUMO

Esta tese investiga as mais de 700 mil mortes por COVID-19 no Brasil, sustentando que não resultaram do acaso, mas de uma agenda deliberada de produção da morte orquestrada pelo governo Bolsonaro. À frente da crise sanitária, Bolsonaro contribuiu ativamente para a tragédia ao sabotar medidas de proteção, promover tratamentos ineficazes, atrasar a compra de vacinas e disseminar negacionismo científico – fatos documentados em fontes jornalísticas de 2020-2021, que constituem as fontes primárias desta investigação. Diante desse cenário, emergiu a questão central: como explicar que brasileiros normalizassem a morte em massa? A hipótese é a existência de um processo sistemático de pedagogização da pandemia – uma necropedagogia – que produziu subjetividades conformadas diante da catástrofe. A lacuna acadêmica suprida reside na ausência de estudos que articulassem, de forma integrada, as dimensões estrutural, biopolítica e pedagógica para explicar a naturalização social da tragédia. Faltava um quadro analítico unificado que demonstrasse como negacionismo, desmonte do SUS e desigualdade operaram em sinergia para produzir não apenas mortes, mas a aceitação social dessas mortes. O objetivo geral foi analisar se a gestão da saúde pública no governo Bolsonaro pode ser caracterizada como necropedagogia. A investigação baseou-se em documentos oficiais, relatórios institucionais e notícias veiculadas entre março de 2020 e dezembro de 2021. Os objetivos específicos foram: (a) reconstituir o modelo ultraliberal na saúde pública; (b) analisar suas consequências sociais; e (c) operacionalizar o conceito de necropedagogia. A necropedagogia, conceito central da tese, designa o conjunto de dispositivos discursivos, midiáticos e culturais que inculcaram na população a aceitação do absurdo. Manifestou-se na enxurrada de *fake news*, na negação da ciência, na promoção de medicamentos ineficazes e na criação de verdades alternativas que anestesiaram o espanto ético. Tratou-se de uma pedagogia da morte, que ensinava a desconfiar da vacina e a ridicularizar a máscara. A necropedagogia está alicerçada em três pilares que atuaram em sinergia: o Estado ultraliberal, que subordinou a vida aos imperativos do mercado; a necropolítica, que direcionou a letalidade do vírus para corpos negros, indígenas e periféricos; e a pedagogia da submissão, que forjou uma subjetividade marcada pela

aceitação passiva do inaceitável. A pesquisa demonstra como esses pilares produziram a naturalização da morte e a pouca comoção social. A conclusão é que o projeto bolsonarista não apenas matou, mas ensinou o país a aceitar a morte como natural.

Palavras-chave: Necropedagogia; Pandemia de COVID-19; Bolsonarismo; Necropolítica; Ultraliberalismo; Pedagogia da Submissão.

RESUMEN

Esta tesis investiga las más de 700 mil muertes por COVID-19 en Brasil, sosteniendo que no resultaron del azar, sino de una agenda deliberada de producción de la muerte orquestada por el gobierno de Bolsonaro. Al frente de la crisis sanitaria, Bolsonaro contribuyó activamente a la tragedia al sabotear medidas de protección, promover tratamientos ineficaces, retrasar la compra de vacunas y diseminar negacionismo científico – hechos documentados en fuentes periodísticas de 2020-2021, que constituyen las fuentes primarias de esta investigación. Ante este escenario, emergió la cuestión central: ¿cómo explicar que brasileños normalizaran la muerte en masa? La hipótesis es la existencia de un proceso sistemático de pedagogización de la pandemia – una necropedagogía – que produjo subjetividades conformadas ante la catástrofe. El vacío académico subsanado reside en la ausencia de estudios que articularan, de forma integrada, las dimensiones estructural, biopolítica y pedagógica para explicar la naturalización social de la tragedia. Faltaba un marco analítico unificado que demostrara cómo negacionismo, desmantelamiento del SUS y desigualdad operaron en sinergia para producir no sólo muertes, sino la aceptación social de esas muertes. El objetivo general fue analizar si la gestión de la salud pública en el gobierno de Bolsonaro puede ser caracterizada como necropedagogía. La investigación se basó en documentos oficiales, informes institucionales y noticias divulgadas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Los objetivos específicos fueron: (a) reconstituir el modelo ultraliberal en la salud pública; (b) analizar sus consecuencias sociales; y (c) operacionalizar el concepto de necropedagogía. La necropedagogía, concepto central de la tesis, designa el conjunto de dispositivos discursivos, mediáticos y culturales que inculcaron en la población la aceptación del absurdo. Se manifestó en el aluvión de fake news, en la negación de la ciencia, en la promoción de medicamentos ineficaces y en la creación de verdades alternativas que anestesiaron el espanto ético. Se trató de una pedagogía de la muerte, que enseñaba a desconfiar de la vacuna y a ridiculizar la mascarilla. La necropedagogía se asienta en tres pilares que actuaron en sinergia: el Estado ultraliberal, que subordinó la vida a los imperativos del mercado; la necropolítica, que direccionó la letalidad del virus hacia cuerpos negros, indígenas y periféricos; y la pedagogía de la sumisión,

que forjó una subjetividad marcada por la aceptación pasiva de lo inaceptable. La investigación demuestra cómo esos pilares produjeron la naturalización de la muerte y la escasa conmoción social. La conclusión es que el proyecto bolsonarista no sólo mató, sino que enseñó al país a aceptar la muerte como natural.

Palabras clave: Necropedagogía; Pandemia de COVID-19; Bolsonarismo; Necropolítica; Ultraliberalismo; Pedagogía de la Sumisión.

ABSTRACT

This dissertation investigates the more than 700,000 deaths from COVID-19 in Brazil, arguing that they did not result from chance but from a deliberate agenda of death production orchestrated by the Bolsonaro government. At the helm of the health crisis, Bolsonaro actively contributed to the tragedy by sabotaging protective measures, promoting ineffective treatments, delaying vaccine procurement, and disseminating scientific denialism – facts documented in journalistic sources from 2020-2021, which constitute the primary sources of this investigation. Given this scenario, the central question emerged: how can we explain that Brazilians normalized mass death? The hypothesis is the existence of a systematic process of pandemic pedagogization – a necropedagogy – that produced conformed subjectivities in the face of catastrophe. The academic gap filled by this study lies in the absence of research that integrally articulated the structural, biopolitical, and pedagogical dimensions to explain the social naturalization of the tragedy. A unified analytical framework was needed to demonstrate how denialism, the dismantling of the public health system (SUS), and inequality operated in synergy to produce not only deaths but also the social acceptance of those deaths. The general objective was to analyze whether public health management under the Bolsonaro government can be characterized as necropedagogy. The investigation was based on official documents, institutional reports, and news published between March 2020 and December 2021. The specific objectives were: (a) to reconstruct the ultraliberal model in public health; (b) to analyze its social consequences; and (c) to operationalize the concept of necropedagogy. Necropedagogy, the central concept of the thesis, designates the set of discursive, media, and cultural devices that inculcated in the population the acceptance of the absurd. It manifested in the flood of fake news, the denial of science, the promotion of ineffective medications, and the creation of alternative truths that anesthetized ethical astonishment. It was a pedagogy of death, which taught distrust of the vaccine and ridicule of the mask. Necropedagogy is grounded in three pillars that acted in synergy: the ultraliberal State, which subordinated life to market imperatives; necropolitics, which directed the virus's lethality toward Black, Indigenous, and peripheral bodies; and the pedagogy of submission, which forged a subjectivity marked by the passive

acceptance of the unacceptable. The research demonstrates how these pillars produced the naturalization of death and scarce social commotion. The conclusion is that the Bolsonarist project not only killed but taught the country to accept death as natural.

Keywords: Necropedagogy; COVID-19 Pandemic; Bolsonarism; Necropolitics; Ultraliberalism; Pedagogy of Submission.

1. Apresentação da temática

A pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, configurou-se não apenas como a maior crise sanitária global em um século, mas também como um espelho político e social capaz de revelar as prioridades, os valores e os mecanismos de poder dos Estados nacionais. No Brasil, esse espelho refletiu uma imagem sombria e deliberada: a de um governo federal que, sob a liderança de Jair Bolsonaro, operou uma gestão da crise pautada não pela proteção da vida, mas pela sua gestão diferencial e letal. Longe de se tratar de mera incompetência administrativa ou de um despreparo técnico, a condução pandêmica brasileira expôs um projeto político estruturado e uma lógica de poder pedagogicamente articulada.

Este trabalho parte da seguinte questão central de pesquisa: ***as políticas ultraliberais na área da saúde pública implementadas no governo de Jair Messias Bolsonaro durante a pandemia de COVID-19 podem ser compreendidas como uma expressão operacional da necropedagogia?*** A pergunta buscou investigar se a gestão da crise sanitária transcendeu a mera negligência para constituir um processo pedagógico de dessensibilização social, no qual a naturalização da morte e a desmontagem do sistema público foram estratégias conscientes de um projeto político mais amplo.

Para responder a esse questionamento, estabelece-se como objetivo geral analisar se o modelo de gestão em saúde pública conduzido pelo governo Bolsonaro durante a pandemia pode ser caracterizado como necropedagogia, identificando suas consequências materiais e simbólicas para a sociedade brasileira. A investigação foi realizada através do exame de documentos oficiais, relatórios de instituições de fiscalização e notícias veiculadas na grande mídia no período de março de 2020 a dezembro de 2021 – recorte que abrange o ápice da letalidade da COVID-19 no país.

Para alcançar esse objetivo geral, a pesquisa desdobrou-se nos seguintes **objetivos específicos**: (a) reconstituir o modelo de gestão ultraliberal imposto na área da saúde pública durante o governo Bolsonaro, com foco em seus princípios, discursos oficiais e ações concretas (ou omissões) no enfrentamento da pandemia, (b) analisar as consequências sociais dessa gestão, a partir de indicadores de mortalidade, estudos sobre desigualdade no acesso à saúde e

na disseminação da desinformação como instrumento de política pública, e (c) operacionalizar o conceito de necropedagogia a partir da articulação de seus três pilares constituintes – o Estado ultraliberal, a necropolítica e a pedagogia da submissão – e aplicá-lo como chave interpretativa para caracterizar o projeto político-sanitário do governo em análise.

A necropedagogia é aqui proposta como conceito analítico que se desenvolve a partir do diálogo entre a necropolítica de Achille Mbembe (2018) e as análises sobre a pedagogia de Paulo Freire. Se a necropolítica descreve o poder soberano de decidir quem pode viver e quem deve morrer, a necropedagogia designa o processo sistemático de ensino e aprendizado social necessário para naturalizar, aceitar e consentir com essa decisão. É o mecanismo pelo qual se dessensibiliza uma sociedade ante a morte, se desmonta a autoridade da ciência e se fabrica o alinhamento político a um projeto que elege a letalidade como estratégia.

Metodologicamente, este estudo adota uma abordagem qualitativa, ancorada em um referencial bibliográfico interdisciplinar que articula a filosofia política, sociologia, ciência política, estudos sobre fascismo, pedagogias e os estudos sobre autoritarismo. A coleta de dados fundamenta-se em fontes secundárias de notícias veiculadas pela grande mídia nacional no recorte temporal estabelecido. Adotou-se o método hipotético-dedutivo, que parte da formulação da hipótese central – a de que a gestão bolsonarista da pandemia pode ser interpretada como necropedagogia – para, em seguida, submetê-la ao teste empírico por meio da coleta e análise sistemática de evidências. Desse modo, a hipótese não é confirmada por acumulação de exemplos favoráveis, mas sim colocada em confronto com os dados selecionados (documentos oficiais, relatórios de fiscalização e reportagens), buscando-se falseá-la ou corroborá-la com base na força explicativa diante dos achados. A investigação, portanto, estrutura-se como um movimento lógico que vai do problema à hipótese, desta às consequências observáveis e, finalmente, à confrontação com os fatos, permitindo avaliar se o conceito de necropedagogia resiste como chave interpretativa válida para o período analisado.

A construção do corpus analítico seguiu um procedimento metódico e criterioso, articulado para garantir a pertinência e robustez em relação à pergunta de pesquisa. A operacionalização deu-se em duas etapas fundamentais e

interdependentes: a elaboração de um diagrama temporal de eventos-chave e a seleção estratégica de veículos e reportagens, culminando na organização analítica por pilares teóricos. Para ancorar a seleção midiática em acontecimentos concretos, foi inicialmente construído um diagrama cronológico abrangendo o período de 2020 a 2021. A curadoria dos eventos priorizou aqueles de maior relevância sociopolítica e sanitária no contexto pandêmico brasileiro, servindo como espinha dorsal objetiva para a identificação subsequente de coberturas jornalísticas significativas.

A identificação das unidades de análise, as reportagens, foi diretamente guiada pelo referido diagrama, assegurando que o corpus refletisse a mediatização dos principais fatos. Paralelamente, a escolha dos veículos de comunicação obedeceu a um critério de relevância estrutural e diversidade de perfil dentro do ecossistema midiático brasileiro, reconhecendo sua distribuição heterogênea e suas distintas formas de influência. A seleção fundamentou-se em dados consolidados de institutos de métrica, como IVC, Comscore, Kantar e IBOPE, visando capturar um espectro representativo do fluxo informativo nacional. O portal G1 foi incluído por sua liderança hegemônica no ambiente digital, concentrando sozinho entre 25% e 35% do mercado de acesso a portais de notícias, o que o configura como um agente central na formação de uma agenda pública de alcance massivo. A Folha de S.Paulo foi selecionada por sua dupla liderança qualificada, com relevante presença digital e, sobretudo, pela liderança no jornalismo impresso pago, conferindo-lhe grande influência junto a formadores de opinião e elites. A revista Veja integrou o corpus em virtude de sua posição histórica dominante no segmento de revistas semanais de informação, mantendo a maior circulação impressa em seu nicho. A CNN Brasil foi incorporada por representar o caso de crescimento acelerado e estratégia multiplataforma no período recente, com liderança expressiva na TV por assinatura. Por fim, a CartaCapital foi incluída por seu perfil distinto e influência qualitativa segmentada em círculos político-acadêmicos e movimentos sociais, garantindo a presença de um espectro ideológico específico e estruturante na amostra. Este conjunto compõe, assim, uma amostra estratégica que abarca desde veículos de alcance hegemônico até outros de influência nichada, permitindo uma análise multifacetada da construção narrativa sobre a pandemia. Posteriormente à seleção, as reportagens foram sistematicamente classificadas

e analisadas com base nos três pilares constitutivos do quadro teórico da necropedagogia: Estado Ultraliberal, Necropolítica e Pedagogia da Submissão. Reconhece-se que um mesmo evento ou reportagem pode se articular a mais de um pilar. Esta sobreposição não constitui uma fragilidade, mas antes enriquece a complexidade da ferramenta analítica, permitindo capturar a intrincada tessitura discursiva em que essas dimensões se entrelaçam e se reforçam mutuamente. Dessa forma, a metodologia delineada—do mapeamento cronológico à seleção representativa de veículos e à categorização teórica rigorosa—foi concebida como um circuito integrado e reflexivo, garantindo que cada etapa estivesse a serviço de iluminar, de modo consistente e profundo, o objeto e a problemática de pesquisa.

Como gesto metodológico complementar e afetivo, esta pesquisa é acompanhada por uma *playlist* sonora concebida pela autora durante o período investigado. As músicas selecionadas, acessíveis via QR Code abaixo, funcionaram como trilha sonora intelectual e emocional do processo de investigação, oferecendo um contraponto crítico e uma imersão sensível no contexto analisado. Mais do que um recurso auxiliar, esta seleção musical representa um testemunho da motivação investigativa que originou este trabalho, convidando o leitor a experienciar, em camadas sensoriais, o mesmo universo de questionamento que conduziu a esta análise.

Figura 1 - A música que a necropedagogia não calou: Dead Fish



O primeiro capítulo foi reservado à introdução da temática, apresentando o contexto da pandemia no Brasil, a questão de pesquisa, os objetivos e os procedimentos metodológicos adotados, incluindo a fundamentação do método hipotético-dedutivo como estrutura lógica da investigação.

O segundo capítulo trata do Estado ultraliberal, examinando seus fundamentos ideológicos, suas formas de intervenção (ou deliberada omissão) nas políticas públicas e como esse modelo, em sua versão mais radical, se

contrapõe aos princípios de universalidade, integralidade e equidade. Neste momento da análise, aborda-se especificamente a necropolítica de Achille Mbembe como chave para compreender o poder soberano de decidir quem vive e quem morre, sem que ainda se introduza a dimensão pedagógica que será desenvolvida adiante.

O terceiro capítulo é dedicado à discussão da importância do Sistema Único de Saúde (SUS) como projeto estruturante de país e à introdução do conceito de necropolítica. Nele, o leitor perceberá como o SUS representa uma conquista civilizatória vinculada à democratização do direito à vida, ao passo que a necropolítica é apresentada como o poder soberano de decidir quem pode viver e quem deve morrer, na contramão desses princípios, operando a naturalização da morte e a gestão diferencial e letal da população.

O quarto capítulo realiza uma descrição detalhada do período crítico da pandemia no Brasil entre 2020 e 2021, reconstituindo cronologicamente os principais eventos sanitários, as omissões e ações do governo federal, o colapso de sistemas regionais de saúde e o avanço descontrolado da COVID-19, oferecendo ao leitor o substrato factual necessário para compreender a magnitude da crise e o contexto no qual as estratégias necropedagógicas se materializaram.

O quinto e último capítulo é reservado à análise dos dados coletados ao longo da pesquisa, articulando as reportagens selecionadas, os documentos oficiais e os relatórios de fiscalização com os três pilares da necropedagogia – Estado ultraliberal, necropolítica e pedagogia da submissão. O leitor encontrará aí o teste empírico da hipótese central à luz do método hipotético-dedutivo, verificando como os achados corroboram ou falseiam a interpretação proposta, além de uma discussão aprofundada das consequências materiais e simbólicas desse modelo de gestão para a sociedade brasileira.

Ao final, espera-se oferecer não apenas uma crítica contundente a um período histórico específico, mas um instrumento analítico – o conceito de necropedagogia – para compreender como projetos políticos autoritários, em conluio com o capitalismo, podem transformar uma crise sanitária em uma oportunidade para o aprofundamento do controle social e da violência de Estado. A pandemia no Brasil, sob essa ótica, não foi um desvio, mas a expressão mais acabada de um projeto de poder cuja lógica permanece ativa,

desafiando a democracia e reafirmando a urgência de uma resistência fundada na defesa intransigente da vida, da ciência e da memória.

2. Ultraliberalismo: o modelo reconfigurado

“Só faz de conta que a política não interessa, quem manda, meu bem! E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político, ele faz em câmaras secretas, ele faz em chás, em almoços (...) podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não podemos resolver no jantar das sextas-feiras, nós não somos da elite dominante desse país.” (fala da economista Maria da Conceição de Almeida Tavares).

A constituição da sociedade tal qual a conhecemos hoje é o resultado de uma determinada *racionalidade* produzida consciente e inconscientemente no avançar dos séculos. Ao longo desse percurso, houve diferentes tipos econômicos como o feudalismo, o absolutismo e, atualmente, o capitalismo, cada qual possuindo uma racionalidade própria de auto-organização. Essa racionalidade advém de uma espécie de programa que leva a um modo de compreender e agir na vida cotidiana.

Embora esse tema envolva diversas áreas do conhecimento, a racionalidade que o trabalho pretende debater é a estatal, isto é, de todas as racionalidades existentes no campo da vida, a racionalidade estatal ou a *razão de Estado* corresponde a uma determinada maneira de exercício do poder pelos governantes e detentores do poder econômico que culmina numa forma específica de sociedade e de constituição de indivíduo.

A razão de Estado se manifesta através do modelo de *Estado de Polícia* que se configura na dominação estatal dentro de seu próprio território, conforme traduz Casara (2021, p. 51-52):

Se na relação com outros Estados, em razão dos poderes que outros países exercem (poder econômico, bélico, simbólico etc.), cada Estado mostra limites, o mesmo não pode ser dito em relação ao exercício do poder na esfera interna. Tem-se, nesse particular, as condições para o surgimento do que convencionou chamar de Estado de Polícia, um modelo que se caracteriza pelo exercício de poder de interferir na esfera de terceiros, sem à existência de limites, para dar conta de uma série de problemas e atender a uma série de objetivos não bem definidos e potencialmente ilimitados. Os detentores do poder político, ao exercerem o poder de polícia, que é a principal manifestação da razão de Estado, podem produzir efeitos sobre um número enorme de indivíduos, em diferentes intensidades e em variados aspectos de suas vidas.

Partindo dessa concepção, podemos esclarecer que o papel do Estado (principalmente após o surgimento do Estado Moderno), frente a produção de efeitos sobre os indivíduos, é o que explicaria algumas formas de relações em sociedade, pois foi através da imposição pela violência estatal que se gestou uma obediência nos corpos dos sujeitos, já que “o poder de polícia não guarda uma relação necessária com o objetivo de criar condições para a lei ou de

conservá-la, ele é uma manifestação da violência sem compromisso com a Lei” (Casara, 2021, p.54). Conjuntamente com esse poder de polícia, o Estado passa a organizar não apenas as demandas econômicas e políticas dentro do seu território, mas também (e sobretudo) as condutas dos corpos e das mentes, técnica que Foucault (2019) denominou de biopoder, já que seria uma configuração de técnicas as quais agiriam diretamente na produção de corpos economicamente ativos, porém politicamente dóceis.

O Estado assume o protagonismo na organização da sociedade justamente para viabilizar práticas da ordem do direito e da ordem econômica, oferecendo a sustentação necessária para a atuação do modelo mercadológico, isto é, ao considerar o mercado como o modelo para tudo o que existe, inclusive como o modelo de organização social, faz-se preciso uma atuação estatal através da produção de leis e de atos concretos do poder, direcionados ao direito de propriedade e aos mecanismos de relações contratuais, mantendo-o apenas como um mero (e importante) instrumento econômico.

Dentre a literatura, houve a tentativa de criação de alguns modelos e ideias que aparentemente suavizariam as características liberais, trazendo nuances mais sociais, entre eles, podemos citar Leonard Hobhouse (1994), com sua proposta de *liberdade social* que garantiria proteção aos mais fracos economicamente, por intermédio de leis estatais, e John Maynard Keynes (1999) teórico e formulador do *Welfare state* ou Estado de bem-estar social. Ambos procuraram, para o liberalismo, uma terceira via: *liberalismo social*, tentaram criar modelos e debates que ficavam situados entre o conservadorismo liberal e o socialismo, porém foram um tanto ingênuos em imaginarem um capitalismo saudável e com preocupações sociais, deixando algumas questões para as diretrizes morais coletivas. Contudo, esses modelos não estavam discutindo uma nova forma de lidar com o Estado, mas sim, uma tentativa de resguardar o liberalismo que caminhava para uma crise, principalmente com a Grande depressão nos anos de 1930. O que ficou evidente, com o passar dos anos, é que não se pode separar Estado, de um lado, e Mercado, de outro, sem a eliminação completa da lógica liberal na economia, em verdade, esse sistema econômico possui seu ponto nevrálgico na separação entre Estado e Sociedade (Orozco, 1980) e não entre Estado e Mercado.

Todos os golpes de Estado sofridos, principalmente pela América Latina, sustentam-se no protagonismo do Estado como agente de implementação desse modelo econômico. O golpe no Chile, em 11 de Setembro de 1973, é a expressão disso, uma vez que foi possível, através dele, implementar as regras ultraliberais *criadas* na Escola de Chicago, sob a égide de Milton Friedman, tornando o país, em questão, um laboratório experimental. Os autores Comblim (2009), Anderson (2003) e Comte-Sponville (2004), Harvey (2008) afirmam que o Chile apresentou uma redução considerável nos direitos sociais e experimentaram uma onda de desemprego massivo, além da privatização de bens públicos e tal façanha só foi viável através do governo autoritário de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

Conforme os apontamentos de Harvey (2008), o golpe no Chile foi um meio de solapar as políticas sociais do Presidente Salvador Allende as quais não agradavam a elite de negócios doméstica, esse desagrado transformou-se em apoio financeiro ao golpe, juntamente com o apoio das corporações dos Estados Unidos e da CIA. Os movimentos sociais e as organizações de esquerda foram desmontados de forma violenta. Os “Chicago boys” - grupo de economistas seguidores da teoria ultraliberal de Milton Friedman – foram chamados para reconstruir a economia do país a pedido de Pinochet. O primeiro trabalho do grupo foi a criação de empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), após houve a realização de políticas de privatizações dos ativos públicos, da seguridade social, além do aumento dos investimentos estrangeiros. O experimento chileno demonstrou principalmente que o ultraliberalismo, desde o começo, foi um projeto voltado para restaurar o poder de classe.

Harvey (2008) exemplifica tal afirmação, determinando que depois da implementação de políticas ultraliberais, no final dos anos de 1970, a parcela da renda nacional estadunidense de 1% dos mais ricos disparou, chegando a 15%. Por outro lado, os países da OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento) registraram, a partir dos anos de 1980, um grande aumento na desigualdade, esclarece o autor.

É nesse fluxo entre Mercado e Estado que o liberalismo se reconfigura no jogo econômico e surge um “*novo*” liberalismo, que limita o papel do Estado e o transforma em mero financiador do mercado. Essa *nova* configuração do modelo econômico conseguiu ser *ultra* perversa, quando o assunto diz respeito às políticas sociais e à democracia, pois as leis aprovadas, antes segundo as regras

da democracia representativa, agora há uma notória substituição dessas por decisões matemáticas supostamente impessoais. E essas mutações ultraliberais vão adentrando no Estado, na Sociedade e no Indivíduo e vão ruindo os ideais de democracia e de coletividade, colocando no lugar autoritarismo, individualismo e concorrência.

O neoliberalismo torna-se, então, uma racionalidade, isto é, um modo de compreender e atuar no mundo, capaz de produzir mutações sobre tudo e todos. Muda o funcionamento das instituições. Muda o relacionamento entre as pessoas. Muda a imagem que cada pessoa faz de si. Uma racionalidade que, para facilitar os 'cálculos de interesses', gera classificações, tais como 'desejáveis' e 'indesejáveis', 'amigos' (do mercado) e 'inimigos'. Um modo de pensar e atuar no mundo que redefine vocabulários, empobrece a linguagem, demoniza culturas políticas, modifica hábitos cidadãos, relativiza direitos fundamentais e inviabiliza práticas democráticas. Sob a égide da racionalidade neoliberal, todas as esferas da vida passam a ser pensadas e avaliadas a partir de critérios econômicos, em termos de cálculos, com o objetivo de obter vantagens e lucros (Casara, 2021, p.103).

Justamente por acreditar que o termo neoliberal não consiga abarcar a perversidade desse modelo econômico que procurarei utilizar o termo *ultraliberalismo*. Renomados autores utilizam o termo neoliberal por entender que o prefixo *neo* seria uma *nova* reprogramação do liberalismo, importante salientar que este trabalho não vai contra essa concepção já consolidada na doutrina, porém apenas indaga e reflete sobre o grau de radicalização das políticas econômicas que a sociedade enfrenta, pois temos uma configuração inédita e que deve ser cuidadosamente denominada, já que estamos lidando com um avanço de políticas econômicas ativamente excludentes.

Por perversidade considero essa racionalidade que recoloca todas as relações humanas como se fossem instrumentos para auferição de satisfação das necessidades individuais, em detrimento das necessidades coletivas, normalizando e tolerando índices cada vez maiores de desigualdade social.

O ultraliberalismo é derivado do liberalismo clássico com seus ideais conservadores do séc. XVIII e XIX. Dasso Júnior (2006, p. 48) afirma, nessa mesma linha de raciocínio, que o termo neoliberal não é o mais apropriado para se utilizar, já que o liberalismo como projeto de dominação nunca cessou e "Portanto, não há nenhuma (ou quase nenhuma) novidade substancial nos liberais contemporâneos que justifique o prefixo neo." Além disso, o autor acrescenta que a forma de agir de seus defensores e seus pressupostos

mostram a radicalidade desse modelo. A partir dessa constatação, Dasso Júnior (2006, p. 56-58) identifica sete principais características do modelo ultraliberal, sendo elas: 1) defesa da lógica do privado em detrimento da lógica do público; 2) aparência de inevitabilidade e de consenso; 3) discurso rico em eufemismos; 4) doutrina com “roupagem científica”; 5) retorno ao individualismo; 6) substituição da democracia pela tecnocracia ou “tirania dos especialistas”; e 7) economia como centro do ser humano. Características essas que dialogam com as premissas privadas e que nada se conectam com direitos sociais presentes nas preocupações estatais com viés mais social.

2.1. A racionalidade ultraliberal posta como teoria

O ultraliberalismo, antes de tudo, é uma racionalidade colocada como *teoria* que foi construída por economistas conservadores e também por grupos de empresários que pretendiam utilizar a máquina estatal em favor da lógica do mercado, assim, demonstrando a falácia dos discursos antiestadismo, ou como Foucault (2019) denominou de fobia de Estado, presentes nas antigas teorias econômicas.

O Colóquio Walter Lippmann, de 1938, debateu essa pretensão da retirada do modelo de *Estado interventor*, já que esse modelo causaria um corte de fluxo da ordem *natural* do mercado, ocasionando, assim, a crise econômica da época. Dardot e Laval (2016) indicam que esse Colóquio criou os fundamentos teóricos de transformação do liberalismo, no intuito de revitalizar o *verdadeiro* liberalismo, criando um *front* contra os inimigos os quais seriam: comunismo, fascismo e tendências de liberalismo *social*. As condições da livre concorrência estariam focadas na “vitória dos mais aptos”, outrora ameaçadas por lógicas sociais que barravam essa *força natural*. Harvey (2008) também ressalta que engenhosamente as figuras fundadoras desse “novo” liberalismo consideravam os ideais políticos da dignidade humana e da liberdade individual como valores centrais de civilização, justamente por serem ideais sedutores e convincentes que haveria um grau maior de dificuldade em negar essa teoria de modo prático e ajudaria, pelo menos no âmbito teórico, a rechaçar outros modelos estatais como o comunismo e o fascismo.

Se nesse primeiro momento a tendência era de retirada do Estado, pelo receio de uma economia planificada, logo, foi necessário repensar essa

estratégia, Limppmann (Apud DARDOT E LAVAL, 2016, p.96) apresenta o motivo, tendo como base de reflexão a atuação do campo jurídico. Para Limppmann, o neoliberalismo é antes de tudo uma questão de adaptação, em que homens devem ser ensinados a viver sob outra constituição de Estado, algo que não é da ordem espontânea da vida dos sujeitos, a questão é a necessidade de viabilizar um novo tipo de vida. Por essa razão que o Estado, através do campo do direito, é recolocado na discussão do ultraliberalismo como peça fundamental:

É precisamente ao Estado e à legislação produzida ou garantida por ele que cabe inserir as atividades produtoras e comerciais em relações evolutivas, enquadrá-las em normas harmônicas com a especialização produtiva e a extensão das trocas comerciais. Longe de negar a necessidade de um quadro social, moral e político para melhor deixar funcionarem os mecanismos supostamente naturais da economia de mercado, o neoliberalismo deve ajudar a redefinir um novo quadro que seja compatível com a nova estrutura econômica. Mais ainda, a política neoliberal deve mudar o próprio homem (Dardot e Laval, 2016, p. 89).

Limppmann critica esse impasse presente nos discursos economicistas de intervenção e não intervenção estatal e salienta que isso dificultou a adaptação dos sujeitos ao novo tipo de vida, pois impediu a compreensão do papel do Estado “na criação jurídica e inibiu ‘as possibilidades de adaptação.’” (DARDOT E LAVAL, 2016, p. 94). Outro ponto ressaltado pelo autor foi importância da função da educação para essa adaptação, uma vez que seria necessária uma política de educação das massas no intuito de incutir nos homens o espírito do capitalismo, sendo essa a única justificativa para o estado custear a educação, mediante orçamento público.

Portanto, o ultraliberalismo só conseguiu ser possível, como racionalidade, tendo como base um sistema normativo resguardado pela estrutura estatal “(...) o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida.” (DARDOT E LAVAL, 2016, p. 07). A partir de uma construção teórica ultraliberal – construída e debatida por um núcleo de intelectuais - que essa *racionalidade* conseguiu se projetar mais como um modelo neutro de atuação econômica do que como um sistema de normas, encobrindo, assim, sua razão de ser perante a sociedade.

A complexidade de análise do modelo também perpassa pelo que a escritora Brown (2019) argumenta, segundo ela, o modelo também visa negar a

sua existência para a manutenção de seu poder. A plasticidade do termo ressaltada por Brown (2019) é pertinente, uma vez que, insere na discussão as estratégias que essa racionalidade se propõe visando construir seu apagamento intencional na sociedade, principalmente aos olhos daqueles mais vulneráveis, afinal, não haveria como culpabilizar algo que não se pode determinar. A racionalidade hegemônica ultraliberal produziu aquilo que Foucault (2009) chamou de *regime de verdade*, pois construiu princípios, regras, valores, narrativas para serem seguidas que permitiram a submissão de muitos aos desejos de poucos. A racionalidade ultraliberal colocada, muitas das vezes, como neutra, é uma estratégia para dissimular as suas reais práticas. A falácia da neutralidade é detectada sobretudo nos discursos que consistem em elevar a crença de que o sistema econômico é *inevitavelmente* capitalista e ultraliberal, negando, assim, qualquer outra alternativa de construção social e de vontade política. Foucault (2019), detectando esse movimento histórico da sociedade, sinaliza essa orientação econômica denominando de governamentalidade política neoliberal que é uma tática de governo, conforme escreve o autor, a governamentalidade refere-se ao:

(...) conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 'governamentalidade' entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de 'governo' sobre todos os outros –soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por 'governamentalidade', creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco 'governamentalizado' (Foucault, 2019, p.143-144).

Portanto, frisar que o ultraliberalismo é uma racionalidade colocada em prática a partir de financiamentos, de ações de economistas e de intelectuais europeus é desmistificar que esse sistema não é passível de superação. Concebido como racionalidade, o sistema passa a ser mais percebido, entretanto, como práticas políticas-econômicas respaldada nas teorias de mercado, tendo o Estado seu principal garantidor.

Não apenas o Colóquio de Limppmann que estruturou o ultraliberalismo, mas também o grupo intitulado de Sociedade de Mont Pèlerin de 1947. Esse grupo, composto de economistas, historiadores e filósofos acadêmicos se reuniram em torno das ideias do filósofo político austríaco Friedrich von Hayek, tendo como compromissos centrais os ideais de liberdade pessoal, a substituição das teorias de liberalismo clássico de Adam Smith (apesar de não refutarem por completo a ideia da “mão invisível” do mercado) e da teoria de Karl Marx. Combatiam profundamente às teorias do Estado Intervencionista - como a de Maynard Keynes, alegando que as decisões estatais estariam fadadas à tendenciosidade política e, por isso, erradas, pois as informações que estariam à disposição do Estado não podiam rivalizar com o mercado. O grupo contou com o apoio financeiro e político da elite dos Estados Unidos e, somente, em 1970 começou a ocupar o centro das discussões econômicas mundiais, sobretudo após Hayek e Friedman ganharem o Nobel de economia em 1974 e 1976, respectivamente. Portanto, o Colóquio de Limppmann e a Sociedade de Mont Pèlerin mostraram o quanto foi necessário o esforço de um núcleo acadêmico conservador, financiado pelas elites, para transformar essa racionalidade ultraliberal em uma teoria concreta e operacional.

Algumas das características que tornaram possível a racionalidade virar teoria culminou em ações problemáticas nas políticas de cunho social, por essa razão que devemos debatê-las no intuito de determinar e analisar o aparelho estatal ultraliberal para que, na afirmação de sua existência, possamos imputar suas responsabilidades perante a civilização. Além disso, há características que devem ser melhor explanadas pelo seu papel decisivo nas políticas de cunho mais excludente. A necropedagogia se insere nesse contexto, pois somente um sistema que tolera certos modos de vivência, de sobrevivência ou, até mesmo, de genocídio é capaz de gerar uma pedagogia nefasta.

O ultraliberalismo é a discussão que primeiramente devemos ultrapassar para então entendermos a complexidade de debater a necropedagogia na Pandemia de COVID no país. Esse sistema econômico que formou a sociedade através de um modo de razão, tem por resultado em uma série de pontos preocupantes que devem ser apresentados e debatidos a seguir.

2.1.1. Teorias gerenciais: a racionalidade da Administração Pública brasileira

As teorias, basicamente, são conceitos, conjuntos de ideias e definições que procuram explicar os fenômenos da realidade e até mesmo prevê-los. Importante frisar que nem todas as teorias se constituem da mesma forma, elas diferem nas construções de estudos, de hipóteses e de observações. Contudo, toda e qualquer teoria possui uma inclinação ideológica e política que serve de pilar na condução da disseminação dessas ideias na sociedade. Especificamente, no caso das propostas de reformas administrativas, há uma teoria por trás do tipo de projeto de reforma do Estado, o grande cerne da questão está em identificar qual teoria está servindo de pilar para o projeto de governo, identificar seus formuladores teóricos e suas inclinações ideológicas e políticas ajudam nessa tarefa, afinal serão suas interpretações e projeções de sociedade que irão servir de planejamento estratégico para implementação de uma modificação da forma administrativa estatal.

Predominantemente, as justificativas para a reforma se concentram no fato da necessidade da superação do aparato burocrático estatal, já que deixaria a máquina inchada e ineficiente frente as demandas públicas. Somando-se a isso, Resende (2002) escreve um texto denominado de “Por que reformas administrativas falham?” debatendo o fato que as burocracias criariam resistência às mudanças, pois haveria agentes estratégicos os quais barrariam tais processos de *inovação* na intenção de conservar seus poderes no interior das instituições estatais, diminuindo, assim, uma possível criação de *performance* do Estado. Porém, essa constante crítica ao aparato burocrático concentra-se mais no *controle* dos processos públicos, do que propriamente no debate sobre o poder dos agentes estratégicos dentro do aparelho estatal.

A crise dos anos de 1970, interpretada como uma crise do Estado, fomentou o contexto de propostas governamentais que tivessem um melhor funcionamento com o menor custo possível, que fossem pouco burocráticas e mais gerenciais, propostas essas que estimularam o modelo de mercado como parâmetro de eficiência. Conforme os autores Silva e Gurgel (2024), a *New Public Management* (NPM) é a denominação desse movimento que internalizou na administração pública conceitos e práticas da administração privada e

Suas principais características são: a visão do cidadão como cliente; a utilização de critérios de mercado para avaliação dos serviços públicos; a adoção de métodos empresariais de gestão (management) em organismos públicos; os custos controlados de maneira regular e cotidiana; e a eficiência considerada um valor normativo prioritário, com a avaliação dos servidores públicos por critérios de desempenho próximos dos utilizados pelas empresas privadas. A NPM orientou intervenções que foram desde a terceirização dos serviços públicos até a abolição da estabilidade dos servidores e mudanças nas relações de trabalho no serviço público, passando pelas privatizações, concessões e transferência de atividades para o Terceiro Setor (Silva e Gurgel, p. 05, 2024).

No contexto brasileiro, é fundamental realizar algumas considerações acerca das propostas de reformas administrativas. A primeira observa que há uma importação de modelos de reforma de outras partes do mundo, o que gera uma incompatibilidade com as realidades político-econômicas e sociais locais durante sua implementação. Esses transplantes, frequentemente realizados sem a devida cautela, podem resultar em disfunções significativas ao longo do tempo, conforme ressaltam Dasso Júnior e Faganello (2022). O segundo ponto a ser destacado é que o termo "reforma" nem sempre está associado ao aprimoramento da máquina estatal; muitas vezes, refere-se a uma tentativa de eliminar premissas burocráticas — especialmente aquelas que impõem maiores controles sobre os processos — e à introdução de princípios gerenciais.

As reformas administrativas surgem na crítica das políticas de *welfare* (bem-estar) na justificativa que elas geram um aumento de despesas estatais, através da garantia do pleno emprego e das condições mínimas sociais financiadas pelo Estado. Madureira e Rodrigues (2006) salientam que a falência eminente das políticas de Estado de bem-estar (decorrente da insustentabilidade orçamental e gestionária do mesmo) é que cria as bases para novos modelos e paradigmas de administração, levando ao surgimento de reformas administrativas. Portanto, as reformas possuem o objetivo de enxugar a máquina pública, diminuindo as despesas de cunho mais social e trazer um paradigma de empresa privada para aumentar a *performance* da máquina estatal. Entretanto, essa racionalidade, que se manifesta como uma teoria neutra de reforma administrativa, provém de formuladores ultraliberais que se organizaram para ocupar espaços de debate público, inserindo-se, principalmente, na mídia e nas universidades, com o intuito de desenvolver novas pedagogias com objetivo de transformar o Estado em uma entidade análoga a uma empresa. Dardot e Laval (2016, p. 24) elucidam esse fenômeno de forma clara:

A sociedade neoliberal em que vivemos é fruto de um processo histórico que não foi integralmente programado por seus pioneiros; os elementos que a compõe reuniram-se pouco a pouco, interagindo uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. (...) a originalidade do neoliberalismo está no fato de criar um novo conjunto de regras que definem não apenas outro "regime de acumulação", mas também, mais amplamente, outra sociedade.

A construção de uma nova sociedade implica a adoção de uma gestão estatal alinhada aos princípios do ultraliberalismo. No contexto brasileiro, foram propostas três reformas administrativas elaboradas por acadêmicos e empresários que lideraram politicamente a busca por suas implementações: a primeira, em 1995, foi formulada por Luiz Carlos Bresser Pereira durante o governo de Fernando Henrique Cardoso; a segunda, em 2009, foi proposta por Roberto Mangabeira Unger e Jorge Gerdau Johannpeter durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva; e a terceira, em 2020, foi elaborada por Paulo Roberto Nunes Guedes no governo de Jair Messias Bolsonaro. Essas reformas refletem uma continuidade nas tentativas de reestruturação da administração pública brasileira, visando a redução do papel do Estado na economia, característica central do modelo ultraliberal.

2.1.1.1 Luiz Carlos Bresser Pereira e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE): governo de Fernando Henrique Cardoso

A proposta de Reforma Administrativa de 1995 foi denominada de Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado – PDRAE e dentre os três principais projetos esse foi o que demonstrou maior organização e empenho para a implementação no país. A sua elaboração foi organizada pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Para assumir tal projeto, foi colocado no cargo de Ministro da pasta Luiz Carlos Bresser Pereira.

Bresser-Pereira já tinha iniciado a sua trajetória política bem antes de assumir o MARE no governo de FHC. Ele foi o responsável, no governo de Sarney, pelo ministério da Fazenda, em 1980, instante que criou o Plano Bresser. Em 1995, quando assume o MARE, ele inicia a organização da proposta de reforma, tendo como argumento principal a necessidade da superação do aparelho burocrático e do ajuste fiscal. Sabendo da dificuldade que seria modificar essas pautas, fez-se necessário reformas constitucionais e, conforme o relato do próprio Bresser-Pereira (2014) na época, ele enfatizou

“(...) que, para podermos ter uma administração pública moderna e eficiente, compatível com o capitalismo competitivo em que vivemos, seria necessário flexibilizar o estatuto da estabilidade dos servidores públicos, de forma a aproximar os mercados de trabalho público e privado. (...) Passados alguns meses, contudo, os apoios começaram a surgir, a partir dos governadores estaduais, dos prefeitos, dos empresários, da imprensa e, finalmente, da opinião pública”. (Bresser-Pereira, p.06, 2014)

Esse argumento sobre a necessidade de mudança estrutural profunda que integrasse as leis constitucionais foi o que deu base para a aprovação da Emenda Constitucional nº19/98 (EC nº19/98) que alterou a Constituição Federal de 1988 em vários pontos, como: regime e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas. Através dessa Emenda, por exemplo, houve o aumento de tempo do estágio probatório, a criação de outras modalidades de demissão para o servidor de carreira e a modificação do At. 37 da Constituição Federal com a inclusão da “eficiência” como princípio.

A EC nº19/98 é o auge da proposta do PDRAE, já que conseguiu modificar parcialmente alguns pontos sensíveis do Estado, inclusive tivemos a construção de uma exposição de motivos interministerial nº 49, de 18 de agosto de 1995 que salientava a necessidade de atualização dos dispositivos legais em relação aos direitos dos servidores públicos. Segundo essa exposição de motivos, a intenção seria precipualmente remoer excessos, através de 3 objetivos:

- a) a recuperação do respeito e da imagem do servidor perante a sociedade: a flexibilidade da estabilidade, a introdução de mecanismos de avaliação e a possibilidade de equacionamento das situações de excesso de quadros deverão contribuir para o revigoramento da imagem do servidor público perante a opinião pública e para a assimilação de uma nova postura profissional;
- b) O estímulo e o desenvolvimento profissional dos servidores: a permissão da reserva de vagas nos concursos e processos seletivos repercutirá na motivação dos servidores e facilitará o seu adequado reposicionamento dentro da administração;
- c) O melhoramento das condições de trabalho: as flexibilizações introduzidas propiciarão a assimilação de novos métodos e técnicas de gestão, criando condições para substancial melhoria dos padrões gerenciais no serviço público, beneficiando os próprios servidores.

Contudo, no seu sentido prático e operante, esses objetivos se materializaram na precarização dos trabalhadores investidos em cargo público, uma vez que a EC nº19/98 não só modificava a Constituição Federal de 1988, como também abria espaço para a criação, nos anos 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O próprio PDRAE já escreveria que

A legislação brasileira reflete a ausência de uma política de recursos humanos coerente com as necessidades do aparelho do Estado. É, em princípio, o aspecto da administração pública mais vulnerável aos efeitos da crise fiscal e da política de ajuste. A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada, notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor. São exemplos imediatos deste quadro a aplicação indiscriminada do instituto da estabilidade para o conjunto dos servidores públicos civis submetidos a regime de cargo público e de critérios rígidos de seleção e contratação de pessoal que impedem o recrutamento direto no mercado, em detrimento do estímulo à competência (PDRAE, 1995, p. 27).

Essa adequação dos servidores públicos, passaria pela redução de custos por intermédio do enxugamento do quadro de pessoal, através de demissões, de privatizações e pela redução dos custos da remuneração, alcançada pelo teto de gastos com pessoal. A denominada rigidez das relações trabalhistas foi combatida por meio de formas de contratações flexíveis (sem necessidade de concursos públicos) e salários definidos de modo negocial, dependendo da correlação de forças e do jogo político.

Além da precarização das leis trabalhistas, a reforma também colocaria em prática a criação de novas formas de privatização, uma vez que, o PDRAE criou novos entes jurídicos para atuar nos *serviços públicos não-exclusivos*, mediante a forma de *propriedade pública não-estatal*, através do programa designado de *publicização*. O PDRAE ressalta que os serviços publicizados seriam, principalmente, nas áreas de saúde e de educação.

As Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) foram criadas com o objetivo de descentralizar a gestão pública e aumentar a eficiência na prestação de serviços, mas sua implementação gerou uma série de críticas e preocupações sobre a precarização dos serviços e a desresponsabilização do Estado.

As Organizações Sociais (OS) foram criadas através da Lei nº 9.637/98 para substituírem os serviços públicos nas áreas de saúde, de educação, de cultura, permitindo que a gestão desses serviços fosse realizada pelas entidades não-estatais, mas com financiamento público, através do *Contrato de Gestão*. A

Organização da Sociedade Civil para o Interesse Público (OSCIPs) criada pela Lei nº 9.790/99 também tinham como objetivo principal substituir os serviços públicos em diversas áreas, recebendo recursos governamentais através da utilização jurídica do *Termo de Parceria*. O início das atuações dessas entidades se concebeu na gestão de hospitais e nas unidades de saúde, com a expectativa de que poderiam operar com mais flexibilidade e eficiência do que as instituições públicas tradicionais.

Concebidas por legislações que já apresentavam uma série de críticas na sua formulação, somente a prática demonstrou que esses problemas eram ainda mais complexos de terem alguma resolubilidade. O Conselho Nacional de Saúde (CNS), na sua 11ª Conferência em 2000, indicou que a introdução das OS na saúde pública resultou em uma diminuição na qualidade do atendimento em várias regiões, com relatos de falta de insumos e equipamentos, salientando que “o tratamento diferenciado do governo federal às chamadas ‘organizações sociais’, do tipo da Fundação Associação das Pioneiras Sociais, que recebem, proporcionalmente, mais recursos que a rede própria do SUS” (CNS, p.39, 2001).

Por sua vez, a Controladoria-Geral da União (CGU) também emitiu o Relatório de Avaliação, no ano de 2020, que consolidou 21 trabalhos de auditoria, realizados no período de 2015 a 2020 e a partir desse relatório foi possível identificar diversas irregularidades no processo de terceirização dos serviços públicos de saúde, entre eles: (a) ausência de estudo prévio quanto à decisão de publicização ou estudo prévio que não demonstra a vantajosidade da terceirização; (b) irregularidades no processo de chamamento, seleção e qualificação de organizações sociais, resultando em não atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade, com consequente situações de prejuízo à ampla participação de interessados, favorecimento, direcionamento e simulação de competitividade; (c) inobservância do Regulamento próprio das OSs nas contratações e na seleção de pessoal e fragilidades nas contratações; (d) não disponibilização em transparência ativa ou disponibilização precária das informações mínimas necessárias ao controle social das parcerias do Poder Público com as OSs.

A criação das OSs e das OSCIPs foi parte de uma estratégia mais ampla para “modernizar” o Estado brasileiro e torná-lo mais eficiente dentro da lógica privatista, contudo esse movimento se traduziu em uma lógica ultraliberal que

priorizava o enxugamento estatal. O resultado foi a precarização dos serviços públicos que afetou diretamente a população mais vulnerável, além de casos graves de corrupção.

Um dos maiores casos de corrupção envolvendo OS no Brasil ocorreu no estado do Rio de Janeiro, especialmente durante os governos de Sérgio Cabral e Wilson Witzel, conforme noticiou o G1 (2020a). Este caso emblemático ilustra como a gestão por meio de OSs facilmente pode se transformar em um terreno fértil para práticas corruptivas, resultando em desvios bilionários de recursos públicos. No período de 2007 a 2020, o Ministério Público Federal (MPF) investigou uma série de irregularidades nas contratações e na gestão das OSs no estado do Rio de Janeiro. As investigações revelaram que as OSs estavam envolvidas em esquemas que desviaram bilhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o MPF, os desvios relacionados à saúde pública no Rio de Janeiro somaram pelo menos R\$ 1,8 bilhão. Esses recursos foram desviados através de contratos superfaturados e serviços não prestados. Ao todo foram 11 OSs envolvidas no esquema de corrupção: Mahatma Gandhi, Associação Filantrópica Nova Esperança, Instituto Lagos Rio, Instituto Diva Alves do Brasil (IDAB), Viva Rio, Instituto Sócrates Guanaes (ISG), Instituto Gnosis, Instituto D'OR, Instituto Solidário, Cruz Vermelha e Ideas.

A gestão política do Rio de Janeiro demonstrou o tamanho da fragilidade no controle desses entes administrativos, evidenciando que a reforma administrativa pública iniciada por Bresser-Pereira não foi criada para haver diálogo com preceitos e prerrogativas dos ditames públicos, apenas acarretou na abertura de práticas empresariais de interesses privados para dentro da *res publica*.

O PDRAE teve um objetivo bastante claro que foi mitigar as barreiras burocráticas que faziam resistência a algumas práticas empresariais. Não podemos deixar de esclarecer que Bresser-Pereira iniciou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar, em 1963, convidado por Abílio Diniz, um dos principais fundadores e executivos da empresa. Bresser-Pereira permaneceu na administração até 1982, porém mesmo após a sua saída manteve-se envolvido com o Grupo como membro do conselho consultivo até 2014, esse envolvimento veio a influenciar sua abordagem sobre gestão pública, transferindo esses conceitos para o MARE.

Miranda (2014) analisou e documentou os relatos históricos sobre a reforma de 1995. Em seu artigo “Reforma gerencial de 1995: uma narrativa analítica das origens” há dados importantes para entendermos a reforma primeiro como uma forma de pedagogia do privado, do que como uma mudança estrutural estatal, já que todo o esforço de Bresser-Pereira foi de enaltecer o setor privado como referência e exemplo de que jamais será possível de ser superado pelo setor público. Contudo, o que fica dissimulado é o empenho discursivo, são os métodos de poder, são os recursos financeiros despendidos para que essa razão do privado se torne incontestável.

Conforme Miranda (2014) informa, os empresários e alguns setores da imprensa foram os principais aliados de Bresser-Pereira, já que era conhecido no meio empresarial há décadas devido às suas relações profissionais com o Grupo Pão de Açúcar. Em relação à imprensa, alguns comentaristas econômicos e alguns editoriais apoiaram a proposta de reforma administrativa do governo. Bresser usou ativamente o espaço da imprensa para defender as suas propostas de reforma.

Os principais empresários e intelectuais que o apoiaram e que atuaram fortemente para a implementação da proposta de reforma gerencial foram:

Tabela 1 - Apoiadores do PDRAE

Apoiadores do PDRAE	Empresa/organização
Antônio Ermírio de Moraes	Grupo Votorantim
João Geraldo Piquet Carneiro	Empresário e advogado brasileiro, com uma carreira marcada por sua atuação em áreas de consultoria jurídica e governamental. Ele é sócio do escritório de advocacia Piquet Carneiro, Magaldi & Guedes Advogados, onde atua desde 2013, e é presidente do Instituto Helio Beltrão desde 1999.
Joaquim Falcão	Advogado e professor da PUC-Rio
Celina Vargas	Socióloga
Gerald Reiss	Empresário brasileiro conhecido por sua atuação em consultoria e administração, especialmente no contexto de reformas gerenciais e no setor de varejo. Ele se

	destacou como um dos principais consultores do Grupo Pão de Açúcar.
Jorge Wilhelm	Arquiteto e urbanista
Lourdes Sola	Cientista política
Abílio Diniz	Fundador e ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar

Fonte: autora, 2024.

Apesar da somatória de esforços para modificar diversos segmentos estatais, a reforma não foi implementada em sua totalidade devido a uma combinação complexa de fatores políticos, econômicos e estruturais. O tempo demonstrou que toda a carga semântica que Bresser colocou nas justificativas do PDRAE sobre ele ser democrático e ser voltado para o cidadão-cliente ou cidadão-usuário eram, na verdade, apenas justificativas que ajudariam a minimizar as críticas sobre a implementação do Plano e que em nada se mostraram reais e palpáveis na sua implementação parcial. O saldo dessa proposta foi a abertura para outras tentativas de reformas públicas brasileiras no intuito de uma abertura maior do campo estatal para as empresas privadas.

2.1.1.2 Roberto Mangabeira Unger, Jorge Gerdau Johannpeter e a Agenda Nacional de Gestão Pública (ANGP): governo de Luiz Inácio Lula da Silva

Sem perder de vista o caminho que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) deixou em aberto nos rumos das propostas de reformas administrativas, a Agenda Nacional de Gestão Pública (ANGP) é uma proposta que tomou forma no início dos anos 2000 no governo de Luiz Inácio Lula da Silva que pretendia prosseguir na questão da reforma do aparelho estatal. A superação do modelo burocrático ainda é uma pauta que orbita nas justificativas para a urgência de se reformular a Administração Pública, a eficiência como princípio trazido pela EC nº19/98 já é absorvida pelo texto e a ideia de privatização continua a ser um dos pilares da proposta. Importante salientar que os principais atores envolvidos na construção dos projetos de reforma da ANGP foram o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, e o empresário e presidente fundador do Movimento Brasil Competitivo Jorge Gerdau Johannpeter.

Cabe ainda destacar, que nesta mesma articulação da ANGP, foi na qual contou com a contribuição do ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, o mesmo que anteriormente, em 1995, esteve à frente das estratégias de elaboração e aprovação do PDRAE, no governo FHC (Dasso Júnior e Faganello, 2022, p.210).

O texto principal que abrange as pautas de discussão e os alinhamentos políticos estratégicos que deram origem à ANGP é intitulado “A agenda nacional de Gestão Pública”. Este documento conta com um texto introdutório chamado “O Verdadeiro Choque de Gestão”, escrito por Jorge Gerdau Johannpeter e publicado no Jornal Valor Econômico, em 2009. O segundo texto apresentou as três principais pautas da proposta de reforma administrativa, que seriam estas: **a) profissionalismo:** objetivando a formação de uma burocracia profissional baseada no mérito, constituindo um corpo generalista de carreira e superando o regime de favoritismo que ainda permeia o Estado; **b) ideal de eficiência:** busca promover um alinhamento entre a Administração Pública e a iniciativa privada, além de propor uma revisão radical do direito administrativo e de suas práticas; e **c) experimentalismo:** visa implementar um novo federalismo, funcionando como um laboratório de experimentação entre os estados federados. O foco está na criação de uma nova relação entre o Estado e a sociedade civil na prestação de serviços públicos.

Esta proposta mantém um diálogo com a ideia de integrar os métodos de gestão da Administração Pública aos métodos de gestão empresarial. No entanto, é importante observar que essa aproximação tende a desconsiderar o contexto político inerente a tais propostas. Como já mencionado por Brown (2019), a neutralidade deve ser compreendida como um fenômeno essencialmente político e ideológico. O texto da proposta de reforma administrativa ao enfatizar a sua neutralidade, demonstra o seu posicionamento e o seu papel ideológico de suas premissas na gestão pública.

A parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) destina-se a assegurar a incorporação do setor produtivo nesse debate. A competitividade da economia brasileira depende da qualidade da administração pública do país. A parceria entre os setores público e privado é do interesse de ambos e do Brasil. O debate em torno da Agenda Nacional de Gestão Pública não é – e nem pode ser – condicionado pelo calendário eleitoral ou por dogmatismos ideológicos (Johannpeter e Unger 2009, p.10).

O Movimento Brasil Competitivo (MBC) foi constituído como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e é uma das entidades organizadoras envolvidas na proposta da Agenda Nacional de Gestão

Pública (ANGP). A organização promove um debate sobre a interação entre os setores público e privado e sua aplicação no Estado. Um dos eixos temáticos da organização refere-se à questão da Educação, que se torna um aspecto importante nas suas atividades. A pedagogia defendida pelo MBC destaca-se ao afirmar que a “educação como eixo principal” é essencial, sustentando que “o ensino técnico e profissional pode contribuir para qualificar jovens e adultos, de acordo com a demanda de mercado.” Essa ênfase na educação técnica reflete uma estratégia que busca alinhar a formação profissional às necessidades do mercado, muitas vezes em detrimento de outras necessidades educacionais de caráter crítico e emancipador. É fundamental ressaltar que esse tipo de educação, caracterizada como "bancária", conforme Freire (2023), frequentemente se ajusta às exigências da lógica do capital, evidenciando que o fenômeno da neutralidade não é uma característica presente nesse contexto.

A base de apoiadores da proposta de reforma da ANGP é abrangente, incluindo um total de 85 indivíduos, entre os quais se destacam grandes empresas, políticos e empresários. Em contraste com o PDRAE, a Agenda Nacional de Gestão Pública decidiu listar os nomes de seus apoiadores ao final do documento. Entre os apoiadores, destacam-se:

Tabela 2 - Alguns dos apoiadores da ANGP

Alguns apoiadores da ANGP	Empresa/organização
Jorge Gerdau Johannpeter	Fundador da MBC e ex-diretor-presidente da Gerdau.
Adriana Machado	Na época, Diretora de Relações Governamentais da Intel Brasil.
Armando Monteiro	Na época, Presidente da Confederação Nacional da Indústria.
Carlos Américo Pacheco	Professor de Economia na Unicamp.
Daniel Feffer	Atualmente Vice-Presidente do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose.
Fernando Luiz Abrucio	Cientista político e professor da FGV.
Flavia Sekles	Na época, integrante da comunicação corporativa da Embraer; atualmente no Google Brasil.

José Mascarenhas	Representante da Odebrecht.
Laércio Cosentino	Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Totvs.
Marcelo Martins	Na época, Presidente do Grupo Cargill.
Pedro Passos	Cofundador da Natura
Walter Cover	Na época, Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vale do Rio Doce.
Wilson Ferreira	Na época, Presidente da CPFL Energia.

Fonte: autora, 2024.

Através desse projeto de reforma administrativa, foi possível a criação de novas modalidades de privatizações como as Parcerias Público-Privadas e os Consórcios Públicos.

(...) é possível destacar os efeitos da ANGP, mas também, as ações que a antecederam as quais dão continuidade ao previsto pelo PDRAE, estando dentre estas a instituição de normas que disciplinam a celebração de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública, pela Lei nº 11.079/2004, na sequência a criação dos Consórcios Públicos, criados pela Lei nº 11.107/2005 e posteriormente regulamentados pelo Decreto Presidencial nº 6.017/2007, estas são ações que também foram formuladas e instituídas no período do governo Lula, assim como as propostas constantes na ANGP (Dasso Júnior e Faganello, 2022, p.210).

À luz das propostas de reformas administrativas, é possível identificar um conjunto de teorias que se alinham à racionalidade da governamentalidade ultraliberal. Essa abordagem visa infiltrar-se em todas as organizações da sociedade, incluindo o próprio Estado, com o objetivo de assegurar a continuidade da hegemonia dessa estrutura. Essa dinâmica é sustentada pelo esforço de atores que se beneficiam diretamente das engrenagens do sistema vigente.

2.1.1.3 Paulo Guedes e a PEC da Nova Administração Pública (PEC 32/2020): Governo de Jair Bolsonaro

A proposta de reforma administrativa mais recente no Brasil foi elaborada durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, sob a coordenação do Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes. Formalizou-se através da Proposta de Emenda à Constituição nº 32 de 2020 (PEC nº 32/2020). Diferente das outras propostas anteriores, a publicização dela só ocorreu quando a PEC foi encaminhada para a Câmara dos Deputados.

A figura de Paulo Guedes, como Ministro responsável pelo projeto de reforma, é representativa do entendimento do que foi proposto na PEC nº 32/2020. Em uma matéria publicada pelo sítio eletrônico *Infomoney* em 2022, Guedes é descrito como alguém que “rezava a cartilha, adotada pelos Chicago Boys, de redução do tamanho do Estado com a venda de estatais, controle das contas públicas (...)”. A descrição em questão ressalta a adesão do ministro a uma perspectiva ultraliberal, a qual visa reconfigurar a administração pública no Brasil. Essa abordagem enfatiza a redução da intervenção do Estado na economia, a reformulação do regime de previdência social, a precarização das carreiras dos servidores públicos e a promoção da privatização de empresas estatais. A PEC 32/2020, não apenas reflete uma mudança nas práticas administrativas, mas também se insere em um contexto mais amplo de transformação das relações entre o Estado e a sociedade.

Paulo Guedes e a sua aproximação com as doutrinas ultraliberaes ocorreu na década de 1970, quando foi bolsista do CNPQ na Universidade do Chile. Durante esse período, teve a oportunidade de ouvir as aulas de Milton Friedman e outros intelectuais que defendiam esse sistema econômico. Essa experiência acadêmica foi fundamental para moldar suas convicções e sua visão sobre a economia, que posteriormente influenciariam suas políticas como Ministro da Economia no Brasil.

Bancado por uma bolsa de estudos do CNPq, que lhe rendia US\$ 2.330 mensais, e auxílio da FGV e da própria Universidade de Chicago, Guedes passou quatro anos assistindo a aulas com gurus liberais como Milton Friedman, que conquistou o prêmio Nobel de 1976, Gary Becker (premiado em 1992), Robert Lucas Jr. (1995) e Thomas Sargent (2011). Seus professores e os debates com colegas moldaram para sempre a forma de pensar de Guedes. Sua tese sobre questões fiscais e endividamento de governo é um indicativo do seu mantra repetido há décadas e mais ouvido ainda após a campanha de Bolsonaro: é preciso reduzir o Estado e os gastos públicos (INFOMONEY, 2022).

O jornalista chileno Cristián Bofill, em entrevista ao jornal "El País" em 2018, argumentou que o projeto de Paulo Guedes visava transformar o Brasil de forma análoga ao que foi implementado no Chile sob a orientação do economista Sergio de Castro, que atuou como assessor da Junta Militar a partir de 1973. Ainda, de acordo com uma reportagem do "Intercept Brasil" publicada em 2019, a população chilena continua a experimentar os efeitos das políticas adotadas pelos chamados "Chicago Boys", especialmente no que se refere às

privatizações, cortes nos gastos com serviços públicos e à persistente desigualdade social. Essas políticas ultraliberais, que buscavam a liberalização econômica e a diminuição do papel do Estado na economia, deixaram um legado duradouro que continua a influenciar a realidade social e econômica do Chile contemporâneo.

As privatizações desenfreadas e o corte de gastos em serviços públicos essenciais melhoraram os números da dívida pública, do PIB e da renda per capita. Apesar desses bons números, o Chile segue entre os países mais desiguais do continente mais desigual do mundo. Mas, como sabemos, essa não é uma preocupação dos ultraliberais. Pelo contrário, é um efeito colateral aceitável que a mão invisível do mercado acabará resolvendo (spoiler: nunca resolve). Esses indicadores excitam os homens do mercado, que enxergam o mundo através de planilhas do Excel. No mundo real, muitos chilenos têm que escolher entre lavar roupa e tomar banho porque não têm grana para pagar a água privatizada. Mas na planilha de Paulo Guedes, a Suíça latino-americana continua bombando! (Intercept Brasil, 2019).

A PEC 32/2020, assim como outras iniciativas voltadas para a reforma administrativa, configura-se como um projeto de Estado ultraliberal que se acumula de forma progressiva, contribuindo para a precarização da relação entre o Estado e Sociedade. É relevante destacar que, no início de 2020, o Brasil já enfrentava a maior crise sanitária global, decorrente da pandemia de COVID-19. Mesmo diante desse cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro buscou aprovar a PEC no Legislativo.

As manifestações rasas, considerando que não foram criados mecanismos formais de diálogo com a cidadania, e polêmicas dos agentes que integram o governo, só enaltecem e dão espaço para que novas críticas se sustentem, principalmente quando é reconhecido que não há nenhum outro documento para consulta pública, além do que já está em formato legislativo, que demonstre as aspirações e objetivos da proposta de “Reforma” Administrativa do Aparelho do Estado proposto pela Administração Federal. Tal fato torna-se notório, quando se percebe que somente o Congresso Nacional, enquanto Poder Legislativo e receptor da proposta oriunda do Executivo, é que tomou a iniciativa de disponibilizar em seu sítio eletrônico, um espaço para tratar dos elementos que contém a PEC nº 32/2020, a fim de elucidar dúvidas e esclarecer as especulações, que influenciarão no contexto da Administração Pública Brasileira (Dasso Júnior e Faganello, 2022, p.211).

A ausência de cuidados adequados com as questões democráticas, especialmente no que se refere às mudanças constitucionais que levaram a PEC à apreciação do Legislativo, evidencia uma preocupante falta de comprometimento com os princípios da Administração Pública, em particular pelo princípio da publicidade. Ademais, era previsível que a abordagem autoritária caracterizaria o mandato do governo Bolsonaro.

Cabe também destacar, que a referida proposta, até o momento não colocada em amplo pleito de discussão e diálogo com os interessados, e sobretudo com a sociedade civil, não tem um impacto somente sob o aparato da Administração Pública Federal, no âmbito do Executivo, mas também, sob os demais Poderes, em todos os níveis de atuação, sendo então uma “Reforma” do Aparelho do Estado, que transcende as necessidades e realidade do autor da proposta, para além da sua capacidade única de se sentir onipresente e detentor exclusivo da capacidade crítica das questões que permeiam o aprimoramento da Administração Pública como um todo, que no mínimo deve ser considerado como audacioso e intransigente, a ponto de não reconhecer a necessidade e manter a diplomacia para com a sociedade e os demais Poderes, para manutenção de habilidades estratégicas (Dasso Júnior e Faganello, 2022, p.211).

No que diz respeito ao conteúdo da PEC, é possível destacar que ela demonstra uma preocupação acentuada com as mudanças no regime jurídico dos servidores públicos civis, introduzindo alterações significativas que visam a precarização das condições de trabalho desses profissionais.

Chamada pelo governo de PEC da Nova Administração Pública, a proposta altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo quatro artigos inteiros. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, válidas somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças (Agência Câmara de Notícias, 2020).

Na exposição de motivos elaborada por Paulo Guedes, encontra-se a justificativa para essa modificação nas disposições referentes aos servidores públicos, conforme expressa o texto: “Torna-se imperativo, portanto, pensar em um novo modelo de serviço público, capaz de enfrentar os desafios do futuro e entregar serviços de qualidade para a população brasileira” (Brasil, 2020).

O novo modelo de serviço público apresentado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) fundamenta-se em três diretrizes principais: **(a)** modernização do Estado, visando conferir maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação; **(b)** aproximação do serviço público brasileiro à realidade nacional; e **(c)** garantia de condições orçamentárias e financeiras que assegurem a existência do Estado e a prestação de serviços públicos de qualidade. A modernização do Estado, conforme estipulado pela PEC, implica na modificação do regime jurídico dos servidores públicos, promovendo uma gestão de pessoas que seja ágil, adaptável e alinhada às melhores práticas internacionais.

A partir do primeiro eixo balizador da proposta, modernizar o Estado, busca-se estabelecer uma política de gestão de pessoas ágil, adaptável e conectada com as melhores práticas internacionais, bem como viabilizar dinâmica de relacionamento com órgãos e entidades públicos e com a iniciativa privada de forma a contribuir com mais

efetividade para o atendimento da demanda por serviços públicos (BRASIL, 2020).

A PEC apresenta justificativas que mencionam práticas internacionais sem aprofundar-se em uma análise crítica sobre o tema, ou mesmo mostrar alguns dados. Estudos indicam que a tendência global é a precarização do trabalho formal. Conforme, Oliveira e Carvalho (2008), houve um aumento na dualização do mercado de trabalho, resultando em grupos distintos de trabalhadores com diferentes níveis de segurança e direitos. As autoras argumentam que a precarização do emprego não é um fenômeno meramente conjuntural, mas uma mudança estrutural observada em muitos países da União Europeia (UE). A liberalização das demissões e a expansão do trabalho temporário têm contribuído para essa precarização, afetando especialmente os jovens, que enfrentam maiores dificuldades para conseguir empregos estáveis. Outro estudo destaca que a precarização é um fenômeno resultante da flexibilização do mercado de trabalho, manifestando-se na proliferação de novas modalidades contratuais e na diminuição de empregos permanentes. Araújo e Moraes (2017) afirmam que esse processo gera uma instabilidade crescente, levando ao aumento do desemprego e à formação de um "exército de reserva" de trabalhadores. Essa situação resulta na alienação dos direitos dos trabalhadores, que se tornam sujeitos a condições laborais insatisfatórias e potencialmente prejudiciais à saúde física e mental. Além disso, o estudo ressalta que a precarização não afeta apenas os trabalhadores informais, mas também aqueles inseridos no mercado formal, que enfrentam insegurança e instabilidade em seus vínculos laborais.

Esse debate sobre as práticas internacionais de trabalho, trazida pela PEC, converge para as questões de financeirização da economia e da consolidação do ultraliberalismo e como elas moldaram as condições laborais nas últimas décadas. Clementino, Araújo e Trovão (2023) enfatizam que essas transformações resultaram em uma maior fragilização das relações trabalhistas, com o aumento da informalidade e da precarização, manifestando-se em formas como o trabalho intermitente, a uberização e o autoemprego. As novas modalidades de trabalho são frequentemente associadas à falta de direitos e à instabilidade na renda, afetando especialmente grupos vulneráveis, como mulheres e pessoas negras.

Além das modificações do regime jurídico dos servidores públicos, também houve uma modificação das atribuições do Presidente da República, conforme estabelecido no Artigo 84 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Essas mudanças ocorreram para que houvesse uma ampliação dos poderes do Chefe do Executivo, em contrapartida, observou-se uma redução das atribuições do Congresso Nacional, que foram absorvidas pelas atribuições presidenciais, como é o caso da proposta de revogação do inciso XI, do artigo 48 da CF/88:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

A PEC também propôs a mudança do artigo 37 da CF/88, inserindo mais 8 princípios nos já existentes, justificando que a absorção desses novos princípios se dá pela necessidade de modernização da concepção de Estado. As regras sobre os acúmulos de cargos também foram questionadas e modificadas pela PEC de Bolsonaro e Paulo Guedes. Houve a proposta de inversão da lógica de acumulação, se antes era vedada, com a modificação, agora deveria ser permitida, desde que haja compatibilidade de horários e não implique conflito de interesse. Aos ocupantes de cargos *típicos* de Estado, seria mantida a vedação de qualquer outra atividade remunerada, incluída a acumulação de cargos públicos, com exceção de atividades de docência ou de atividades profissionais de saúde regulamentadas. Também haveria na regra a inclusão da possibilidade do militar da ativa ocupar cargo ou emprego de atividade própria de profissional de saúde ou de magistério.

2.1.1.4 Apontamentos das propostas de reforma administrativa

A conclusão da análise das reformas administrativas no Brasil, com foco nas figuras de Luiz Carlos Bresser Pereira, Roberto Mangabeira Unger, Jorge Gerdau Johannpeter e Paulo Guedes, revela um cenário complexo e crítico sobre a evolução das políticas públicas e suas implicações sociais. Bresser Pereira, como arquétipo do reformista do Estado moderno, introduziu a Emenda Constitucional nº 19/98, que visava modificar a administração pública, principalmente no tocante constitucional ao flexibilizar a estabilidade dos servidores e inserir a eficiência como princípio. As suas propostas abriram

caminho para a precarização das condições de trabalho no setor público, uma tendência que se acentuou nas reformas subsequentes. A crítica a Bresser reside na sua capacidade de articular mudanças estruturais que resultaram em um ambiente que favoreceu a desvalorização do servidor público e a implementação de práticas que priorizavam a eficiência em detrimento da equidade social.

A Agenda Nacional de Gestão Pública (ANGP), impulsionada por Unger e Gerdau Johannpeter, continuou essa trajetória ao buscar uma aproximação entre os métodos de gestão pública e empresarial. A crítica reside na falta de consideração pelo contexto político e social brasileiro. O enfoque na eficiência e na privatização pode ser visto como uma continuidade da lógica ultraliberal que desconsidera as necessidades sociais mais amplas, refletindo uma visão de Estado que se alinha mais aos interesses do mercado do que aos direitos dos cidadãos.

Por fim, Paulo Guedes, com sua PEC nº 32/2020, representa uma radicalização dessa agenda reformista. A proposta não apenas busca reconfigurar o papel do Estado na economia, mas também amplia os poderes do Executivo em detrimento do Legislativo, o que levanta sérias preocupações sobre a democracia e a participação cidadã nas decisões que afetam a administração pública. A crítica à abordagem de Guedes é clara: suas políticas ultraliberares não apenas precarizam as condições de trabalho dos servidores públicos, mas também perpetuam um modelo econômico que favorece a desigualdade social. As experiências passadas no Chile servem como um alerta sobre os riscos dessas reformas, onde a busca por eficiência econômica resultou em profundas desigualdades sociais. Em suma, as trajetórias de Bresser Pereira, Unger, Gerdau Johannpeter e Guedes revelam um padrão preocupante nas reformas administrativas brasileiras: a busca de um Estado mais *eficiente* se desvia significativamente das necessidades sociais e dos direitos dos trabalhadores. A crítica unificada a essas figuras destaca a necessidade urgente de repensar as reformas administrativas como propriamente públicas, sem aderir às racionalidades privadas e respeitando os princípios da justiça social e da dignidade humana.

Tabela 3 - Comparativo de propostas de reformas administrativas

PROPOSTA	ANO	GOVERNO	PRINCIPAL PROPOSITOR	FOCO	TIPO DE REGIME	ESTADO
PDRAE	1995	FHC	Bresser Pereira	Novas formas de privatização	Democracia hegemônica ou representativa	Ultraliberal
ANGP	2009	LULA	Mangabeira Unger e Gerdau Johannpeter	Continuação do caminho do PDRAE com outras formas de privatização	Democracia hegemônica ou representativa	Ultraliberal
PEC 32/2020	2020	BOLSONARO	Paulo Guedes	Avanço nas privatizações, precarização da carreira de servidores públicos	Autoritário	Ultraliberal

Fonte: autora, 2024.

É crucial reconhecer que as propostas de reformas administrativas no Brasil estão profundamente enraizadas em racionalidades ultraliberais, defendidas por indivíduos que, durante toda a sua vivência, pedagogizaram-se em contextos acadêmicos em que teorias que favorecem a lógica do setor privado em detrimento do público são frequentemente apresentadas como neutras, despojadas de seu conteúdo ideológico. Essa perspectiva evidencia os caminhos trilhados por tais propostas, ressaltando a influência de uma visão que minimiza o papel do Estado na promoção do bem-estar social. No caso da PEC nº 32/2020, coordenada por Paulo Guedes, a divulgação ocorreu apenas após seu envio à Câmara dos Deputados, o que reflete a postura do governo Bolsonaro em relação ao desrespeito aos princípios democráticos brasileiros.

2.2. A antidemocracia no regime de Estado Ultraliberal

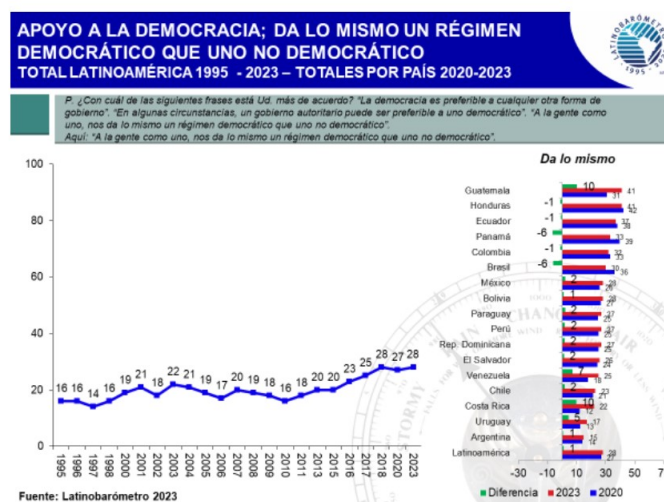
Com o advento das transformações revolucionárias que marcaram o século XVI na Europa, reacendeu-se o debate acerca dos direitos fundamentais do homem, os quais têm como princípio basilar a garantia da liberdade e da igualdade entre os indivíduos, conforme expresso no lema francês: *liberdade, igualdade e fraternidade*. Nesse contexto, ressurgiu a valorização da democracia como um mecanismo essencial para a transformação de indivíduos em cidadãos plenos, dotados de direitos e deveres, e capazes de participar ativamente dos processos deliberativos coletivos, com o objetivo de modificar a realidade de forma engajada e consciente, “a democracia ultrapassa a simples ideia de um regime político identificado à forma do governo, e devemos tomá-la como forma geral de sociedade” (Chauí, 2019, p. 11).

No entanto, com a gradual erosão do conceito de democracia como um valor substantivo, reduzindo-a a um mero método de aplicação de normativas, como o exercício do voto, sua capacidade transformadora e participativa acaba sendo significativamente limitada. Restringir a democracia ao ato do sufrágio equivale a contemplar apenas uma de suas múltiplas dimensões, negligenciando sua complexidade e potencialidade. Essa lógica constitui a base da concepção hegemônica de democracia, também denominada democracia liberal, que se fundamenta em um modelo representativo no qual a participação política é basicamente realizada por meio do voto, exercido em intervalos periódicos predefinidos por lei. Tal perspectiva, no entanto, desconsidera a necessidade de uma participação cidadã mais ampla e contínua, essencial para a efetivação de uma democracia substantiva e inclusiva, nas palavras de Brown (2018, p.34) “democracias liberais, burguesas ou capitalistas nunca foram democracias plenas, e quaisquer que sejam suas disposições democráticas, elas vêm sendo constantemente enfraquecidas nas últimas décadas”. A democracia deveria constituir-se como um modelo de organização social pautado por valores éticos e políticos, no qual a dimensão coletiva fosse prioritariamente considerada na implementação de direitos, na alocação de orçamentos e na definição de investimentos públicos. Em essência, trata-se de assegurar que o poder decisório seja efetivamente exercido por aqueles a quem ele legitima e pertence: a comunidade, por meio de mecanismos de participação cidadã que sejam ativos, inclusivos e eficazes. Essa perspectiva reforça a ideia de que a democracia não se limita a procedimentos formais, mas deve ser um instrumento vivo e dinâmico de transformação social, garantindo a voz e a ação direta dos cidadãos na construção do bem comum.

A Organização Latinobarómetro publicou recentemente os resultados da pesquisa intitulada *Balanco da Democracia na América Latina 2023*, apresentando dados relevantes e significativos para a análise do cenário político latino-americano. O relatório do estudo evidencia um aumento no sentimento de indiferença em relação à preferência entre um regime democrático e um não democrático. A questão central que fundamentou a construção do gráfico subsequente foi formulada da seguinte maneira: **“Da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”** (“Tanto faz um regime democrático

quanto um não democrático”). Esse indicador reflete uma preocupante tendência de desencanto ou apatia em relação aos valores democráticos.

Figura 2 - É indiferente a escolha entre um regime democrático a um não democrático - dados de 2023



Fonte: Latinobarómetro (informe 2023).

Percebe-se pelo gráfico que houve um aumento (1995 a 2023) do sentimento de *indiferença* na escolha de um regime democrático na América Latina. Embora o Brasil tenha aumentado o seu apoio as instituições democráticas em relação ao ano de 2020.

A organização também apresentou o resultado referente a pergunta **“Apoyaría a un Gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático, si las cosas se ponen muy difíciles”** e, conforme podemos observar na Figura 2, o ano de 2023 foi o que apresentou maior apoio em relação aos anos anteriores.

Figura 3 - Apoio a um governo militar na América Latina dados de 2023



Fonte: Latinobarómetro (informe 2023).

O declínio da confiança no regime democrático, observado na maioria dos países da América Latina, reflete os impactos da agenda ultraliberal, que desloca a concepção de democracia como um valor substantivo, reduzindo-a a um mero método de organização política, ao mesmo tempo em que promove o distanciamento dos cidadãos dos processos decisórios governamentais. Quando o sistema político e econômico introduz, de forma estratégica, discursos que fragilizam a noção de democracia, o objetivo subjacente é, em última instância, o enfraquecimento e a desestruturação do Estado. Essa dinâmica evidencia uma tensão entre a preservação dos princípios democráticos e a lógica de mercantilização e privatização característica do ultraliberalismo, com implicações profundas para a soberania e a participação popular.

O neoliberalismo tinha o franco objetivo de dismantelar o Estado social, seja privatizando-o (a revolução Reagan-Thatcher), seja delegando suas tarefas (a "Grande Sociedade" do Reino Unido e os "mil pontos de luz" de Bush), seja eliminando completamente tudo o que resta de bem-estar social ou "desconstruindo o Estado administrativo" (o objetivo de Steve Bannon para a presidência de Trump). Em cada caso, não é apenas a regulação e a redistribuição sociais que são rejeitadas como interferência inapropriada nos mercados ou como assaltos à liberdade. A dependência da democracia em relação à igualdade política também é alijada. O ataque neoliberal ao social, (...), é fundamental para gerar uma cultura antidemocrática desde baixo, ao mesmo tempo em que constrói e legitima formas antidemocráticas de poder estatal desde cima. A sinergia entre os dois é profunda: uma cidadania cada vez mais não democrática e antidemocrática está mais e mais disposta a autorizar um Estado crescentemente antidemocrático. À medida que o ataque ao social derrota a compreensão democrática de sociedade

zelada por um povo caracterizado pela diversidade e habilitado a governar a si de forma igualitária e compartilhada, a política se torna um campo de posicionamento extremo e intransigente, e a liberdade se torna um direito de apropriação, ruptura e até mesmo destruição do social - seu inimigo declarado (Brown, 2018, p.39).

A democracia hegemônica deve ser contestada por meio do fortalecimento da justiça social, a qual atua como um antídoto contra as estratificações, exclusões, abjeções e desigualdades que, historicamente despolitizadas, sustentam práticas privatistas. Para tanto, é essencial incorporar ao debate a influência das agendas neoliberais, que têm contribuído para o enfraquecimento da percepção da necessidade de vivermos sob regimes democráticos. A democracia combativa, em oposição à concepção hegemônica, configura-se como o espaço ideal no qual os cidadãos são convocados a exercer plenamente seus direitos políticos, respaldados por bens e serviços públicos que visam corrigir desigualdades historicamente consolidadas.

No entanto, mesmo diante da recente consolidação da democracia no Brasil, marcada pela promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime democrático enfrenta ameaças constantes. O avanço do neoliberalismo busca desconstruir sua essência, transformando-a em uma mera representação simbólica, que evoca tons de verde-oliva remissivos dos regimes autoritários do passado, esvaziando-a de seu potencial transformador e de sua capacidade de promover justiça social. Diante desse cenário, torna-se imperativo reafirmar e defender os princípios democráticos, assegurando que a democracia não se restrinja a uma formalidade, mas se consolide como um instrumento efetivo de emancipação e equidade.

Quando a democracia deixa de ser consolidada como um valor fundamental para a nação, observa-se a emergência e a proliferação de organizações antidemocráticas, as quais encontram espaço propício para se estruturar e expandir. Essa dinâmica evidencia a fragilidade do tecido social e político, permitindo que práticas e ideologias contrárias aos princípios democráticos ganhem relevância e influência, comprometendo a estabilidade e a legitimidade do regime democrático.

A relação entre a descrença no regime democrático e o surgimento de tendências autoritárias é um tema central para entender os desafios políticos contemporâneos no Brasil. Em um país marcado por uma história de

autoritarismo, como a ditadura militar (1964-1985), e por uma democracia relativamente jovem, consolidada apenas com a Constituição de 1988, esse debate ganha contornos urgentes e complexos.

No Brasil, parte da sociedade ainda guarda uma visão nostálgica do período da ditadura militar, associando-o a uma suposta estabilidade econômica e segurança pública. Essa visão, no entanto, ignora os graves abusos de direitos humanos, a repressão política e o cerceamento das liberdades individuais que marcaram o regime autoritário. A idealização do passado autoritário reflete uma falha na educação política e na memória histórica do país, que ainda não superou completamente o legado da ditadura.

Líderes populistas frequentemente exploram a descrença na democracia para consolidar seu poder. No Brasil, figuras políticas têm utilizado retóricas autoritárias, atacando instituições como o Judiciário, o Congresso e a imprensa, e sugerindo que essas instâncias são obstáculos à "vontade do povo". Esse tipo de discurso, que deslegitima os pilares da democracia, pode levar ao enfraquecimento do sistema democrático e ao fortalecimento de práticas autoritárias.

As redes sociais e a disseminação de desinformação desempenham um papel crucial nesse processo. Notícias falsas, teorias da conspiração e discursos de ódio são amplificados, criando um ambiente em que a democracia é constantemente questionada. A desinformação alimenta a ideia de que o sistema democrático é corrupto, ineficaz ou controlado por elites, o que pode levar parte da população a apoiar medidas autoritárias como forma de "limpar" o sistema.

O fenômeno das milícias no Brasil representa uma das faces mais sombrias da interseção entre autoritarismo, violência e controle territorial. As milícias brasileiras emergiram como grupos paramilitares que, sob o pretexto de oferecer segurança, consolidaram-se como organizações criminosas envolvidas em atividades ilegais, como extorsão, tráfico de armas, controle de serviços públicos e participação política. Originadas principalmente em áreas periféricas do Rio de Janeiro, as milícias expandiram-se para outras regiões do país, tornando-se um problema nacional. No entanto, o que começou como uma resposta à incapacidade do Estado em garantir segurança rapidamente degenerou em uma forma de controle autoritário sobre as populações locais.

Hoje, as milícias são responsáveis por dominar territórios inteiros, impondo regras, cobrando taxas ilegais e eliminando qualquer forma de dissidência.

A expansão das milícias está diretamente ligada à fragilidade das instituições democráticas e à corrupção endêmica no sistema de segurança pública. Muitos milicianos são ou foram agentes do Estado, o que lhes confere conhecimento e conexões para operar à margem da lei, mas com a proteção de setores do próprio Estado.

A ascensão das milícias é sintomática da fragilidade do Estado democrático de direito no Brasil. A incapacidade do Estado em garantir segurança pública, combater a corrupção e promover justiça social cria um vácuo de poder que é preenchido por grupos criminosos. As milícias, em particular, exploram essa fragilidade para consolidar seu poder, agindo como uma força autoritária que desafia a soberania estatal.

Além disso, a atuação das milícias é facilitada pela convivência de agentes públicos, incluindo policiais, políticos e membros do Judiciário. Essa convivência revela uma crise de legitimidade das instituições democráticas, que falham em proteger os cidadãos e em garantir o cumprimento da lei.

2.2.1. Milícia como uma faceta da crise democrática: a constituição da subjetividade da morte

A declaração do então deputado Jair Bolsonaro em 2017, na Comissão de Segurança Pública da Câmara, expressando o desejo de que “a polícia matasse 200 mil vagabundos” após qualificar a Constituição de 1988 como “porcaria” no tocante aos Direitos Humanos, não constitui um desvio retórico isolado. Ela representa a expressão discursiva cristalizada de uma racionalidade política cuja genealogia remonta à formação do Estado brasileiro moderno. Esta racionalidade, que instrumentaliza a morte como tecnologia de governo, possui raízes históricas profundas que antecedem a ditadura civil-militar (1964-1985), articulando-se em uma continuidade que atravessa regimes políticos aparentemente distintos.

Sua origem situa-se nos anos 1960, com a emergência de grupos de extermínio formados majoritariamente por policiais que, operando a partir de comunidades periféricas do Rio de Janeiro, atuavam como “justiceiros”. Estes grupos instituíam um ciclo perverso de violência e controle: semeavam o terror

para, em seguida, se apresentarem como a solução coercitiva para os problemas de segurança por eles mesmos fomentados. Esta prática constituía uma estratégia de acumulação de capital simbólico e econômico em territórios marcados pela omissão estatal.

O regime militar representou um momento de sistematização e transferência tecnológica desta violência. Houve uma convergência operacional entre policiais civis – detentores de um conhecimento repressivo desenvolvido nas favelas, com técnicas como o “pau de arara” e a “pimentinha” (um aparelho de choque elétrico) – e militares engajados no combate à guerrilha. Figuras como o Capitão Aílton Guimarães Jorge personificaram essa transferência, tornando-se instrutores de tortura para os órgãos de repressão política. Este episódio evidencia uma linhagem contínua de violência estatal, na qual técnicas inicialmente empregadas para o controle de populações marginalizadas foram refinadas e direcionadas para a repressão política, consolidando um arsenal de terror como parte do aparato de Estado.

A redemocratização não interrompeu esta linhagem, mas promoveu sua reconversão e privatização. Militares e policiais egressos de órgãos como o DOI-CODI migraram para o crime organizado, frequentemente associando-se a redes de contravenção como o jogo do bicho. Deste caldo cultural e operacional emergiram, a partir dos anos 1990, as milícias. Estes grupos constituem a expressão contemporânea e capitalizada daquela racionalidade violenta, ocupando o vácuo de soberania em territórios periféricos – especialmente na Baixada Fluminense – para impor um regime de acumulação primitiva baseado no medo e na morte.

Como analisa o jornalista Bruno Paes Manso em “*A República das Milícias*” (2021), a força e complexidade destas organizações derivam de sua natureza híbrida e de suas múltiplas ramificações, que articulam o jogo do bicho, o tráfico de drogas, grupos de extermínio e agentes políticos em uma rede de poder de difícil desmonte. Dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF), através do *Mapa Histórico dos Grupos Armados no Rio de Janeiro* (2022), quantificam esta hegemonia: um crescimento de 387% na presença miliciana no estado, com aproximadamente 4,4 milhões de pessoas residindo em áreas sob controle de grupos criminosos.

A consolidação deste poder foi viabilizada por uma “carta branca para matar” – uma permissividade estrutural que garantiu vantagem competitiva no mercado da violência. Esta impunidade permitiu às milícias estabelecer um monopólio territorial que sustenta um vasto portfólio de atividades econômicas extorsivas, incluindo:

- a) Taxação de comércio e moradores por “proteção”;
- b) Venda monopolizada de gás, água, energia e serviços de TV e internet;
- c) Controle do transporte por vans;
- d) Invasão e loteamento irregular de áreas ambientais para construção de condomínios clandestinos.

O desmoronamento de dois prédios em Muzema (2019), sob responsabilidade da milícia do Capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, resultando em mais de vinte mortes, é o epítome trágico deste modelo de negócios. Ele expõe como a violência, o controle territorial e o empreendedorismo criminoso se fundem em uma lógica de acumulação que trata a vida como externalidade descartável.

Figura 4 - Em 16 anos, milícias viram maior grupo criminoso do Rio (Crescimento de 387%)



Fonte: estudos do GENI-UFF (2022)¹

A trajetória do Capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, egresso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e ex-integrante do 16º Batalhão da Polícia Militar, sintetiza a metamorfose do poder estatal em

¹ Veja esse mapa de forma interativa. Disponível em: <<https://fogocruz.github.io/mapafc/>>. Acesso em 17 de Dezembro de 2023.

empreendimento criminoso. Sua atuação institucional foi marcada pela organização de esquemas de "arrego"² e pela prática sistemática de tortura, consolidando um *modus operandi* que conjugava violência institucional e acumulação ilegal. Em 2004, sua prisão – decorrente do assassinato de uma testemunha que o incriminaria – não interrompeu sua carreira criminosa, mas a transferiu para um novo patamar de sofisticação. No cárcere, Nóbrega estruturou um escritório de homicídios por encomenda, voltado principalmente para clientelas do jogo do bicho, e iniciou investimentos no setor imobiliário em Muzema, inovando ao integrar o controle do transporte por vans ao tráfico de drogas – um modelo de gestão territorial integrada do crime.

A conexão estrutural deste aparato com a esfera política foi selada em 2003, através de uma parceria com Fabrício Queiroz, que atuaria como elo operativo permanente entre as milícias e a família Bolsonaro. Juntos, no 18º Batalhão de Jacarepaguá, replicaram o modelo de dominação territorial de Rio das Pedras, transformando a instituição policial em uma plataforma de expansão miliciana. Esta relação simbiótica foi institucionalizada via vínculos empregatícios e financeiros: em 2006, a esposa de Nóbrega e de Queiroz foi contratada pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual; em 2016, a mãe de Nóbrega ingressou no mesmo gabinete, envolvendo-se em esquemas de "rachadinha". O ápice desta conexão ocorreu em 2005, quando Flávio Bolsonaro concedeu a medalha Tiradentes a Adriano Nóbrega, então preso por homicídio, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) – um ato que ritualizou publicamente a aliança entre o poder parlamentar e a soberania miliciana.

Paralelamente, o ecossistema criminoso passou por um processo de convergência e hibridização, conforme analisado por Bruno Paes Manso. Se inicialmente as milícias limitavam-se a extorsões, monopólios de serviços e grilagem, hoje atuam diretamente no tráfico de drogas. Inversamente, facções tradicionais do tráfico adotaram práticas milicianas, como a venda coercitiva de serviços de gás e internet. O resultado é a emergência de um mercado criminal integrado, onde a distinção entre milícia e tráfico se dissolve em favor de

² Arrego é como se chama a prática dos policiais de cobrarem propina dos traficantes para não coibir as atividades criminosas nas bocas de fumo.

uma governança territorial híbrida baseada no controle violento de populações e na diversificação de fluxos de renda ilícita.

É neste contexto que a retórica bolsonarista da "bandido bom é bandido morto" adquire seu sentido plenamente seletivo e performático. O bandido a ser eliminado não é o miliciano – integrante de uma rede que inclui aliados políticos –, mas sim o competidor no mercado da ilegalidade, representado pela figura do traficante. Esta construção discursiva atualiza, no presente, a lógica da "guerra interna" da ditadura militar, que então visava a guerrilha urbana. Agora, o inimigo social é ressignificado como o sujeito associado ao caos das drogas, alimentando um imaginário do medo que justifica a exceção permanente. A necropolítica, teorizada por Achille Mbembe, opera precisamente nesta zona de indistinção: a criação de Estados de Exceção localizados, nos termos de Giorgio Agamben (2002), onde indivíduos são reduzidos à vida nua (zoé), destituídos de proteção jurídica e política, tornando-se corpos matáveis.

O Estado, assim, terceiriza seu monopólio da violência para atores como Nóbrega e suas redes, conferindo-lhes uma "carta branca para matar" que é, ao mesmo tempo, negação de direitos e garantia de impunidade. A pedagogia necropolítica materializa-se, portanto, em duas frentes indissociáveis: na gestão empresarial do crime pelas milícias e na gramática política do governo Bolsonaro, que naturalizou a morte como instrumento de ordem. Esta simbiose gera um efeito colateral estrutural: a consolidação de um poder fragmentado e disseminado que não emana apenas do Palácio do Planalto, mas de uma constelação de soberanias locais onde milicianos, policiais e políticos conjuram para governar pela morte. O caso Nóbrega não é uma anomalia, mas o paradigma de uma forma de poder na qual a linha que separa a lei do crime, o Estado do banditismo, e a política do extermínio se dissolve na prática cotidiana da dominação.

2.3. O sujeito idiosubjetivado: o indivíduo necessário

“não há sociedade, só indivíduos” – Margaret Thatcher

A economia ultraliberal transcende a mera análise das trocas e dos sistemas de produção de riqueza. Ela se configura como uma prática disciplinar que, em grande medida, se fundamenta em princípios morais. Assim, essa economia não se limita a descrever fenômenos, mas também propõe um modelo

pedagógico que orienta comportamentos a serem internalizados. Nesse sentido, discute-se não apenas como os indivíduos devem desejar, mas também como devem agir e julgar em suas interações que extrapolam o campo do econômico. Diante disso, constitui um equívoco atribuir à constante demanda por desempenho estatal o expressivo apoio social encontrado pelas reformas administrativas, mesmo quando estas se opõem de forma intencional aos interesses dos próprios cidadãos. Esse apoio majoritário, na realidade, emerge de uma construção intelectual promovida por pensadores que disseminam tais ideias. Essa construção intelectual fundamenta-se nos princípios do ultraliberalismo, o qual demanda a formação de um tipo específico de sujeito: aquele desprovido de capacitação intelectual e disposição crítica.

Dardot e Laval (2016) assinalam que o ultraliberalismo constitui a fundamentação do capitalismo contemporâneo, caracterizando-se como uma forma de capitalismo que se desvincula de suas referências arcaicas e é plenamente reconhecida como uma construção histórica e norma geral de vida. O ultraliberalismo pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que estabelecem um novo modo de governança dos indivíduos, orientado pelo princípio universal da concorrência.

A economia ultraliberal apresenta um *modus operandi* que se infiltra em diversos modos de vida, resultando, por sua vez, em transformações nas relações interpessoais e na subjetividade dos indivíduos, além do mais, “(...) o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida” (DARDOT e LAVAL, 2016, p.07). O argumento central dos autores está sobre a necessidade de desconstruir o sistema normativo ultraliberal vigente e substituí-lo por uma nova “razão do mundo”, na qual a crítica não fique limitada apenas às falsas teorias ou aos comportamentos imorais do sistema.

O principal desafio dessa equação reside na maneira de como a maioria dos indivíduos acaba por internalizar conceitos cuja lógica, em grande medida, implica na supressão de seus próprios direitos, inclusive ao direito à vida. A astúcia central do sistema econômico ultraliberal consiste na sua capacidade de formar uma massa de sujeitos que, embora não se beneficie desse sistema, defende-o e se sacrifica em seu favor.

Jessé Souza (2019) argumenta que toda a *ideia dominante* se origina de uma *classe dominante* que exerce controle sobre o sistema econômico. Essa classe, por sua vez, formula e dissemina uma racionalidade ultraliberal que, embora esteja profundamente enraizada em interesses privados, é veiculada como se fosse de natureza coletiva, visando à preservação de seus privilégios.

O que tem de ser explicado aqui é como a elite do dinheiro, que detém o capital econômico e, por conta disso, manda na economia, passa a mandar de modo indireto também no mundo social e político pela construção, colonizada pelo dinheiro, da opinião pública. Essa elite precisa travestir seus interesses de proprietário em suposto interesse geral para garantir o controle da reprodução social mantendo seus privilégios (Souza, 2019, p. 128).

O ultraliberalismo é a expressão econômica do capitalismo contemporâneo, mas sua abrangência vai além dessa dimensão. Trata-se também de uma forma de organização social que requer a implementação de mecanismos de assujeitamento para garantir a permanência das premissas desse sistema como hegemônicas. A construção de um tipo de indivíduo que esteja “apto” a obedecer de maneira inquestionável e a se sacrificar em prol do sistema é influenciada por diversos fatores de alienação. Nesse sentido, essa construção é essencial para a perpetuação do sistema em vigor.

Wendy Brown (2018) introduz o conceito de cidadão sacrificial para elucidar o comportamento desses indivíduos que acreditam que, para prosperar no capitalismo, é imprescindível realizar sacrifícios. Somente podemos entender esse “sacrifício”, se compreendermos, em primeiro lugar, que o imaginário ultraliberal apreende o indivíduo e o condiciona a performar como se fosse uma empresa. Conforme afirmado por Rubens Casara, “É o imaginário neoliberal, porém, que permite a extensão a todas as dimensões da vida de um modo de compreensão e de funcionamento econômico: uma espécie de ‘devir empresa’ que passa a atingir domínios, atividades e sujeitos” (Casara, 2024, p. 186).

O imaginário ultraliberal, impõe ao indivíduo que ele se responsabilize, tanto pelo seu sucesso, quanto pelo seu fracasso, que realize sacrifícios “pelo bem maior”, que se coloque como oferta de si mesmo para que o sistema funcione. Essa dinâmica é particularmente evidente na implementação de medidas de austeridade, que frequentemente contrariam os direitos sociais, uma vez que tais direitos são considerados incompatíveis com uma sociedade que valoriza a *performance* individual.

A expressão 'sacrifício compartilhado' está nas bocas de todos os políticos e gerentes engajados em cortes, *downsizing*, apertar de cintos, revogação de direitos e em toda imposição de medidas de austeridade pelo Estado. Mas há mais nessa escolha terminológica. Sacrifício, por definição, envolve oferecer comida, objetos, vidas de animais ou pessoas a um propósito mais alto, uma figura divina ou sobrenatural (...) Oblação, às vezes usado como sinônimo de sacrifício, também é uma oferta a Deus, mais especificamente uma oferta de si mesmo. Um oblato devota (normalmente de forma monástica) sua vida a Deus, e a oblação carrega a ideia particular de 'esvaziar-se de si por Deus' (...) O cidadão sacrificial do neoliberalismo não é aquele cujos interesses são feridos ou temporariamente postos entre parênteses. Mais que isso, pode-se dizer que esse cidadão é oblato em relação ao projeto de crescimento econômico; tropeçamos, portanto, na dimensão teológica do capitalismo, que muitos vêm explorando nos últimos anos (Brown, 2018, p.44).

Não é por acaso que o lema "a economia não pode parar", amplamente disseminado durante a pandemia de 2020, não se restringiu apenas ao Brasil; essa afirmação reflete uma conduta necessária dentro do contexto da sociedade ultraliberal, que exige a figura do cidadão sacrificial.

Mas o mantra "estamos todos juntos nisso" hoje atravessa nações, empresas, indústrias, cidades e instituições públicas, convocando os indivíduos ao sacrifício pela sobrevivência ou a recuperação do todo econômico, especialmente nos níveis mais baixos das escalas empresariais e de renda. De maneira mais importante, perda de empregos, terceirização, downsizing e reduções de benefícios, bem como cortes em educação pública, infraestrutura e seguridade social, tudo isso toma forma como decisões econômicas na governança neoliberal, e não como decisões políticas (Brown, 2018, p.46).

Marilena Chauí (2021), ao perceber esse movimento de condução do Estado e da sociedade como empresa privada, denominou-o de *sociedade administrada* em que os preceitos e dogmas empresariais são absorvidos nas mais diferentes esferas sociais e que geram, fundamentalmente, uma postura de isolamento do indivíduo e da dissolução das classes trabalhistas. Há uma transformação do proletariado em *precariado* na figura do empreendedor-de-si.

Trata-se de uma nova ética do trabalho, na qual o sujeito passa a se enxergar enquanto elemento ativo dentro da empresa, vendo essa relação como um acordo não entre empregado e empregador, mas sim como entre duas empresas - sendo o trabalhador um empresário de si mesmo. Como estamos argumentando, a definição do sujeito como um empreendedor é, na racionalidade neoliberal, atribuída não somente às suas ações no âmbito econômico, pois o empreendedorismo seria uma faculdade empresarial existente em todos os sujeitos, que são capazes de se tornar empreendedores de todos os aspectos de sua vida, inclusive empreendedores de si mesmos (Braga e Silva, 2023, p.146).

Sob essa perspectiva, a educação deixa de ser uma busca motivada pela curiosidade ou pela aquisição de ferramentas para a compreensão do contexto histórico no qual esse sujeito está inserido. Em vez disso, a educação passa a ser vista como um investimento estratégico, com o objetivo de aumentar seu "valor de mercado" e torná-lo mais competitivo no âmbito empresarial.

Os indivíduos, diante desse contexto, passam a figurar, ainda que sem consciência de seu papel, como atores ou como objetos cenográficos do mercado. A partir dos processos neoliberais contemporâneos, que apresentam a vida social e a vida política como fenômenos exclusivamente econômicos, as próprias pessoas passam a ser imaginadas como objetos, como empresas ou como capital humano. Mais precisamente, em razão do imaginário neoliberal, o indivíduo se imagina como um empreendedor-de-si, enquanto as empresas e as constelações econômicas nacionais e pós-nacionais (como a União Europeia e o Mercosul) tratam-no como um ativo (um capital), um servo ou um objeto a ser descartado (Casara, 2024, p. 186-187).

A sociedade ultraliberal se manifesta como uma expressão da miséria, refletindo-se tanto na formação de bolsões de pobreza, quanto na redução e simplificação da linguagem. A “arte de governar”, conforme destacado por Casara (2024), seria a simplificação da linguagem como um recurso político estratégico que resultaria na busca pela ignorância, promovendo a falta de reflexões críticas sobre os rumos da humanidade. “(...) A manutenção das múltiplas opressões requer corpos e mentes dóceis e tristes. A ignorância, percebida como uma positividade, mostra-se compatível com imagens e com ideias empobrecidas” (Casara, 2024, p.163).

O "homem ignorante" é o tipo ideal de cidadão, uma figura que não representa riscos aos interesses dos detentores do poder econômico. O saber contra-hegemônico, que poderia fomentar uma conduta crítica e reflexiva, é visto como uma ameaça e, portanto, deve ser afastado. Observa-se uma busca pelo "orgulho de ser ignorante", evidenciada pela adesão a movimentos anti-intelectuais presentes na sociedade contemporânea.

Diante desse quadro, cada vez mais pessoas buscam se expressar a partir de uma linguagem empobrecida, com recurso a slogans, chavões, jargões e construções gramaticalmente pobres, com o objetivo de serem compreendidas e contarem com a simpatia de interlocutores que elas supõem ignorantes. A orientação para os governantes, a oposição, os jornalistas, os magistrados, os gerentes e os diretores de grandes empresas é a de limitar-se a formulações simples (sujeito-verbo-complemento) e a utilizar um vocabulário pobre para conseguir a atenção de um auditório que eles acreditam ser (e agem para tornar) cada vez mais inculto (Casara, 2024, p. 86-87).

Em 2024, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou um estudo sobre a percepção e a recepção de notícias falsas e verdadeiras em 21 países. A pesquisa “Thruth Quest” (OECD, 2024) teve como objetivo analisar se determinados tipos de conteúdo são mais facilmente identificados como falsos ou enganosos em comparação com outros, bem como avaliar se o tema abordado influencia a capacidade de detecção. Para isso, o estudo foi estruturado em torno de três eixos temáticos principais: meio ambiente, saúde e assuntos internacionais. Os resultados indicaram que os países com os menores índices de identificação de notícias falsas foram Brasil, Colômbia, México e Portugal. Dentre esses, o Brasil destacou-se como o país onde os entrevistados demonstraram maior confiança nas mídias sociais (20% dos entrevistados) e que utilizam essas plataformas como principal fonte de informação.

De maneira mais ampla, o estudo demonstrou que, em média, os participantes conseguiram identificar corretamente 60% a cada 100 notícias falsas disponibilizadas. Esse percentual indica que, para cada 100 notícias falsas, aproximadamente 60 foram reconhecidas como tal, enquanto as demais permaneceram sem detecção. Esse resultado é alarmante, pois indica que cerca de um terço das notícias falsas circulantes nas mídias sociais diariamente tende a ser interpretado como verdadeiro pelos usuários. Essa dificuldade em distinguir entre informações falsas e verdadeiras representa um desafio crítico para a promoção da conscientização e o enfrentamento da desinformação. Além disso, o estudo destacou a influência do nível educacional nesse processo, constatando que os pesquisados com menor escolaridade apresentaram desempenho inferior na identificação de notícias falsas, enquanto aqueles com maior nível de escolaridade demonstraram maior capacidade de discernimento. Essa correlação reforça a importância da educação como fator determinante na capacidade de análise crítica e na mitigação dos efeitos da desinformação.

À medida que as notícias falsas adquirem crescente relevância no cenário político contemporâneo, torna-se imperativo resgatar e reafirmar a educação sob uma perspectiva freiriana como proposta e prática pedagógica essencial.

(...) o pensamento reflexivo e a inteligência tornam-se obstáculos. No ambiente capitalista, radicalizado na fase neoliberal, a contradição ‘que consiste na estupidez da inteligência é uma contradição necessária. Pois a *ratio* burguesa tem que pretender a universalidade e, ao mesmo

tempo, desenvolver-se no sentido de restringi-la'. Uma pessoa deve ser inteligente, na medida em que isso sirva aos interesses dos detentores do poder econômico, mas os mesmos interesses vão levar a mesma pessoa a portar-se como estúpida sempre que necessário ao processo de acumulação do capital (Casara, 2024, p. 27).

A banalização do "orgulho da ignorância" foi estrategicamente construída e implementada por agentes dominantes do sistema capitalista, como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, com o intuito de manipular e subjugar os indivíduos, impedindo-os de refletir criticamente sobre a sua realidade e sobre o momento histórico no qual é pertencente.

Outro estudo, conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2022, e publicado na revista científica *The Lancet Global Health*, intitulado "Preventable risk factors of dementia: Population attributable fractions in a Brazilian population-based study" (BORELLI, Wyllians Vendramini et al., 2022), associou o declínio cognitivo não à idade, mas à falta de acesso à educação. A pesquisa, que analisou dados de 41 mil indivíduos na América Latina, identificou que a baixa escolaridade e as desigualdades educacionais estão diretamente relacionadas ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Isso ocorre porque a educação atua como um fator protetor para a saúde cognitiva, reforçando sua importância na prevenção de tais condições. O estudo destaca a necessidade de políticas públicas que garantam maior acesso à educação de qualidade, não apenas como um direito social fundamental, mas também como uma estratégia essencial para a prevenção de doenças neurodegenerativas e a promoção da saúde mental da população. A educação, além de ser um pilar central para o desenvolvimento social e econômico, revela-se, portanto, como uma ferramenta indispensável para a saúde pública, capaz de mitigar riscos associados ao declínio cognitivo e contribuir para o bem-estar coletivo.

A educação, enquanto elemento fundamental para a transformação das estruturas sociais vigentes, desempenha um papel crucial na formação de sujeitos críticos, conectados à sua realidade e capacitados para refletir, debater e aprimorá-la. É justamente essa capacidade de promover consciência crítica e emancipação que a torna uma ferramenta potencialmente disruptiva, ameaçadora para aqueles que buscam distorcê-la e reduzi-la a um mero instrumento de reprodução de um modelo bancário de ensino. Nessa perspectiva,

a educação é transformada em um mecanismo de formação de indivíduos adaptados ao sistema vigente, em vez de capacitá-los para questioná-lo e transformá-lo. Essa deturpação do papel da educação visa manter as estruturas de poder e dominação, impedindo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

3. A Necropolítica na pandemia: a disputa entre biossistemas e o projeto da morte

O projeto ultraliberal fundamenta-se em premissas excludentes e individualizantes, dependente da formação de subjetividades idiossincráticas que não oponham resistência à sua perpetuação. Sob um véu de racionalidade técnica, essa estrutura ideológica reveste-se de uma aparência de cientificidade para legitimar seu caráter desumanizante.

Nessa lógica, todo direito fundamental converte-se em mercadoria em potencial, permitindo que grupos restritos auferem lucro sobre esferas antes garantidas socialmente. A saúde constitui um caso emblemático. Contudo, em contraste a essa tendência, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resultou de um processo singular: amplos debates públicos e democráticos, com participação de diversos setores e movimentos sociais, culminando na institucionalização de mecanismos como conselhos e conferências de saúde.

Por sua natureza contrária à mercantilização, o SUS configura-se como um entrave à racionalidade ultraliberal. As estratégias para neutralizá-lo (como o estrangulamento financeiro, a precarização de suas estruturas participativas e a narrativa da incompetência sistêmica) visam justamente ocultar seu caráter disruptivo. Ainda assim, mesmo sob tais pressões, a mera existência e resistência do SUS opera como um catalisador de consciência crítica.

Esse processo ocorre em um contexto de desmonte do pensamento crítico, no qual os indivíduos são levados a assimilar acriticamente os valores institucionalizados pelo próprio sistema. Como resultado, naturaliza-se a ideia da ineficiência do SUS e advoga-se por sua privatização, um paradoxo evidente durante a pandemia de COVID-19, quando a rede privada de saúde foi a primeira a entrar em colapso.

Neste cenário, emerge a Necropedagogia, conceito que articula a exploração de um momento de vulnerabilidade social generalizada para normalizar a indiferença e o “deixar morrer” de segmentos populacionais específicos, assegurando a continuidade da acumulação capitalista. Sua viabilização, no entanto, exigiu a conjugação de um aparato político-institucional e de uma base econômica estruturada para operacionalizar tal lógica.

3.1. O SUS como Prática Pedagógica Antagônica

A saúde pública consolida-se como um eixo analítico fundamental para a compreensão das dinâmicas sociais e das disparidades territoriais, constituindo-se como um dos principais indicadores de desenvolvimento humano. Em contextos nacionais marcados por significativas assimetrias regionais, como o caso brasileiro, um país de dimensões continentais e profundas desigualdades estruturais, o estudo dos sistemas de saúde revela-se particularmente elucidativo para a identificação de padrões de vulnerabilidade social.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022-2023) corroboram essa premissa ao evidenciarem marcantes contrastes regionais na dependência do Sistema Único de Saúde (SUS). Como demonstram os indicadores, a região Nordeste apresenta o maior índice de utilização exclusiva do sistema público de saúde, com aproximadamente 77% de sua população dependendo integralmente dos serviços do SUS. Esse fenômeno mostra-se intimamente correlacionado com os indicadores socioeconômicos da região, destacando-se a renda per capita de R\$ 1.098 - a segunda mais baixa entre as macrorregiões brasileiras, superando apenas a região Norte.

Portanto, analisar o sistema de saúde brasileiro necessariamente remete à discussão sobre o histórico estrutural de desigualdades que marca o país. Esse imperativo torna-se particularmente relevante no atendimento às populações de territórios geograficamente isolados ou economicamente menos atraentes para a iniciativa privada, onde a presença estatal se configura como única garantia de acesso universal à saúde. Tal realidade corrobora a premissa teórica de que o cuidado em saúde se constitui como uma prática intrinsecamente coletiva, cuja efetivação transcende a esfera da individualização.

Como destacado por Vigotski (2007) em sua teoria da mediação social, o desenvolvimento humano ocorre por meio das interações socioculturais, reforçando a ideia de que o ser humano, enquanto ser gregário, depende da vida em comunidade para sua plena realização biopsicossocial. Nesse contexto, o isolamento prolongado configura-se como um fator de risco para complicações psicológicas significativas, corroborando as análises de Durkheim (2000) sobre a relação entre desintegração social e deterioração da saúde mental. Além

desses impactos psicossociais, é necessário considerar também as implicações de ordem biológica:

(...) também na dimensão meramente biológica do viver em sociedade, do agrupamento humano decorrem efeito que podem se transformar em causas com o impacto sobre a saúde de cada um e, simultaneamente, de todos. Os conceitos epidemiológicos de contágio e transmissão e a definição imunológica de imunidade, tanto a natural quanto a adquirida, constituem fundamentos para a compreensão desses efeitos, seja compreendendo-os como agentes etiológicos, os causadores de doenças, seja como fatores de proteção contra micro-organismos em geral. É por essas razões que a saúde de um indivíduo vivendo em sociedade interessa a todos os demais. Ninguém está só. Ninguém pode ser abandonado à própria sorte (Navai, 2022, p. 66).

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representou um marco fundamental na história das políticas públicas de saúde no Brasil e na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). O eixo central dos debates - "Saúde como direito de todos e dever do Estado" - posteriormente consagrado no Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, significou uma transformação paradigmática ao redefinir o conceito de saúde, que passou a ser compreendido não como simples ausência de enfermidades, mas como "completo bem-estar físico, mental e social" (BRASIL, 1988).

Esta ampliação conceitual implicou uma maior complexidade na compreensão do direito à saúde, que deixou de se restringir ao estado de doença para abarcar os múltiplos fatores que afetam a capacidade produtiva e a qualidade de vida dos trabalhadores. Nessa perspectiva, a saúde tornou-se indissociável de outros direitos fundamentais, como acesso à terra, moradia digna, alimentação adequada, educação de qualidade e meio ambiente equilibrado.

O SUS configura-se como um sistema organizado de forma descentralizada e participativa, estruturado principalmente sobre três princípios fundamentais que compõem sua matriz ideológica: universalidade, equidade e integralidade. Estes princípios transcendem a condição de meros dispositivos legais, representando um projeto civilizatório voltado à superação das profundas desigualdades históricas do país, o que Fleury (2012) conceitua como "cidadania sanitária".

A universalidade, como princípio norteador, vai estabelecer a saúde como direito de cidadania e dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para toda a população brasileira. Paim (2013)

identifica neste princípio uma conquista fundamental da Reforma Sanitária, representando uma ruptura paradigmática com o modelo anterior, caracterizado por sua natureza excludente, contributiva e seletiva, exemplificado pelo extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). O princípio da equidade, por sua vez, pressupõe a justa distribuição dos recursos de saúde considerando as desigualdades sociais e regionais existentes. Como demonstram Viacava et al. (2018) em estudos epidemiológicos, a equidade no SUS opera como mecanismo compensatório das iniquidades históricas, direcionando maiores esforços para populações em situação de maior vulnerabilidade. Teixeira e Vilasboas (2014) argumentam que este princípio representa uma inovação na política social brasileira, ao reconhecer que tratar desigualmente os desiguais é condição para a justiça social.

A integralidade, talvez o princípio mais complexo da tríade, conforme análise de Mattos (2009), compreende a articulação entre ações preventivas e curativas, a organização de redes de atenção à saúde e a abordagem holística do indivíduo. Pinheiro e Mattos (2006) destacam que a integralidade opera em três dimensões: como modo de organização dos serviços, como prática profissional e como experiência da pessoa. Este princípio desafia o paradigma biomédico hegemônico, propondo uma visão ampliada de saúde que incorpora seus determinantes sociais, conforme preconizado pela Carta de Ottawa (1986). A interação dialética entre esses três princípios é o que Campos (2003) denomina de "ideário da Reforma Sanitária", representando um projeto contra-hegemônico no campo das políticas sociais. Como demonstram Paim e Almeida Filho (2014), esta tríade principiológica diferencia o SUS de outros sistemas universais, incorporando tanto a tradição do *welfare state* europeu, quanto adaptações necessárias ao contexto brasileiro.

A análise histórica desenvolvida por Escorel (2008) revela como esta tríade ideológica emergiu do movimento sanitário dos anos 1970-1980, sintetizando demandas por democracia e justiça social. Entretanto, como argumenta Cohn (2018), a implementação destes princípios enfrenta desafios crescentes no contexto ultraliberal, marcado por restrições fiscais e pressões privatizantes. Os estudos de avaliação do SUS, como os conduzidos por Noronha et al. (2020), demonstram avanços significativos na cobertura populacional, mas também persistentes desigualdades no acesso e na qualidade

dos serviços. A tensão entre estes princípios fundantes e as condições materiais de sua implementação constitui o que Fleury (2012) denomina de "paradoxo brasileiro": um sistema universal em uma sociedade profundamente desigual. Portanto, para Paim et al. (2011), a realização plena desta tríade ideológica exigiria não apenas reformas no setor saúde, mas transformações estruturais na sociedade brasileira como um todo. Neste sentido, a análise da universalidade, equidade e integralidade transcende o debate sobre políticas de saúde, configurando-se como termômetro da própria democracia brasileira.

Nesse contexto, pode-se afirmar que há fortes indícios materiais para caracterizar o SUS como projeto pedagógico de nação, sobretudo pelo permanente processo de desestabilização política que ele enfrenta, já que, do ponto de vista econômico, o sistema configura um importante vetor de desenvolvimento, impulsionando cadeias produtivas no setor saúde, gerando empregos qualificados e fomentando inovações tecnológicas, conforme demonstra Bahia (2016). No plano social, assume função inclusiva ao garantir acesso universal em um contexto nacional marcado por profundas desigualdades regionais e estruturais (Viacava et al., 2018). Politicamente, o SUS se mantém como espaço de resistência às tendências privatizantes, sustentando-se como referência de garantia de direitos sociais mesmo em cenários ultraliberais adversos, conforme análise de Noronha et al. (2020).

A restrição do direito à saúde configura-se, desse modo, como um mecanismo de fragilização da classe trabalhadora, cujas consequências transcendem a esfera orgânica, isto é, o processo de adoecimento físico e mental decorrente dessa privação atua como fator de desmobilização social, comprometendo a capacidade de organização coletiva e de enfrentamento das desigualdades inerentes a uma sociedade marcadamente competitiva.

Os detentores do capital, que determinam as diretrizes da economia, têm interesse na desagregação social e na disseminação da ideologia individualista entre a classe trabalhadora, fazendo crer que a sobrevivência depende exclusivamente da competição individual, e não da solidariedade coletiva. As reformas do Estado, como observado, propagaram a noção de que a iniciativa privada seria a solução mais eficiente para determinados serviços públicos e justamente aqueles que demandam elevados investimentos estatais, como a saúde. Contudo, omite-se deliberadamente dos discursos oficiais que o setor

privado busca mercados financeiramente atrativos, nos quais é possível obter altos lucros com investimentos relativamente baixos. Na prática, as políticas administrativas recentes têm transferido, progressivamente, as responsabilidades sociais do Estado para o Mercado, convertendo direitos fundamentais em mercadorias. Esse processo é corroborado pelos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que registrou um aumento significativo na adesão a planos de saúde privados em 2023. Em dezembro daquele ano, o setor atingiu a marca inédita de 51.081.018 beneficiários em planos médico-hospitalares, enquanto os planos odontológicos contabilizaram 32.668.175 usuários. No comparativo anual, os planos médicos tiveram um incremento de 957.197 beneficiários, enquanto os odontológicos expandiram-se em 2.469.502. Em termos regionais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram o crescimento no segmento médico, enquanto São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul destacaram-se nos planos odontológicos.

A análise por faixa etária revela que indivíduos entre 45 e 49 anos foram os que mais aderiram a planos de saúde (240.716 novos beneficiários), seguidos pela faixa de 40 a 44 anos (183.201). No segmento odontológico, o mesmo padrão se repete, com incrementos de 281.144 e 253.934 beneficiários, respectivamente. Segundo Maurício Nunes, diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, esse crescimento está associado ao aquecimento econômico em 2023, com um aumento do PIB em aproximadamente 3% e a geração de 1,9 milhão de empregos formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Esse cenário impulsionou os planos coletivos empresariais, que passaram de 34,8 milhões para 36 milhões de beneficiários no mesmo período.

Entretanto, esse fenômeno não pode ser interpretado apenas como um reflexo do crescimento econômico, mas também como resultado do desmonte sistemático do sistema público de saúde, que, fragilizado, empurra a população para a esfera privada. A análise dos dados permite inferir que a extinção abrupta do Sistema Único de Saúde (SUS) não seria estrategicamente vantajosa para os líderes políticos. Em vez disso, uma desconstrução gradual desse sistema parece mais adequada, visando consolidar, no imaginário coletivo da população brasileira, a narrativa de sua ineficiência. A mercantilização da saúde reforça desigualdades, uma vez que o acesso a serviços de qualidade passa a depender

da capacidade de pagamento, em detrimento do princípio constitucional da universalidade. Assim, o aumento na procura por planos privados não representa necessariamente uma melhoria no bem-estar social, mas sim a consolidação de um modelo excludente, em que direitos fundamentais são submetidos à lógica do lucro.

3.1.2. O SUS: um projeto de (re)construção de existências

O SUS, instituído pela Constituição de 1988, representa um avanço significativo ao garantir acesso universal e gratuito à saúde para toda a população. No entanto, os desafios são imensos, desde a má distribuição de recursos até a necessidade de fortalecimento da atenção primária, que é a porta de entrada para a prevenção e o cuidado contínuo. A saúde pública no Brasil enfrenta problemas crônicos, como a falta de investimentos adequados, a carência de profissionais em áreas remotas e a superlotação de hospitais. Esses fatores impactam diretamente a qualidade do atendimento e a eficácia das políticas de prevenção de doenças. Além disso, o país ainda lida com a dupla carga de doenças: por um lado, as infecciosas, como dengue e tuberculose, e por outro, as crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, que exigem abordagens distintas e integradas. A importância da saúde pública no Brasil vai além do cuidado individual; ela está intrinsecamente ligada à redução das desigualdades sociais e ao fortalecimento da cidadania. Investir em políticas públicas eficazes, educação em saúde e infraestrutura é essencial para garantir um futuro mais equitativo e saudável.

O SUS foi concebido em um contexto distinto da lógica político-econômica capitalista e ultraliberal, tendo como fundamento a construção de um modelo de saúde pública baseado na participação ampla e articulada entre profissionais da saúde, gestores públicos e a sociedade civil. Essa estrutura foi pensada para consolidar uma rede de fortalecimento institucional, assegurando constitucionalmente a saúde como um direito fundamental. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, representa um marco regulatório desse princípio, ao estabelecer mecanismos formais de participação social na gestão do SUS e definir normas para transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Essa legislação prevê a existência de duas instâncias colegiadas em cada esfera de governo: as Conferências de Saúde, que se reúnem quadrienalmente para

avaliar a situação sanitária e propor diretrizes, e os Conselhos de Saúde, órgãos permanentes e deliberativos compostos por representantes do Estado, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, com funções estratégicas e fiscalizadoras. A paridade na representação dos usuários visa garantir equilíbrio no processo decisório.

Contudo, enquanto o SUS foi estruturado para fortalecer a participação social, enfrenta um cenário político-econômico que frequentemente busca minar esses mecanismos. Os Conselhos de Saúde, importantes para o controle social do sistema, vêm enfrentando desafios históricos, como a perda progressiva de autonomia, o desmantelamento de estruturas participativas e a redução de sua influência na formulação de políticas públicas. Esse processo foi intensificado durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), marcado pela desarticulação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com a diminuição de sua capacidade deliberativa, além de cortes orçamentários que limitaram a fiscalização e o atraso na realização de conferências nacionais. Em 2019, a edição do Decreto nº 9.759 representou um ponto crítico nesse processo, ao extinguir centenas de conselhos vinculados à Política Nacional de Participação Social e ao Sistema Nacional de Participação Social, reduzindo de aproximadamente 700 para menos de 50 esses espaços institucionais. Essa medida impactou profundamente a governança democrática, especialmente no campo da saúde pública. Francisco Batista Júnior, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde (2006-2011), em entrevista, destacou o caráter agressivo do decreto, que não apenas extinguiu colegiados, mas também impôs restrições à criação de novos espaços participativos (FIOCRUZ, 2019).

Batista argumentou que os conselhos exercem um papel estratégico no SUS, permitindo um diagnóstico preciso das dificuldades em diferentes níveis de gestão, a identificação de necessidades reais e a promoção de ações intersetoriais para o fortalecimento do sistema. A fragilização desses espaços compromete não apenas o controle social, mas a própria efetividade das políticas de saúde. Embora reconheça que os conselhos já enfrentavam limitações antes de 2019, ele avalia que o decreto aprofundou uma crise preexistente, inserindo-se em um projeto político-ideológico que marginaliza, ainda mais, o SUS. A amplitude da medida, capaz de atingir até mesmo conselhos instituídos por lei, configura um risco estrutural à democracia participativa. Essa análise revela uma

contradição estrutural entre o modelo participativo inerente ao Sistema Único de Saúde e as dinâmicas político-econômicas hegemônicas que sistematicamente o contestam. A erosão dos instrumentos de controle social configura não apenas um enfraquecimento institucional do SUS, mas uma regressão nos fundamentos democráticos que orientaram sua concepção original.

O período governamental sob a liderança de Bolsonaro exacerbou as características mais problemáticas do capitalismo contemporâneo, marcado por uma lógica excludente que se mostra incompatível com princípios democráticos e participativos. Nesse contexto, evidencia-se uma cisão fundamental no tecido social brasileiro: o distanciamento progressivo entre a cidadania e os processos decisórios estatais, fenômeno que compromete a própria natureza inclusiva das políticas públicas de saúde. Ainda que persistam narrativas que caracterizam a Constituição Federal de 1988 como um retrocesso para o país, discurso institucionalizado por Bresser-Pereira e ainda reproduzido em espaços como a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a discussão demanda uma abordagem mais profunda que a questão democrática introduzida pelo texto constitucional. É necessário investigar as raízes autoritárias que permanecem enraizadas na burguesia nacional, manifestando-se tanto no plano discursivo quanto nas estruturas materiais de poder.

Essas raízes autoritárias e tradicionais não se limitam à retórica de repúdio à democracia e a normalização da neoescravidão, expressada na precarização do trabalho e na persistência de condições análogas à escravidão, mas também se revelam no financiamento e no apoio político que sustentam sua institucionalização. A manutenção dessas estruturas evidencia uma contradição fundamental: não é possível consolidar um Sistema Único de Saúde universal e igualitário em um sistema capitalista que, por sua própria lógica, prioriza a acumulação privada em detrimento dos direitos sociais. Da mesma forma que não se pode alcançar o comunismo sem a superação do Estado burguês, uma vez que esse opera como instrumento de dominação de classe. A configuração atual do SUS reflete os limites estruturais e políticos impostos pelo contexto histórico brasileiro contemporâneo.

3.1.2.1 - Os Fundamentos da resistência: o SUS como pedagogia crítica e a formação da consciência

Parte-se do pressuposto de que a estrutura ultraliberal, embora fundamentada na individualidade, na exclusão e na produção de vulnerabilidades, não constitui um monólito impermeável ou homogêneo. A existência do Sistema Único de Saúde (SUS), um modelo deliberadamente social e democrático de política pública, evidencia a vigência de fissuras concretas no interior desse sistema.

O principal desafio analítico, portanto, talvez não resida apenas na identificação dessas contradições inerentes, mas sim na elaboração e consolidação de pedagogias críticas capazes de confrontar a hegemonia dominante. Tais pedagogias são fundamentais para ampliar e solidificar as fissuras necessárias à desestabilização do sistema. Nesse contexto, o SUS configura-se não apenas como um catalisador de pensamento crítico, mas como um espaço fértil para a geração de contra-hegemonia. Ao institucionalizar fóruns democráticos de debate e contestação das políticas de saúde hegemônica, o sistema atua no duplo movimento de frear as necropolíticas, mecanismos formativos que naturalizam e administram a morte, e fomentar a emergência de biosistemas, compreendidos como ecologias políticas e sociais comprometidas com a proteção e a ampliação da vida. Cabe salientar que a sustentação e o crescimento contínuo desses biosistemas dependem intrinsecamente de uma pedagogia crítica, relação essa que será examinada na seção subsequente.

Ao se introduzir a discussão sobre pedagogia engajada, crítica ou transformadora, a obra de Paulo Freire destaca-se como um marco fundante e referência incontornável. Seu aporte teórico-metodológico radicaliza a própria noção de educação ao concebê-la não como um gesto de depósito de conteúdos, mas como um ato político e um exercício de liberdade. Freire dedicou-se a uma *práxis* reflexiva, termo que sintetiza a indissociabilidade entre ação e reflexão, posicionando-se explicitamente como um sujeito comprometido com a transformação da realidade material opressora. Em sua epistemologia, estudada por Guareschi (2024), o conhecimento é construído dialeticamente, no mundo e com o mundo, tendo como finalidade última a humanização de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Na literatura especializada, é consensual que as pedagogias de caráter crítico e transformador, herdeiras desse legado

freireano, constituem instrumentos fundamentais para a modificação dos sujeitos por meio de processos de conscientização (ou *consciencição*). Tais processos propiciam, de modo indissociável, tanto a reflexão profunda sobre o mundo quanto a ação efetiva para sua transformação. Essa transformação ocorre precisamente quando os indivíduos se inserem como agentes ativos de mudança, capazes de modificar suas realidades dentro do *continuum* histórico. Por constituir um processo histórico, essa trajetória de emancipação está distante de ser linear ou unidirecional, caracterizando-se antes por contradições, avanços e refluxos.

Guareschi (2024) identificou, no pensamento de Paulo freire, a existência de distintos níveis de consciência que podem desembocar não necessariamente em uma postura crítica, mas sim em formas de consciência ingênua que, por sua vez, podem evoluir para estágios reacionários, manifestando-se particularmente na conformação de uma consciência autoritária. Esse legado intelectual de Paulo Freire constitui-se não apenas em suas obras, mas também em pistas, registros e proposições para o debate acerca da importância da inserção crítica no mundo. Não é espantoso que Freire tenha sido forçado ao exílio durante o regime militar, uma vez que suas reflexões se centravam em formas de questionar, construir e reconstruir a democracia brasileira. Assumo aqui a necessidade de abrir um parêntese analítico para discutir, ainda que de forma sintética, as persistentes estruturas autoritárias enraizadas na burguesia brasileira, as quais nela se retroalimentam, e que nos fornecem elementos explicativos fundamentais para compreender a resistência ativa desse grupo social à ampliação dos direitos sociais.

Schwarcz (2019), em sua obra, apresenta um dado relevante sobre a construção da narrativa histórica do Brasil. Com a chegada da corte portuguesa, foram estabelecidas diversas estruturas institucionais, como a Academia Real Militar (1810), o curso de Agricultura (1814) e a Real Academia de Pintura e Escultura (1820), que conferiam diplomas profissionais, funcionando como mecanismos de acesso ao mercado de trabalho. Posteriormente, em 1838, após a independência política, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), cujo objetivo explícito era elaborar uma narrativa histórica que exaltasse o passado nacional sob uma perspectiva patriótica. O primeiro concurso público promovido pela instituição tinha como tema “como se deve escrever a história do

Brasil”, deixando evidente o projeto de construção de uma nova historiografia alinhada aos interesses do Estado, não restando dúvidas; tratava de criar uma *outra* história.

De acordo com a autora, a narrativa escolhida sobre a identidade brasileira foi consolidada a partir da visão de Karl von Martius, cientista estrangeiro que propôs uma representação idealizada do país. Em seus escritos, Martius descreveu o Brasil como fruto de uma harmoniosa mistura de povos, enfatizando um suposto caráter pacífico das relações étnico-raciais. Nesse contexto, atribuía à herança portuguesa a função de "purificar" a mestiçagem decorrente da presença indígena e africana. Essa narrativa, no entanto, encobre a realidade histórica da escravidão secular e do extermínio sistemático das populações originárias. Em vez de oferecer uma análise crítica e fundamentada nos fatos históricos, o discurso de Martius privilegiava uma visão edênica e tropicalista do território brasileiro, apagando os aspectos de violência estrutural e de dominação. Apresentava-se, assim, uma nação cuja suposta felicidade residiria na capacidade de integrar diferentes culturas de forma harmônica e unificada, ignorando as profundas desigualdades e conflitos que marcaram e, ainda marcam, a formação social do país.

Na obra "A Elite do Atraso", o sociólogo Jessé Souza (2017) argumenta que a elite brasileira se perpetuou no poder utilizando-se de mecanismos institucionais, culturais e econômicos oriundos da escravidão. Souza critica a narrativa liberal que exime as elites atuais de responsabilidades históricas, ao mesmo tempo que denuncia a naturalização das desigualdades sociais como herança direta do escravismo. Para o autor, a elite brasileira não apenas herdou o capital econômico dos seus antepassados escravocratas, mas também a lógica de exclusão e exploração que sustentou a escravidão.

A investigação conduzida pelo Projeto Escravizadores, iniciativa da Agência Pública com financiamento do *Pulitzer Center*, evidencia a persistência de estruturas históricas de poder no Brasil contemporâneo, demonstrando que ao menos 33 autoridades brasileiras possuem antepassados diretamente vinculados à escravidão. O estudo de 2024, que mapeou genealogias de 116 figuras políticas em cargos executivos e legislativos, identificou que aproximadamente metade dos presidentes pós-ditadura militar, quase metade dos atuais governadores estaduais e um quinto dos senadores descendem de

proprietários de escravizados, participantes do tráfico negreiro ou agentes responsáveis pela repressão a revoltas de pessoas negras e pobres durante o período colonial e imperial.

Os casos identificados abrangem desde o uso de mão de obra escravizada em empreendimentos agropecuários até transações comerciais envolvendo compra, venda e aluguel de pessoas escravizadas. Conforme assinala o estudo, a escravidão não era restrita a grandes proprietários, mas permeava diversos estratos sociais, incluindo comerciantes e pequenos agricultores que utilizavam um ou dois escravizados para produção de subsistência ou mercado local. Entre os casos emblemáticos documentados, destaca-se o do ex-presidente José Sarney, cujo quinto avô, Manuel de Sousa Martins (visconde da Parnaíba), utilizou trabalho escravizado em fazendas de pecuária no Piauí, consolidando uma linhagem familiar que remonta a Valério Coelho Rodrigues, denominado "patriarca do sertão" no século XVIII. Já o ex-presidente Itamar Franco possui em sua ascendência Vicente Ferreira Franco, que participou de transações envolvendo pessoas escravizadas, incluindo uma jovem de 16 anos oferecida como garantia em operação financeira. No caso de Fernando Collor, a investigação revelou vínculos familiares com territórios do antigo Quilombo dos Palmares, onde antepassados teriam utilizado mão de obra escravizada.

A árvore genealógica de Fernando Henrique Cardoso apresenta nuances complexas: se por um lado o ex-presidente reivindica ascendência negra através de sua trisavó potencialmente escravizada, por outro descende do coronel José Manoel da Silva e Oliveira, que comandou expedições com uso de trabalho escravizado em Minas Gerais e Goiás, resultando em mortes trágicas durante atividades mineradoras. Entre autoridades contemporâneas, identificam-se casos como o do senador Marcos do Val, cujo tataravô Matheus Gomes do Val possuía escravizados na Fazenda da Cachoeira Alegria; do governador Tarcísio de Freitas, cuja trisavó Ana Rosalina Pacheco de Freitas teve pelo menos três mulheres escravizadas; da senadora Soraya Thronicke, cujo tataravô Albino Jacinto de Oliveira deixou sete pessoas escravizadas em inventário; e do governador Romeu Zema, com ascendência em Silvério Antônio de Freitas, que possuía três escravizados domiciliados na Freguesia de Franca em 1819. A investigação ressalta que a subnotificação é provável devido à escassez

documental e dificuldades de acesso a registros históricos, sugerindo que o número real de autoridades com antepassados escravizadores possa ser superior aos 33 identificados.

Este estudo desvela as bases não meritocráticas dos privilégios burgueses, demonstrando sua gênese em uma herança escravocrata. Nesse sentido, elucidam-se as razões estruturais da resistência das elites capitalistas à ampliação de direitos sociais: tal posicionamento deriva do fato de que sua acumulação primitiva e sua trajetória de sucesso econômico foram edificadas sobre a exploração e a sistemática precarização do trabalho. A investigação evidencia, outrossim, a intrínseca conexão entre a desigualdade estrutural brasileira e continuidades históricas, as quais se manifestam na notável permanência de linhagens familiares, patrimônios e influências políticas desde o período escravista. Ao evidenciar a incompletude do processo abolicionista quanto à redistribuição de poder e à concretização da justiça social, torna-se imperativa a implementação de políticas reparatórias e a revisão crítica do imaginário nacional como condições fundamentais para o enfrentamento das desigualdades historicamente constituídas no Brasil.

Com base na análise de Pedrinho Guareschi (2024) acerca dos escritos de Paulo Freire, em especial sobre os níveis de consciência nas sociedades, identifica-se uma convergência entre a perspectiva freiriana e as revelações do “Projeto Escravizadores”: a impossibilidade de separação entre as questões éticas e os propósitos humanos. Conforme assinala Freire, “somos seres éticos”, isso implica que nenhuma ação ou reflexão alheia a uma prática ética é capaz de formar sujeitos dotados de consciência crítica. Uma sociedade historicamente alicerçada na escravidão, por exemplo, operou por meio da negação sistemática da ética. Atualmente, segmentos expressivos da ordem ultraliberal reatualizam essa negação, substituindo-a pela primazia da eficiência, um movimento que se tornou particularmente visível durante a pandemia. A necessidade da idiossujetivação é fundamental para a manutenção do *status quo* social, uma vez que inibe o questionamento crítico sobre a construção histórica das desigualdades. Quando cessa a problematização das estruturas sociais, isto é, quando se deixa de indagar as razões pelas quais a ordem se configura tal como é, abre-se espaço para análises pretensamente neutras, as quais atendem e são incentivadas pelo sistema ultraliberal. Essa suposta neutralidade, contudo, é

veementemente contestada por Paulo Freire, por demandar uma consciência ingênua que naturaliza a ordem social, interpretando-a como algo pré-estabelecido, imutável e resultado de contingências, em vez de produto de relações de poder e escolhas políticas.

No momento em que se compreende que a estrutura social resulta da síntese das ações de uma classe específica, a neutralidade perde sua função operante. Diante dessa constatação, torna-se imperativa a substituição da postura neutra por uma teoria da ação consciente, a qual reconhece que toda prática se constitui nas relações sociais, tornando, assim, a inação uma impossibilidade política. A sociedade constitui-se histórica e dialeticamente, e sua forma atual é produto intencional da vontade e dos interesses de grupos determinados.

A obra de Paulo Freire indica caminhos pedagógicos para o desenvolvimento do pensamento crítico. Para alcançar esse estado de autonomia, é imprescindível adotar uma postura interrogativa, capaz de identificar e desvelar as amarras sociais e as ingenuidades que restringem a consciência. Nessa perspectiva, a busca por liberdade não se configura como um ponto de chegada definitivo, mas sim como a conquista de uma inquietação permanente, inerente ao processo contínuo de humanização. É por meio do ato de perguntar que se instiga a reflexão crítica sobre si mesmo e sobre as estruturas do mundo circundante. Dessa forma, a pedagogia crítica freiriana consolida-se, efetivamente, como uma pedagogia da pergunta, da indagação constante e da contestação, posicionando-se diametralmente oposta a modelos que visam a busca por certezas.

Este debate resgata os fundamentos da saúde pública brasileira. O ideal que orientou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) operacionalizou o debate contínuo como mecanismo de aprimoramento do sistema, incorporando ativamente às políticas públicas a realidade das periferias. Tais territórios são, majoritariamente, habitados por populações negras, que ainda carregam as sequelas do período escravocrata brasileiro.

Dessa forma, efetivar os princípios da universalidade, gratuidade e equidade em um país de profundas desigualdades significa, necessariamente, dar voz e ouvidos aos historicamente excluídos. O SUS, em sua estrutura,

configura-se como uma potente força motriz para o desenvolvimento da consciência crítica por meio da democratização do debate sobre saúde.

Sua descentralização, materializada na localização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas às comunidades trabalhadoras, performa um ato de inclusão. Ao levar o Estado até essas populações, o SUS as integra simbolicamente e concretamente em uma estrutura da qual antes se encontravam à margem, promovendo seu reconhecimento como sujeitos de direitos dentro da sociedade. O autorreconhecimento do indivíduo como integrante da sociedade funciona como um catalisador para o exercício da cidadania ativa. Essa condição possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico e inquisitivo em relação às políticas públicas, fomentando uma postura mais participativa.

Esse engajamento, por sua vez, tem o potencial de expandir-se para além da esfera da saúde, gerando questionamentos e demandas por transparência e eficiência em outras dimensões do Estado, como as áreas sociais, econômicas e políticas. Desse modo, o processo de inclusão social constitui a base para a ampliação do debate democrático em todas as instâncias da vida pública.

Esses questionamentos são fundamentais para fomentar uma análise crítica de ordem estrutural, especialmente em um contexto nacional que, historicamente, limita a formação de uma cidadania verdadeiramente contestadora. Tais indagações permitem problematizar as profundas disparidades que persistem nas instâncias de poder.

Um exemplo paradigmático dessa contradição é a composição do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro. Como é possível que, em uma sociedade plural e diversa, a mais alta corte do país seja integrada por apenas uma mulher e nenhuma pessoa negra? A mera observação desses dados já evidencia um profundo *deficit* de representatividade.

É crucial, ainda, analisar o peso semântico do termo "Supremo". O adjetivo, que denota a mais alta hierarquia e poder, opera como um espelho simbólico da estrutura social. A homogeneidade racial e de gênero nesse espaço exemplifica, de forma concreta, como a linguagem e as instituições consagram e perpetuam os valores de uma sociedade machista, sexista e racista. Não encontraremos respostas para tais questionamentos em fenômenos isolados ou contemporâneos. Elas estão fundadas em um passado colonial e escravocrata,

cujas estruturas de poder, que privilegiam um grupo específico em detrimento de outros, continuam a reverberar intensamente no presente, moldando as instituições e mantendo as desigualdades.

A compreensão do campo da saúde demanda o reconhecimento de que se trata, fundamentalmente, de um espaço de tensões e conflitos estruturais. Neste cenário, exige-se dos profissionais vidas re-existent – um conceito cunhado por Arroyo (2023) para definir a contínua luta e resistência daqueles que, historicamente marginalizados, precisam constantemente reafirmar sua existência e seu direito à cidadania plena frente a um sistema opressivo. A materialidade mais crua dessa luta de classes e raças se expressa nas políticas de privatização, que segmentam o acesso e consagram a existência de um sistema dual: uma saúde para ricos e outra para pobres. Este *apartheid* sanitário não é espontâneo; é a manifestação concreta de um projeto político que naturaliza as iniquidades.

Na prática, observa-se que a saúde pública no Brasil tem sido progressivamente direcionada para o atendimento das classes mais pobres. Paradoxalmente, é justamente neste segmento, o que mais demanda cuidado integral e qualificado, que se concentra o maior contingente de servidores públicos com formação não-médica (por exemplo, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de limpeza, entre outros), notoriamente subvalorizados e com remuneração aviltante.

Os dados demográficos apresentados no início do capítulo, que apontam que 77% da população nordestina é usuária exclusiva do SUS, concomitantemente à posição da região como detentora da segunda menor renda *per capita* do país, revelam muito mais do que uma simples disparidade socioeconômica. Evidenciam uma profunda e crítica dependência da população em relação ao sistema público de saúde. Diante dessa realidade, a implementação de políticas ultraliberais de contingenciamento de gastos na saúde transcende a mera gestão econômica; configura-se como uma política deliberada de aniquilação. Essa não é uma aniquilação restrita à esfera física, pela negligência assistencial, mas também uma aniquilação política e social, que visa extinguir o direito à vida digna e à cidadania daqueles que já se encontram em situação de vulnerabilidade sistêmica.

Essas políticas visam a uma meta mais profunda e perversa: a morte do espírito questionador. Trata-se de um empreendimento de asfixia da capacidade crítica, que é o último reduto de resistência dos oprimidos. Sem a possibilidade de questionar, de indignar-se e de imaginar alternativas, a própria noção de humanidade é esvaziada.

É precisamente neste contexto que se faz imperativo resgatar, conforme propunha Walter Benjamin, as "vozes abafadas da história dos oprimidos". A humanidade plena, que se define pela busca por respeito e pela possibilidade de múltiplas existências, não pode ser construída sobre o silenciamento. Ela só pode ser reivindicada e trabalhada a partir da escuta radical dessas vozes silenciadas e da incorporação de suas narrativas ao centro do debate político. O direito à saúde, portanto, é inseparável do direito à voz e à consciência crítica. A luta pela preservação do SUS é, simultaneamente, uma luta contra a morte do espírito, uma defesa intransigente da capacidade humana de questionar, sonhar e existir para além da mera sobrevivência.

3.1.2.2 - As Humanidades e a luta por existências plenas

É possível afirmar que partilhamos uma mesma concepção de humanidade? Que fundamentos delineiam a noção de humanidade que sustentamos? Retrocedendo ao período da descoberta das Américas, é plausível inferir a existência de uma clara disparidade na atribuição de humanidade entre colonizadores e colonizados. Ao longo de séculos, os povos indígenas foram representados como desprovidos de alma e, conseqüentemente, destituídos de humanidade. O dualismo que permeia a sociedade contemporânea mantém-se análogo ao de outrora, perpetuando uma constante distinção entre aqueles que são considerados humanos e aqueles que são desumanizados.

Os europeus, enquanto agentes colonizadores, autoproclamaram-se como portadores exclusivos de humanidade, baseando-se em supostos atributos de inteligência e racionalidade. Contudo, cabe questionar: a que inteligência e racionalidade se referiam? Esses critérios, longe de serem universais, serviram como instrumentos de exclusão e dominação. Os "Outros", aqueles negados a condição de não humanos, foram sistematicamente declarados destituídos de cultura e de natureza humana. Esse processo de desumanização foi

intensamente vivido pelos povos africanos, escravizados e violentamente privados de sua condição humana perante os colonizadores. Diante desse legado, torna-se imperativo refletir criticamente sobre qual humanismo pedagógico orienta nossas práticas educativas e fundamenta nossas pedagogias. Que projeto de humanidade desejamos construir pedagogicamente?

Reconhecer os Outros, sistematicamente silenciados e permanentemente resistentes, exige o reconhecimento da diversidade pedagógica e das múltiplas matrizes de humanização que perpassam a história. Acompanhados pelas reflexões de Miguel Arroyo, adentramos uma discussão densa e complexa, fundamental para a compreensão posterior do conceito de necropedagogia. Encontramo-nos, assim, diante de uma concepção hegemônica, fechada e única de formação humana, que opera pela negação da humanidade de outras existências, particularmente das vidas re-existent De Outros.

As teorias pedagógicas, a história da educação, as identidades docentes/ educadoras são obrigadas a ultrapassar o limiar das culturas, dos paradigmas duais, abissais de humano, colonial e até republicano-democrático e tentar entender o drama político, ético que acompanha os Outros, a diferença em vidas ameaçadas, não vivíveis porque decretados com deficiência originária de humanidade. A essa radicalíssima desumanização os Outros resistiram e re-existiram afirmando-se humanos (Arroyo, 2023, p 14).

Na contemporaneidade, a categoria dos Outros continua a abranger grupos sociais sistematicamente marginalizados do paradigma do "humano único", um constructo hegemônico fundado em ideais eurocêntricos, brancos, masculinos, cristãos, racionais e proprietários. Esse modelo opera por meio de mecanismos persistentes de inferiorização e negação da alteridade, sustentando hierarquias que perpetuam a exclusão. Entre tais grupos, encontram-se os povos indígenas das Américas, historicamente representados como selvagens e privados de alma, conforme narrativas coloniais que os relegavam à sub-humanidade; os povos africanos escravizados, reduzidos a meras mercadorias ou força bruta, com negação de sua história, cultura e racionalidade; e as mulheres, associadas à natureza e à emoção, em oposição dicotômica e depreciativa à cultura e à razão masculinas.

A essa lista somam-se as populações pobres e periféricas, frequentemente estigmatizadas como incivilizadas ou perigosas em contextos de marginalização socioeconômica, e as pessoas com deficiência, medicalizadas e

interpretadas sob um viés patologizante que as representa como incompletas ou defeituosas ante um padrão normativo corporal. Tais coletivos permanecem submetidos a processos de exclusão simbólica e material, embora resistam e reexistam, afirmando outras formas de humanidade e desafiando as estruturas que os oprimem. Paulo Freire, em sua reflexão sobre a condição dos oprimidos, aborda profundamente o processo de desumanização a que estão submetidos. Ele enfatiza que a luta constante pela presença e resistência em contextos desfavoráveis representa um ato de reinserção na história e de afirmação da própria humanidade. Essa atitude desafiadora estabelece um precedente crucial para a construção de uma pedagogia alternativa e de uma matriz distinta de humanização, fundamentada na experiência e na perspectiva daqueles que foram historicamente marginalizados.

As vidas re-existent por vida têm sujeitos: os oprimidos em vidas ameaçadas pelo necropoder expondo a dor, o sofrimento o inumano sobreviver em estruturas opressoras como a matriz primeira de negação da humanidade. Coletivos sociais, étnicos, raciais, de gênero, orientação sexual, classe que em vidas re-existent expõem as re-existências como matriz histórica perene de afirmação de sua humanidade na história (Arroyo, 2023, p.16).

A ideia de Arroyo vai muito além do conceito tradicional de "resistência", enquanto a resistência implica em opor-se a algo, uma reação a uma força externa, a re-existência é um ato positivo, criativo e afirmativo. É a arte de existir novamente (re-existir) e existir de outra maneira em condições que foram projetadas para negar essa própria existência.

Nesse sentido, a proposta do autor configura um poderoso quadro teórico que inverte a lógica da opressão. Arroyo argumenta que a humanidade dos grupos oprimidos não é uma concessão do sistema dominante, mas sim um atributo constantemente reafirmado e reinventado por eles mesmos por meio da re-existência. Sob essa ótica, a história da humanidade é também a história dessas incontáveis e perenes re-existências. Consequentemente, ela não é apenas moldada pelo poder de negar vidas (o necropoder), mas é definida, sobretudo, pela força incontestável de re-existir, isto é, de criar vida, cultura, dignidade e futuro onde só era suposto haver morte e silêncio. A re-existência emerge, portanto, como a prova definitiva da humanidade indomável desses coletivos.

A luta por uma educação inclusiva e igualitária emerge dialeticamente da realidade concreta da exclusão e da desigualdade. Essa demanda não é um ideal abstrato, mas uma resposta material à condição de grupos historicamente desumanizados. O paradoxo central reside no fato de que os "excluídos", frequentemente os grupos socioeconômicos mais vulneráveis que constituem a base produtiva da economia, são simultaneamente fundamentais para o funcionamento do sistema e negados em sua plena humanidade por ele.

Nesse contexto, o próprio ato de proclamar a necessidade de "igualar humanos" é um ato político radical, pois explicita o reconhecimento de que a estrutura social vigente opera a partir de uma classificação hierárquica da humanidade. Ao afirmar que alguns devem ser "incluídos" ou "igualados", desvela-se que a norma existente os constitui, na prática, como não-humanos ou sub-humanos, termo que ecoa a concepção de necropoder de Achille Mbembe: o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer social, política e economicamente. Como retomado no primeiro capítulo deste trabalho, a análise de Rubens Casara sobre o "sujeito idiota" revela uma figura crucial para a perpetuação do sistema ultraliberal: um indivíduo que, mesmo sendo usurpado em sua existência, persiste na crença de que sua valorização econômica será suficiente para prosperar na lógica social vigente. Esse sujeito, caracterizado pela ausência de pensamento crítico e pela incapacidade de refletir sobre suas próprias opressões, frequentemente reproduz mecanismos de dominação contra outros grupos igualmente oprimidos. Tal condição não é acidental, mas resulta diretamente de bases pedagógicas que operam para diminuir a humanidade dos excluídos e consolidar sua idiotização sistêmica.

Diante desse cenário, a construção de uma pedagogia verdadeiramente humanizadora, nos moldes propostos por Miguel Arroyo, exige a compreensão crítica dos processos que produzem e reproduzem a desumanização. Enquanto a pedagogia hegemônica tende a enclausurar-se em componentes curriculares estanques, tratando disciplinas como português e matemática como fins em si mesmas, uma perspectiva arroyana e freiriana coloca no centro do projeto educativo a reflexão sobre a condição humana, especialmente em contextos marcados pela negação sistemática da humanidade de sujeitos e grupos sociais.

Arroyo convoca, assim, a um movimento pedagógico análogo ao do pediatra que, para cuidar integralmente da criança, dialoga com aquela que a

conhece em sua totalidade: a mãe. Do mesmo modo, o educador deve empenhar-se em conhecer profundamente os sujeitos com os quais trabalha: suas histórias, vivências, temporalidades e condições existenciais. Trata-se de investigar em qual "tempo humano" esses indivíduos se situam, reconhecer suas trajetórias e decifrar as condições (humanizadas, desumanizadas ou inumanas) que conformam suas existências. Somente a partir desse reconhecimento será possível fundar uma prática educativa que não apenas afirme a humanidade de todos, mas que também combata os mecanismos, dentre os quais se inclui a produção do "sujeito idiota", responsáveis por negá-la.

O debate educacional contemporâneo configura-se em torno de um tensionamento fundamental entre projetos formativos antagônicos, que disputam sentidos e finalidades para a formação de subjetividades. Este embate manifesta-se na dialética entre a constituição da idiosubjetivação do sujeito, categoria analítica que designa o indivíduo despolitizado, funcional à reprodução das estruturas hegemônicas, e a formação da pessoa crítica, capaz de decifrar e transformar suas condições de existência. De um lado, persiste um paradigma instrumental que reduz o processo educativo à preparação para o mercado de trabalho, subordinando a formação humana às demandas do capital e produzindo subjetividades adaptadas à lógica mercantil. De outro, consolida-se uma perspectiva humanizadora, que concebe a educação como prática integral de desenvolvimento do ser humano em sua complexidade histórica, social e existencial, visando à emancipação política e ao fortalecimento da autonomia crítica. Essa contraposição reflete, em última instância, projetos societários antagônicos: enquanto o primeiro modelo reforça a manutenção das estruturas vigentes de poder e exclusão, o segundo propõe-se a fomentar a transformação social através da formação de sujeitos capazes de questionar, intervir e reimaginar o mundo.

A crítica à educação como preparação "para" o mercado encontra fundamentação teórica sólida na tradição da pedagogia "Do Outro", já que a verdadeira função educativa não reside em moldar indivíduos para demandas econômicas transitórias, mas em reconhecer e desenvolver plenamente o ser humano que "já é", em sua temporalidade específica e condições existenciais concretas. Como argumenta Arroyo, a educação deve operar uma "virada

copernicana" que coloque no centro do processo educativo o sujeito em sua humanidade já existente, e não projeções futuras de utilidade econômica.

Esta reflexão adquire especial urgência no contexto do Estado capitalista contemporâneo, onde o agronegócio e o mercado tendem a reduzir a vida à condição de mercadorias. A lógica da mercantilização, quando transposta para o campo educacional, produz uma distorção fundamental: transforma o direito à educação em mero investimento em capital humano, e os estudantes em produtos a serem ajustados às demandas do mercado. Se não aceitamos esta redução da pessoa à condição de recurso produtivo, consequentemente não podemos conceber uma educação que forme jovens e adultos para se comportarem como mercadorias no grande mercado da vida.

A reforma do ensino médio (Lei nº 13.415/2017) exemplifica esta tensão paradigmática. O modelo anterior, embora limitado em muitos aspectos, mantinha como horizonte ideal a formação integral e o acesso ao ensino superior. O novo modelo, ao contrário, com sua ênfase nos itinerários formativos e na flexibilização curricular, parece orientar-se explicitamente pela lógica da capacitação para o mercado. O discurso do "projeto de vida", central na reforma, frequentemente esconde uma adaptação às limitações estruturais de um sistema que não pode garantir acesso universal à universidade, canalizando assim as expectativas juvenis para uma inserção precoce no mundo do trabalho.

Esta orientação representa mais do que uma mudança curricular: configura uma transformação na própria concepção de educação e de sujeito. Ao privilegiar competências técnicas em detrimento de formação crítica e cidadã, corre-se o risco de formar técnicos competentes, mas cidadãos incapazes de questionar as estruturas sociais que produzem desigualdade e exclusão. Como alertava Adorno, a educação após Auschwitz deve formar seres humanos que não se deixem levar pela barbárie, objetivo incompatível com uma formação reduzida à empregabilidade.

A superação desta contradição exige repensar radicalmente os fundamentos da prática educativa. Uma educação verdadeiramente humanizadora deve recusar a ditadura do utilitarismo econômico e afirmar seu compromisso com o desenvolvimento integral da pessoa humana. Isto implica reconhecer os estudantes em sua condição histórica concreta, valorizar seus saberes experienciais e cultivar não apenas competências técnicas, mas

também capacidade crítica, sensibilidade estética, consciência ética e engajamento político. Como ressalta Arroyo (2023), o desafio contemporâneo consiste em construir uma educação que não prepare para a vida, mas que já seja, em si mesma, vida plena no presente, uma educação que não adie a humanização para um futuro mercadológico, mas que afirme, aqui e agora, a dignidade incontível de cada ser humano em seu tempo histórico. Além dessa reforma do Ensino Médio, que introduziu significativos obstáculos à consolidação de bases pedagógicas orientadas para a formação de sujeitos críticos, as escolas cívico-militares emergem como mais um dispositivo de supressão de projetos educativos fundados numa pedagogia da re-existência.

A fundamentação central para a militarização escolar assenta-se na premissa de que pedagogias democráticas mostram-se incapazes de educar as chamadas "infâncias violentas", demandando, portanto, a intervenção militar como remédio disciplinar. Tal perspectiva configura uma manifestação de criminalização da infância e juventude pobre, majoritariamente negra e periférica, partindo do pressuposto equivocado de que estes jovens possuem uma violência intrínseca e que apenas métodos coercitivos seriam capazes de contê-los.

Este discurso, contudo, omite deliberadamente a natureza multifatorial da violência escolar, a qual mantém íntima correlação com condições de vulnerabilidade social que transcendem os muros das instituições de ensino. A militarização educacional opera como mecanismo de evasão estatal em relação às suas responsabilidades sociais e educacionais, transferindo para a lógica militar problemas estruturais que demandariam políticas públicas redistributivas e inclusivas. A própria racionalidade subjacente às escolas cívico-militares revela-se profundamente excludente: parte do pressuposto de que jovens de territórios periféricos seriam naturalmente violentos e que pedagogias democráticas seriam incapazes de educá-los. Esta construção discursiva não apenas criminaliza a infância pobre, mas opera uma desumanização simbólica ao sugerir que a presença armada seria o único meio eficaz de educar essas populações. Tal abordagem representa a antítese de projetos educativos emancipatórios, na medida em que substitui o diálogo pela coerção, a reflexão crítica pela obediência cega, e a construção coletiva pelo autoritarismo hierárquico.

É importante ressaltar a noção das totalidades humanas corpóreas como imperativo categórico para as práticas educativas e formativas que Arroyo debate, criticando a tendência histórica de privilegiar o trabalho sobre as mentes em detrimento dos corpos, como se estes fossem meros suportes materiais do cognitivo. Essa perspectiva assume especial relevância na formação de trabalhadores da saúde. Os corpos que chegam aos serviços de saúde não se reduzem a organismos biológicos, conjuntos de sintomas ou casos patológicos a serem reparados. Representam, antes de tudo, totalidades humanas corpóreas – sujeitos históricos, sociais e culturais, portadores de narrativas, sofrimentos, saberes e expectativas. Consequentemente, formar profissionais de saúde sob essa ótica exige uma pedagogia capaz de superar o dualismo cartesiano mente/corpo, compreendendo a saúde como fenômeno integral, indissociável das condições existenciais e materiais. Tal abordagem prepara os profissionais para acolher, escutar e tratar pessoas em sua plenitude humana, transcendendo a mera diagnose de doenças em corpos-objeto. Deste modo, a formação técnica deve necessariamente articular-se com uma formação humana, ética e política, consciente da dignidade e complexidade inerentes a cada sujeito que busca cuidado.

Conforme já foi anteriormente abordado neste debate, a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) emerge como um marco fundamental para a construção do SUS, ao ampliar radicalmente o conceito de saúde e instituí-lo como um direito de cidadania. Retomando e ampliando essa premissa inicial, é crucial reafirmar que o SUS se consolida muito além de uma simples rede de atendimento médico; ele se projeta como um verdadeiro projeto societário que enuncia uma concepção específica de ser humano. Esta concepção, gestada naquele momento histórico e em diálogo com pensadores da educação e dos direitos humanos, vislumbra o indivíduo como uma totalidade humana – categoria esta que percebe que o sujeito de direitos é indivisível, não podendo ser fragmentado em dimensões econômicas, sociais, biológicas e espirituais estanques. Sob essa ótica, a saúde é um direito integrador, fundamental para a realização dessa totalidade em sua plenitude.

É precisamente nesta qualidade de projeto civilizatório, que vê os cidadãos como totalidades humanas concretas, que o SUS se erige como uma barreira contrária à lógica reducionista do sistema econômico dominante.

Este sistema, ao operar pela fragmentação do indivíduo em meros papéis de produtor e consumidor, nega sua condição integral e, com frequência, opera pelo enfraquecimento da força de trabalho. Em uma perspectiva que privilegia a produtividade acima da reprodução social da vida, a saúde do trabalhador é comumente negligenciada ou tratada como um custo a ser minimizado. Nesse sentido, retoma-se o debate para enfatizar que restringir o direito à saúde, seja por via do subfinanciamento, da precarização dos serviços ou da mercantilização, constitui um mecanismo eficaz de fragilização sistêmica da classe trabalhadora, pois ataca diretamente a sua condição de totalidade.

As implicações desse processo são profundamente incapacitantes. O adoecimento resultante não é meramente físico, mas um comprometimento de toda a totalidade humana, afetando suas dimensões mental, social e existencial, gerando um ciclo de sofrimento e desmobilização. A exaustão, o desânimo e a alienação decorrentes da falta de um sistema de apoio robusto corroem a capacidade de agência e a potência política dos indivíduos. Em uma sociedade que incessantemente convoca seus membros a uma competição desenfreada, a debilitação da saúde opera como um fator de contenção, minando a energia vital necessária para a organização coletiva e para o enfrentamento das lutas inerentes à transformação social.

3.1.2.3. Um novo princípio surge no SUS: a atenção humanizada

O adoecimento físico consolida-se frequentemente a partir da negação da condição humana fundamental: o direito de adoecer e de ter dignidade no processo de cura. Essa negação atinge especialmente populações vulnerabilizadas, para as quais a doença não é apenas um evento biológico, mas uma experiência marcada pela precarização do cuidado e pela violação de direitos básicos. Embora o SUS enfrente desafios históricos de subfinanciamento, filas para procedimentos e desigualdades no acesso, ele permanece como um contraponto essencial à lógica mercantilizada da saúde, afirmando-se como espaço de resistência e garantia de direitos.

Nesse contexto, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) emergem como pilares estratégicos no enfrentamento do adoecimento psíquico no Brasil. Sua relevância tornou-se ainda mais evidente diante do agravamento da crise de saúde mental, amplificada pela pandemia de COVID-19, por transformações

precarizantes no mundo do trabalho e por determinantes sociais como desigualdade e exclusão. Estudos e dados epidemiológicos recentes (G1, 2025a) apontam para um cenário alarmante: em 2024, o Brasil registrou um recorde histórico de afastamentos por transtornos mentais, totalizando 472.328 licenças médicas concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um aumento de 68% em relação a 2023, quando foram registrados 283 mil afastamentos (Agência Brasil, 2025a). Esse é o maior patamar da última década, conforme dados do Jornal da USP de 2025 (Jornal da USP, 2025), com ansiedade e depressão como principais causas, frequentemente agravadas por fatores como crise econômica, mudanças no mercado de trabalho e as sequelas prolongadas da pandemia.

A pandemia de COVID-19 exacerbou crises de ansiedade e depressão em escala nacional. Já em 2020, pesquisas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) indicavam um aumento de 90% nos casos de depressão entre março e abril, enquanto relatórios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apontavam que 80% da população brasileira experimentou níveis elevados de ansiedade durante esse período (Agência Brasil, 2020a). Em 2023, os afastamentos por transtornos mentais já totalizavam 283 mil, refletores de um cenário crítico e persistente no pós-pandemia. Esse contexto sublinha a importância crucial dos CAP (BRASIL, 2025), enquanto dispositivos de cuidado territorializados, comunitários e orientados pela perspectiva da redução de danos e da reinserção social.

Além disso, a recente ampliação da atuação dos CAPS, como a inclusão do atendimento a pessoas com vício em jogos de azar (G1, 2025b), aprovada por lei em agosto de 2025, demonstra sua capacidade de adaptação às novas demandas sociais e de saúde. Essa expansão consolida o papel desses centros não apenas como serviços de tratamento, mas como estruturas fundamentais de promoção de vida e dignidade, resistindo à patologização individualizante e reafirmando o caráter coletivo e social do cuidado em saúde mental.

A obra do filósofo e crítico cultural Mark Fisher torna-se cada vez mais imperativa para avançar o debate sobre a luta pela humanização dos excluídos no contexto da saúde pública. Em sua obra "Realismo Capitalista", Fisher argumenta que o capitalismo não se restringe a um sistema econômico, mas atua como uma força que molda a subjetividade humana, produzindo sofrimento

psíquico em larga escala e naturalizando externalidades negativas (como a pobreza e o adoecimento mental) como problemas meramente individuais. Conforme afirma o autor, “não há nenhuma tendência de ‘desnudamento’ progressivo do capitalismo, nenhum gradual desmascaramento mostrando o capital como ‘realmente’ é: selvagem, indiferente, desumano” (FISHER, 2020, p. 80). Essa análise ajuda a compreender como a estrutura socioeconômica vigente dificulta o reconhecimento das causas coletivas do sofrimento.

Nesse sentido, a Lei nº 15.126/2025, sancionada em abril de 2025 pelo atual governo brasileiro, representa uma resposta institucional significativa a essa problemática. Ao incorporar formalmente o princípio da atenção humanizada à Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), a legislação não apenas amplia os princípios do SUS, mas também estabelece o dever legal de garantir um atendimento pautado no respeito, na empatia e no acolhimento, considerando de maneira integral as necessidades físicas, emocionais, psicológicas e sociais dos usuários. Ao insistir na consideração dos determinantes sociais da saúde, a nova lei desafia a lógica do realismo capitalista descrita por Fisher, que tende a individualizar e medicalizar o mal-estar social. Ao reconhecer que o adoecimento é frequentemente sintoma de um contexto social mais amplo, marcado por desigualdades, exclusão e condições precárias de vida, a legislação avança na direção de uma prática em saúde que não apenas trata sintomas, mas também enfrenta as causas estruturais do sofrimento. Dessa forma, a Lei 15.126/2025 pode ser interpretada como um instrumento de resistência que reafirma o SUS como um espaço de defesa da vida e da dignidade humana, em oposição à mercantilização da saúde e à naturalização do adoecimento como falha individual.

Nesse contexto, a lei surge como um contraponto direto ao que Mark Fisher identificou como a "ontologia empresarial" do capitalismo, na qual serviços públicos essenciais (como a saúde) passam a ser geridos sob uma lógica empresarial, privilegiando indicadores de eficiência mercadológica em detrimento das reais necessidades humanas. Fisher (2020) argumenta que o ultraliberalismo buscou substituir categorias éticas por imperativos de gestão, naturalizando a ideia de que todas as esferas da vida social, inclusive saúde e educação, devem operar como empresas. Como afirma o autor:

Não é preciso dizer que o que conta como 'realista', o que parece possível em qualquer ponto do campo social, é definido por uma série de determinações políticas. Uma posição ideológica nunca é realmente bem-sucedida até ser naturalizada, e não pode ser naturalizada enquanto ainda for pensada como valor, e não como um fato. Não por acaso, o neoliberalismo tem procurado acabar com a própria categoria de valor em um sentido ético. Ao longo dos últimos trinta anos, o realismo capitalista implantou com sucesso uma 'ontologia empresarial', na qual é simplesmente óbvio que tudo na sociedade, incluindo saúde e educação, deve ser administrado como uma empresa. Como um grande número de teóricos radicais - de Brecht a Foucault e Badiou - já sustentaram, a política emancipatória precisa sempre destruir a aparência de uma 'ordem natural': deve revelar que o que nos é apresentado como necessário e inevitável é, na verdade, mero acaso, e deve fazer com que o que antes parecia impossível seja agora visto como alcançável (Fischer, 2020, p.34).

Ao reforçar a Política Nacional de Humanização (PNH) e exigir práticas como escuta qualificada, transparência na comunicação e respeito incondicional à dignidade dos usuários, a nova legislação ressignifica o espaço público da saúde, transformando-o em um *locus* de acolhimento e cuidado, e não de mercantilização da vida. Essa abordagem contesta a visão que reduz o sofrimento humano a disfunções individuais, resgatando sua dimensão coletiva e política. Fisher associava o aumento de transtornos como depressão e ansiedade diretamente à precarização do trabalho, ao isolamento social e à cultura competitiva imposta pelo ultraliberalismo. A referida lei avança nessa discussão ao exigir que os profissionais de saúde estejam preparados para oferecer um cuidado sensível e individualizado, reconhecendo que o sofrimento mental não é uma falha ou responsabilidade exclusiva do indivíduo, mas sim um resultado político de um contexto social patogênico. Dessa forma, a lei contribui para a politização da saúde mental, situando-a no campo dos direitos e da justiça social.

Ao institucionalizar a humanização como princípio organizador do SUS, a legislação transcende o caráter de uma mera reforma administrativa e consolida-se como um ato de resistência contra a captura da vida pela lógica do capital. Como destaca Fisher (2020), a política emancipatória deve revelar a contingência da ordem vigente e abrir espaço para o possível. A ênfase em valores não mercantis, como vínculo, comunidade e empatia, atua como um antídoto à mercantilização do sofrimento e do desejo, reafirmando a saúde como um bem comum e um projeto coletivo.

Nessa perspectiva, o SUS configura-se como um obstáculo estrutural ao projeto ultraliberal e a sua pedagogia da submissão, que opera pela supressão da autonomia e pela restrição das margens de ação dos indivíduos. Ao inibir a curiosidade e a capacidade de indagação, dimensões fundamentais, segundo Freire, para o exercício da humanização, tal projeto pedagógico sufoca o espírito inventivo necessário não apenas para criar e recriar a realidade, mas também para contestar e desestabilizar os próprios fundamentos ideológicos do ultraliberalismo.

3.2. A Necropedagogia: um projeto de morte

A Pedagogia constitui um campo de conhecimento dedicado ao estudo de métodos e estratégias orientados à formação de condutas individuais e coletivas. Embora tradicionalmente associada ao ambiente escolar, suas manifestações transcendem os espaços institucionalizados de educação formal, abrangendo dimensões diversas do processo educativo. Enquanto método e estratégia, a pedagogia apresenta-se sob múltiplas formas na tessitura social, carregando consigo distintos propósitos e, conseqüentemente, distintas fundamentações ideológicas. Na obra de Paulo Freire, encontra-se uma significativa problematização acerca da construção de uma prática educativa emancipatória, capaz de elevar o educando a um estado de consciência que lhe permita exercitar plenamente sua curiosidade epistemológica no processo dialético de ensinar-aprender, transformando-o em sujeito criador de seu próprio conhecimento e história.

A educação constitui uma ação transformadora que transcende o mero ato de agir no mundo, configurando-se como "(...) experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética" (Freire, 2002, p.13). Este processo educativo remete à transformação da realidade, uma vez que os sujeitos, enquanto seres históricos, possuem a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo.

Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro antes que foi novo e se fez velho e se 'dispõe' a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se

trabalha a produção do conhecimento ainda não existente (Freire, 2002, p.15)

Cabe ao pesquisador o compromisso de atentar para o surgimento de pedagogias que se afastam dos princípios éticos fundamentais. Práticas educativas que inibem o pensamento crítico e a pluralidade de ideias devem ser rigorosamente analisadas e confrontadas, uma vez que modalidades de educação pautadas por uma ética "menor, restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro" (Freire, 2002, p.07) não preservam a integridade do elemento humano, contribuindo, em vez disso, para a manutenção de um status quo fundado na opressão. A ética freiriana à qual nos referimos consiste precisamente em:

(...) que condena o cinismo do discurso (...), que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal (Freire, 2002, p.07).

A educação deve integrar os preceitos democráticos da sociedade, visando desenvolver e fortalecer nos sujeitos a capacidade crítica de interpretar a realidade em que vivem. O respeito por outros saberes, culturas e formas de relacionamento potencializa a superação do sistema vigente. O questionamento da realidade concreta constitui elemento fundamental de uma educação crítica e antiultraliberal. Paralelamente, observa-se a construção de pedagogias opressoras que objetivam despolitizar amplos contingentes populacionais, transformando-os em destituídos de sua capacidade de atuação direta nas políticas da vida. Tais pedagogias progressivamente eliminam a inquietude questionadora inerente ao ser humano, suprimindo a emergência de alternativas pedagógicas. Essas modalidades educacionais de caráter opressor domesticam, despotencializam e induzem os sujeitos à renúncia de sua autonomia intelectual em favor dos bastiões do sistema capitalista, reduzindo o indivíduo à condição de mero espectador social.

O sistema capitalista, objeto de análise desta pesquisa, apresenta-se em estágio modificado, marcado por significativo conservadorismo e perversidade. O ideal societário por ele propagado tolera e estimula a desigualdade social, a fome, a violência e práticas de genocídio. A despolitização, enquanto agenda política, viabiliza estratégias de atuação sobre as condutas dos sujeitos e

fomenta pedagogias opressoras para manutenção do *status quo*. É neste contexto despolitizado, opressor, desigual, violento e genocida que a necropedagogia assume sua forma mais contumaz.

O conceito de necropedagogia emerge da articulação entre a noção de pedagogia e o conceito de necropolítica. Entende-se por necropolítica o conjunto de ações voltadas para corpos considerados descartáveis pelo sistema econômico, por representarem ameaças ou obstáculos à acumulação de capital. Importa salientar que a necropolítica constitui uma política da morte, uma prática que assume deliberadamente a função de eliminar, operando conforme a lógica do ultraliberalismo. Os corpos selecionados para a morte servem a um propósito específico: movimentar a economia sem onerar o Estado com gastos em saúde e educação, mantendo-se inteiramente subservientes ao capital.

A necropolítica brasileira adquiriu maior fôlego através do movimento denominado bolsonarismo, que, embora faça referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, desenvolveu dinâmica própria e mantém atuação significativa no cenário político nacional. O termo necropolítica aproxima-se do conceito elaborado por Achille Mbembe (2011), que discute a instrumentalização da destruição humana com base na herança colonial e no modo escravocrata: "qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras manifestações da experimentação da biopolítica" (MBEMBE, 2011, p. 27). Embora o Brasil não seja mais uma colônia e tenha abolido o regime escravocrata, persistem territórios que operam sob lógicas análogas, particularmente as periferias. Conforme Pelbart (2019, p. 163), "As periferias de nossas cidades brasileiras, contudo, conjugam essas duas lógicas [colonialismo e escravidão], acrescidas dos mecanismos inventados pelo neoliberalismo".

A análise foucaultiana sobre a transição do poder soberano - que opera sob a lógica de "fazer morrer ou deixar viver" - para a biopolítica - que atua mediante o "fazer viver ou deixar morrer" - oferece um instrumental teórico fundamental para compreender a realidade das periferias brasileiras. Nestes territórios, conforme observado por Pelbart (2019), conjugam-se as heranças do colonialismo e da escravidão com os mecanismos contemporâneos do neoliberalismo, criando uma configuração singular de exercício do poder.

O poder soberano, caracterizado pelo direito de vida e morte sobre os súditos, manifesta-se nas periferias através da persistência de práticas estatais violentas que operam sob a lógica do "fazer morrer". Esta dinâmica atualiza-se por meio de ações policiais letais, milícias e um aparato de segurança pública que frequentemente age sob a égide do estado de exceção, onde a vida de certos grupos populacionais é sistematicamente desvalorizada.

Paralelamente, a biopolítica, que emerge no século XVIII como tecnologia de poder voltada para a administração da vida da população, apresenta seu aspecto sombrio no "deixar morrer". Esta dimensão materializa-se na precarização crônica do acesso a serviços essenciais como saúde, saneamento básico, educação e moradia digna. O Estado, ao gerir a vida da população, estabelece critérios de priorização que frequentemente marginalizam territórios periféricos, tratando-os como zonas de sacrifício onde a morte é permitida, quando não incentivada, pela via da negligência estrutural.

A interseção entre essas duas lógicas torna-se particularmente visível quando consideramos o conceito de necropolítica, desenvolvido por Mbembe (2018) como desdobramento da análise foucaultiana. Nas periferias brasileiras, a necropolítica manifesta-se como poder soberano de decidir quem pode morrer combinado com a racionalidade biopolítica que administra e naturaliza essas mortes. O racismo, que Mbembe identificou como mecanismo fundamental para fragmentar a população entre aqueles que merecem viver e os que podem ser deixados para morrer, opera como fio condutor dessa articulação, atualizando a herança colonial e escravocrata na contemporaneidade.

O ultraliberalismo acrescenta a esta equação uma racionalidade econômica que aprofunda a desvalorização da vida periférica. Ao transformar o cidadão em consumidor e reduzir o Estado a um gestor de mercados, essa lógica produz sujeitos descartáveis - corpos que, quando não são úteis ao circuito de acumulação capitalista, tornam-se passíveis de eliminação tanto pela ação direta do Estado quanto pelo abandono sistemático. Desta forma, as periferias brasileiras representam espaços onde o poder soberano, a biopolítica e o neoliberalismo se entrelaçam, produzindo uma gestão diferencial da vida e da morte que mantém e atualiza as estruturas coloniais e escravocratas fundantes da sociedade brasileira.

As relações estabelecidas pelo projeto ultraliberal introduzem pedagogias de alto risco para o tecido social. O cenário brasileiro contemporâneo caracteriza-se por uma complexa tessitura de violências dirigidas a corpos específicos, sistematicamente eliminados mediante anuência estatal - nem sempre explícita - concentrando-se majoritariamente nas periferias dos grandes centros urbanos. A necropedagogia não constitui um fenômeno acidental, mas sim um constructo intencional, implementado e progressivamente aprimorado ao longo do tempo nesses territórios, onde inclusive se desenvolveu uma lógica opressiva singular denominada modelo de milícia. Um aspecto que tem despertado a reflexão de pesquisadores críticos ao modelo bolsonarista refere-se às condições que possibilitaram a adesão de aproximadamente 30% da população brasileira à necropedagogia. Esta questão remete a um problema estrutural mais profundo: a não superação do legado autoritário do regime militar de 1964 na formação sociopolítica nacional.

A permanência de valores, práticas e estruturas remanescentes do período ditatorial constitui um substrato histórico propício para a assimilação de um projeto político que exalta a violência, normaliza assimetrias sociais e opera a instrumentalização da morte como mecanismo de administração da vida coletiva. A necropedagogia, por sua vez, ecoa em segmentos sociais que não empreenderam uma revisitação crítica do legado autoritário, tampouco desenvolveram uma reflexão substantiva sobre seu lugar no mundo, possibilitando que paradigmas de exceção se reinscrevam no imaginário social sob novas formas de expressão.

Em um exercício analítico de natureza perturbadora, por metodologicamente necessário, é possível estabelecer uma aproximação com a reflexão desenvolvida por Pelbart (2019). O autor observa que o prelúdio da Shoá (ou Holocausto) já estava inscrito na obra literária de Hitler, salientando que poucos contemporâneos perceberam que o livro expunha “minuciosamente a doutrina de dominação do mundo que conduziria à catástrofe que todos nós conhecemos” (Pelbart, 2019, p. 190). Diante dessa constatação, Pelbart (2019) formula um questionamento paradoxal: como foi possível que alguém levasse a sério “aquele livro feito inteiramente de ódio, racismo, eugenia, servilismo, militarização, torção histórica, megalomania, que aspirava à dominação absoluta de um povo e, por conseguinte, do globo?” (Pelbart, 2019, p. 190). Em

contrapartida, como foi possível que alguém não o tenha levado a sério, negligenciando o que era enunciado com total clareza? O texto hitlerista não expressava apenas “a ambição da dominação absoluta, mas o detalhamento de sua realização no plano operacional, seja pela organização, seja pela propaganda, seja pela guerra, seja pelo extermínio dos adversários ou o suicídio do próprio povo alemão” (Pelbart, 2019, p. 190).

Para Pelbart (2019), as semelhanças com o contexto brasileiro não podem ser atribuídas a meras coincidências. Jair Bolsonaro, antes de sua vitória eleitoral em 2018, constituía uma figura politicamente esvaziada, cujas aparições restringiam-se a programas televisivos de humor, onde proferia discursos marcados por ódio e discriminação, inclusive com explícita exaltação a torturadores atuantes durante o golpe militar de 1964. Embora tenha construído carreira no legislativo como Vereador e Deputado Federal pelo estado do Rio de Janeiro, sua relevância no cenário político nacional era ínfima. Nesse momento inicial, poucos o consideravam seriamente como um potencial Presidente da República. No entanto, impõe-se a reflexão: como não levar a sério um discurso proferido em rede nacional? Que condições sociopolíticas permitiram e fomentaram tal espaço midiático? E, sobretudo, como foi possível que um projeto político com tal teor discursivo lograsse acesso ao Poder Legislativo? A resposta a esses interrogantes parece residir no reconhecimento de que a figura do ex-presidente não representava uma ruptura, mas uma potencial maximização do regime ultraliberal. Nessa equação, as barbáries verbais e as ameaças à democracia tornavam-se toleráveis para setores específicos da sociedade e do mercado, desde que os resultados econômicos fossem considerados satisfatórios.

Quando chega ao poder em 2018, como Chefe do Executivo, a sua política já estava posta: governar para o capital, governar para poucos e destruir seus oponentes. Pelbart (2019, p. 190) continua a sua comparação do nazismo com o bolsonarismo:

O fascínio que despertou em alguns a repulsa; em outros, a mera indiferença; em terceiros, não diz nada sobre o que estava apenas se anunciando, que foi implementado ponto por ponto, exaustivamente. Nada ali é dissimulação, tudo estava às claras – os desígnios, os métodos, o cálculo, os efeitos. Que fosse considerado apenas o delírio de um megalômano foi um dos maiores equívocos já cometido por seus oponentes naturais. E por que falar disso hoje? Em um momento de perigo iminente, às vésperas do desastre [segundo turno da eleição

presidencial de Outubro de 2018], não temos o direito de não levar a sério o que está sendo enunciado e anunciado aos quatro ventos com clareza cristalina. É o nosso dever pesar cada palavra e gesto que parecem ser apenas fanfarronice.

No contexto pós-impeachment da Presidenta democraticamente eleita Dilma Rousseff, marcado por discursos de crise fiscal, pela ascensão de Michel Temer à presidência, pela emblemática declaração do senador Romero Jucá sobre a necessidade de um "pacto" para "estancar a sangria" envolvendo as instituições judiciárias, e pela prisão do principal candidato às eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva, sem condenação transitada em julgado, consolidou-se o cenário político propício para a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder. Este processo não foi acidental, mas resultado de uma articulação institucional específica.

O contexto pandêmico permitiu evidenciar a construção e o fortalecimento de uma pedagogia opressora e perversa gestada neste governo. O conceito de necropedagogia aplica-se, portanto, para designar uma *ação característica do bolsonarismo na condução da pandemia no Brasil, mediante a implementação de práticas destinadas a pedagogizar a sociedade brasileira no sentido de criar uma conduta social permissiva e despolitizada*. Esta estratégia teve como objetivo claro a eliminação de determinados sujeitos e a supressão de condutas questionadoras e contra-hegemônicas, operacionalizada através de múltiplos mecanismos: disseminação sistemática de desinformação, discursos que incitam a violência, desmonte de políticas sociais, omissão estatal na proteção dos cidadãos frente ao vírus e estigmatização de segmentos sociais específicos.

Em sua análise do projeto bolsonarista em sua vertente autoritária e antissistêmica, Marcos Nobre (2020) problematiza a incapacidade desse projeto de acumular forças suficientes para sua implementação plena, uma vez que esta exigiria uma reorganização do sistema político. Segundo o autor, essa estratégia de desorganização sistemática foi cunhada como “caos como método”.

Nesse contexto, Nobre (2020) observa que a opção política pela não atuação no enfrentamento da crise sanitária, incluindo a negação da gravidade da doença, deriva precisamente da fidelidade do governo a seus ideais autoritários. O autor argumenta que tal reorganização significaria a rendição à lógica democrática, o que implicaria pautar-se na colocação do Ministério da Saúde como eixo central da reestruturação governamental, com todas as ações

coordenadas no combate à pandemia. Essa transformação converteria o governo Bolsonaro em um governo "normal", com um Chefe do Executivo que efetivamente governa, postura que, conforme o autor, não foi adotada durante sua gestão presidencial. Nobre (2020) identifica, ainda, a presença de características típicas de um governo de guerra. Esta análise elucidaria a mórbida metáfora utilizada pelo ex-presidente ao relacionar o número avassalador de mortes com soldados falecidos em batalha, estratégia discursiva que visava atribuir à negligência estatal o caráter de consequência "natural" de um embate militar. Contudo, conforme sustenta o autor, esta guerra não se dirigia contra o vírus, nem contra uma ameaça comum, mas constituía-se como uma guerra contra as vidas dos cidadãos brasileiros, particularmente contra os estratos sociais mais vulneráveis.

Safatle (2020) caracterizou o Brasil sob o governo Bolsonaro como um "Estado Suicidário", conceito que representaria uma etapa ainda mais cruel do modelo ultraliberal. O autor estabelece diálogo com Achille Mbembe ao argumentar que não estaríamos meramente inseridos em uma necropolítica, mas sim para além desta configuração. Segundo sua análise:

Um estado como o nosso não é a penas o gestor da morte. Ele é o ator contínuo de sua própria catástrofe, ele é o cultivador de sua própria explosão. Para ser mais preciso, ele é a mistura da administração da morte de setores de sua própria população e do flerte contínuo e arriscado com sua própria destruição. O fim da Nova República terminará em um macabro ritual de emergência de uma nova forma de violência estatal e de rituais periódicos de destruição de corpos (Safatle, 2020, p. 02).

O autor identifica no governo traços de um fascismo contemporâneo que encontra sua força precisamente ao testar sua vontade diante do fim, não se tratando de um estado autoritário convencional que utiliza a violência para destruição de inimigos. Safatle (2020) observa que, até recentemente, o país dividia seus sujeitos entre "pessoas" e "coisas", entre aqueles cuja morte provocaria luto e comoção social e aqueles cuja morte seria tratada como mero número estatístico, uma fatalidade sem significado. "Agora, chegamos à consagração final desta lógica. A população é apenas o suprimento descartável para que o processo de acumulação e concentração não pare sob hipótese alguma" (Safatle, 2020, p. 05).

A pandemia, conjugada com a crise da saúde pública brasileira, contribuiu para desvelar esse direcionamento neofascista do governo contra parcelas

específicas da população. A arena política da saúde fornece evidências suficientes que revelam a estratégia governamental na eliminação sistemática desses cidadãos, seja mediante a escassez de recursos, seja através de desvios de verbas, potencializando a construção social da descartabilidade desses sujeitos. Não é fortuito que as taxas de mortalidade por COVID-19 entre pessoas negras tenham superado as registradas entre pessoas brancas no Brasil: está em curso uma política declarada de eliminação daqueles considerados indesejáveis pela elite, daqueles a quem negam acesso a melhores condições de vida.

3.2.1. Necropolítica, Estado ultraliberal e o fascismo no Brasil: a construção de uma Necropedagogia

A obra do filósofo camaronês Achille Mbembe (2018) apresenta o conceito de necropolítica como um desdobramento crítico e uma ruptura epistemológica em relação ao paradigma do biopoder formulado por Michel Foucault (2008). Para fundamentar sua crítica, Mbembe não apenas dialoga com a noção foucaultiana de biopoder, mas articula-a com outras duas categorias fundamentais: o estado de exceção e o estado de sítio, ambas cunhadas e desenvolvidas por Giorgio Agamben. Essa triangulação teórica permite a Mbembe deslocar a análise do poder moderno para além da gestão e regulação da vida, direcionando-a para as formas contemporâneas de soberania. Cabe destacar que, em sua releitura, o autor enfatiza o lugar proeminente do racismo na racionalidade do biopoder, argumentando que a distinção e hierarquização entre vidas (algumas dignas de serem vividas e outras expostas à morte) constitui um mecanismo estruturante das tecnologias políticas modernas e neocoloniais.

Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe (a ideologia que define história como uma luta econômica de classes), a raça foi a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros – ou a dominação a ser exercida sobre eles (...) Com efeito, em termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, ‘este velho direito soberano de matar’. (...) Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a ‘condição para a aceitabilidade do fazer morrer (Mbembe, 2018, p.18).

Se, para Foucault, a modernidade inaugurou uma modalidade de poder soberano centrada na gestão administrativa da vida – o biopoder, que opera sob o lema “*fazer viver e deixar morrer*”, por meio de dispositivos de regulação e otimização das populações –, Mbembe sustenta que, em contextos marcados pela herança colonial e por regimes de violência extrema, a expressão suprema da soberania desloca-se para a faculdade de decidir quem pode viver e quem deve morrer.

Foucault afirma claramente que o direito soberano de matar (*droit de glaive*) e os mecanismos de biopoder estão inscritos na forma em que funcionam todos os Estados modernos; de fato, eles podem ser vistos como elementos constitutivos do poder do Estado na modernidade. Segundo Foucault, o Estado nazista foi o mais completo exemplo de um Estado exercendo o direito de matar (Mbembe, 20218, p.18).

A necropolítica, portanto, é a política da morte como instrumento de governança, onde a morte não é um acidente, mas um objetivo ou uma consequência política calculada e racializada. Ela expõe um racismo neocolonial estrutural, no quais certas populações, marcadas por sua raça, classe ou geografia, são sistematicamente expostas ao risco de morte, seja por ação direta do Estado, seja por seu abandono deliberado. Nesses cenários, o paradigma do biopoder se mostra insuficiente, pois o que está em jogo não é apenas a otimização da vida, mas sua gestão diferencial e letal.

Este arcabouço necropolítico encontra um terreno fértil de implementação no Estado ultraliberal, conforme analisado por pensadores como Wendy Brown, Pierre Dardot e Christian Laval. Eles demonstram que a racionalidade ultraliberal, longe de ser uma mera doutrina econômica, é uma lógica de governo totalizante que, ao submeter todas as esferas da vida à competição de mercado, destrói os fundamentos da democracia e cria as condições para formas políticas autoritárias. Dardot e Laval mostram como o ultraliberalismo produz um “sujeito da empresa” isolado e hostil ao coletivo, preparando a subjetividade para a aceitação de líderes fortes que prometem ordem e eficiência. O Estado ultraliberal, portanto, não é o oposto do fascismo, mas pode ser seu incubador e aliado.

As características desse tipo de Estado, sintetizadas a partir de Dasso Júnior (2006), convergem de maneira direta com as características do fascismo identificados por Jason Stanley (2018). A comparação é elucidativa:

1) primado do privado sobre o público (ultraliberal) dialoga com o mito da sociedade unida e pura (fascismo), pois ambos deslegitimam a esfera pública e o conflito político em nome de uma unidade ou de uma eficiência técnica superior; 2) aparência de inevitabilidade, consenso e roupagem científica (ultraliberal) reforçam o anti-intelectualismo e o realismo hierárquico (fascismo), ao apresentar a ordem de mercado como uma lei natural e científica incontestável, que justifica hierarquias sociais; 3) discurso rico em eufemismos (ultraliberal) é um instrumento crucial para a desrealização da linguagem (fascismo), onde termos como "flexibilização" ou "eficiência" mascaram a violência social, assim como a propaganda fascista corrói o significado das palavras. 4) substituição da democracia pela tecnocracia e a economia como centro do ser humano (ultraliberal) ecoam a substituição da verdade pelo poder (fascismo), onde a verdade deixa de ser factual para ser definida pela conveniência do líder ou pela lógica do mercado. 5) retorno ao individualismo radical e a formação do "sujeito idiota" (ultraliberal), aquele desprovido de pensamento crítico e voltado apenas para o consumo, criam o cidadão apático e facilmente mobilizável por apelos emocionais, condição essencial para o culto da vitimização e do pensamento de grupo (fascismo).

O governo Bolsonaro (2019-2022) personificou essa síntese perversa. Conforme analisado por Teixeira (2022), a gestão estatal foi marcada por uma governança que via na pandemia uma oportunidade para exercer a necropolítica. Rocha (2023), demonstra como o projeto mobilizou um arsenal retórico fascista, listado também por Umberto Eco: o apelo a um passado mítico (a ditadura como época de ouro), o culto da ação pela ação (o negacionismo como coragem), o medo da diferença (a guerra cultural contra gênero e comunismo), a obsessão por conspirações (a narrativa do globalismo e da fraude eleitoral) e o desprezo pelos fracos (a dessensibilização diante das mortes na pandemia).

A condução da pandemia de COVID-19 no Brasil foi o laboratório final onde essa amalgama se cristalizou em um projeto político letal. Não se tratou de mera incompetência, mas de uma estratégia consciente que uniu necropolítica, Estado ultraliberal e fascistização. A necropolítica se manifestou na gestão calculada da morte, na exposição deliberada de populações vulneráveis ao vírus e na naturalização das mortes em massa como destino. A lógica ultraliberal se

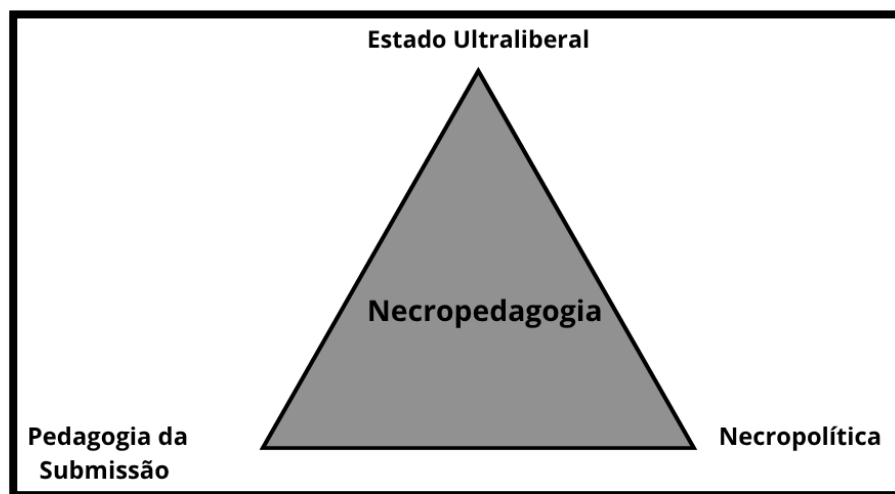
fez presente na priorização absoluta da economia sobre a vida, na transferência da responsabilidade para o indivíduo e no desmonte das estruturas públicas de saúde.

Porém, esse projeto só pôde alcançar eficácia e adesão através de um processo ativo de doutrinação: a Pedagogia da Submissão. A negação das máscaras, o descrédito nas vacinas, a glorificação do tratamento precoce sem eficácia e a ridicularização do luto foram atos pedagógicos. Ensinou-se à população a substituir a evidência científica pela lealdade ao líder, a dessensibilizar-se diante da morte do outro e a aceitar a necropolítica como inevitabilidade. É essa camada final que transforma o cenário em necropedagogia: uma pedagogia que não apenas ensina a morrer, mas ensina a consentir com a própria morte e a dos outros como preço a pagar por uma ordem política e econômica específica. A necropedagogia é, assim, o mecanismo pelo qual o poder necropolítico, sustentado pelo Estado ultraliberal e pela retórica fascista, se internaliza e se reproduz na subjetividade dos governados, completando o ciclo de dominação na era das mortes administradas.

3.2.2. A Operacionalização da Necropedagogia: desvendando seus três eixos estruturantes

A necropedagogia constitui-se na intersecção de três pilares conceituais que não apenas permitem, mas também potencializam sua operacionalização: (1) o Estado Ultraliberal, que fornece a base material e ideológica; (2) a Necropolítica, que instrumentaliza a gestão da morte; e (3) a Pedagogia da Submissão, que atua na formação de subjetividades acríticas

Figura 5 - Conceitos constituidores da necropedagogia utilizada na condução da pandemia brasileira



Fonte: a autora (2025).

Do ponto de vista analítico, a necropedagogia apresenta-se como um conceito mais abrangente do que a necropolítica, tal como formulada por Mbembe (2018). Enquanto esta última concentra sua análise na figura do Estado soberano e em seus mecanismos de biopoder e necropoder para administrar a vida e autorizar a morte em territórios específicos, a necropedagogia expande esse escopo. Ela não se restringe à esfera estatal, mas permeia e é disseminada por múltiplas instituições sociais, atuando como um vetor de legitimação e naturalização das políticas de extermínio. Trata-se de um projeto concebido por grupos opressores, enraizado em uma modalidade perversa de capitalismo que demanda a inculcação constante e ininterrupta de uma racionalidade excludente.

Nesse processo, conforme os fundamentos da pedagogia crítica, opera-se uma profunda distorção do ato educativo. Como afirma Paulo Freire (2002), *a pedagogia é, em sua essência, uma teoria da prática que se consolida na dialética entre ação e reflexão*. Ao se esvaziar o ensino de seu caráter problematizador e reduzi-lo a um simples ato de transferência de conteúdos, instaura-se uma lógica bancária da educação. Nela, consolida-se a rígida dicotomia entre aquele que supostamente detém o saber e aquele que é considerado ignorante. Suprime-se, assim, a curiosidade epistemológica, motor do aprendizado autêntico, e anula-se a capacidade de indagação, fazendo com que os indivíduos se limitem a assimilar passivamente narrativas apresentadas como verdades absolutas e incontestáveis.

3.2.2.1 – O pilar Estado Ultraliberal: condição de possibilidade da Necropedagogia

Para compreender a necropedagogia em sua plenitude, é imprescindível analisar o Estado ultraliberal não meramente como um pilar entre outros, mas como a base material. Este ultraliberalismo transcende a condição de uma simples política econômica para se constituir, nos termos da filósofa política Wendy Brown, em uma racionalidade política totalizante. Trata-se de uma lógica que coloniza todas as esferas da vida, reconfigurando relações sociais, subjetividades e a própria ideia de democracia, subordinando-as à métrica do mercado. Neste paradigma, o valor da vida é progressivamente medido por sua utilidade econômica e por seu potencial de geração de lucro, criando o terreno fértil para a naturalização de hierarquias sociais e, em última instância, para a distinção entre vidas que merecem ser vividas e outras que podem ser descartadas.

Contrariamente ao senso comum que prega um Estado mínimo, o projeto ultraliberal não promove o desaparecimento do aparato estatal, mas, sim, sua radical reconfiguração funcional. O Estado é recolocado a serviço do capital, transformando-se em um agente ativo na criação e manutenção das condições para a acumulação. Esta atuação se dá em três frentes principais: primeiramente, na criação de mercados onde estes não existem ou são incipientes, notadamente em setores historicamente entendidos como direitos sociais, como a saúde e a educação. Ao fomentar a mercantilização destas áreas, o Estado converte cidadãos em consumidores e necessidades básicas em oportunidades de negócio.

Em segundo lugar, o Estado atua como protetor do capital, garantindo por meio de um arcabouço jurídico, legislativo e de segurança os interesses dos agentes de mercado. Esta função assegura que os mecanismos de acumulação não sejam perturbados por demandas sociais ou por eventuais crises de legitimidade. Por fim, e de modo crucial, opera na socialização de perdas e na precarização sistemática da vida. O estrangulamento financeiro e administrativo de sistemas públicos universais, como o Sistema Único de Saúde (SUS), não é um descuido gerencial, mas um projeto político deliberado. Ao tornar os serviços públicos ineficientes e a vida mais precária, cria-se um mercado cativo para

soluções privadas, transformando o sofrimento e a vulnerabilidade em negócios lucrativos. Dessa forma, o Estado ultraliberal não é um pilar estático, mas o campo de força ativo que organiza a sociedade, estabelecendo as condições materiais sem as quais a necropolítica e a pedagogia da submissão não poderiam florescer como estratégias complementares de governo.

3.2.2.2 - O pilar Necropolítico: articulações teóricas e a realidade brasileira

A compreensão do pilar necropolítico exige uma aproximação crítica entre o arcabouço teórico de Achille Mbembe e a específica realidade brasileira. O conceito de necropolítica, formulado pelo filósofo camaronês, avança e complexifica a noção de biopoder cunhada por Michel Foucault (2022). Se Foucault descreveu a transição do poder soberano, que decide sobre a morte, para um poder que administra a vida e a regula (a biopolítica), Mbembe demonstra que, em contextos marcados por histórias coloniais e escravistas, o poder sobre a vida se revela, em última instância, como o poder de determinar quem pode ser morto ou deixado morrer. No Brasil, esta necropolítica não se manifesta através de um soberano arcaico, mas se opera por meio de uma sofisticada tecnicidade. Configura-se uma verdadeira burocracia da morte, onde a letalidade é administrada através de cortes orçamentários, desmontes regulatórios e uma linguagem tecnocrática de eficiência e custo-benefício que naturaliza a exposição de populações ao risco de morte.

Esta gestão técnica da morte é profundamente seletiva, possuindo cor, classe e geografia definidas. A necropolítica no Brasil constitui-se como a reatualização do legado escravocrata, um projeto político que sempre hierarquizou o valor da vida. As populações consideradas descartáveis no contexto da pandemia são os mesmos corpos racializados e empobrecidos, historicamente alvos preferenciais da violência de Estado. Para dar contundência analítica a este fenômeno, os conceitos de mortalidade seletiva e genocídio tornam-se instrumentos teóricos e políticos importantes. Eles permitem transcender a ideia de um mero "deixar morrer" por negligência, revelando-o como uma escolha política ativa e sistemática. Trata-se, portanto, de um processo onde a soberania, nos termos de Mbembe, se exerce precisamente através da capacidade de definir quem pode ser exposto à morte

e cujo extermínio permanece na impunidade, caracterizando uma continuidade brutal com as estruturas de poder que moldaram a formação social brasileira.

3.2.2.3 - O pilar da Pedagogia da Submissão: a fabricação da aceitação

Para compreender a operacionalização da necropedagogia, é fundamental analisar seu terceiro pilar, a Pedagogia da Submissão, que atua como mecanismo de produção de consentimento e conformidade. Diferente de uma mera ideologia difusa, trata-se de um projeto pedagógico intencional e ativo, que se estrutura na antítese direta da Pedagogia da Autonomia, proposta por Paulo Freire.

Enquanto Freire (1996) fundamenta sua *práxis* na consciência crítica, no diálogo e na humanização como fins da educação, a pedagogia da submissão opera pela fabricação sistemática de uma consciência ingênua e autoritária. Se o educador freireano problematiza o mundo para transformá-lo, o pedagogo da submissão investe no monólogo e na desqualificação do outro rotulado pejorativamente como comunista ou globalista, anulando a possibilidade do debate racional e da construção coletiva do conhecimento.

Esta pedagogia se materializa através de mecanismos concretos. Primeiro, pela dessensibilização, processo pelo qual a repetição exaustiva de números de mortes os transforma em estatísticas abstratas, esvaziando-as de seu caráter trágico e humano. Segundo, pelo anti-intelectualismo, que promove um sistemático ataque à ciência, às universidades e aos especialistas, erigindo uma “verdade” alternativa onde o sentimento e a crença pessoal se sobrepõem ao fato empiricamente verificado.

A síntese desses mecanismos configura o que se pode denominar de Gramática do Genocídio, um conjunto articulado de símbolos, narrativas e procedimentos discursivos que, ao banalizar o sofrimento e ridicularizar a morte, torna a letalidade em massa politicamente aceitável. Esta gramática opera uma inversão perversa do projeto freireano: se para Freire a educação é o caminho para a libertação, aqui ela é metodicamente instrumentalizada para a submissão e a naturalização do inaceitável.

Em resumo, a tríade da necropedagogia opera de forma sinérgica e retroalimentadora. O Estado Ultraliberal fornece a lógica econômica e o arcabouço institucional que torna a morte uma variável de ajuste. A Necropolítica

é a prática concreta de gestão e administração dessa morte, seletiva e racializada. Por fim, a Pedagogia da Submissão atua como o lubrificante ideológico indispensável desse sistema, dessensibilizando a sociedade, fabricando consentimento e neutralizando a resistência através da erosão do pensamento crítico. Sem este último pilar, a implementação dos dois primeiros encontraria um custo político insustentável.

4. Trajetória política e gestão pandêmica: uma análise descritiva do período bolsonarista

A trajetória política de Jair Bolsonaro constitui um fenômeno singular na história brasileira recente. Sua carreira política iniciou-se em 1988, com a eleição para vereador do Rio de Janeiro, após polêmicos anos no Exército Brasileiro onde chegou a capitão. O período militar foi marcado por artigos que criticavam a hierarquia castrense e por um plano de implantar explosivos em quartéis, episódio que resultou em processo no Superior Tribunal Militar, conforme detalhado por Piva (2022).

Nos trinta anos seguintes, Bolsonaro construiu uma sólida base parlamentar como deputado federal, elegendo-se por sete mandatos consecutivos. Sua atuação legislativa consolidou-se através de um estilo confrontador e de defesa intransigente de bandeiras conservadoras, posicionando-se sistematicamente contra pautas progressistas e tornando-se voz destacada na crítica às instituições democráticas. Esse perfil político, que Manso (2020) identifica como conectado a redes de poder paralelas, foi fundamental para sua ascensão à presidência em 2018, quando capitalizou o sentimento antipetista e antissistema que dominava o país.

A eleição de Bolsonaro representou a culminância de um projeto de poder gestado durante décadas, cujas bases incluíam alianças com setores das polícias e militares, além de conexões com figuras como Fabrício Queiroz e o Adriano da Nóbrega. Esta rede de sustentação, analisada por Manso (2020) como parte da "república das milícias", revelaria seu impacto mais devastador durante a pandemia de COVID-19.

Quando a pandemia atingiu o Brasil em 2020, o padrão de operação política característico do bolsonarismo transferiu-se integralmente para a gestão da emergência de saúde pública. A instabilidade deliberada no Ministério da Saúde, com a sucessão de quatro ministros em pouco mais de um ano, refletia a primazia da lealdade política sobre a competência técnica. O vácuo de informação confiável gerado pela comunicação oficial caótica e pelo negacionismo estatal foi parcialmente preenchido por um esforço coletivo do jornalismo profissional. A formação de consórcios de veículos de imprensa, como

o Projeto Comprova, representou uma resposta da sociedade civil à desinformação patrocinada pelo próprio governo.

A trajetória de Bolsonaro e os diagramas temporais permitem demonstrar, de forma concreta, que a gestão da crise sanitária não foi um episódio isolado ou uma simples sucessão de erros, mas a materialização de um *modus operandi* político gestado e refinado ao longo de três décadas.

O primeiro subcapítulo, ao reconstituir a trajetória de Bolsonaro, marcada por um estilo deliberadamente confrontador e pela defesa de um conservadorismo radical, revela a construção de uma tendência política baseada no antagonismo ao establishment e na deslegitimação de instituições democráticas. Mais do que isso, ao mapear a formação da "rede bolsonarista" – com a inserção estratégica de familiares em cargos públicos, as conexões com figuras como Fabrício Queiroz e a proximidade com o universo miliciano, conforme detalhado por autores como Manso (2020) –, este subcapítulo identifica a ossatura de um projeto de poder que privilegia a lealdade incondicional em detrimento da competência técnica e que opera nas fronteiras entre o institucional e o paralelo.

É precisamente essa base descritiva que confere significado ao segundo subcapítulo. Os diagramas temporais da pandemia, documentados pelo consórcio de veículos de imprensa, deixa de ser uma simples cronologia de eventos para se tornar a ilustração empírica da aplicação desse projeto de poder em um contexto de crise nacional. A instabilidade no Ministério da Saúde, a promoção de tratamentos sem eficácia e o conflito sistemático com governadores e com a comunidade científica não são, portanto, decisões aleatórias. Elas são a expressão concreta da necropolítica e da necropedagogia, conceitos que ganham materialidade quando entendidos como o desdobramento lógico de uma trajetória que sempre desprezou a competência, instrumentalizou a desinformação e tratou a vida como um custo político.

Dessa forma, a importância da justaposição destes dois subcapítulos reside em sua capacidade de demonstrar causalidade e continuidade. Eles mostram como as práticas e alianças que levaram Bolsonaro ao poder foram as mesmas que orientaram sua resposta à pandemia, com consequências devastadoras. Juntos, eles oferecem uma chave interpretativa para entender não apenas um governo, mas um fenômeno político que ecoa na sociedade brasileira.

4.1. A Trajetória de Jair Bolsonaro (1988 a 2018)

A trajetória política de Jair Messias Bolsonaro teve início em 1988, no contexto da promulgação da nova Constituição Federal e da retomada do processo eleitoral após anos de regime militar. Naquele período, Bolsonaro era capitão do Exército Brasileiro na reserva remunerada. Anos antes, entre 1986 e 1987, esteve envolvido em episódios que marcaram sua passagem pela instituição militar. Conforme registra Piva (2022, p. 40), ele:

Escreveu um artigo reclamando do salário dos militares que lhe rendeu uma punição disciplinar por prisão por 15 dias. Depois ensaiou um plano para implantar bombas em instalações do Exército; foi condenado pelo Conselho de Justificação do Exército mas terminou absolvido, em um polêmico julgamento, no Superior Tribunal Militar (Piva, 2022, p.40).

No Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira militar e posteriormente política, declarava, em sua atuação parlamentar inicial, o objetivo de combater a corrupção e defender a moralidade pública. No entanto, sua passagem pela Câmara Municipal foi marcada por avaliações negativas. Conforme apurado pela própria Casa em 1990, Bolsonaro foi considerado o pior vereador carioca, como noticiou o *Jornal do Brasil* em 31 de janeiro de 1990. De acordo com Piva (2022), durante seu mandato, apresentou apenas cinco projetos de lei e duas resoluções, voltados a temas como aposentadoria de servidores, saúde e transporte de militares, sem atuação relevante nas questões centrais da administração municipal.

A despeito de sua retórica em defesa da transparência pública, a conduta parlamentar de Jair Bolsonaro revelou notória contradição quando, em fevereiro de 1991, logo após assumir o mandato, nomeou seu sogro, João Garcia Braga, para um cargo na Câmara Municipal. Relatos indicam que o indicado não cumpria funções efetivas, dedicando-se predominantemente à distribuição de material de campanha do genro durante períodos eleitorais (Piva, 2022).

Bolsonaro posteriormente projetou sua então esposa, Rogéria Bolsonaro, na vida política, impondo como condição que ela prestasse contas de suas ações no legislativo. Durante seu mandato, ela teria gerido aproximadamente 66 funcionários parlamentares, integrantes de quatro famílias diferentes. A recusa de Rogéria – mãe de Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro – em aceitar a intromissão do marido em suas decisões ocasionou uma fissura conjugal que culminou na separação do casal.

Após o divórcio, Bolsonaro estabeleceu relacionamento com Cristina Bolsonaro, então casada. Em 1997, quando Bolsonaro já estava separado, o então marido de Cristina suspeitou do envolvimento entre ambos, o que levou ao fim do casamento após a descoberta de que ela esperava um filho de Jair Bolsonaro. Cristina tornou-se a principal articuladora do que a jornalista Piva (2022) denominou "negócio do Jair", gerenciando e organizando os esquemas de rachadinha no gabinete parlamentar. Familiares de Cristina foram registrados como funcionários do gabinete mediante simples fornecimento de CPF. Conforme descreve Piva (2022, p. 65-66), "Cristina explicou que Jair só queria duas coisas: a entrega de grande parte do salário (em alguns casos 90%) todos os meses e uma mãozinha na época da campanha eleitoral. De resto, era aproveitar a mesada sem fazer esforço".

Esse período coincide temporalmente com a aquisição de imóveis em Brasília por Jair Bolsonaro, transações estas liquidadas em moeda corrente. Anteriormente, conforme relata Piva (2022), circulavam nos corredores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro suspeitas de que o parlamentar exigia o repasse de parte dos vencimentos dos assessores de sua primeira esposa, Rogéria Bolsonaro, prática conhecida como "rachid" ou rachadinha.

Com a transição para a gestão do mandato de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), foi nomeado em 2003 Marcelo Nogueira como funcionário de gabinete. Contudo, suas reais atribuições consistiam em cuidar da residência da família na Barra da Tijuca e do filho Jair Renan, sob a condição de repassar 80% de sua remuneração a Jair Bolsonaro (PIVA, 2022).

O esquema operava sob regras específicas que se tornaram progressivamente mais complexas. Conforme ressalta Piva (2022), se inicialmente era exigida apenas a devolução do percentual combinado do salário, posteriormente Cristina Bolsonaro determinou a inclusão dos benefícios trabalhistas no esquema. Dessa forma, além da parcela salarial, os funcionários precisavam restituir vale-alimentação, auxílio-educação e até valores recebidos como restituição do Imposto de Renda, sob a justificativa de que constituíam parte integrante da remuneração.

O relacionamento entre Cristina e Bolsonaro prolongou-se por quase uma década, findando em meio a conflitos conjugais. Subsequentemente, Bolsonaro

contraiu matrimônio com sua assessora parlamentar Michele Bolsonaro, então com 25 anos. Apesar do término do vínculo conjugal, a estrutura operacional manteve-se, com familiares de Cristina permanecendo como funcionários-fantasmas nos gabinetes (Piva, 2022).

A transição na gestão dos “negócios do Jair”, com a saída de Cristina Bolsonaro da posição de principal articuladora, coincidiu com a ascensão de Flávio Bolsonaro nessas atividades. Conforme os registros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o patrimônio declarado pelo primogênito em sua candidatura a deputado estadual em 2002 limitava-se a um veículo Gol 1.0. Contudo, nas duas décadas subsequentes, o parlamentar realizou transações envolvendo vinte imóveis, evidenciando expressiva expansão patrimonial que acompanhou sua consolidação na estrutura dos negócios. Esse processo de crescimento econômico desenvolveu-se paralelamente à atuação de Fabrício Queiroz - ex-colega de Jair Bolsonaro na carreira militar e posteriormente integrante do 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro - cuja trajetória se mostrou intrinsecamente vinculada à organização bolsonarista.

Diante do acúmulo de registros disciplinares na Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), incluindo alegações de envolvimento em operações com resultado letal em comunidades, Fabrício Queiroz solicitou a intervenção de Jair Bolsonaro, com quem mantinha amizade, para ser removido do serviço operacional. Três meses após o óbito de Anderson Rosa de Souza em ação policial, Flávio Bolsonaro requereu formalmente à PM a designação de Queiroz para seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) em 2003. Através de Queiroz, estabeleceu-se o vínculo entre a família Bolsonaro e Adriano da Nóbrega (Manso, 2020).

O então Capitão Adriano da Nóbrega, formado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), atuava no 16º Batalhão onde, segundo investigações, coordenava esquemas de extorsão a traficantes e praticava tortura. Em 2004, foi preso sob acusação de assassinar uma testemunha que deporiam sobre essas práticas. No sistema prisional, aprofundou sua atuação criminosa, organizando uma equipe de assassinos profissionais que atendia principalmente a contraventores, além de estabelecer sociedade no setor imobiliário na Muzema e criar um empreendimento de transporte de drogas utilizando vans (Manso, 2020).

A relação profissional entre Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz, estabelecida em 2003, constituiu o elo entre a família Bolsonaro e as milícias. Juntos atuaram no 18º Batalhão em Jacarepaguá, onde replicaram o modelo de dominação territorial implementado em Rio das Pedras, expandindo o controle miliciano para outras comunidades. Nesse período, consolidou-se a reputação de Adriano no crime organizado (Piva, 2022).

Em 2006, Flávio Bolsonaro contratou a então esposa de Adriano da Nóbrega para seu gabinete na ALERJ. Em 2016, a mãe de Adriano também foi admitida no gabinete para participar dos esquemas de rachadinha. O relacionamento entre a família Bolsonaro e as milícias intensificou-se a ponto de, em 2005, Flávio Bolsonaro conceder a Adriano da Nóbrega a Medalha Tiradentes, honraria máxima do legislativo fluminense (Manso, 2020).

Conforme relata Manso (2020), Fabrício Queiroz atuava como principal articulador da base de aliados bolsonaristas no meio paramilitar. Em 2018, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) apontou Queiroz como organizador do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. De acordo com as investigações da instituição ministerial, o referido esquema foi criado no mesmo ano em que Queiroz iniciou suas atividades como assessor parlamentar.

Manso (2020) relata que os Bolsonaro "não pegavam dinheiro de empreiteiras nem de bancos, não se vendiam a grandes empresários". A família dispunha de vantagem eleitoral singular, uma vez que "contava com os votos garantidos dos militares e policiais (e seus familiares)", o que reduzia significativamente a necessidade de financiamento convencional para campanhas políticas. Não obstante, Jair Bolsonaro manifestava insatisfação com sua remuneração como deputado federal, alegando que parcela majoritária de seu salário era destinada ao pagamento de impostos, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e pensão alimentícia para sua ex-esposa.

Quando a campanha presidencial de 2018 se inicia, Bolsonaro surge como um candidato que encarna essa dupla face: o político de carreira longa que se apresenta como outsider, e o defensor da lei e da ordem cujas principais alianças se construíram nas fronteiras entre a política institucional e o crime organizado. Sua campanha, pobre em recursos convencionais se comparada à de seus adversários, soube capitalizar com maestria o descontentamento

popular e o sentimento antipolítica, utilizando as redes sociais como palco principal. O atentado a faca sofrido por Bolsonaro em setembro de 2018, longe de prejudicá-lo, projetou sua imagem nacionalmente de forma dramática, gerando uma onda de solidariedade que se traduziu em votos. Assim, o candidato que não dependia do financiamento tradicional das empreiteiras, mas que mantinha conexões com esquemas informais de custeio político e com as milícias, conseguiu se eleger Presidente da República em 2018, consolidando um projeto de poder que havia sido gestado nas entranhas do sistema político ao longo de décadas.

A pandemia de COVID-19, contudo, representou um elemento desestabilizador significativo para o governo Bolsonaro. A gestão federal da crise sanitária caracterizou-se por notória instabilidade na liderança do Ministério da Saúde, que teve quatro titulares em um período de aproximadamente dois anos. Essa rotatividade ministerial deliberada refletia a natureza essencial do projeto político bolsonarista, no qual a desorganização institucional sistemática e a instrumentalização política da ciência atendiam a objetivos estratégicos mais amplos: a perpetuação no poder mediante a acentuação da polarização social e a implementação de uma necropolítica. Desse modo, o enfrentamento da pandemia configurou-se como expressão paradigmática da necropedagogia, mecanismo pelo qual a banalização da morte e o descrédito sistemático do saber científico operavam como instrumentos de dominação política.

4.2. Pandemia de COVID-19 no Brasil e a descrição cronológica dos fatos (2020 a 2021)

A pandemia de COVID-19, desencadeada pelo coronavírus SARS-CoV-2, configurou-se como um dos maiores desafios sanitários, sociais e econômicos do século XXI. Declarada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020 e, posteriormente, como uma pandemia em março do mesmo ano, a crise exigiu respostas rápidas e complexas de governos e sociedades em escala global (OMS, 2020). No Brasil, o cenário não foi diferente. A chegada do vírus, oficialmente confirmada em fevereiro de 2020, desencadeou uma sucessão de eventos marcantes que redefiniram o cotidiano da população, testaram a resiliência do Sistema Único de Saúde (SUS) e expuseram profundas desigualdades sociais.

Os anos de 2020 e 2021 representam um período particularmente crítico e dinâmico neste contexto. O primeiro ano foi caracterizado pela fase aguda da crise, com a implementação abrupta de medidas não-farmacológicas, como o isolamento social e o lockdown, a sobrecarga do sistema de saúde, e a adoção de políticas de auxílio econômico para amortecer o impacto social do vírus. Já 2021 trouxe consigo a complexidade da gestão da pandemia em um cenário de fadiga pandêmica, o trágico marco de centenas de milhares de vidas perdidas e, finalmente, a esperança com o início da campanha de vacinação, um processo crucial, porém marcado por disputas políticas e logísticas.

Diante do volume e da complexidade dos acontecimentos relacionados à pandemia de COVID-19 no Brasil, faz-se necessária uma sistematização cronológica que possibilite uma análise adequada, a ser no capítulo subsequente. Para atender a esse objetivo, apresenta-se nesta seção uma linha do tempo descritiva dos eventos ocorridos entre 2020 e 2021, elaborada com base no levantamento sistemático de fontes primárias obtidas em veículos jornalísticos de grande circulação nacional. A periodização adotada organiza-se em quatro momentos distintos: o primeiro semestre de 2020 (fevereiro a junho), o segundo semestre de 2020 (julho a dezembro), o primeiro semestre de 2021 (janeiro a junho) e o segundo semestre de 2021 (julho a dezembro), permitindo assim uma

compreensão estruturada e evolutiva do desenrolar dos fatos ao longo desse período crítico.

As figuras, dispostas na sequência, constituem um instrumento visual central para o mapeamento cronológico dos eventos, permitindo a visualização clara das intersecções entre as esferas da saúde pública e política. Do ponto de vista metodológico, o presente estudo delimita seu recorte temporal aos anos de 2020 e 2021 no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. Adota-se como marco inicial 26 de fevereiro de 2020, data de confirmação do primeiro caso no país, e como término, dezembro de 2021, período que registrou avanço significativo na campanha de imunização, com aproximadamente 80% da população brasileira com a segunda dose da vacina. Esta delimitação possibilita a análise do ciclo mais crítico da pandemia, desde sua introdução até o estabelecimento da proteção vacinal em escala populacional.

A opção por esse recorte justifica-se pela singular expressividade do biênio. O ano de 2020 caracterizou-se pela emergência sanitária, registrando seu primeiro pico de mortalidade em maio, enquanto 2021 foi marcado pelo agravamento da crise, com o colapso generalizado dos sistemas de saúde em diversos estados no início do ano. Paralelamente, este último período representou um divisor de águas, com a implementação e a consolidação do plano nacional de vacinação, elemento crucial para a mudança no curso da pandemia. A apresentação dos fatos históricos será organizada cronologicamente por data dentro de cada semestre, com a descrição sistemática dos eventos relevantes de cada período que estarão destacados no diagrama temporal. Esta organização fornecerá a base factual necessária para a análise interpretativa do capítulo final, que articulará os dados empíricos com os referenciais teóricos previamente estabelecidos nos capítulos iniciais deste trabalho.

Figura 6 - Diagrama temporal do primeiro semestre de 2020 da Pandemia de COVID-19

2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
26 FEVEREIRO	09 MARÇO	11 MARÇO	17 MARÇO	20 MARÇO	22 MARÇO	23 MARÇO	24 MARÇO	25 MARÇO	26 MARÇO	28 MARÇO	31 MARÇO
Confirmado o primeiro caso de COVID-19 no Brasil.	Presidente Bolsonaro declara que poder destrutivo da COVID-19 é "superdimensionado"	OMS declara pandemia	Confirmação do primeiro óbito e abertura de investigação sobre outras mortes suspeitas em São Paulo.	Presidente utiliza o termo "gripezinha" para se referir à COVID-19.	Medida Provisória permite suspensão do contrato de trabalho por quatro meses.	Revogação de trecho de MP trabalhista e suspensão de prazos da LAI.	Presidente afirma que, por seu histórico de atleta, não seria gravemente afetado pela COVID-19.	Ministério da Saúde anuncia distribuição de cloroquina e publica guia para manejo de corpos.	Bolsonaro sugere resistência natural do brasileiro ao coronavírus.	Imperial College projeta mais de 1 milhão de mortes no Brasil sem isolamento.	Postura de Bolsonaro na pandemia motiva ameaça de restrição de voos pelos EUA.
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
02 ABRIL	06 ABRIL	10 ABRIL	16 ABRIL	20 ABRIL	21 ABRIL	23 ABRIL	27 ABRIL	28 ABRIL	05 MAIO	06 MAIO	09 MAIO
Senado aprova auxílio emergencial de R\$ 600	Governo Federal anuncia transição do distanciamento social ampliado para o seletivo.	Registrado primeiro óbito por COVID-19 em indígena Yanomami em Roraima	Presidente exonera o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.	Início do Lockdown no Brasil	Associação Médica Brasileira registra 3,1 mil denúncias por falta de EPI em um mês.	Brasil atinge novo recorde: 407 mortes por COVID-19 em 24 horas.	Ministério da Saúde anuncia flexibilização gradual e regionalizada do isolamento.	Ministro da Saúde e Presidente manifestam posições antagônicas sobre a gravidade da pandemia.	Brasil se recusa a integrar iniciativa global da OMS para vacinas e tratamentos.	Brasil atinge novo recorde de mortalidade por COVID-19: 615 óbitos em 24h.	Congresso Nacional e STF decretam luto oficial pelos 10 mil mortos por COVID-19.
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
11 MAIO	12 MAIO	13 MAIO	14 MAIO	15 MAIO	16 MAIO	18 MAIO	19 MAIO	20 MAIO	21 MAIO	22 MAIO	24 MAIO
Presidente inclui novos setores como essenciais, mas estados podem descumprir a regra.	Estudo no Journal of the American Medical Association não encontra evidências de que cloroquina reduz mortalidade por COVID-19.	Presidente defende cloroquina enquanto ministro da Saúde alerta para riscos.	Transmissão comunitária atinge pico com mais de 13 mil casos em um dia.	Ministro Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde.	Estado de São Paulo supera a China em número de mortes por COVID-19.	Primeira vacina contra COVID-19 induz resposta imune positiva em testes iniciais.	COVID-19 torna-se a principal causa de morte no Brasil.	Ministério da Saúde, sob Pazuello, oficializa uso da cloroquina para casos leves de COVID-19.	Flocruz alerta para falta de acesso à saúde de 7,8 milhões de brasileiros.	Brasil consolida-se como epicentro global da pandemia.	Governo do Pará encerra lockdown na região metropolitana de Belém.
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
27 MAIO	30 MAIO	31 MAIO	02 JUNHO	05 JUNHO	08 JUNHO	07 JUNHO	09 JUNHO	11 JUNHO	22 JUNHO	27 JUNHO	
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil registra 143 mortes indígenas por COVID-19, destacando subnotificação.	Presidente realiza atos públicos sem máscara e com aglomerações durante a pandemia.	Bolsonaro realiza passeio a cavalo em ato simbólico contra o STF.	Estudo da UFRGS projeta 1 milhão de infectados e 50 mil mortes para junho.	Bolsonaro ameaça retirar Brasil da Organização Mundial da Saúde.	Governo Federal retira do ar painel de dados da COVID-19 do Ministério da Saúde.	Presidente testa positivo para COVID-19 e compara pandemia a "chuva" inevitável.	STF determina e governo retoma divulgação integral dos dados da pandemia.	Presidente incita apoiadores a invadirem hospitais para verificar lotação.	Discrepância entre dados federais e estaduais de COVID-19 evidencia crise de informação.	Ministério da Saúde antecipa data da primeira morte por COVID-19 para 12 de março.	

Fonte: autora (2025).

4.2.1. De Wuhan para o Brasil: o primeiro semestre de 2020 da Pandemia

A emergência sanitária global que se configuraria como a pandemia de COVID-19 teve seus primeiros indícios registrados em 8 de dezembro de 2019, quando um hospital em Wuhan, China, identificou um aglomerado de casos de pneumonia desconhecida, posteriormente associados a um mercado atacadista de animais da região. Este evento representou o surgimento do agente patogênico SARS-CoV-2. Em 5 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu seu primeiro comunicado oficial sobre o surto, notificando a existência de 44 casos da então denominada “pneumonia de causa desconhecida”, marcando o início do alerta formal aos sistemas de vigilância sanitária internacionais. Um marco crucial no entendimento da nova doença ocorreu em 9 de janeiro de 2020, com a divulgação do primeiro código genético do vírus, possibilitando à comunidade científica global iniciar o desenvolvimento de testes diagnósticos e investigar abordagens terapêuticas. A escalada da preocupação internacional foi formalmente reconhecida pela OMS em 28 de janeiro, quando a organização admitiu que o risco de uma epidemia global era alto, representando um alerta solene para que os países implementassem medidas de preparação e resposta frente à iminente propagação do vírus que, em poucas semanas, se espalharia por todos os continentes.

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi confirmado oficialmente em 26 de fevereiro de 2020, referente a um paciente do sexo masculino de 61 anos com histórico de viagem recente ao norte da Itália. O diagnóstico foi realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein na cidade de São Paulo, onde o indivíduo havia sido internado na data anterior apresentando sintomas compatíveis com a doença (Agência Brasil, 2025b). Este marco inicial representou o início da circulação comunitária do vírus SARS-CoV-2 no território nacional, inaugurando um novo capítulo na história da saúde pública brasileira.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a COVID-19 uma pandemia global, conforme pronunciamento da Organização das Nações Unidas (ONU). A decisão foi fundamentada na aceleração exponencial da disseminação do vírus SARS-CoV-2, evidenciada pelo aumento de treze vezes no número de casos e pela triplicação do número de países afetados fora da China em um período de duas

semanas, com transmissão comunitária sustentada registrada em todos os continentes.

Em pronunciamento histórico, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou profunda preocupação com os níveis alarmantes de propagação e de inação (Organização Pan-americana de Saúde, 2020). Apesar da gravidade do momento, ele enfatizou que a declaração de pandemia não alterava as ações recomendadas pela organização e que seria um erro os países abandonarem a estratégia de contenção. Tedros apelou por uma resposta internacional coordenada e mais agressiva, sublinhando a necessidade imperiosa de os países encontrarem um equilíbrio entre a proteção da saúde pública, a minimização das disrupções econômicas e sociais e o respeito aos direitos humanos.

Em 22 de março de 2020, o governo federal brasileiro editou a Medida Provisória nº 936, estabelecendo um regime excepcional de suspensão temporária de contratos de trabalho por até quatro meses como resposta aos impactos econômicos da pandemia de COVID-19. Conforme noticiado pela imprensa, o dispositivo permitia que empresas suspendessem os contratos mediante manutenção de benefícios como plano de saúde e oferta de qualificação profissional online (Forbes, 2020).

A medida, que gerou intenso debate público, autorizava ainda o pagamento de auxílio financeiro não salarial, com valor definido por acordo entre as partes (G1, 2020r). O instrumento normativo, que entrou em vigor imediatamente após sua publicação, estava sujeito à conversão legislativa no prazo de 120 dias, conforme estabelece a Constituição Federal (Brasil, 2020).

Em 23 de março de 2020, o governo federal editou e revogou, no mesmo dia, medidas provisórias, para lidar com a pandemia de COVID-19 em um contexto de crescente tensão, com o Ministério da Saúde declarando transmissão comunitária em todo o país e mais de 1.960 casos confirmados (G1, 2020b). Entre os dispositivos legais então publicados e subsequentemente revogados, destaca-se a Medida Provisória nº 927, justificada pelo Executivo como necessárias para evitar demissões em massa durante a crise sanitária (Valor Econômico, 2020). Tal medida foi revogada logo após sua edição, diante de fortes críticas de especialistas, parlamentares e centrais sindicais, que as

consideraram excessivamente prejudiciais aos direitos dos trabalhadores (Folha de S.Paulo, 2020a).

Paralelamente, foi publicada a Medida Provisória nº 928, que determinou a suspensão dos prazos para atendimento a solicitações feitas com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) para órgãos com servidores em regime de teletrabalho ou atuando prioritariamente no combate à pandemia (BRASIL, 2020). A vigência desta disposição estava condicionada à permanência do estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia do novo coronavírus, sendo justificada pela Controladoria-Geral da União como forma de evitar punições a servidores sem acesso físico aos dados durante a emergência sanitária (BRASIL, 2020s). Entretanto, a medida gerou críticas de mais de 50 entidades da sociedade civil, incluindo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Transparência Brasil, que alertaram para o estabelecimento de um precedente perigoso e o risco da transparência pública tornar-se uma vítima colateral na guerra contra o coronavírus (Transparência Brasil, 2020).

Em 2 de abril de 2020, foi sancionada a Lei nº 13.982, estabelecendo o auxílio emergencial de R\$ 600,00 como principal medida de proteção social durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional em sessão virtual no dia 30 de março, representou uma resposta estatal aos graves impactos socioeconômicos decorrentes das medidas de enfrentamento ao coronavírus (Brasil, 2020). O benefício foi destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que atendessem aos critérios de vulnerabilidade econômica definidos na legislação. Conforme destacado pela Agência Brasil, o auxílio emergencial “atingiu cerca de 54 milhões de brasileiros em sua primeira fase, configurando-se como fundamental para a manutenção da segurança alimentar e do poder de consumo das famílias durante o período mais crítico das medidas de distanciamento social” (Agência Brasil, 2020b).

A implementação do programa ocorreu em tempo recorde, com os primeiros pagamentos sendo realizados apenas nove dias após a publicação da lei, conforme registrou a Folha de São Paulo (Folha de S. Paulo, 2020e). A operacionalização ficou a cargo de instituições financeiras públicas federais, por meio de contas poupança sociais digitais abertas automaticamente para os

beneficiários. Segundo análise do G1, o auxílio emergencial representou "a maior ação de transferência de renda da história do país" (G1, 2020c), com impacto significativo na redução da pobreza extrema durante os meses mais críticos da pandemia. O programa estabelecia que cada família poderia receber até dois benefícios, com valor duplicado para mulheres chefes de família, alcançando R\$ 1.200,00 mensais.

Em 10 de abril de 2020, confirmou-se o primeiro óbito por COVID-19 na população indígena do estado de Roraima, envolvendo o adolescente Alvanei Xirixana, de 15 anos, da etnia Yanomami. Conforme registrado pela Agência Brasil, o paciente "permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Roraima desde 3 de abril" (Agência Brasil, 2020c), evidenciando a rápida progressão da doença. Este caso inaugural, amplamente noticiado como um "marco trágico" pela BBC News Brasil (BBC NEWS, 2020d), expôs a vulnerabilidade epidemiológica específica dos povos originários frente à pandemia. O episódio ganhou contornos ainda mais graves considerando que, conforme noticiou o G1 Roraima, "o adolescente era natural da aldeia Rehebe, na região do Palimiú, Terra Indígena Yanomami, onde vivem aproximadamente 9.800 indígenas" (G1 RR, 2020d), destacando o potencial de disseminação do vírus em comunidades com limitado acesso a serviços de saúde.

Especialistas em saúde indígena entrevistados pelo El País alertaram que "a combinação entre desassistência histórica, alta prevalência de comorbidades e a invasão de garimpeiros no território yanomami criava uma tempestade perfeita para uma tragédia anunciada" (El país, 2020a). A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) emitiu nota técnica reconhecendo o "elevado risco de dispersão do vírus entre populações indígenas devido às suas particularidades culturais e epidemiológicas" (Brasil, 2020u)³.

Em 16 de abril de 2020, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou o então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, marcando a primeira mudança no comando da pasta durante a pandemia de COVID-19. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, a demissão ocorreu em um contexto de "profundas divergências públicas entre o Planalto e o Ministério da Saúde sobre as estratégias de enfrentamento à pandemia" (Folha de S.Paulo,

³ BRASIL, Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Nota Técnica nº 45/2020. Brasília, 10 abr. 2020.

2020b). Para sucedê-lo, foi nomeado o médico oncologista e empresário Nelson Teich, cuja posse foi oficializada através de edição extra do Diário Oficial da União publicada na mesma data, através do Decreto nº 10.317, de 16 de abril de 2020 e do Decreto nº 10.318, de 16 de abril de 2020.

Segundo análise do jornal O Globo, "as críticas públicas de Bolsonaro às medidas de isolamento defendidas por Mandetta tornaram insustentável a permanência do ministro" (O globo, 2020a). A BBC News Brasil destacou que "a popularidade de Mandetta, que chegava a 76% segundo pesquisa Datafolha, contrastava com os 33% de aprovação do presidente na mesma pesquisa, alimentando ainda mais as tensões políticas" (BBC news, 2020c).

A nomeação de Nelson Teich, conforme noticiado pelo G1, "representou a tentativa do governo de alinhar o Ministério da Saúde ao Palácio do Planalto, embora o novo ministro também tenha formação médica e defendesse medidas baseadas em evidências científicas" (G1, 2020e).

Em 20 de abril de 2020, enquanto estados e municípios brasileiros intensificavam as medidas de restrição para conter o avanço da COVID-19, o debate sobre a implementação do lockdown ganhava centralidade no cenário nacional. Em meados de abril, quando o país registrava 2.584 óbitos pela doença, essa discussão se tornou ainda mais complexa devido as declarações do Presidente Jair Bolsonaro contrárias a essa medida. O lockdown, medida mais rigorosa de isolamento social, já havia sido adotado pioneiramente no estado do Pará em 22 de março e, conforme noticiado pelo G1, "pelo menos oito estados e o Distrito Federal estudavam decretar a medida naquele momento" (G1, 2020f). Esta estratégia de enfrentamento à pandemia encontrava amplo respaldo na população, com pesquisas do Datafolha divulgadas pelo CNN BRASIL indicando que "76% dos brasileiros apoiavam as medidas de restrição mais rigorosas" (CNN Brasil, 2020a).

Foi neste contexto que, durante interlocução com a imprensa no dia 20 de abril, o Presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre o crescente número de mortes pela COVID-19, proferiu a frase "Eu não sou coveiro". A declaração, conforme análise da Folha de S.Paulo, "sintetizou a postura de distanciamento do Planalto em relação à gravidade da crise sanitária" (Folha de S. Paulo, 2020c). O episódio ocorreu em um momento particularmente delicado da gestão federal da pandemia, apenas quatro dias após a exoneração do ministro Luiz Henrique

Mandetta. Segundo análise do El País, o episódio representava a culminação de um mês de tensionamento entre Bolsonaro e ministros que defendiam o isolamento social horizontal (El país, 2020b).

Em 05 de maio de 2020, o governo brasileiro decidiu não participar da iniciativa global coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para desenvolvimento e distribuição equitativa de vacinas e tratamentos contra a COVID-19 (UOL, 2020a). Esta decisão ocorreu em um contexto de crescente tensão entre o governo federal e organismos multilaterais, marcado pela defesa de acordos bilaterais em detrimento de mecanismos de cooperação coletiva. Conforme análise do Boletim Epidemiológico da Fiocruz (2021g), o posicionamento brasileiro representou uma significativa mudança na tradição diplomática do país, historicamente alinhada aos princípios do multilateralismo em saúde. A opção por não integrar a iniciativa da OMS refletiu uma reorientação da política externa brasileira que privilegiou negociações diretas com produtores específicos, conforme documentado pela UOL (2020b) em sua cobertura do episódio.

O afastamento do Brasil desta cooperação internacional ocorreu paralelamente à manifestação de interesse do governo em estabelecer parcerias bilaterais com laboratórios e desenvolvedores de vacinas, estratégia que foi amplamente criticada por especialistas em saúde pública devido ao potencial comprometimento do acesso equitativo às tecnologias médicas (G1, 2020g).

Em 9 de maio de 2020, quando o Brasil ultrapassou a marca de dez mil óbitos por COVID-19, registrou-se uma divergência significativa na postura dos diferentes Poderes do Estado. Enquanto o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) decretaram luto oficial de três dias, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi fotografado pilotando uma moto aquática, conduta amplamente divulgada pela mídia (Correio do povo, 2020; G1, 2020h).

Os Presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, emitiram nota conjunta na qual afirmaram que o Parlamento não se mantinha indiferente à gravidade da crise sanitária (Brasil, 2020n). De forma análoga, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, decretou luto no âmbito da Corte, conclamando, em seu comunicado, a união entre os Poderes da República e a implementação de ações coordenadas, fundamentadas no conhecimento científico (Brasil, 2020p).

A ausência de qualquer manifestação de pesar ou reconhecimento oficial por parte do Poder Executivo federal na ocasião foi notada pela imprensa e por analistas políticos, configurando um contraste institucional significativo (CNN Brasil, 2020b).

Um estudo retrospectivo, publicado em 12 de maio de 2020 no periódico *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, analisou 1.438 pacientes hospitalizados por COVID-19 em Nova York entre 15 e 28 de março, com acompanhamento até 24 de abril. A pesquisa, que se tornou uma referência crítica no debate científico, concluiu que a administração de hidroxicloroquina não foi associada a uma redução significativa no risco de mortalidade intra-hospitalar quando comparada à ausência do tratamento (Geltzer et al., 2020). A publicação deste robusto estudo contribuiu decisivamente para o consenso científico contra a eficácia da cloroquina e seus análogos para o tratamento da COVID-19.

O estudo de Geltzer et al. (2020) utilizou métodos estatísticos robustos, incluindo regressão de Cox e análise de *propensity-score matching*, para controlar possíveis fatores de confusão. Os resultados demonstraram que a taxa de mortalidade ajustada foi de 25,7% no grupo tratado com hidroxicloroquina versus 19,8% no grupo controle. A ausência de benefício estatisticamente significativo foi consistente em todas as análises de sensibilidade realizadas pelos pesquisadores.

Em 13 de maio de 2020, o Brasil registrou um novo pico na transmissão comunitária do SARS-CoV-2, com a confirmação de 11.385 novos casos em um período de 24 horas, superando o recorde anterior de 10.611 diagnósticos (Brasil, 2020a). Nesse contexto epidemiológico crítico, enquanto o país contabilizava aproximadamente 12.531 óbitos pela doença, evidenciou-se uma significativa divergência entre o Presidente da República e o Ministro da Saúde quanto às diretrizes terapêuticas para a COVID-19.

O Presidente Jair Bolsonaro reiterou publicamente sua defesa pelo uso da cloroquina no tratamento da COVID-19, posicionamento que já havia manifestado em ocasiões anteriores (Brasil, 2020m). Esta posição colocou-o em dissonância com as recomendações técnicas de seu próprio Ministro da Saúde, Nelson Teich, que, no dia anterior, havia alertado sobre a ausência de evidências robustas sobre a eficácia do fármaco e seus potenciais efeitos colaterais,

sugerindo a necessidade de um termo de consentimento informado para a sua utilização (Brasil, 2020c).

Em 15 de maio de 2020, o Ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou seu pedido de demissão do cargo, permanecendo por apenas 29 dias à frente da pasta (Brasil, 2020f). Este evento marcou a saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês, aprofundando significativamente a instabilidade política na gestão federal da pandemia de COVID-19.

Em seu breve mandato, Teich defendeu publicamente orientações baseadas em evidências científicas, posicionando-se a favor da manutenção de medidas de distanciamento social controlado e da adoção de cautela no uso da cloroquina e seus derivados para tratamento da COVID-19 (Brasil, 2020d). Estas posições técnicas entraram em rota de colisão com as diretrizes publicamente defendidas pelo Presidente Jair Bolsonaro, que advogava pelo relaxamento das medidas de isolamento e pela liberação ampla da cloroquina (Brasil, 2020l). Em coletiva de imprensa concedida no dia de sua demissão, Teich afirmou que "a vida é feita de escolhas" e que para permanecer no cargo "precisaria estar alinhado" (Brasil, 2020).

Em 19 de maio de 2020, especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) alertavam, já em abril de 2020, que a mudança de gestão no Ministério da Saúde no auge da pandemia era profundamente preocupante, pois ameaçava a continuidade das ações planejadas e a necessária coordenação nacional no combate ao vírus (UFJF, 2020). Essa instabilidade ocorria paralelamente a um afastamento do Brasil de fóruns multilaterais. No final de maio de 2020, senadores manifestaram pública preocupação com o fato de o país ter ficado de fora de iniciativas globais, como a aliança internacional para acelerar a produção de tratamentos e vacinas coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que poderia colocar em risco o futuro acesso do país a esses insumos (Senado Federal, 2020o).

Foi nesse cenário de crescente mortalidade e incertezas políticas que, em 19 de maio de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro proferiu declaração que associou o uso da cloroquina – fármaco cuja eficácia contra a COVID-19 já era questionada pela comunidade científica – a simpatizantes de sua base política, sugerindo que opositores "tomassem tubaína" (UOL, 2020a).

Em 20 de maio de 2020, durante a gestão do ministro interino General Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde publicou diretriz que recomendava o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de casos leves de COVID-19 (Brasil, 2020h). Esta posição foi estabelecida em um contexto de crescente consenso científico internacional sobre a falta de eficácia terapêutica desses fármacos contra a doença, configurando um significativo desalinhamento entre a política de saúde brasileira e as evidências científicas disponíveis.

O protocolo do Ministério da Saúde, publicado em um momento em que o país registrava mais de 250 mil casos confirmados e se aproximava de 17 mil óbitos, orientava a utilização dos medicamentos mesmo para pacientes com sintomas leves, desde que houvesse concordância do médico e do paciente (Brasil, 2020). Esta recomendação foi emitida apesar da ausência de estudos robustos que comprovassem a eficácia do tratamento e da existência de evidências sobre potenciais efeitos adversos, especialmente cardíacos.

Paralelamente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reafirmou publicamente sua posição contrária ao uso desses medicamentos fora de ensaios clínicos controlados, alertando que a administração em contextos não experimentais apresentava um perfil de risco desfavorável, com efeitos colaterais que superavam os eventuais benefícios (OMS, 2020a). A entidade recomendou, portanto, que o uso fosse restrito estritamente a contextos de pesquisa, posicionamento compartilhado por diversas sociedades médicas internacionais e nacionais, incluindo a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Em 22 de maio de 2020, o Brasil consolidou-se como epicentro global da pandemia de COVID-19, ultrapassando a Rússia e tornando-se o segundo país com maior número de casos confirmados em nível mundial, atrás apenas dos Estados Unidos (OMS, 2020b). Este marco refletiu a intensa e descontrolada transmissão comunitária do vírus em território nacional, que já havia sido declarada pelo Ministério da Saúde em março daquele ano (Brasil, 2020e). Conforme análise de pesquisadores brasileiros em colaboração com a Universidade de Oxford, citada pelo El País (2020c), as taxas de mortalidade no país seguiam uma trajetória exponencial similar à observada nos Estados Unidos, configurando um cenário epidemiológico de extrema gravidade. A situação foi agravada pela insuficiente capacidade de testagem, com o país realizando

apenas aproximadamente 1.600 testes por milhão de habitantes, resultando em significativa subnotificação de casos (Fiocruz, 2020c). Paralelamente, a Organização Mundial da Saúde destacou que a América do Sul havia se tornado o novo epicentro global da pandemia, sendo o Brasil o país mais afetado da região (OMS, 2020b).

Em 27 de maio de 2020, enquanto o Brasil consolidava-se como epicentro global da pandemia, registrando recordes diários de contaminação, evidenciou-se o impacto desproporcional da COVID-19 sobre os povos indígenas e as limitações dos sistemas oficiais de vigilância epidemiológica. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) divulgou, no final do mês, um levantamento independente que contabilizava 143 óbitos e 1.256 casos de contaminação entre populações indígenas, números significativamente superiores aos registros oficiais do governo federal, que reportavam 40 mortes e 824 diagnósticos no mesmo período (APIB, 2020; Brasil, 2020b). A disparidade entre os dados oficiais e o monitoramento realizado pela organização indígena evidenciou críticas consistentes sobre a subnotificação e a precariedade do sistema de vigilância epidemiológica voltado especificamente para os povos originários. Paralelamente a esta constatação, o Brasil consolidou-se como o país com os piores indicadores globais do dia, registrando, em 24 horas, 20.599 novos casos confirmados e 1.086 óbitos por COVID-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2020g).

Em 5 de junho de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro emitiu uma declaração pública ameaçando retirar o Brasil da OMS, acusando a entidade de atuar com um suposto "viés ideológico" (Brasil, 2020k). Este posicionamento alinhou-se diplomaticamente à postura do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia formalizado o rompimento de seu país com a OMS dias antes (G1, 2020i). Esta não foi uma ação isolada, mas parte de um distanciamento progressivo do Brasil das instâncias de cooperação global, manifestado um mês antes, em maio, quando o país ficou de fora de uma aliança mundial de mais de 40 países para acelerar a produção de vacinas e apoiar a OMS (UOL, 2020c).

Paralelamente a essa retórica de confronto, o país dependia ativamente do cenário global que criticava. Conforme destacado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2021f), a instituição empenhava-se em um extenso trabalho que

incluía desde a ampliação da capacidade de testagem e assistência hospitalar até a adaptação de sua fábrica para a produção nacional de uma vacina, um esforço que consumiu investimentos próprios superiores a R\$ 1,9 bilhão e dependia de acordos de transferência de tecnologia com desenvolvedores internacionais. Apenas dois dias após a ameaça de saída da OMS, o Ministério da Saúde anunciou a previsão de recebimento do primeiro lote da vacina candidata de Oxford para a Fase 3 de ensaios clínicos no Brasil (G1, 2020j).

Em 11 de junho de 2020, durante o pico da primeira onda pandêmica no Brasil, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, conclamou publicamente seus apoiadores a adentrarem hospitais públicos e de campanha para documentar, por meio de gravações, a situação de ocupação dos leitos de emergência (Folha de S. Paulo, 2020d). Esta incitação, veiculada em transmissão pelas redes sociais, visava a produção de material audiovisual que supostamente comprovaria a subutilização da estrutura hospitalar, contestando assim os dados oficiais sobre a saturação do sistema de saúde durante a pandemia.

O posicionamento presidencial ocorreu em um contexto epidemiológico comprovadamente crítico. Conforme dados do Conselho Federal de Medicina (CFM, 2020), o sistema de saúde brasileiro enfrentava colapso em diversas unidades federativas, com taxas de ocupação de leitos de UTI COVID-19 superiores a 90% em estados como Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro.

A medida foi amplamente criticada por entidades médicas e de classe, que a caracterizaram como um risco à segurança de profissionais e pacientes, uma violação à privacidade e um potencial vetor de contaminação intra-hospitalar (Associação médica brasileira, 2020). O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2020) emitiu nota técnica alertando que a exposição de pacientes e equipes a aglomerações não autorizadas configurava violação grave dos princípios éticos e de biossegurança, podendo caracterizar infração administrativa e penal conforme o Código Penal Brasileiro.

Dessa forma, o primeiro semestre de 2020 encerrou-se com um cenário epidemiológico caracterizado pela progressão ininterrupta da curva de contágios, sem indícios de estabilização. Contudo, o segundo semestre iniciou-se com perspectivas promissoras no campo da pesquisa científica, marcado pelo acelerado desenvolvimento de imunizantes contra a COVID-19, impulsionado

por investimentos de empresas farmacêuticas e iniciativas coordenadas de diversos países.

Figura 7 - Diagrama temporal do segundo semestre de 2020 da Pandemia de COVID-19

2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
01 JULHO	03 JULHO	07 JULHO	21 JULHO	22 JULHO	06 AGOSTO	08 AGOSTO	11 AGOSTO	14 AGOSTO	01 SETEMBRO	03 SETEMBRO	04 SETEMBRO
Mortes por COVID-19 caem 2% em uma semana, enquanto casos sobem 13%.	Presidente veto artigos que obrigavam uso de máscaras em estabelecimentos privados e ações de fiscalização.	Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para a COVID-19.	Iniciam os testes de Fase 3 da vacina contra COVID-19 no Brasil.	Brasil atinge novo recorde de casos diários de COVID-19: 65.339 infecções.	Instituto Butantan projeta vacina contra COVID-19 para outubro.	Brasil atinge a marca de 100 mil mortes por COVID-19. País se torna o 2º no mundo em mortes e casos totais de COVID-19.	Rússia anuncia registro da primeira vacina contra COVID-19, a Sputnik V.	Governo federal rejeita a primeira proposta de vacinas da Pfizer.	Presidente declara que "ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina".	Presidente afirma que máscara "não protege bulhufas". Declaração contra máscaras ocorre com mais de 124 mil mortes no país.	Ministério da Saúde prevê distribuição de vacinas para início de 2021. Anvisa libera venda de Ivermectina e Nitazoxanida sem retenção de receita.
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
30 SETEMBRO	05 OUTUBRO	24 OUTUBRO	29 OUTUBRO	10 NOVEMBRO	15 NOVEMBRO	15 DEZEMBRO	17 DEZEMBRO	24 DEZEMBRO	31 DEZEMBRO		
Butantan anuncia início de testes da CoronaVac em crianças e adolescentes.	Entrega de 30 milhões de doses da vacina de Oxford é adiada para janeiro de 2021.	Bolsonaro desautoriza compra federal e chama CoronaVac de "vacina chinesa de Doria".	Rússia inicia processo de registro da Sputnik V junto à Anvisa.	Presidente declara que Brasil precisa "deixar de ser um país de maricas". Fala pejorativa sobre pandemia é proferida com mais de 162 mil mortes.	Testes da CoronaVac são brevemente suspensos após morte de voluntário.	Governo federal apresenta plano de vacinação sem data de início. Plano Nacional de Imunização é divulgado sob determinação do STF. Enquanto governo federal apresenta rascunho, SP anuncia data para início da vacinação.	STF autoriza obrigatoriedade vacinal, enquanto Presidente faz declarações contra vacinas. Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem decretar vacinação obrigatória. Presidente afirma "se tomar vacina e virar jacaré, problema é seu".	Governo aumenta imposto de importação sobre cilindros de oxigênio.	CoronaVac atinge eficácia mínima de 50% exigida pela OMS.		

Fonte: autora (2025).

4.2.2. O esperarçar através das vacinas: o segundo semestre de 2020.

Em 03 de julho de 2020, a gestão federal da crise sanitária foi marcada por tensões institucionais entre o governo central e outros entes federativos. Um dos reflexos desse conflito foi a edição e subsequente modificação da lei que instituía o uso obrigatório de máscaras no país. Ao sancionar a Lei nº 14.019/2020, aprovada pelo Congresso Nacional, que determinava o uso de máscaras em locais públicos, o Presidente Jair Bolsonaro vetou pontos centrais do texto. Foi suprimida a obrigatoriedade do item em estabelecimentos comerciais, indústrias, igrejas e templos, sob a justificativa de que a medida consistiria em violação de domicílio. Também foi vetada a obrigação do poder público de distribuir máscaras gratuitamente para a população de baixa renda, a previsão de aplicação de multas para quem não usasse o equipamento e a realização de campanhas públicas para incentivar seu uso.

Contudo, a autoridade dos estados e municípios para legislar sobre o tema já havia sido reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 15 de abril de 2020, através da ADI 6.341 (Brasil, 2020q). Em decisão unânime, a Corte reconheceu a competência concorrente dos entes subnacionais para adotar suas próprias medidas de enfrentamento à pandemia, fundamentando que o cidadão deveria seguir as regras estabelecidas no local onde mora, mesmo que divergentes da orientação federal. Esse entendimento consolidou o papel dos estados e municípios como principais atores na linha de frente da implementação de políticas de saúde pública durante a crise.

Em 6 de agosto de 2020, o Instituto Butantan anunciou a possibilidade de registro de uma vacina contra o coronavírus ainda no mês de outubro daquele ano. Durante audiência na Câmara dos Deputados, o diretor da instituição, Dimas Covas, afirmou que a vacina, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, estava em fase final de testes com 9 mil voluntários nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal (Butantan, 2020).

Conforme explicou Covas (G1, 2020k), o cronograma previa a conclusão dos estudos de fase III até setembro, com submissão do dossiê à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de outubro. O diretor ressaltou que, se comprovada a eficácia e segurança do imunizante, a vacina seria

imediatamente incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) mediante celebração de contrato de fornecimento com o Ministério da Saúde (UOL, 2020d). O anúncio representou um marco importante na resposta brasileira à pandemia, uma vez que o país dependia até então de iniciativas internacionais para acesso às vacinas. A perspectiva de um imunizante produzido nacionalmente pelo Butantan, instituição com tradição na fabricação de soros e vacinas, gerou expectativas quanto à autonomia do país no enfrentamento à crise sanitária (Fiocruz, 2020b).

O processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19 pelo governo brasileiro em 2020 foi marcado por uma sequência de oportunidades perdidas, conforme documentado pela CPI da Pandemia (Senado Federal, 2021p). Em 14 de agosto de 2020, a Pfizer encaminhou ao Ministério da Saúde três propostas consecutivas para fornecimento de vacinas, conforme detalhado em depoimento do presidente regional da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, à CPI da Pandemia (Senado Federal, 2021a).

A primeira oferta foi apresentada em 14 de agosto de 2020, prevendo a entrega de 500 mil doses em dezembro de 2020 e totalizando 70 milhões de doses até junho de 2021 (Pfizer, 2020 apud Senado Federal, 2021a). A segunda proposta, enviada em 18 de agosto, aumentava para 1,5 milhão o número de doses a serem entregues ainda em 2020 (Pfizer, 2020 apud Brasil, 2021q). A terceira oferta, de 26 de agosto, mantinha o volume de 70 milhões de doses com validade de 15 dias, prazo que se esgotou sem resposta do governo federal (Pfizer, 2020 apud Brasil, 2021q).

Conforme atestado por Carlos Murillo (2021q) em seu depoimento, "as propostas expiraram por falta de resposta do Ministério da Saúde". Este comportamento do governo federal não se limitou às negociações com a Pfizer, mas estendeu-se a outras oportunidades, como atestado por Dimas Tadeu Covas (diretor do Instituto Butantan) em depoimento à CPI da Pandemia, que revelou a não resposta a uma oferta de 60 milhões de doses da CoronaVac enviada pelo Instituto Butantan em julho de 2020. As consequências dessas recusas sucessivas refletiram-se no calendário nacional de vacinação, que somente teve início em 17 de janeiro de 2021, conforme registro da Fiocruz (2021e), mais de um mês após o início da vacinação em outros países ocidentais. O primeiro contrato com a Pfizer foi assinado apenas em março de 2021 (Brasil,

2021h), configurando um atraso de sete meses nas tratativas que impactou o enfrentamento da pandemia no país.

Em 04 de setembro de 2020, no contexto da gestão federal da pandemia de COVID-19 no Brasil, o Ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello, manifestou publicamente durante reunião da Organização Mundial da Saúde a expectativa de que as vacinas contra o vírus estariam disponíveis para distribuição "ainda no início de 2021", desde que sua eficácia fosse comprovada (GZH, 2020). Esta declaração ocorreu em um momento em que o país contabilizava um crescente número de casos e óbitos, refletindo a corrida global pelo desenvolvimento de imunizantes e a pressão interna por uma solução definitiva para a crise sanitária.

Paralelamente ao discurso oficial sobre as vacinas, consolidou-se no país uma política de incentivo a tratamentos precoces sem comprovação científica robusta. O próprio Ministério da Saúde, sob o comando de Pazuello, elaborou um protocolo para ampliar o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves de COVID-19, medida tomada "na contramão de estudos recentes" que não apontavam eficácia para o medicamento (GZH, 2020). Esta postura ocorria em um ambiente de confronto com as orientações de organismos multilaterais de saúde, culminando, em junho de 2020, com a ameaça pública do Presidente Jair Bolsonaro de retirar o Brasil da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando-a de possuir um "viés ideológico" (G1, 2020l).

Em 24 outubro de 2020, o governador de São Paulo, João Doria, assinou contrato com a biofarmacêutica chinesa Sinovac para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac e para a transferência de tecnologia ao Instituto Butantan, viabilizando a fabricação nacional do imunizante (São Paulo, 2020a). Esta iniciativa subnacional colocou São Paulo como o único estado brasileiro com um calendário de vacinação definido, que previa o início da imunização em 25 de janeiro de 2021.

Em oposição a esta medida, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou sua conta no Twitter para questionar publicamente o investimento no que denominou "a vacina chinesa de João Doria" (Bolsonaro, 2020). Esta manifestação pública resultou na desautorização, por parte do Presidente, da compra de 46 milhões de doses da CoronaVac pelo governo federal, anulando tratativa anteriormente anunciada pelo então Ministro da Saúde, Eduardo

Pazuello. O conflito institucional aprofundou-se quando o governo de São Paulo anunciou que assumiria a distribuição da CoronaVac para seus 645 municípios caso o governo federal se recusasse a adquirir as doses, elaborando um "plano B" que utilizaria a estrutura do SUS em coordenação com as secretarias municipais de saúde (CNN Brasil, 2020c). O Secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, em entrevista concedida para a CNN Brasil (2020c), salientou que, embora a logística estadual estivesse garantida, a não incorporação da vacina no Programa Nacional de Imunizações configuraria um "problema social" e "antirrepublicano", pois privaria cidadãos de outros estados do acesso ao imunizante. Este episódio evidenciou as profundas divergências na condução da política de enfrentamento à pandemia entre diferentes esferas de governo.

Em 15 de dezembro de 2020, em cumprimento a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal apresentou uma versão preliminar do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (Brasil, 2020i). O documento, com suas 94 páginas, foi recebido com significativas ressalvas por especialistas em saúde pública, que o caracterizaram como impreciso por não estabelecer datas específicas para o início da imunização em território nacional (Oliveira et al., 2022).

O plano federal propunha a divisão da vacinação em quatro etapas, organizadas conforme grupos populacionais prioritários, mas carecia de um cronograma operacional detalhado (Brasil, 2020). Esta vagueza contrastava fortemente com o anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo, que, na segunda-feira anterior à divulgação do plano federal, já havia estabelecido a data de 25 de janeiro de 2021 para o início da vacinação em seu território (São Paulo, 2020b). A disparidade entre os planejamentos estadual e federal evidenciou as tensões federativas que marcaram o enfrentamento da pandemia no Brasil.

Em 17 de dezembro de 2020, o Brasil atingiu a marca de 184.827 mortes por COVID-19 em um contexto de profunda polarização acerca da vacinação, que opunha declarações públicas do Presidente da República a decisões técnicas do Supremo Tribunal Federal (STF). O Presidente Jair Bolsonaro, reforçando sua oposição pública à imunização compulsória, manifestou-se sobre os termos de responsabilidade de fabricantes de vacinas, afirmando: "Se tomar vacina e virar jacaré não tenho nada a ver com isso" (G1, 2023). Em referência ao contrato com a Pfizer, declarou que a farmacêutica "não se responsabiliza por

possíveis efeitos colaterais" e completou: "Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Se você virar um super-homem, se nascer barba em alguma mulher ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. E, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas" (G1, 2023).

Em direção oposta, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária, estabeleceu que a obrigatoriedade da vacinação e a implementação de sanções poderiam ser determinadas por estados, municípios e Distrito Federal. Por 10 votos a 1, a tese vencedora fundamentou-se na "supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse individual diante da emergência sanitária" (Brasil, 2020r), descartando a exigência de consentimento prévio individual para imunização. O entendimento do tribunal foi de que o direito à vida e à saúde, consagrados na Constituição Federal como direitos fundamentais de primeira e segunda geração, respectivamente, prevalecem sobre interesses individuais em situações de calamidade pública (Brasil, 2020). O ministro Nunes Marques, único a divergir, votou pela competência exclusiva da União para determinar a vacinação compulsória.

Às vésperas do Natal de 2020, o Ministério da Economia elevou a alíquota do imposto de importação sobre cilindros de oxigênio, dispositivo indispensável para a oxigenoterapia de pacientes em estado grave (CNN Brasil, 2020d). Conforme apurado a partir de documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação, a elevação tarifária foi uma consequência direta da exclusão desses itens da lista de produtos com tarifa zero pelo Ministério da Saúde (gazeta do povo, 2020b). A revogação do benefício fiscal, que vigorou até a primeira quinzena de janeiro de 2021, tornou mais onerosa a aquisição internacional desse insumo em um momento em que o sistema de saúde brasileiro já enfrentava sérias dificuldades de abastecimento.

O segundo semestre de 2020 caracterizou-se pelo desenvolvimento acelerado de pesquisas para a produção de vacinas contra a COVID-19, cujos resultados possibilitaram o início da vacinação no território nacional no primeiro semestre de 2021. Contudo, este mesmo período foi marcado por elevados índices de mortalidade, com o mês de março configurando-se como o mais letal de toda a pandemia.

Figura 8 -Diagrama temporal do primeiro semestre de 2021 da Pandemia de COVID-19

2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
05 JANEIRO	07 JANEIRO	08 JANEIRO	11 JANEIRO	14 JANEIRO	17 JANEIRO	22 JANEIRO	04 FEVEREIRO	11 FEVEREIRO	04 MARÇO	05 MARÇO	12 MARÇO
Presidente afirma que "Brasil está quebrado" e "não consegue fazer nada".	Brasil atinge 200 mil mortes por COVID-19.	CoronaVac atinge 50,38% de eficácia em estudos divulgados pelo Butantan.	Ministro Pazuello afirma que vacina começará no "dia D, na hora H".	Colapso do sistema de saúde de Manaus causa mortes por falta de oxigênio.	Primeira vacina contra COVID-19 é aplicada no Brasil.	Presidente afirma que Coronavac "não está comprovada cientificamente".	Ministério da Saúde inicia negociações para vacinas Sputnik V e Covaxin.	Presidente classifica quem "entra na pilha da vacina" como "idiota útil".	Bolsonaro defende fim das restrições: "Chega de frescura e mimi".	Gestão da crise coloca Brasil como ameaça sanitária internacional.	Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford/AstraZeneca.
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
15 MARÇO	16 MARÇO	23 MARÇO	25 MARÇO	26 MARÇO	28 MARÇO	30 MARÇO	31 MARÇO	01 ABRIL	08 ABRIL	27 ABRIL	14 MAIO
Marcelo Queiroga é anunciado como quarto ministro da Saúde na pandemia.	Brasil vive maior colapso hospitalar da história, com UTIs acima de 80% em 25 unidades federativas.	Brasil ultrapassa 3 mil mortes por COVID-19 em um único dia.	País ultrapassa 300 mil mortes por COVID-19.	Butantan anuncia ButanVac, primeira vacina 100% nacional.	Brasil atinge novo recorde na média móvel de mortes por COVID-19: 2.598 óbitos/dia.	Março de 2021 se torna o mês mais letal da pandemia no Brasil (62.918 mortes).	Brasil atinge novo recorde de mortes por COVID-19: 3.869 óbitos em 24h.	País ultrapassa 325 mil mortes totais por COVID-19.	Brasil atinge maior número de mortes por COVID-19 em 24h: 4.249 óbitos.	Senado instala CPI da COVID-19 para investigar ações do governo federal na pandemia.	Bolsonaro equipara criminalização da cloroquina à liberação da maconha. "Se falar cloroquina é crime, falar em maconha é legal", diz Bolsonaro.
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
17 MAIO	23 MAIO	05 JUNHO	09 JUNHO	12 JUNHO	16 JUNHO	17 JUNHO	24 JUNHO	25 JUNHO	28 JUNHO	31 JUNHO	
Presidente chama de "idiotas" quem segue recomendação de ficar em casa.	Bolsonaro declara que Brasil está "no final da pandemia". Presidente e ministro são autuados por aglomeração sem máscara em "motociclista".	Presidente participa de 84 aglomerações durante a pandemia.	Presidente afirma que "nunca viu ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina".	Presidente é autuado por descumprir normas sanitárias em "motociclista" em SP.	Butantan atinge marca de 50 milhões de doses da CoronaVac entregues ao Plano Nacional de Imunização.	Bolsonaro declara que infecção natural (imunidade de rebanho) é mais eficaz que vacina. Presidente afirma que "quem pegou o vírus está 'imunizado'".	Presidente afirma que "não teria morrido tanta gente" sob sua coordenação direta. Bolsonaro atribui mortes à falta de "tratamento precoce" sem eficácia comprovada.	Bolsonaro ameaça usar próprio "tapetão" contra investigações do Senado. Declaração sobre "tapetão" ocorre durante investigação da CPI da COVID.	Junho de 2021 registra 33.660 mortes, com tendência de queda após pico.	Óbitos por COVID-19 caem 42% em julho com avanço da vacinação.	

Fonte: autora (2025).

4.2.3. Crise epidemiológica e tensões institucionais: o cenário brasileiro no primeiro semestre de 2021

Em 11 de janeiro de 2021, durante visita a Manaus, o então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, emitiu uma declaração pública que se tornaria emblemática da fase de implantação do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a COVID-19 no Brasil. Em um contexto onde o país ultrapassava a marca de 200 mil óbitos pela doença, o ministro foi questionado sobre os prazos concretos para o início da vacinação e respondeu que "a vacina vai começar no dia D, na hora H no Brasil" (Correio braziliense, 2021), acrescentando que a imunização ocorreria "a partir do terceiro ou quarto dia" após autorização da Anvisa (Folha de S. Paulo, 2021a).

A fala, caracterizada pela vagueza temporal, ocorreu em um momento de crescente pressão social e política por um cronograma vacinal transparente (Veja São Paulo, 2021a). Esta postura contrastava significativamente com a precisão de cronogramas já anunciados por governos estaduais, como o de São Paulo, que havia estabelecido data específica para o início de sua campanha. A declaração ministerial refletia a ausência de um planejamento detalhado e comunicável por parte do governo federal naquele estágio crítico da pandemia. A autorização da Anvisa para o uso emergencial das primeiras vacinas ocorreu em 17 de janeiro de 2021, e a campanha nacional teve início efetivamente em 19 de janeiro.

Em 14 de janeiro de 2021, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso devido ao aumento progressivo de casos e internações por COVID-19, resultando em uma grave crise de desabastecimento de oxigênio hospitalar (G1, 2022). Paralelamente à emergência sanitária, equipes do Ministério da Saúde promoveram a difusão do chamado "tratamento precoce", em contradição às evidências científicas disponíveis (Diário do centro do mundo, 2021).

O colapso do sistema de saúde no Amazonas foi agravado pela escassez crítica de cilindros de oxigênio, equipamento essencial para a manutenção da vida de pacientes graves. Conforme documentado, a falta deste insumo resultou em consequências fatais: defensores públicos relataram que, entre 15 e 19 de janeiro de 2021, foram registradas pelo menos 30 mortes de pacientes com

COVID-19 por falta de oxigênio ou impossibilidade de remoção para outros centros (Abrasco, 2023).

Em meio a esta crise humanitária, o então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, determinou o deslocamento de equipes para Manaus com o objetivo de implementar o "tratamento precoce" (Diário do centro do mundo, 2021). As equipes realizaram visitas em 13 unidades básicas de saúde para difundir o uso de cloroquina, hidroxiclороquina e azitromicina, medicamentos sem eficácia comprovada contra a COVID-19 (Abrasco, 2023).

Em 17 de janeiro de 2021, após a aprovação do uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a enfermeira Mônica Calazans tornou-se a primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID-19 no Brasil, recebendo a dose do imunizante CoronaVac no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo (Folha de S.Paulo, 2021b). Este marco histórico foi amplamente noticiado e representou o início formal da campanha nacional de imunização (CNN Brasil, 2021a).

A logística de distribuição foi imediatamente acionada, com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) decolando para distribuir as vacinas por todos os estados, permitindo que a campanha tivesse início ainda na mesma semana (BBC news, 2021b). Inicialmente, o país contava com 6 milhões de doses da CoronaVac já em território nacional, e mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca seriam importadas da Índia (BBC news, 2021b).

A estratégia de imunização previa a progressiva nacionalização da produção. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assumiram o compromisso de produzir localmente as vacinas para entregas ao Ministério da Saúde (COFEN, 2021). A previsão estabelecia que a Fiocruz produziria 100 milhões de doses da vacina de Oxford até o primeiro semestre de 2021, e mais 100 milhões até o final do ano. Paralelamente, o Instituto Butantan planejava fabricar 86 milhões de doses da CoronaVac até o final de 2021 (BBC Brasil, 2021).

Em 05 março de 2021, a gestão da pandemia de COVID-19 pelo governo brasileiro resultou em um significativo isolamento internacional do país, que foi caracterizado por veículos de imprensa influentes e por ações concretas de outras nações. Conforme amplamente noticiado, o Brasil foi posicionado como "ameaça sanitária global" por veículos de prestígio internacional como The

Guardian e The New York Times (G1, 2021c). Esta percepção internacional teve consequências práticas imediatas, resultando na suspensão de voos ou estabelecimento de restrições a passageiros vindos do Brasil por pelo menos 18 países (O dia, 2021).

Em 15 de março de 2021, o Brasil atingiu a marca de quatro ministros da Saúde em menos de um ano de pandemia, um reflexo da significativa instabilidade política que caracterizou a gestão federal da crise sanitária (UOL, 2021a). A nomeação do cardiologista Marcelo Queiroga para substituir o general Eduardo Pazuello representou a tentativa de realinhar a pasta a um perfil técnico, ainda que as declarações iniciais do novo ministro mantivessem a tensão entre ciência e política (El país, 2021b).

A substituição ocorreu em um contexto de crescente pressão sobre o governo federal, impulsionada pelo agravamento da pandemia, com recordes consecutivos de mortes e uma campanha de vacinação considerada lenta (G1, 2021d). Pazuello, o ministro mais longo do período pandêmico, havia sido alvo de críticas constantes, incluindo demora na negociação por vacinas e atuação durante a crise de oxigênio em Manaus (Carta capital, 2021a).

Em sua primeira entrevista após a confirmação no cargo, Queiroga buscou delinear os princípios de sua gestão. O novo ministro posicionou-se cautelosamente sobre medidas restritivas, afirmando que o lockdown deveria ser adotado apenas em "situações extremas" e não como política de governo (Agência Brasil, 2021). Paralelamente, anunciou como prioridades a criação de uma "grande união nacional" e o fortalecimento do papel de liderança do Ministério da Saúde (Agência Brasil, 2021).

Em 16 de março de 2021, o Brasil atingiu o ponto mais crítico de sua crise sanitária durante a pandemia de COVID-19. Conforme análise publicada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2021a), o país vivenciava o maior colapso hospitalar de sua história, com um quadro de saturação do sistema de saúde em escala nacional. Os dados, compilados no Boletim Extraordinário do Observatório COVID-19 da Fiocruz, demonstravam que 24 estados e o Distrito Federal registravam taxas de ocupação de leitos de Terapia Intensiva (UTI) para adultos com COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) iguais ou superiores a 80% (Fiocruz, 2021a). Desse total, a situação era ainda mais grave em 15

estados, onde as taxas de ocupação ultrapassavam a marca crítica de 90% (DW, 2021a).

Este cenário de colapso generalizado foi caracterizado por pesquisadores como a maior crise sanitária e hospitalar já registrada no país (Andes, 2021). A análise da Fiocruz alertava para a sobrecarga extrema da capacidade instalada do sistema de saúde, que operava no limite em praticamente todas as regiões brasileiras, com consequências diretas para a mortalidade hospitalar e a qualidade do atendimento prestado à população. O colapso evidenciou as limitações estruturais do SUS frente a uma crise de proporções pandêmicas e a urgência de medidas coordenadas de enfrentamento em nível federal.

Em 30 de março de 2021, o Brasil atingiu o trágico ápice de sua crise sanitária, consolidando aquele como o mês mais letal de toda a pandemia de COVID-19 no país. Conforme dados do consórcio de veículos de imprensa, foram registradas 3.668 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 317.936 desde o início da pandemia (G1, 2021a). A média móvel de mortes, um indicador crucial para analisar a tendência da pandemia, atingiu um novo recorde pelo quinto dia consecutivo, chegando a 2.728 óbitos (G1, 2021a). Com a confirmação de 86.704 novos casos na mesma data, o país totalizava 12.664.058 infecções confirmadas (G1, 2021a).

Com apenas um dia para o seu encerramento, março de 2021 somava 62.918 óbitos, um número que representa quase o dobro do registrado em julho de 2020 (que, até então, era o pior mês da pandemia) (G1, 2021a). Este cenário de colapso não era uniforme em todo o território nacional, mas estava amplamente disseminado: dezessete estados e o Distrito Federal apresentavam tendência de alta nas mortes (G1, 2021a). Esta situação crítica ocorria em um contexto de lenta campanha de vacinação, que até aquela data havia imunizado com a primeira dose apenas 8% da população brasileira (G1, 2021a).

Em 27 de abril de 2021, o Senado Federal instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19 (CPI da Pandemia), através do Ato da Mesa Nº 5, com o objetivo central de apurar ações e omissões do governo federal durante a crise sanitária. A comissão teve como finalidade ouvir autoridades, ex-ministros, executivos de empresas de saúde e outras pessoas relacionadas à gestão da crise sanitária (Brasil, 2021o).

A instalação da CPI atendeu a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ao presidente do Senado a adoção das "providências necessárias à criação e instalação" da comissão (BRASIL, 2021r). Durante seus trabalhos, que se estenderam por quase seis meses, a comissão exerceu poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, incluindo a convocação de ministros de Estado e a requisição de documentos de órgãos públicos (Senado Federal, 2021n).

Em 17 de maio de 2021, quando o Brasil contabilizava oficialmente 436.537 mortes por COVID-19 (Brasil, 2021c), o Presidente Jair Bolsonaro proferiu declaração pública em que se referiu como "idiotas" aos cidadãos que adotavam a medida de "ficar em casa" (Folha de S. Paulo, 2021c). A fala, dirigida a apoiadores, ocorreu em um contexto de crescente polarização política em torno das medidas de enfrentamento à pandemia e de aprofundamento da crise sanitária no país.

O quarto semestre de 2021 configurou-se como um período de relativa superação da crise sanitária no Brasil, marcando uma transição epidemiológica significativa após três semestres caracterizados pelo colapso dos sistemas de saúde. Este cenário de maior otimismo consolidou-se com a expressiva ampliação da cobertura vacinal, culminando no alcance de 80% da população-alvo imunizada com o esquema completo de duas doses ao final do ano (Brasil, 2021g).

Figura 9 - Diagrama temporal do segundo semestre de 2021 da Pandemia de COVID-19

2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
11 JULHO	06 AGOSTO	31 AGOSTO	02 SETEMBRO	08 SETEMBRO	30 SETEMBRO	14 NOVEMBRO	29 NOVEMBRO	30 NOVEMBRO	02 DEZEMBRO	07 DEZEMBRO	16 DEZEMBRO
Presidente não visita hospitais ou postos de vacinação durante pandemia.	Brasil atinge 50% da população com primeira dose e 22% com vacinação completa.	Agosto de 2021 registra menor número de mortes mensais por COVID-19 no ano.	Presidente afirma estar "melhor que o pessoal que tomou CoronaVac".	Presidente afirma que COVID-19 "apenas encurtou a vida por alguns dias".	Setembro de 2021 registra menor número de mortes mensais por COVID-19 no ano (16.275). País atinge 596 mil óbitos totais, mas setembro fecha com menor mortalidade mensal de 2021.	Brasil ultrapassa EUA em porcentagem de população totalmente vacinada contra COVID-19.	Estudo do Butantan na Lancet comprova eficácia coletiva da vacinação.	Novembro de 2021 registra menor número de mortes mensais por COVID-19 desde abril de 2020.	Bolsonaro associa vacinação a "gente de esquerda" que deseja sua morte.	Presidente chama passaporte vacinal de "coleira que querem botar no povo brasileiro".	Brasil aprova primeira vacina pediátrica contra COVID-19 para faixa de 5-11 anos.
2021		2021		2021							
22 DEZEMBRO		24 DEZEMBRO		28 DEZEMBRO							
Sociedades médicas pedem urgência na vacinação infantil contra COVID-19.		Presidente afirma que mortes infantis por COVID-19 "não justificam" vacinação.		Brasil atinge 80% da população adulta totalmente vacinada contra COVID-19. 172 milhões de brasileiros completam esquema vacinal contra COVID-19.							

Fonte: autora (2025).

4.2.4. Proteção populacional pelas vacinas e fenômenos de recusa: segundo semestre de 2021.

Em 11 de julho de 2021, quando o Brasil atingiu a marca de 532.949 óbitos por COVID-19 (Brasil, 2021), a conduta pública do Presidente Jair Bolsonaro caracterizou-se por notória ausência em visitas a hospitais e postos de vacinação, estabelecimentos fundamentais no enfrentamento da crise sanitária. Esta postura contrastava com sua participação regular em eventos políticos do tipo "motociata" em diversas capitais brasileiras (G1, 2021e), incluindo Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Chapecó e Porto Alegre, com planejamento de grande evento similar para o 7 de setembro na capital federal (Folha de S.Paulo, 2021d).

A ausência presidencial nos locais-chave do combate à pandemia ocorreu em um contexto de persistente crise no sistema de saúde, marcado pela escassez de leitos e medicamentos em várias unidades federativas (Fiocruz, 2021b). Enquanto o país registrava números trágicos de mortalidade, a agenda pública do Presidente privilegiou manifestações políticas que, frequentemente, aglomeravam pessoas sem observância das medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias (UOL, 2021b).

Este padrão de conduta refletiu uma significativa dissonância entre a gestão federal da crise e as necessidades sanitárias imediatas, caracterizando uma priorização de agendas políticas em detrimento de ações de supervisão direta da crise nos serviços de saúde. A postura presidencial pode ser interpretada como alinhamento a um discurso público de minimização da gravidade da pandemia, que contrastava com as recomendações da comunidade científica nacional e internacional (The lancet, 2021a).

Em 06 de agosto de 2021, a cobertura vacinal mostrou-se como a principal estratégia para o controle da pandemia, refletindo-se na queda de quase 95% na média móvel de óbitos desde o pico registrado em abril de 2021 (Brasil, 2021m). O sucesso da campanha foi impulsionado pela capacidade de produção nacional de vacinas, articulada pelo Governo Federal por meio de parcerias com instituições como o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e pela aquisição de doses de laboratórios internacionais (Brasil, 2021).

Em 31 de agosto de 2021, o Brasil registrou uma significativa redução na mortalidade por COVID-19, com aproximadamente 24 mil óbitos, representando

o menor número mensal desde dezembro de 2020 (G1, 2021f). Este declínio ocorreu em um contexto de avanço progressivo da campanha de vacinação, que começava a impactar nos indicadores de saúde pública, embora especialistas alertassem para os riscos representados pela variante Delta e pela cobertura vacinal ainda parcial da população (Fiocruz, 2021b).

A melhora nos indicadores de mortalidade refletia, em parte, o aumento da cobertura vacinal no país. Dados do Ministério da Saúde indicavam que, até o final de agosto de 2021, aproximadamente 70% da população havia recebido pelo menos uma dose de vacina contra COVID-19, enquanto 30% encontrava-se com o esquema vacinal completo (Brasil, 2021t). No entanto, a circulação da variante Delta, classificada como de maior transmissibilidade, representava uma ameaça constante à sustentabilidade desta tendência positiva (OMS, 2021).

Em 14 de novembro de 2021, o Brasil atingiu um marco significativo em sua campanha de imunização contra a COVID-19, superando os Estados Unidos no percentual de população com o esquema vacinal completo. Conforme dados da plataforma Our World in Data, vinculada à Universidade de Oxford, o Brasil registrou 59,8% de sua população totalmente imunizada, enquanto os Estados Unidos contabilizavam 57,6% na mesma data (Our world in data, 2021). Este desempenho posicionou o Brasil entre os países que superaram os índices norte-americanos, representando uma conquista notável no contexto da pandemia (G1, 2021g).

O avanço brasileiro na vacinação foi amplamente reconhecido internacionalmente, inclusive pelo cientista Eric Topol, que destacou o feito em suas redes sociais (CNN Brasil, 2021b). A existência de um sistema de saúde pública universal, o Sistema Único de Saúde (SUS), também foi considerada uma vantagem estrutural decisiva para a aplicação em massa das doses (Brasil, 2021).

Em 29 de novembro de 2021, o Instituto Butantan submeteu à revista The Lancet e disponibilizou em formato *preprint* os resultados consolidados do "Projeto S", um estudo abrangente que avaliou o impacto da vacinação em massa com CoronaVac no controle da pandemia de COVID-19 no Brasil (Butantan, 2021). A pesquisa concluiu que a imunização de todos os adultos com o imunizante produziu significativo efeito de proteção populacional, reduzindo em 80,5% o número de casos de COVID-19 e em 94,9% as mortes causadas pela

doença, demonstrando importante proteção indireta mesmo na população não vacinada (Butantan, 2021).

Os resultados do Projeto S, que envolveu estudo em grande escala na cidade de Serrana (SP), forneceram evidências robustas sobre a eficácia da estratégia de vacinação em massa para o controle da transmissão comunitária do SARS-CoV-2 (The Lancet, 2021b). A pesquisa demonstrou que a vacinação em massa com CoronaVac foi capaz de interromper as cadeias de transmissão do vírus, resultando no controle da epidemia mesmo antes da cobertura vacinal atingir níveis teóricos de imunidade de rebanho (Fiocruz, 2021c).

Estes achados corroboraram o papel crucial da vacinação como principal estratégia de saúde pública para o enfrentamento da pandemia, reforçando a importância do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e do Sistema Único de Saúde (SUS) na implementação de campanhas de vacinação em larga escala (Brasil, 2021i). O estudo também destacou o potencial dos imunizantes para reduzir drasticamente a mortalidade por COVID-19, mesmo em contextos de circulação de variantes de preocupação.

Em 30 de novembro de 2021, o Brasil registrou o menor número mensal de óbitos por COVID-19 desde abril de 2020, com 6.894 mortes confirmadas pelas secretarias estaduais de Saúde (G1, 2021h). Este indicador representou uma redução drástica em comparação com o pico epidêmico ocorrido em abril de 2021, quando foram registrados 82.401 óbitos (DW, 2021b), configurando uma diferença de aproximadamente 92% entre os dois períodos.

A trajetória da mortalidade ao longo de 2021 demonstrou uma nítida tendência de declínio após o ápice de abril, com reduções progressivas mensais que culminaram no patamar mais baixo em novembro. Esta melhora nos indicadores epidemiológicos coincidiu com o avanço significativo da campanha de vacinação no país, que em novembro de 2021 já havia imunizado completamente mais de 50% da população brasileira (CNN Brasil, 2021c). O contraste entre os 5.804 óbitos registrados em abril de 2020 - primeiro ano da pandemia - e os 6.894 de novembro de 2021, ambos em patamares reduzidos, evidencia a evolução do cenário epidemiológico nacional ao longo dos diferentes momentos da crise sanitária.

Em 24 de dezembro de 2021, quando o Brasil registrava 618.392 óbitos pela COVID-19 (Brasil, 2021j), o Presidente Jair Bolsonaro manifestou-se

publicamente sobre a vacinação infantil, afirmando que o número de mortes de crianças pela doença não justificava a imunização emergencial para essa faixa etária. Na ocasião, declarou ser o "pai que decide em 1º lugar" sobre a vacinação de seus filhos, posicionando-se contrariamente à medida (Folha de S.Paulo, 2021e). Este posicionamento ocorreu em um contexto de avanço do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, que é responsável por coordenar a política de vacinação no país e disponibilizar imunizantes gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2021k). O PNI, estabelecido em 1973, é reconhecido como uma estratégia fundamental para a promoção da saúde pública no Brasil, atuando na prevenção de doenças graves por meio da imunização (Fiocruz, 2021d).

Em 28 de dezembro de 2021, o Brasil atingiu um marco histórico em sua campanha de imunização, com 80% da população vacinável - compreendendo brasileiros a partir de 12 anos - totalmente imunizada com as duas doses ou dose única da vacina contra a COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde divulgados naquela data (Brasil, 2021g). Este percentual representava, em números absolutos, mais de 143 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo dentro de um público-alvo total de 177 milhões (CNN Brasil, 2021d). A conquista foi resultado da maior campanha de vacinação da história do país. Desde o seu início, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 380 milhões de doses de vacinas COVID-19 aos estados e ao Distrito Federal (Metrópoles, 2021). Dessas, 320 milhões já haviam sido aplicadas, incluindo 161 milhões de primeiras doses (Veja São Paulo, 2021). Com a disponibilidade de remessas adicionais, as unidades federativas já haviam iniciado a aplicação da dose de reforço, totalizando mais de 16 milhões de doses administradas até a data (Campo grande news, 2021).

O ministro da Saúde à época, Marcelo Queiroga, atribuiu o sucesso da campanha a uma "estratégia diversificada na aquisição de vacinas", que garantiu um número suficiente de doses para avançar não apenas com o esquema primário, mas também com o reforço para a população adulta (Brasil, 2021i). A dose de reforço foi ampliada para todos os brasileiros com mais de 18 anos, a ser realizada quatro meses após a conclusão do esquema vacinal primário (Brasil, 2021s).

Assim, o segundo semestre de 2021 encerrou-se com um cenário de cauteloso otimismo no Brasil, impulsionado pela expressiva queda nos indicadores de mortalidade por COVID-19, que contrastava com a ainda trágica marca de 617.121 óbitos acumulados até meados de dezembro daquele ano (G1, 2021i). Este sentimento, contudo, foi temporário, uma vez que a nação atingiria posteriormente a marca de 700 mil mortes em março de 2023 (Brasil, 2023). A trajetória pandêmica entre esses dois marcos reflete uma combinação de fatores críticos, incluindo a aquisição tardia de vacinas, a implementação demorada do plano nacional de imunização e uma significativa instabilidade na condução da pasta da Saúde, evidenciada pela troca de quatro ministros durante o período mais agudo da crise.

Em dezembro de 2021, os dados do consórcio de veículos de imprensa, baseados nas secretarias estaduais de Saúde, apontavam uma tendência consistente de queda na média móvel de óbitos, que atingiu 151 e, no final do mês, chegou a 97. Esta melhora nos indicadores estava diretamente associada ao avanço da campanha de vacinação, que, até 20 de dezembro, já havia imunizado completamente com duas doses ou dose única 66,39% da população. Apesar do cenário em melhora, o sistema de saúde ainda enfrentava desafios, como a redução progressiva de leitos de internação no SUS.

A chegada tardia a um controle mais efetivo da pandemia pode ser atribuída a uma conjunção de elementos, incluindo a instabilidade na liderança, com a rotatividade de quatro ministros da Saúde, o que comprometeu a continuidade e a coordenação de uma estratégia nacional coesa e baseada em evidências científicas. Além disso, o atraso na aquisição de vacinas, com lentidão nas negociações e recusa inicial de ofertas de laboratórios internacionais, retardou o início e a ampliação da campanha de imunização, mantendo a população vulnerável por um período mais prolongado. O ano de 2021 foi o mais letal da pandemia, com mais de 420 mil mortes registradas, o que representou um aumento de 16,9% no número total de óbitos no país em relação a 2020 e superou em mais do dobro o número de óbitos do primeiro ano da pandemia, contexto que explica a trajetória que levou o país a ultrapassar a marca de 700 mil mortes em 2023.

5. Análise da Necropedagogia em Ação: a Pandemia de COVID-19 sob a lente dos Três Pilares

Este capítulo tem como objetivo central articular os resultados do campo empírico, apresentados no capítulo 4 — com base nas notícias veiculadas pela mídia — com o referencial teórico dos capítulos anteriores, a fim de analisar as medidas adotadas durante a pandemia. A análise será organizada mediante a aplicação da estrutura dos três pilares que compõem a necropedagogia (Figura 5). Os eventos constantes do diagrama temporal da pandemia (Figuras 6, 7, 8 e 9) serão classificados de acordo com esses três pilares, Estado Ultraliberal, Necropolítica e Pedagogia da Submissão, podendo um mesmo evento enquadrar-se em mais de uma categoria.

No que se refere ao pilar do **Estado Ultraliberal**, serão analisados eventos que tratam da saúde como nicho de mercado, distanciando-a de sua condição de direito fundamental. A lógica ultraliberal converte a saúde pública em fonte de lucro, conforme exemplificado por práticas emblemáticas como as da Prevent Senior destacada na CPI da Covid-19, a edição das Medidas Provisórias 926/2020, 927/2020 e 936/2020 pelo Presidente da República, e as sucessivas trocas no comando do Ministério da Saúde. Para tanto, o pilar do Estado Ultraliberal pretende se guiar através da seguinte pergunta: *como as ações e omissões do governo durante a pandemia privilegiaram interesses econômicos, a desregulamentação e a mercantilização da vida?*

O **pilar necropolítico** da análise será desenvolvido a partir de uma constelação de eventos que materializam a conversão da morte em tecnologia de governo. O enfoque recai sobre como práticas estatais, mais do que negligenciar, orquestraram politicamente a distribuição diferencial do risco de morrer, configurando uma tentativa — cujos efeitos foram contidos apenas por resistências sociais e institucionais — de intensificar a letalidade entre grupos historicamente vulnerabilizados. A investigação abrangerá episódios paradigmáticos como a desestruturação precoce do *lockdown*, a guerra discursiva contra os equipamentos de proteção individual, o atraso estratégico na constituição de um estoque vacinal, a mortalidade racialmente estratificada, a institucionalização de protocolos de sepultamento em massa e as políticas genocidas contra os Yanomami. O eixo norteador deste pilar reside na

interrogação: *como o governo administrou a morte, tornando-a uma consequência "natural" e aceitável da pandemia, e para quais grupos sociais essa morte foi direcionada?*

Por fim, o pilar da **Pedagogia da Submissão** constitui elemento fundamental para compreender a operacionalização da necropedagogia. Por meio de declarações presidenciais e da atuação de mídias que manipularam pesquisas e informações sobre a pandemia, agravou-se o cenário de mortes. Serão analisados eventos como as falas do Presidente Jair Bolsonaro à imprensa, a disseminação de *fake news* para manipulação da opinião pública, a resistência ao uso de máscaras e a promoção institucional do negacionismo científico. Esse pilar irá se guiar na seguinte pergunta: *como o governo e seus apoiadores usaram da comunicação para dessensibilizar a população, promover o anti-intelectualismo e fabricar o consentimento para a necropolítica?*

5.1. O preço do negacionismo: como o desprezo às pesquisas nacionais alçou o Brasil à condição de epicentro da COVID-19

A autonomia universitária, característica fundamental das instituições acadêmicas, manifesta-se nas esferas do ensino, da pesquisa e da extensão, garantindo liberdade de pensamento e ação frente a interferências de ordem política. Durante a pandemia de COVID-19, as universidades brasileiras emergiram como atores centrais na produção de respostas assertivas, em um contexto marcado por tentativas de minimizar a gravidade da doença e seus impactos no território nacional e global.

O campo científico consolidou-se como a principal fonte de informações concretas sobre as consequências da doença no Brasil, caso medidas urgentes não fossem implementadas. Com a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, universidades e institutos de pesquisa da área da saúde já demonstravam engajamento na investigação do novo vírus. O protocolo estabelecido para mitigar o impacto do agente viral, até o desenvolvimento de uma vacina, consistia na adoção de medidas não farmacológicas, como isolamento social, uso de máscaras e higienização. Dentre essas, a evitabilidade de aglomerações destacava-se como fundamental para conter a disseminação, conforme elucidado pela BBC News Brasil (2020a) a partir da fala do microbiólogo Luiz Almeida:

Para Luiz Almeida, microbiólogo e integrante do Instituto Questão de Ciência, há diversos estudos que comprovam que o risco de contaminação em locais fechados, como bares e baladas, é maior, pois o vírus pode permanecer no ambiente por até três horas. 'O problema da aglomeração em praias é que as pessoas vêm de vários lugares do país e elas precisam sair de casa para comer, fazer mercado, elas frequentam restaurantes, bares e isso acaba aglomerando em um único lugar', diz Almeida (BBC News Brasil, 2020a).

Paralelamente, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) emitiu, em maio de 2020, um alerta sobre as disparidades regionais no acesso à saúde, apontando a carência de assistência para 7,8 milhões de brasileiros, com destaque para os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso:

(...) A análise mostra que a situação é pior nos estados de Amazonas (1,3 milhão de habitantes), Pará (2,3 milhões) e Mato Grosso (888 mil). Nessas três unidades da federação, mais de 20% da população mora em áreas com até quatro horas de deslocamento para chegar ao município mais próximo que ofereça condições de atendimento em casos graves de Covid-19. Outras regiões com elevado percentual de população que leva mais de quatro horas de deslocamento até um município que ofereça atendimento especializado são o interior do Nordeste, o norte de Minas Gerais e o sul do Piauí e do Maranhão (FIOCRUZ, 2020a).

Em 24 de maio de 2020, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou um boletim intitulado "Covid-19 em Dados: Projeções", indicando que, na ausência de medidas mais severas, o país ultrapassaria a marca de um milhão de infectados em menos de um mês. Conforme relatado pelo coordenador do estudo, o professor Dalson Figueiredo (CNN Brasil, 2020e):

(...) o principal objetivo do levantamento é tentar ajudar no processo de tomada de decisões do poder público baseado em evidências científicas. 'A ideia é que toda a política pública, na verdade, ela só fosse implementada, a partir de dados e informações robustas sobre o problema que ela se propõe a atacar', explica. A equipe possui mais seis pesquisadores: Antônio Fernandes, Diego Costa, Enivaldo Rocha, Lucas Silva, Lucas Borba e Rodrigo Amaro. O material foi produzido a partir de números do Governo Federal e com uma técnica de estatística que analisa a reação entre duas ou mais variáveis. Dalson entende que o fato de uma vacina ser criada, por exemplo, pode anular o estudo, mas adianta que, pelo que já foi visto, a tendência é continuar com o mesmo panorama. 'Se você faz uma previsão muito curta, a chance de acerto é maior, mas para o gestor público, talvez não seja tão útil. A medida que a gente aumenta, ela se torna mais útil, mas temos menos confiança nos resultados do modelo. Por outro lado, ela informa de forma mais robusta para o processo de tomada de decisões', diz Dalson (CNN Brasil, 2020e).

De forma convergente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) projetou, em 2 de junho daquele ano, um milhão de infectados e 50 mil óbitos para o final do mês. A projeção, elaborada pelo Instituto de Informática,

partiu do dado de que o Brasil havia ultrapassado 500 mil casos em 31 de maio. Nas palavras do pesquisador João Comba (UOL, 2020e):

(...) ‘O cálculo é refeito diariamente. A janela de 7 dias foi usada por ser um intervalo que, experimentalmente, julgamos gerar um resultado de crescimento mais próximo da realidade.’ Para ele, a análise de dados é importante porque ela auxilia em decisões a respeito da pandemia, como a de governos sobre o momento de reabertura. ‘A análise de dados permite trazer ingredientes adicionais neste complexo quebra-cabeça de entender a evolução da pandemia.’ Além de projeções, a plataforma também faz comparações de similaridade. Segundo elas, a cidade de São Paulo estaria com um cenário semelhante ao do estado do Texas, nos Estados Unidos, na análise de casos, por exemplo. Para Comba, os dados ajudam na análise de medidas a serem tomadas pelos governos. ‘Comparando regiões similares, pode-se tentar fazer relações entre características adicionais, como medidas de distanciamento social’. Mas nenhum governo procurou o professor até o momento para fazer uso dos dados produzidos pela plataforma, mas já teve parcerias hospitalares de Porto Alegre, como o Moinhos de Vento e o de Clínicas, para usar dados e inteligência artificial no combate à covid-19. ‘Estamos à disposição para ajudar’ (UOL, 2020e).

Os esforços das instituições brasileiras em projetar a tendência de contaminação e alertar para a importância dos protocolos de saúde foram cruciais para informar a população sobre a gravidade da doença. Em escala global, a gestão da crise sanitária na China, país epicentro inicial do surto, tornou-se objeto de análise, uma vez que a epidemia foi contida em um período considerado curto, considerando-se a dimensão populacional e territorial do país. Após controlar a disseminação interna, a China mobilizou esforços para auxiliar outras nações, fornecendo informações, especialistas, materiais hospitalares e mantimentos. Contudo, é importante reconhecer as críticas relacionadas à transparência na gestão inicial da crise em Wuhan, conforme relatado por um morador à reportagem do El País (2021a): “As autoridades locais sabiam da existência do vírus e decidiram ocultar informação, isso é um crime. Alguém tem de assumir a responsabilidade e corrigir os erros”, denuncia Zhang” (El país, 2021a).

A gestão de uma crise sanitária de proporções globais não é tarefa trivial, demandando amplo alinhamento nas decisões institucionais, significativo aporte financeiro para a estruturação da rede de saúde e a adoção coordenada de medidas baseadas em evidências. A China adotou um conjunto rigoroso de protocolos, incluindo quarentena, bloqueio de estradas, uso obrigatório de máscaras, fiscalização com drones, construção de hospitais temporários e medição sistemática de temperatura. Os resultados dessas ações foram

considerados cruciais para a contenção do vírus, registrando um número de casos e óbitos relativamente baixos quando comparado a outros países, como Brasil e Estados Unidos, como mostram as figuras a seguir:

Figura 10 - Posição do Brasil no ranking dos países com maior número de mortes por COVID- 19 em dezembro de 2021

	país	casos	casos diários*	mortes ▾	mortes diárias*	população	data
1	Estados Unidos	49 387 208	118 747	791 514	1 565	332 915 074	07/Dez
2	Brasil	22 157 726	9 038	616 018	191	213 993 441	07/Dez
3	Índia	34 656 822	8 578	473 952	672	1 393 409 033	07/Dez
4	México	3 902 015	2 493	295 313	195	130 262 220	07/Dez
5	Rússia	9 692 411	31 967	278 131	1 176	145 912 022	07/Dez
6	Peru	2 246 633	1 469	201 450	39	33 359 415	07/Dez
7	Reino Unido	10 620 535	47 827	146 281	124	68 207 114	07/Dez
8	Indonésia	4 258 076	238	143 893	9	276 361 788	07/Dez
9	Itália	5 134 318	15 110	134 386	80	60 367 471	07/Dez
10	Irã	6 141 335	3 413	130 356	75	85 028 760	07/Dez

Fonte: ECDC (Our World in Data), 2021.⁴

Figura 11 - Posição da China no ranking dos países com maior número de mortes por COVID- 19 em dezembro de 2021

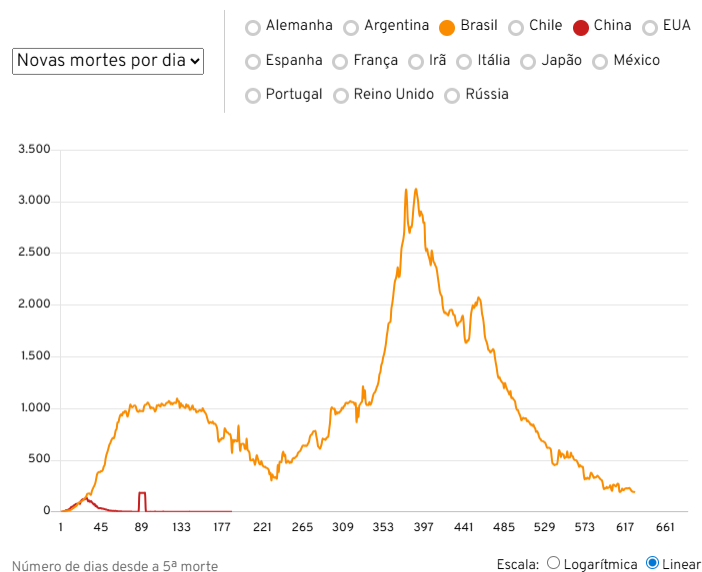
	país	casos	casos diários*	mortes ▾	mortes diárias*	população	data
81	China	99 448	78	4 636	0	1 444 216 102	07/Dez
82	Letônia	258 419	680	4 300	17	1 866 934	07/Dez
83	República Dominicana	409 002	250	4 212	1	10 953 714	07/Dez
84	Omã	304 631	11	4 113	0	5 223 376	07/Dez
85	Coreia do Sul	489 484	5 305	4 020	52	51 305 184	07/Dez
86	El Salvador	119 803	0	3 789	2	6 518 500	07/Dez
87	Zâmbia	210 374	29	3 668	0	18 920 657	07/Dez
88	Namíbia	130 051	123	3 574	0	2 587 344	07/Dez
89	Uganda	127 775	32	3 258	1	47 123 533	07/Dez
90	Sudão	44 170	155	3 200	6	44 909 351	07/Dez

Fonte: ECDC (Our World in Data), 2021.⁵

⁴ Disponível em: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/casos-no-mundo/>

⁵ Disponível em: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/casos-no-mundo/>

Figura 12 - Comparação Brasil e China nos casos de novas morte por dia de COVID-19 período até dezembro de 2021

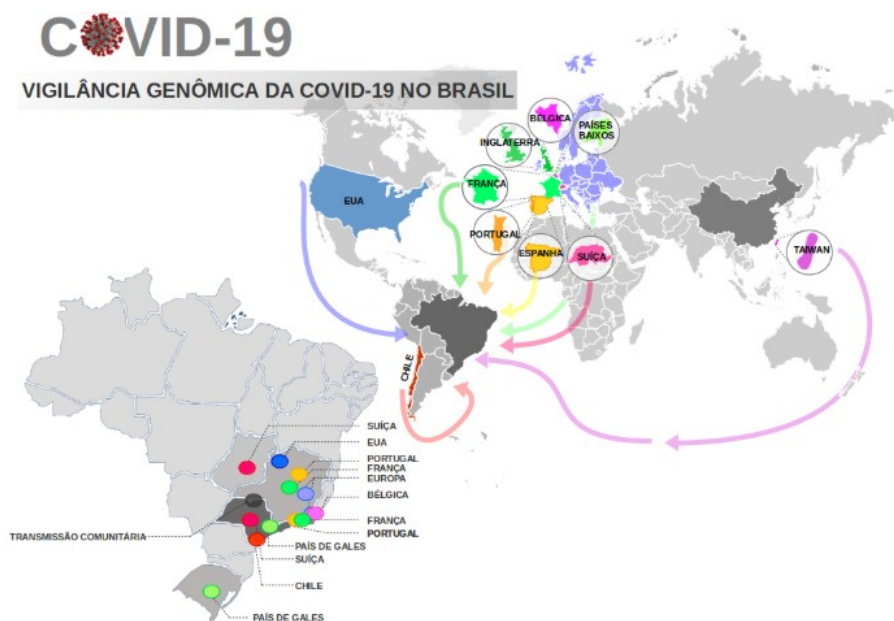


Fonte: Johns Hopkins University, 2021.

Destaca-se a resposta em tempo recorde das instituições científicas brasileiras ao sequenciarem 19 genomas do vírus SARS-CoV-2, coletados de pacientes nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, em um prazo de apenas 48 horas. Em 21 de março, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a conclusão desse trabalho, realizado por seus pesquisadores em colaboração com equipes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

Quatro dias depois, em 25 de março, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o primeiro sequenciamento completo do genoma do SARS-CoV-2 no país. O estudo, conduzido pelo pesquisador Felipe Naveca e sua equipe no Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), utilizou amostras de um paciente do Amazonas e representou uma contribuição significativa para a compreensão do comportamento viral e da dinâmica pandêmica da COVID-19.

Figura 13 - A origem do vírus no Brasil de acordo com os resultados das pesquisas da Fiocruz



Dois dos 19 vírus são de origem asiática, enquanto os outros têm origem europeia.

Fonte: Jornal da Ciência, 2020⁶

A análise comparativa das taxas de mortalidade e das medidas de contenção do vírus, particularmente entre Brasil e China, evidencia que o enfrentamento eficaz da letalidade viral em grandes centros populacionais demandava uma coordenação política coesa, alinhada às evidências fornecidas pelas instituições científicas. Tanto na China quanto no Brasil, a comunidade científica respondeu com celeridade, gerando conhecimentos fundamentais para a minimização do contágio e, por consequência, dos óbitos. Dado que a pesquisa nacional não apresentou defasagem significativa em sua capacidade de resposta, infere-se que a gravidade do cenário epidemiológico brasileiro esteve menos associada a uma eventual lentidão científica e mais diretamente vinculada à ausência de uma governança unificada e efetiva para o enfrentamento da crise.

A contradição entre uma ciência ativa e alerta e um resultado final de centenas de milhares de mortes evitáveis revela que a gestão pandêmica no Brasil não pode ser explicada por mera incapacidade administrativa. Pelo contrário, ela foi a expressão concreta de um projeto político e social

⁶ Disponível em: <https://cienciaviva.org.br/cienciabrasileirarespondecoronavirus/>

profundamente arraigado, que pode ser desdobrado analiticamente em três pilares interligados. Primeiro, a moldura de um Estado ultraliberal, que, por meio de cortes orçamentários históricos na saúde e educação e a priorização dogmática da economia em detrimento da vida, criou as condições de vulnerabilidade que amplificaram a tragédia. Segundo, a operação de uma necropolítica, na qual o poder estatal, por meio de ações e omissões, decidiu quem era digno de proteção e quem poderia ser 'deixado morrer', gerenciando a morte de forma seletiva entre os mais vulneráveis. E, por fim, a consolidação de uma pedagogia da submissão, que utilizou a desinformação como ferramenta estratégica para criar uma realidade paralela, fidelizar apoiadores e ensinar a população a aceitar passivamente o luto e a negligência como novos normais. São esses três eixos que, articulados, compõem a arquitetura da necropedagogia, e que serão detalhados a seguir.

5.2. Análise do Pilar 1: O Estado Ultraliberal na Pandemia

Com a transição das prioridades estatais, que outrora se orientavam para as demandas sociais, para uma focalização nas dinâmicas de mercado, observa-se um enfraquecimento das estruturas que sustentam a democracia e os direitos fundamentais. Nesse contexto, é imperativo não reduzir a análise a uma simples associação entre o mercado e o modelo de Estado ultraliberal. Conforme salienta Brown (2019, p. 21), esse modelo é plástico e articula-se com formas preexistentes na sociedade, constituindo-se “como uma política econômica, como um modo de governo e como uma forma de ordenar a razão, um fenômeno simultaneamente mundial e mutante, diferenciado, não sistemático e impuro”. Não obstante, seu ponto mais crítico reside nas técnicas empregadas em sua implementação em países do Sul global, especialmente naqueles marcados por legados coloniais e escravistas, onde se observa a operação de mecanismos de biopoder e de necropolítica.

O Estado ultraliberal configura-se como uma racionalidade que se estabelece enquanto teoria e é empregada como fundamento de validação tanto no domínio das ciências quanto na esfera da vida. Na condição de teoria, ela é operacionalizada na formulação de políticas de Estado por meio de imposições de diversos atores, com destaque para políticos e empresariais. A esse respeito, Casara (2021, p. 151) ressalta:

Esse caráter mutante é fundamental para compreender essa permanência neoliberal. As políticas e o modo de pensar neoliberais se difundem através dos agentes mais diversos e em diferentes níveis de intensidade, em discursos progressistas e em discursos conservadores, por via formalmente democrática ou por golpes de Estado, espontaneamente ou por pressão das instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O projeto ultraliberal, ao converter todas as esferas da existência em fontes potencial de lucro, transforma o mundo-da-vida em um repositório de alternativas instrumentalmente viáveis aos seus próprios ideais. Ademais, a liberdade de concorrência, princípio basilar desse modelo, gera conflitos intersubjetivos que, por sua vez, demandam a criação de mecanismos de controle destinados a assegurar a realização dos interesses dos detentores do capital.

O ultraliberalismo apresenta diversas facetas, conformadas pelas configurações locais e globais do cenário político e econômico de um determinado contexto histórico. Consequentemente, pode revestir-se de um verniz democrático ou, de modo mais contundente, aderir a regimes ultraconservadores. É precisamente neste último cenário que seu desempenho econômico tende a ser mais efetivo, uma vez que a criação de um estado de caos social — subsequentemente "combatido" por meio de repressão estatal — permite que a economia seja dirigida pela elite econômica, que assim amplia seus lucros. Compreender essa dinâmica é essencial para desvendar a lógica do sistema. Este se revela mutável e engenhoso, pois é construído por pessoas, por ideias e por movimentos violentos impostos por potências imperialistas. Em última análise, por trás do sistema, há sempre indivíduos e suas agências.

Dasso Júnior (2006) elenca sete características fundamentais do ultraliberalismo. A partir dessa base, propõe-se aqui a incorporação de uma oitava característica, considerada essencial para a compreensão da complexidade desse sistema: a necessidade de suprimir a formação de uma consciência crítica nos indivíduos, por meio de um processo de idiosubjetivação. Tal mecanismo é fundamental para manter a alienação das pessoas em relação aos processos constitutivos do sistema econômico. Nesse contexto, não apenas se propõe, mas efetiva-se, um modelo pedagógico que orienta comportamentos socialmente aceitos e rejeitados. Conforme argumentam Dardot e Laval (2016),

esse modelo se materializa por meio de um conjunto articulado de discursos, práticas e dispositivos.

Em relação ao período pandêmico, o governo de Jair Bolsonaro foi marcado por um cenário de instabilidade, no qual a inação configurou-se como uma característica central de sua gestão. Nobre (2020), ao analisar o governo Bolsonaro, identificou a presença de uma metodologia do caos, derivada de um discurso antissistema comumente adotado por lideranças de extrema-direita. Desse modo, Bolsonaro alinha-se a um posicionamento que defende a ineficiência e a necessidade de rejeição do sistema institucional brasileiro em sua configuração atual, o qual se associa ao ordenamento estabelecido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Para Bolsonaro, todo mundo que aceitou as regras da Constituição de 1988 é de 'esquerda'. A própria Constituição é 'de esquerda', faz parte da 'falsa democracia'. Para Bolsonaro, a redemocratização é a responsável por todos os males do país. A 'verdadeira democracia' é apenas aquela que existia durante a ditadura militar. Quem conseguir entender a expressão 'a democracia da ditadura era a verdadeira democracia', conseguirá entender Bolsonaro (Nobre, 2020, p.25).

O governo ultraliberal de Jair Bolsonaro conduziu a pandemia através de decisões não democráticas, com desrespeito a vida dos cidadãos brasileiros, com instabilidades institucionais movimentos esses observados por outros países com preocupação, pois o Brasil tornou-se núcleo de proliferação do vírus.

A análise dos eventos ocorridos durante o período pandêmico, com base em reportagens e fatos amplamente divulgados, foi conduzida à luz do referencial ultraliberal. Ademais, com o intuito de orientar a classificação das notícias a serem analisadas neste subcapítulo, adotou-se o seguinte questionamento norteador: *de que maneira as ações e omissões do governo durante a pandemia privilegiaram interesses econômicos, promoveram a desregulamentação e fomentaram a mercantilização da vida?*

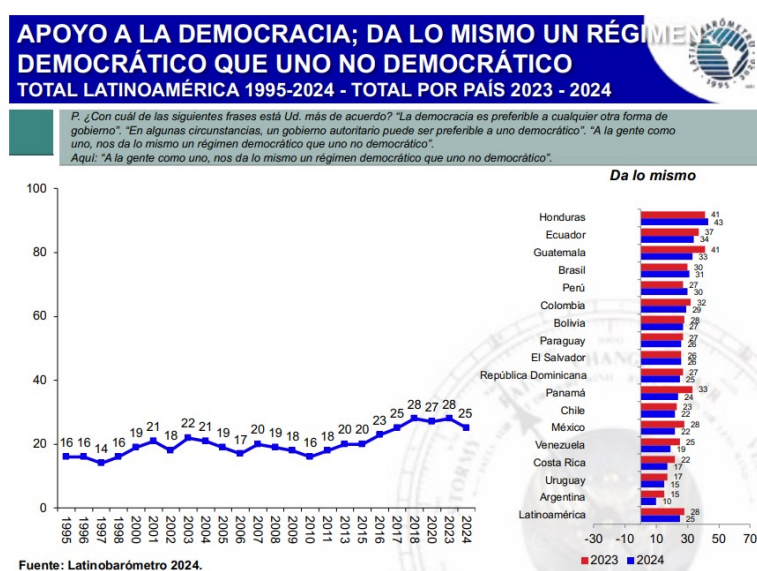
5.2.1. Análise dos fatos ocorridos durante a Pandemia sob o viés ultraliberal

A gestão da pandemia pelo governo federal brasileiro sob a liderança do então Presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) pode ser analisada como a implementação de um projeto de Estado ultraliberal, que buscou fomentar uma sensação de hiperindividualismo, transferindo a responsabilidade pela contenção do vírus da esfera estatal para a esfera privada e familiar. Ao

deslegitimar a ação coletiva coordenada e depreciar a intervenção estatal, tal narrativa contribuiu para corroer ainda mais a percepção social da necessidade de um governo democrático robusto e de políticas públicas universais, enfraquecendo os fundamentos da cidadania coletiva.

A persistência de modelos de governança que não contestam os fundamentos do paradigma ultraliberal tem contribuído para uma percepção limitada da democracia, reduzindo-a frequentemente ao mero exercício do sufrágio. Essa constatação é corroborada por dados empíricos, como os levantados pela Organização *Latinobarómetro* em 2023, que evidenciam uma dificuldade significativa por parte de muitos cidadãos latino-americanos em discernir diferenças substantivas entre regimes democráticos e não democráticos. A atualização do estudo em 2024 revelou, contudo, um agravamento desse cenário, com o caso brasileiro emergindo como um dos mais críticos e merecedor de análise específica. Enquanto se observa uma tendência de crescimento no apoio aos regimes democráticos na América Latina como um todo, o Brasil apresenta uma trajetória inversa, registrando um declínio no apoio a esse sistema de governo.

Figura 14 - É indiferente a escolha entre um regime democrático a um não democrático: dados de 2024



Fonte: Latinobarometro, 2024.

A comparação dos dados do *Latinobarómetro* entre 2023 e 2024 revela que, embora o sentimento de indiferença quanto à preferência por regimes

democráticos tenha registrado um declínio na América Latina em geral, o Brasil seguiu uma trajetória oposta. No país, o índice de indiferença aumentou no período de um ano, passando de 30 para 31 pontos. Esse cenário constitui um indicador preocupante, sobretudo diante da proximidade do próximo ciclo eleitoral brasileiro, em 2026.

Figura 15 - Satisfação com a democracia de 1995 a 2024



Fonte: Latinobarometro, 2024.

Uma análise da série histórica do *Latinobarómetro*, que compila 29 anos de dados sobre a satisfação com a democracia, revela que o Brasil registrou sua primeira queda acentuada no indicador em 2016. Esse ano foi marcado pelo golpe e impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e pela subsequente ascensão do governo Michel Temer, um processo político que, na análise de diversos especialistas, criou as condições para a eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018. Naquele período, o nível de satisfação democrática atingiu a marca crítica de 10 pontos, sendo superado negativamente apenas pelo ano eleitoral de 2018, quando registrou 9 pontos.

O governo Bolsonaro se caracterizou por uma ofensiva estratégica contra as instituições democráticas, utilizando para tanto as prerrogativas inerentes ao Poder Executivo federal. Essa atuação teve como um de seus eixos centrais a promoção da flexibilização e desconstituição de direitos trabalhistas consolidados. Para compreender a profundidade desse movimento, é imperativo

analisar a natureza da relação entre o regime democrático e os direitos do trabalho no contexto brasileiro.

Esta ligação não é acidental ou meramente contingente, mas sim de ordem estrutural e constitutiva. A trajetória histórica nacional demonstra que a consolidação da democracia e a ampliação da proteção ao trabalho são processos que se retroalimentam. Os direitos trabalhistas transcendem, assim, a condição de simples conquistas no interior do sistema, assumindo a função de pilares materiais da própria ordem democrática. Eles fornecem o substrato socioeconômico indispensável para a efetiva participação política, promovendo condições de vida dignas que conferem concretude à cidadania formal. Simultaneamente, ao fomentar a organização sindical e a negociação coletiva, fortalecem a sociedade, criando diques de contenção contra tendências autoritárias e garantindo um pluralismo essencial à vitalidade do regime.

Desta forma, o desmonte dos direitos trabalhistas não pode ser analisado como uma política setorial isolada. Trata-se de um vetor de erosão democrática, que, ao debilitar a proteção social e a capacidade de organização autônoma dos trabalhadores, corrói os fundamentos materiais que sustentam e legitimam a democracia no Brasil. A ofensiva contra esses direitos revela, portanto, uma dimensão fundamental do projeto político então em curso, que busca reconfigurar as relações entre Estado, mercado e sociedade em detrimento das garantias coletivas e do equilíbrio de forças inerente a um regime democrático robusto.

Em março de 2020, uma das primeiras iniciativas do governo frente à pandemia consistiu na edição de Medidas Provisórias que precarizaram as condições de trabalho durante a crise sanitária, destacando-se a MP nº 936 e a MP nº 927, ambas de 2020. A Medida Provisória nº 936/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.020/2020, autorizou a redução de jornada e salários por parte dos empregadores, bem como a suspensão de contratos de trabalho por período de até 60 dias. Como contrapartida, previu-se o pagamento de um benefício emergencial para trabalhadores formais, cujo valor variava entre R\$ 261,25 e R\$ 1.813,03, calculado com base no seguro-desemprego a que teriam direito em caso de demissão, nos termos estabelecidos pela legislação.

A Medida Provisória nº 927, de 2020, igualmente introduziu dispositivos problemáticos no âmbito das relações trabalhistas. Diferentemente da MP nº 936,

esta não foi convertida em lei e teve dois de seus artigos, os Arts. 29 e 31, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, logo após sua edição. Conforme fundamentação do referido ministro,

(...) o artigo 29, ao prever que casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal, ofende inúmeros trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos ao risco. O artigo 31, por sua vez, que restringe a atuação dos auditores fiscais do trabalho, atenta contra a saúde dos empregados, não auxilia o combate à pandemia e diminui a fiscalização no momento em que vários direitos trabalhistas estão em risco (Brasil, 2020x).

A análise conjunta da MP 936/2020 e da MP 927/2020 evidencia que, à despeito do discurso oficial de "preservação do emprego e da renda", o governo conduziu um processo de reconfiguração do vínculo laboral que potencializou a assimetria de poder nas relações de trabalho. Esta estratégia, em vez de fortalecer a negociação coletiva como instrumento de equilíbrio, privilegiou acordos individuais em um contexto de elevada vulnerabilidade, fragilizando assim os mecanismos institucionais de proteção e os direitos fundamentais historicamente consagrados.

Além da política de flexibilização e precarização das relações trabalhistas, o governo editou a Medida Provisória nº 928, de 2020, que introduziu alterações significativas na Lei nº 13.979/2020 (Lei Geral de Enfrentamento da Pandemia). A norma estabeleceu a suspensão dos prazos de resposta previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) para órgãos públicos cujos servidores estivessem em regime de teletrabalho ou quarentena, desde que a análise da demanda dependesse de acesso presencial. Adicionalmente, o dispositivo impunha a obrigatoriedade de reiteração dos pedidos pendentes pelos interessados após o término do estado de calamidade pública e afastava a possibilidade de interposição de recursos administrativos contra respostas negativas, cerceando assim o direito de defesa dos cidadãos. A medida foi posteriormente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, que a considerou contrária ao princípio constitucional da publicidade.

Ao reiterar o entendimento expresso na concessão da liminar, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a maior prova de que as modificações sugeridas pela medida provisória eram abusivas é o fato de que, desde que a pandemia foi declarada, não houve qualquer problema de acesso à informação, pois quase 100% das informações

requeridas são prestadas a distância, por meio eletrônico. Segundo o ministro, a administração pública encontrou meios de manter a prestação de serviços com total transparência. Como exemplo, citou as sessões das Turmas do STF, que passaram a ser realizadas por videoconferência e transmitidas pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo YouTube. O relator ressaltou que a publicidade e a transparência ganham ainda mais relevância no momento atual, quando gestores públicos estão autorizados a dispensar licitações para aquisição de insumos e serviços para fazer frente à pandemia. Ele asseverou que a Constituição Federal consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. Para o ministro Alexandre, a MP pretendeu transformar a exceção, que é o sigilo de informações, em regra, afastando a plena incidência dos princípios da publicidade e da transparência (Brasil, 2020v).

A Medida Provisória nº 928/2020 representou uma precarização do direito fundamental à informação pública no momento mais crítico da pandemia. Ao suspender prazos da Lei de Acesso à Informação para órgãos com servidores em regime de teletrabalho e exigir a reiteração de pedidos após o estado de calamidade, a medida criou barreiras artificiais à transparência. O dispositivo mais severo foi o que afastava a possibilidade de recursos contra negativas de resposta, eliminando um mecanismo vital de controle durante uma crise que demandava total clareza das ações governamentais. Assim, somada às MPs 936 e 927, que precarizaram as relações trabalhistas, a MP 928 compôs um cenário triplo de retrocessos: fragilização de direitos no trabalho, redução da proteção à saúde ocupacional e restrição ao acesso à informação. Este conjunto transferiu os custos da crise para os trabalhadores e para a sociedade, ao mesmo tempo em que tentou ofuscar a transparência sobre as ações do Estado, configurando um aprofundamento da precarização em múltiplas dimensões durante a emergência sanitária.

A investida contra as garantias trabalhistas no Brasil não constitui uma exceção no governo Bolsonaro, uma vez que as reformas administrativas implementadas no país historicamente incidem, sobretudo, sobre direitos trabalhistas, democráticos e sociais. Já na Emenda Constitucional nº 19, de 1998, um dos objetivos centrais consistia na flexibilização da estabilidade no serviço público. Essa lógica de precarização dos vínculos empregatícios materializa-se por meio de mecanismos políticos que demandam da força estatal para obter legitimidade perante a sociedade. Nesse contexto, Limppmann identifica no campo do direito – simultaneamente teórico e prático – um instrumento eficaz

para introduzir modificações sociais profundas, reposicionando o Estado como agente fundamental na consolidação da estratégia ultraliberal.

No contexto analisado, práticas governamentais que configuraram um regime de opacidade informacional — incluindo a restrição sistemática ao acesso a dados epidemiológicos, o deliberado atraso na formulação e implementação do Plano Nacional de Imunização, bem como obstruções ao processo de aquisição de vacinas — foram concomitantes ao desrespeito aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência administrativa. Tais condutas encontraram sua justificativa discursiva na alegação de proteção de "dados sensíveis", argumento utilizado para legitimar a exceção e consolidar um paradigma de gestão pelo obscurecimento das ações estatal.

Em junho de 2020, o Ministério da Saúde determinou a retirada do ar o painel de dados que consolidava e divulgava em tempo real as informações epidemiológicas, conforme noticiado pelo jornal *El País* (2020d).

O Ministério da Saúde do Governo Jair Bolsonaro apagou de sua plataforma oficial os números consolidados que revelavam o alcance do novo coronavírus no Brasil, provocando críticas imediatas dos demais Poderes e da sociedade civil organizada. Depois de ficar horas fora do ar nesta sexta-feira, o site oficial foi republicado neste sábado, entretanto, somente com as notificações registradas nas últimas 24 horas. Não constam mais o número total de pessoas infectadas pelo vírus Sars-Cov-2 no país desde o início da pandemia, nem o acumulado de óbitos provocados pela covid-19 no território brasileiro. Também foram apagadas do site as tabelas que mostravam a curva de evolução da doença desde que o Brasil registrou seu primeiro caso, no final de fevereiro, e gráficos sobre infecções e mortes por Estado. Na noite deste sábado, seguindo essa política, o Ministério da Saúde divulgou 904 óbitos notificados e 27.075 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. A reportagem somou os números ao computado até a sexta-feira, totalizando em 35.930 óbitos e 672.846 casos da doença em todo o país (El País, 2020d).

Diante disso, tornou-se impossível dimensionar com precisão a magnitude do contágio no território nacional, gravidade acentuada pelo fato de o Brasil ocupar, à época, a segunda posição no *ranking* mundial de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos. Em resposta à medida, o Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para apurar a supressão de informações, estabelecendo prazo de 72 horas para que o então Ministro de Estado da Saúde *ad interim*, Eduardo Pazuello, justificasse a alteração metodológica. Conforme noticiado pelo portal G1 em 6 de junho de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro declarou em rede social que “o Ministério da Saúde adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados à covid-19”, sem, no

entanto, apresentar – nem o Presidente, nem a Pasta – qualquer fundamentação técnica ou científica que justificasse a descontinuidade da divulgação dos números totais (G1, 2020m).

Posteriormente, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Eduardo Pazuello atribuiu inconsistências nos sistemas de informação do Ministério a falhas na atualização de dados por parte de estados e municípios. Ao questioná-lo sobre tais alegações, a Senadora Leila Barros (PSB-DF) indagou:

A senadora Leila Barros (PSB-DF) indagou sobre os motivos de o Ministério da Saúde ter desativado o seu painel de casos e óbitos confirmados por covid-19. Isso aconteceu abruptamente em junho de 2020, mas a divulgação voltou ao ar pouco depois por ordem judicial. A partir de então, um consórcio formado por veículos de imprensa passou a ser a fonte principal para esses dados.

— Se o senhor foi aconselhado por alguém para não mais apresentar esses dados, isso é muito preocupante. O Ministério da Saúde tem a obrigação de dar transparência a todo o processo. Ficaram muitas notícias paralelas, muita desinformação, confundiu muito a cabeça dos brasileiros. Eu acho que faltou esse compromisso do ministério na divulgação desses números — disse Leila Barros (Agência Senado, 2021).

Diante da tentativa de ocultação de dados epidemiológicos, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, determinou o restabelecimento da divulgação integral das estatísticas relacionadas à COVID-19, conforme noticiado pelo portal G1 (2020m).

A gravidade da emergência causada pela pandemia do Covid-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde', escreveu Moraes na decisão.

'Caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas, dentre elas, a colheita, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos necessários, tanto ao planejamento do poder público para tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas, quanto do pleno acesso da população para efetivo conhecimento da situação vivenciada no país', acrescentou o ministro. Alexandre de Moraes também ressaltou que a publicidade é a regra na administração pública, além de ser um dos 'vetores imprescindíveis'.

'A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade', escreveu (G1, 2020m).

A despeito da vigência de uma democracia hegemônica no país, caracterizada por sua fragilidade, inconsistência e baixa capacidade de

promover a participação cidadã plena ou a emancipação política efetiva da população, tornou-se necessária a mobilização de instituições e poderes tradicionalmente reticentes à intervenção direta no Executivo, com o intuito de conter os avanços da agenda do governo Bolsonaro. Nesse esforço, invocaram-se os princípios constitucionais da administração pública, visando enquadrar juridicamente as distorções verificadas no âmbito do Ministério da Saúde.

A publicidade, em uma sociedade democrática de moldes hegemônicos ultraliberais, constitui elemento fundamental do modelo democrático, que concebe a democracia primordialmente com base na transparência, na prestação de contas e no exercício do voto. Ao suprimir dados relativos aos óbitos por COVID-19, o Brasil alcançou projeção internacional negativa, sendo alvo de críticas de veículos de imprensa estrangeiros, como o jornal britânico *The Guardian*, que qualificou a postura do governo Bolsonaro como totalitária.

No fim do dia, o *Guardian* publicou nova reportagem, dessa vez com o título 'Brasil deixa de divulgar número de mortos por Covid-19 e apaga dados do site oficial'. Nela, o repórter Dom Phillips, correspondente do jornal no Rio de Janeiro, ressalta que o governo brasileiro foi acusado de 'totalitarismo e censura' pela nova metodologia (BBC News, 2020b).

Além do *The Guardian*, outros veículos de imprensa internacional manifestaram preocupação com a condução governamental brasileira, a exemplo do *Financial Times*, que caracterizou Bolsonaro como um presidente de extrema-direita.

Brasil acusado de ocultar dados sobre crise de coronavírus' foi a manchete do também britânico *Financial Times*. O jornal descreve Bolsonaro como 'presidente de extrema direita', que 'há muito tempo é acusado de subestimar a gravidade do surto, levando ao despedimento de um ministro da saúde e à demissão de outro, e à nomeação de um general sem experiência em saúde pública para substituí-los' (BBC News, 2020b).

Na mesma perspectiva, o periódico estadunidense *The Washington Post* direcionou críticas à postura do governo brasileiro, particularmente no que tange à supressão de dados epidemiológicos durante o período pandêmico.

O jornal americano *The Washington Post* foi na mesma linha, com a manchete 'À medida que as mortes por coronavírus no Brasil aumentam, Bolsonaro limita a divulgação de dados'. De acordo com o jornal, um dos mais influentes dos Estados Unidos, 'a retirada repentina dos dados acumulados provocou uma avalanche de críticas quando as pessoas nas cidades retornaram às suas varandas para bater em panelas e detratores sugeriram que o governo federal estava tentando ocultar a gravidade de uma crise de saúde pública que pouco fez para resolver' (BBC News, 2020b).

A estratégia discursiva do governo federal caracterizou-se pela sistemática transferência de responsabilidades pelas falhas na gestão sanitária para os demais entes federativos: estados e municípios. Evidenciava-se, inegavelmente, uma discrepância entre os dados epidemiológicos divulgados pelas esferas federal e estaduais, configurando uma crise informacional no âmbito da pandemia. Contudo, diversos estudos apontavam a necessidade crucial de uma política federal coordenada para conter a disseminação do vírus. Na prática, observou-se uma atuação governamental contrária a esse imperativo, negligenciando o cuidado com a população.

Em 14 de abril de 2021, a revista *Science* publicou um estudo que atribuiu o fracasso do Brasil no combate à pandemia a uma série de falhas e omissões por parte de gestores públicos, com ênfase na responsabilidade primária do governo federal. A pesquisa, liderada pela demógrafa brasileira Márcia Castro, da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, e assinada por dez cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, buscou explicar como um país dotado de um sistema universal e gratuito de saúde (SUS) tornou-se um dos mais gravemente afetados pela crise sanitária.

A pesquisa afirma que, ‘embora nenhuma narrativa única explique a diversidade na disseminação, um fracasso geral em implementar respostas imediatas, coordenadas e equitativas em um contexto de fortes desigualdades locais alimentaram a propagação da doença’. Os cientistas reiteram que a conduta do governo do presidente Jair Bolsonaro tem um peso proporcionalmente muito maior no cenário de caos gerado pela pandemia – uma conduta que ficou marcada não só por omissões, mas por atos irregulares como a promoção de curas ineficazes. ‘No Brasil, a resposta federal tem sido uma combinação perigosa de inação e irregularidades, incluindo a promoção da cloroquina como tratamento, apesar da falta de evidências’, diz o estudo. ‘Sem uma estratégia nacional coordenada, as respostas locais variaram em forma, intensidade, duração e prazos de início e fim, até certo ponto associadas a alinhamentos políticos.’ Segundo os pesquisadores, essa falta de coordenação na adoção de medidas por parte dos governos regionais – atribuída ao fracasso do governo Bolsonaro em implementar uma estratégia nacional – apenas contribuiu para que o vírus se espalhasse sem barreiras pelo país. ‘À medida que estados e municípios impuseram e relaxaram medidas restritivas em diferentes momentos, a mobilidade populacional facilitou a circulação do vírus e atuou como desencadeador da disseminação da doença’, destaca o estudo. Ao comparar os números de infecções e mortes registrados entre fevereiro e outubro com as políticas de restrição à circulação de pessoas adotadas pelos gestores públicos, os pesquisadores observaram que essas medidas se mantiveram moderadas ou foram flexibilizadas mesmo em meio a uma fase crítica da pandemia, quando medidas mais rígidas se faziam necessárias (DW, 2021c).

O governo Bolsonaro, para além da supressão de dados sobre mortalidade por COVID-19, caracterizou-se também pela deliberada desaceleração do calendário nacional de imunização. Evidência desse fato ocorreu com a divulgação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, em 15 de dezembro de 2020, o qual não estabelecia uma data concreta para o início da campanha. Tal omissão relacionava-se diretamente à ausência de imunizantes registrados junto às autoridades sanitárias nacionais, contexto agravado pela histórica rejeição governamental a propostas de aquisição. Conforme documentado em diversas fontes, o governo federal recusou um total de onze ofertas de vacinas contra COVID-19, sendo seis referentes à Coronavac, do Instituto Butantan, três da Pfizer e duas provenientes do consórcio internacional Covax Facility.

Das onze recusas conhecidas e que podem ser provadas com documentos, seis são referentes à Coronavac. Há três ofícios assinados pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, oferecendo o imunizante. O primeiro, datado de 30 de julho de 2020, e o segundo, de 18 de agosto, ficaram sem resposta. O terceiro documento foi entregue pessoalmente em 7 de outubro por Dimas Covas, ao ministro da saúde, o general Pazuello. Como os documentos não tinham resposta, o Instituto Butantan realizou três videoconferências com integrantes do Ministério da Saúde para fazer a oferta. Nada andou. Os documentos com as provas da sabotagem do governo federal à Coronavac já estão separados numa gaveta do Instituto Butantan, aguardando apenas um pedido formal da CPI para serem entregues. Há ainda mais três ofertas formais feitas pelo laboratório Pfizer. A primeira delas foi feita em agosto de 2020, quando a farmacêutica colocou à disposição do Brasil 70 milhões de doses para serem entregues em dezembro. As outras duas ofertas formais, feitas através de documentos, foram confirmadas pelo laboratório. Segundo o ex-secretário de comunicação, Fabio Wajngarten, como o Ministério ignorava as propostas, exatamente como fez com o Butantan, ele próprio abriu as portas do Palácio do Planalto para uma negociação formal com o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Também não andou. O senador Randolfe Rodrigues, autor do requerimento da CPI acrescenta à contagem as duas vezes que o governo Jair Bolsonaro se recusou a participar consórcio da Covax Facility. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, o Brasil só aderiu no terceiro convite para aquisição de 212 milhões de doses. O acordo era visto pelo Ministério das Relações Exteriores como uma atitude globalista, portanto nociva ao país. O número de doses foi reduzido a pedido do governo brasileiro. (G1, 2021b).

Ademais, constatou-se significativa divergência entre a divulgação oficial do plano de imunização pelo Ministério da Saúde e o posicionamento do grupo de especialistas consultados. Horas após a publicação do documento, os pesquisadores emitiram nota pública informando não ter tido acesso à versão

final do plano. Evidência dessa desconexão encontra-se na estrutura do próprio documento: os nomes dos 31 especialistas foram listados como "colaboradores", enquanto o campo destinado aos "elaboradores" permaneceu vazio. Diante dessa inconsistência formal, parte dos consultados recusou-se a comentar o conteúdo do plano, por considerá-lo um documento não legitimado pelo conjunto dos especialistas.

— Não posso comentar sobre um plano que não sabemos se é fraude, se é verdadeiro, por quem foi escrito, quem é que assina. Como vou comentar da parte técnica de um plano cujos técnicos não assinaram — fala a microbiologista Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e colunista de O GLOBO. — Esse tipo de confusão, seja por incompetência, seja por má fé, não pode acontecer. O plano nacional de imunização é provavelmente o documento mais importante que o governo federal vai ter para embasar as campanhas de vacinação no ano que vem. Esse tipo de bagunça com este tipo de documento é inadmissível.

Na referida nota, os pesquisadores salientaram que “Um atraso na campanha de vacinação significa vidas perdidas”, acrescentando ser imperioso, naquele contexto, “utilizar a ciência para a tomada de decisão que norteará o que mais importa, a preservação de vidas de milhares de brasileiros e brasileiras” (Carta Capital, 2020). A imprecisão sobre o cronograma de imunização foi reiterada em janeiro de 2021, quando o então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao ser questionado sobre uma data definida para o início da vacinação, respondeu de forma evasiva que a campanha teria início “no dia D, na hora H”.

Todos os Estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina começará no dia D na hora H no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina ou a autorização for feita, a partir de terceiro ou quarto dia já estará nos Estados e municípios para iniciar a vacinação. A prioridade já está dada, é o Brasil todo. Vamos fazer como exemplo para o mundo. Os grupos prioritários já estão distribuídos. Os números já estão distribuídos pelas 3 hipóteses: 2 milhões, 6 milhões ou 8 milhões agora para janeiro. Sabe o que vai acontecer se forem 8 milhões? Nós vamos ser o país que mais vai vacinar no mundo, e quero ver o que vão dizer (Carta Capital, 2021b).

Cabe ressaltar que, no momento da declaração ministerial, registrava-se um significativo contraste entre o cenário internacional e o nacional: enquanto 57 países já haviam iniciado seus respectivos programas de imunização contra o vírus, o Brasil permanecia em situação de inércia vacinal, conforme documentado pela CNN (2021e).

Foto 01 – PAINEL de Vacinas divulgada pela CNN



Países que iniciaram a vacinação contra a Covid-19 até 16 de janeiro de 2021

Fonte: CNN Brasil, 2020f.

A declaração do então Ministro Eduardo Pazuello, na qual afirmou que o Brasil seria "exemplo para o mundo", demonstrava notável desconexão com o contexto nacional. A afirmação foi proferida após um extenso histórico de rejeição a propostas de aquisição de imunizantes e sucessivos atrasos no cronograma de vacinação, que tratavam a crise sanitária sem a urgência demandada pela gravidade epidemiológica, agravada pela falta de transparência na divulgação dos dados oficiais de mortalidade. Cabe contextualizar que o Reino Unido havia iniciado sua campanha de imunização global em 8 de dezembro de 2020, quando a nonagenária Margaret Keenan recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer em hospital de *Coventry*, no centro da Inglaterra (CNN Brasil, 2020f).

A análise dos eventos ocorridos durante a pandemia de COVID-19 no Brasil revela uma relação intrínseca entre a gestão da crise sanitária e a erosão de pressupostos democráticos fundamentais. O governo federal, sob a liderança de Jair Bolsonaro, adotou um modelo de gestão pública alinhado aos preceitos ultraliberais, os quais, conforme fundamentado por Dasso Júnior (2006) e ampliados pela noção de idiossubjetivação de Casara (2024), priorizam a lógica privada em detrimento do interesse público e promovem a fragilização institucional.

A racionalidade ultraliberal, além de reestruturar as esferas econômica e política, promove uma reconfiguração subjetiva profunda, engendrando um tipo específico de sujeito. Este sujeito caracteriza-se pela aceitação acrítica de sua realidade, tornando-se especialmente permeável a concepções individualistas que privilegiam o empreendedorismo solitário e demonizam formas de vida coletiva e democrática. O modo de existência dos indivíduos é progressivamente ajustado aos imperativos dessa racionalidade, um processo que, conforme analisado por Dardot e Laval (2016), é frequentemente mascarado por uma retórica que inscreve tais imperativos numa suposta natureza coletiva (Souza, 2019).

Esta engrenagem exige sacrifícios contínuos em nome de um progresso incessante (Brown, 2018), os quais, por sua vez, moldam comportamentos alienantes. Os indivíduos são conduzidos a se compreender e gerir como "empresas de si mesmos", internalizando uma lógica de custo-benefício para todas as dimensões da vida. Tal dinâmica entra em rota de colisão direta com a noção de direitos sociais, uma vez que estes são percebidos como obstáculos incompatíveis com o projeto societal que almeja o "devir empresa" de todos e de tudo (Casara, 2024).

Portanto, compreender a mecânica do governo Bolsonaro exige reconhecer que instituições, políticas e subjetividades estiveram, em maior ou menor grau, inseridas numa lógica programática de desmonte do saber e da ciência. Este projeto mantém deliberadamente um cenário empobrecido de imagens e ideias, pois seu "tipo ideal" de cidadão não é o sujeito crítico e participativo, mas sim o "homem ignorante" – figura moldada pela desinformação, pelo pensamento binário e pela incapacidade de refletir sobre o comum.

Precisamente essa ausência de capacidade reflexiva crítica que pavimenta o terreno para a aceitação acrítica de determinados discursos políticos, os quais se erigem como um "regime de verdade". Um emblemático exemplo desta dinâmica reside na declaração proferida pelo então Ministro da Economia, Paulo Guedes, em 24 de março de 2020. Em seu pronunciamento, o ministro prognosticou que a persistência das medidas de restrição econômica, concebidas como ferramentas de enfrentamento à pandemia, culminaria, em sua análise, em uma crise de magnitudes consideráveis para o país:

Meus amigos, duas ondas enormes avançam em direção ao Brasil. A primeira já nos atingiu, é uma calamidade de saúde pública e ameaça nossas vidas, nossa saúde. E a segunda vem na esteira da primeira, pode ser uma enorme onda, dependendo de nossa reação, ameaça nossos empregos e uma crise econômica como nunca sofremos antes. (Ventura e Reis, 2021, p.38)

A retórica governamental recorrente sustentava que o não atendimento estrito às exigências de reprodução do capital acarretaria uma crise de proporções inéditas. Nesse contexto, as ações estatais priorizaram a disseminação de temor e insegurança entre os trabalhadores quanto à permanência no mercado, em detrimento do enfrentamento adequado aos impactos da disseminação viral e à garantia de condições seguras de trabalho. Como expressão dessa orientação, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lançou, em 26 de março de 2020, a campanha publicitária intitulada "Brasil não pode parar".

(...) veiculando a informação de que 'no mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e adultos' e incitando à desobediência das medidas quarentenárias: 'Para trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar' (Ventura e Reis, 2021, p.39).

Apesar da insistência do governo nessa campanha publicitária, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou a suspensão imediata, argumentando que a mesma configurava propaganda enganosa ao desconsiderar evidências científicas e consensos técnicos internacionais acerca da necessidade do isolamento social horizontal como medida de controle do contágio pelo coronavírus. Conforme demonstrado pela petição inicial, a campanha incentivava manifestações contra restrições sanitárias e pressionava gestores locais pelo afrouxamento prematuro das medidas de distanciamento, criando um cenário de risco coletivo que poderia acarretar colapso do sistema de saúde e aumento exponencial de óbitos.

Em 09 de abril de 2020, Arthur Weintraub, então assessor especial da Presidência da República, manifestou-se em sua conta no Twitter mediante a seguinte publicação: "Estamos vendo a vida ser esmagada. Remédios sendo negados, informações obstruídas, liberdades destruídas, intimidades violadas. Tudo 'em nome da saúde'. Pessoas presas por caminhar, trabalhadores presos

por trabalhar, celulares rastreados. Isolamento é novilíngua de escravidão” (VENTURA e REIS, 2021, p. 46).

Já na reunião ministerial realizada em 22 de abril de 2020, o então Presidente da República teria solicitado aos integrantes de seu governo que minimizassem a gravidade da pandemia junto à opinião pública. De acordo com tal orientação, a prioridade seria evitar que o vírus gerasse pânico na população, transferindo-se o temor para as consequências econômicas decorrentes da paralisação das atividades comerciais: o que evidencia a primazia da agenda econômica sobre as considerações sanitárias.

Então vamos alertar a quem de direito, ao respectivo ministério, pode botar Covid-19, mas bota também tinha fibrose, montão de coisa, eu não entendo desse negócio, não. Tinha um montão de coisa lá, para exatamente não levar o medo à população. Porque a gente olha, morreu um sargento do Exército, por exemplo. A princípio é um cara que está bem de saúde, né? Um policial federal, né? Seja lá o que for, e isso daí não pode acontecer. Então a gente pede esse cuidado com os colegas, tá? A quem de direito, ao respectivo ministério, que tem alguém encarregado disso, né? Pra tomar esse devido cuidado pra não levar mais medo ainda pra população (Ventura e Reis, 2021, p.49).

Essa orientação governamental reflete os princípios característicos de governos ultraliberais, fundamentados na cisão estrutural entre Mercado e Sociedade. Nesse paradigma, priorizam-se indicadores macroeconômicos em detrimento do enfrentamento às desigualdades sociais e à vulnerabilidade da população trabalhadora, consequências diretas dessa opção política.

É importante salientar que os principais articuladores do discurso econômico que projeta uma falsa aparência de solidariedade, fundamentado na premissa de que a negligência com a economia seria prejudicial ao conjunto da sociedade, são, em grande medida, setores específicos do empresariado nacional, como o agronegócio e grandes conglomerados industriais e financeiros. Esses mesmos atores, historicamente vinculados ao financiamento de campanhas eleitorais e à promoção de agendas de reformas administrativas e trabalhistas, possuem um interesse estrutural na manutenção de um quadro de precarização laboral e na fragmentação da coesão política da classe trabalhadora. Tal configuração institucional é funcional à lógica de maximização de lucros, um imperativo que, conforme evidenciado em contextos de crise aguda, pode ser perseguido mesmo em detrimento da saúde, da segurança e da própria vida dos trabalhadores.

Outro eixo discursivo recorrente no corpo político do ex-presidente consistiu na disseminação de narrativas que defendiam a denominada "imunidade de rebanho"⁷ como estratégia de saúde pública, posicionamento que se contrapunha ao consenso científico internacional estabelecido para o enfrentamento da pandemia. Cumpre destacar que a aplicação desta estratégia se revelava fundamentalmente vinculada a objetivos de natureza econômica, buscando acelerar a retomada das atividades produtivas à margem das recomendações sanitárias internacionalmente reconhecidas.

Líder do governo na Câmara, Deputado Ricardo Barros afirma em live da Confederação Nacional da Indústria (CNI): 'A literatura diz que 90% que pegarem serão assintomáticos. Os que tiverem sintomas serão tratados desde o início. (...) Precisamos encerrar a pandemia. Como? Imunidade de rebanho. Todos voltarem a trabalhar. Retomar a economia e colocar o estado para funcionar. Já temos os respiradores, os leites de UTI, antivirais... A vacina de hoje é o respirador de ontem. Quem tiver dinheiro vai comprar primeiro. Temos que tocar a vida (Ventura e Reis, 2021, p.92).

A estratégia de imunidade de rebanho adotada pelo governo federal foi objeto de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal. Conforme delineado no relatório final da comissão, as ações e omissões do governo no enfrentamento à pandemia contribuíram significativamente para a aceleração do número de óbitos registrados durante o período crítico. Na qualidade de relator do processo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) sustentou em seu parecer que:

Entre as decisões tomadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o parecer critica a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural (ou 'imunidade de rebanho'); a priorização de um tratamento precoce sem amparo científico de eficácia; o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas e o atraso na aquisição de imunizantes. 'Com esse comportamento o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu com a morte de brasileiras e brasileiros', disse o relator. Renan alega que as investigações da CPI demonstraram que a aquisição de imunizantes não foi uma prioridade do governo em nenhum momento. 'Essa atuação negligente apenas reforça que se priorizou a cura via medicamentos, e não a prevenção pela imunização, e optou-se pela exposição da população ao vírus, para que fosse atingida mais rapidamente a imunidade de rebanho (CNN Brasil, 2021e).

⁷ Defesa da tese da imunidade de rebanho (ou coletiva) por contágio (ou transmissão) como forma de resposta à Covid-19, disseminando a crença de que a "imunidade natural" decorrente da infecção pelo vírus protegeria os indivíduos e levaria ao controle da pandemia, além de estimativas infundadas do número de óbitos e da data de término da pandemia.

Em depoimento prestado à CPI da COVID-19, o ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou ter compreendido que a estratégia de enfrentamento à pandemia adotada pelo então Presidente Jair Bolsonaro consistia em uma opção deliberada, cuja implementação estaria diretamente associada ao elevado número de óbitos registrados no período.

A impressão que eu tenho é que era alguma coisa nesse sentido [de buscar a imunidade de rebanho], o principal convencimento, mas eu não posso afirmar', afirmou o ex-ministro, que também afirmou que Bolsonaro tinha outro aconselhamento sobre a pandemia que não vinha do ministério da saúde. Mandetta disse que Bolsonaro foi alertado das consequências de não ouvir a ciência. O ex-ministro afirmou que o presidente inclusive foi informado da projeção de alto número de mortes caso as medidas com comprovação científica (como adotar o isolamento social e só promover tratamentos com eficácia comprovada) não fossem seguidas (BBC News, 2021a).

Em igual direção, o também ex-titular da pasta da Saúde, Nelson Teich, quando inquirido sobre o tema durante seu depoimento, afirmou que a estratégia de imunidade de rebanho não foi formalmente apresentada ou discutida como diretriz oficial pelo então Presidente Jair Bolsonaro em quaisquer reuniões ministeriais.

Essa tese de imunidade de rebanho, em que você adquire a imunidade através do contato, e não da vacina, isso é um erro. A imunidade você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas', afirmou. Apesar de, segundo Teich, Bolsonaro não ter falado sobre o assunto com o então ministro, o presidente fez discursos onde defendeu o isolamento social apenas de idosos e elogiou países e cidades que haviam adotado a estratégia da imunidade de rebanho sem vacinas na época (BBC News, 2021a).

Em declaração à comissão, o senador Humberto Costa (PT-PE), membro da comissão, afirmou: "Se isso é verdadeiro, o presidente incorreu em um grave crime, que representa um dolo eventual, ou seja, que ele correu o risco de causar um dano irreversível às pessoas com essa tese. E isso se transforma em um grave crime de responsabilidade" (BBC News, 2021a).

Paralelamente, observa-se que a racionalidade conservadora ultraliberal, embora se apresente discursivamente como neutra e técnica, constitui-se como um constructo ideológico promovido por conglomerados empresariais, corporações tecnológicas (*big techs*), nações com projeção imperialista e instituições financeiras. Este arcabouço teórico depende estruturalmente da disponibilidade de uma massa descartável de trabalhadores, garantindo a continuidade da acumulação capitalista mesmo à custa do bem-estar coletivo, o

que coincidia de maneira plena com as bases políticas do governo Bolsonaro, alinhado com tal agenda.

A influência do interesse empresarial alcançou o âmago da condução política da saúde, manifestando-se de forma direta na instabilidade da liderança do Ministério da Saúde. Essa instabilidade institucional tornou-se uma marca distintiva do governo, com o registro de quatro substituições ministeriais ao longo do período. Parte significativa dessas rotatividades decorreu de divergências substantivas entre os titulares da pasta e a orientação do Palácio do Planalto, especificamente quanto à adoção de protocolos sanitários fundamentados em evidências científicas, em contraste com a pressão por medidas alinhadas a uma agenda econômica imediatista.

Figura 16 - Cronologia dos ministros da saúde (2019 a 2022)



Fonte: autora (2025).

A exoneração de Luiz Henrique Mandetta do cargo de Ministro da Saúde, em 16 de abril de 2020, decorreu substancialmente da ingerência do Presidente Jair Bolsonaro nas diretrizes técnicas da pasta.

A principal razão da demissão é o dissenso sobre a estratégia de resposta à pandemia, em particular o uso precoce da cloroquina. Segundo Mandetta, ao final de março, o Presidente passou a buscar assessoria para se contrapor à estratégia do Ministério da Saúde. O ex-Ministro descreve este momento em livro publicado em setembro de 2020: 'O Palácio do Planalto passou a ser frequentado por médicos bolsonaristas. (...) Ele queria no seu entorno pessoas que dissessem aquilo que ele queria escutar', em alusão ao que mais tarde seria chamado de 'assessoramento paralelo' ou 'gabinete paralelo'. Ainda segundo o livro, nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a cloroquina como um caminho de saúde. A preocupação dele era sempre 'vamos dar esse remédio porque com essa caixinha de cloroquina na mão os trabalhadores voltarão à ativa, voltarão a produzir'. (...) o projeto dele para combate à pandemia é dizer que o governo tem o remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem ia morrer de qualquer maneira (Ventura e Reis, 2021, p.47).

O afastamento ocorreu em um contexto de divergência substantiva quanto às estratégias de enfrentamento da pandemia, notadamente acerca da incorporação da cloroquina como terapêutica. Enquanto o Ministério da Saúde sustentava posicionamento alinhado às evidências científicas disponíveis, o Chefe do Executivo federal empenhava-se na disseminação do medicamento para a população, à revelia do consenso técnico-sanitário.

Nelson Teich, que registrou a mais breve passagem pela pasta ministerial, igualmente manifestou divergências substantivas em relação às diretrizes do governo Bolsonaro. À semelhança de seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, Teich defendia a adoção de medidas de isolamento social como estratégia de contenção da pandemia, tendo chegado a propor a implementação de lockdown em localidades com elevados índices de transmissão viral, conforme registrado em cobertura jornalística da época (UOL, 2021a).

O Ministro da Saúde Nelson Teich se demite: 'Não vou manchar a minha história por causa da cloroquina', teria dito. Assume interinamente o secretário-executivo Eduardo Pazuello, militar sem formação ou experiência na área da saúde. Em 07/10, ele declarou, em uma solenidade oficial, que, antes de assumir o cargo, 'nem sabia o que era o SUS' (Ventura e Reis, 2021, p.54).

Em 15 de maio de 2020, Ministério da Saúde foi conduzido pelo General de Exército Eduardo Pazuello, em um dos períodos mais críticos da pandemia de COVID-19 no Brasil. Sua nomeação representou uma significativa mudança de perfil na liderança da pasta, marcando a transição de uma gestão técnica para uma gestão militarizada no comando das políticas de saúde. Pazuello assumiu inicialmente como ministro interino em 15 de maio, sendo efetivado no cargo em 16 de setembro do mesmo ano. Sua trajetória prévia era predominantemente na área logística das Forças Armadas, sem experiência anterior em gestão de saúde pública. Esse aspecto seria frequentemente citado como uma das limitações de sua gestão, especialmente em um contexto que demandava expertise técnica em epidemiologia e saúde coletiva.

Pazuello consolidou-se por institucionalizar o protocolo de tratamento precoce para COVID-19, que incluía a recomendação de cloroquina e hidroxicloroquina, alinhando-se assim às diretrizes do presidente Bolsonaro. Sua gestão à frente do Ministério da Saúde foi alvo de contundentes críticas por parte de especialistas e da comunidade científica, que apontavam tanto a excessiva

subordinação às orientações do Planalto quanto a lentidão nas tratativas para aquisição de imunizantes junto aos laboratórios farmacêuticos internacionais.

Em seu discurso de posse como ministro da Saúde, Pazuello afirma: 'O aprendizado ao longo da pandemia mostrou que, quanto mais cedo atendermos aos pacientes, melhor a chance de recuperação. O tratamento precoce salva vidas. Por isso, temos falado dia após dia, 'não fique em casa', receba o diagnóstico clínico do médico. Receba o tratamento precoce (Ventura e Reis, 2021, p.86).

Em dezembro de 2020, o então Pazuello manifestou publicamente ceticismo em relação ao processo de imunização, questionando: "Para que essa ansiedade e essa angústia?" (Ventura e Reis, 2021, p.111). A declaração foi proferida no mesmo dia em que Bolsonaro enfatizou em seu discurso que os fabricantes de vacinas se isentavam de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais em suas bulas, estratégia retórica que contribuía para alimentar hesitação vacinal na população.

O projeto político do governo Bolsonaro promoveu um retorno a um individualismo exacerbado, que serviu de base ideológica para uma gestão pandêmica que subordinou a saúde pública a imperativos econômicos. Esse ambiente, que minou a empatia e a noção de responsabilidade coletiva, criou as condições para que empresas como a *Prevent Senior* adotassem práticas que colocaram o lucro acima da vida, culminando em um dos capítulos mais sombrios da crise sanitária no Brasil. Esse individualismo associa a um estilo de vida comunitário em declínio e a uma sociedade que se atomiza, não foi apenas uma característica social, mas uma estratégia política que encontrou eco em setores da sociedade. Em um contexto que demandava solidariedade e iniciativas coletivas, a postura oficial caracterizou-se por um negacionismo científico que sistematicamente boicotou medidas de proteção sanitária, desqualificou evidências científicas e fomentou a noção de que cada indivíduo deveria procurar suas próprias soluções. Essa orientação foi sintetizada na emblemática declaração "Eu não sou coveiro", que se tornou símbolo da abdicação da responsabilidade estatal na coordenação de políticas públicas de enfrentamento à crise sanitária.

Foi neste terreno fértil de desdém pela coletividade que o caso da *Prevent Senior* floresceu, ilustrando de forma crua como a lógica do lucro ininterrupto se aproveitou do contexto de desinformação e desamparo estatal. O Caso *Prevent*

Senior durante o governo Bolsonaro constituiu um episódio paradigmático da confluência entre interesses privados, políticas públicas anticientíficas e a instrumentalização da saúde com fins políticos. Este caso, amplamente investigado por comissões parlamentares e órgãos do Ministério Público, revelou uma articulação que teve como pano de fundo a estratégia negacionista adotada pelo governo federal no enfrentamento à pandemia de COVID-19.

A operadora de saúde *Prevent Senior*, cuja base de beneficiários é majoritariamente composta por idosos – grupo de alto risco para a doença –, buscou uma aproximação estratégica com o governo após ter sua reputação inicialmente abalada. A empresa estabeleceu uma ligação com um grupo informal de médicos que assessorava o presidente Jair Bolsonaro, conhecido como "gabinete paralelo", cujo objetivo comum era promover um protocolo de "tratamento precoce" como alternativa às medidas de distanciamento social. Essa aliança atendia ao discurso presidencial de que "o Brasil não podia parar", fornecendo uma aparente base técnica para uma política que priorizava a atividade econômica.

Com este suposto aval, a *Prevent Senior* realizou um estudo clínico para testar a hidroxicloroquina associada à azitromicina, o chamado "kit COVID", em seus próprios pacientes. As investigações da CPI da Pandemia do Senado Federal e do Ministério Público de São Paulo constataram que este estudo foi realizado de forma profundamente fraudulenta e antiética. Médicos foram instruídos a não obter o consentimento livre e esclarecido dos pacientes ou de seus familiares para a administração dos medicamentos experimentais, uma violação grave dos preceitos éticos da pesquisa. Além disso, foi comprovada a ocultação de mortes ocorridas durante o experimento; enquanto nove participantes faleceram, o estudo divulgado publicamente reportou apenas dois óbitos, atribuídos a outras causas. Áudios internos revelaram a coordenação do estudo orientando a manipulação de dados para que os resultados fossem "assertivos e perfeitos", demonstrando que a conclusão favorável foi pré-determinada.

A análise dos dados de aquisição do denominado "kit-covid" pela empresa, referente ao período entre 2016 e 2020, foi possibilitada por meio do requerimento de autoria do Senador Humberto Costa (PT-PE). A disponibilização dessas informações permite dimensionar o volume e a evolução temporal dos

investimentos em medicamentos como a hidroxiclороquina e a azitromicina, usualmente associados ao protocolo de "tratamento precoce" contra a COVID-19 promovido pelo governo federal.

Figura 17 - Aquisição de Hidroxiclороquina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020

- Hidroxiclороquina:

HCQ	Quantidade	Valor (R\$)
2016	30	64,04
2017	90	194,57
2018	0	0,00
2019	150	376,04
2020	1.190.280	2.183.112,68
2021	60	172,20

Fonte: Relatório final da CPI da COVID Brasil (2021a).

Figura 18 - Aquisição de Azitromicina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020

- Azitromicina:

Azitro	Quantidade	Valor (R\$)
2016	0	0,00
2017	44	210
2018	7.530	191.448
2019	10.697	282.861
2020	289.866	1.276.450
2021	86.331	357.244

Fonte: Relatório final da CPI da COVID Brasil (2021a).

Figura 19 - Aquisição de Ivermectina pela Prevent Senior no período de 2016 a 2020

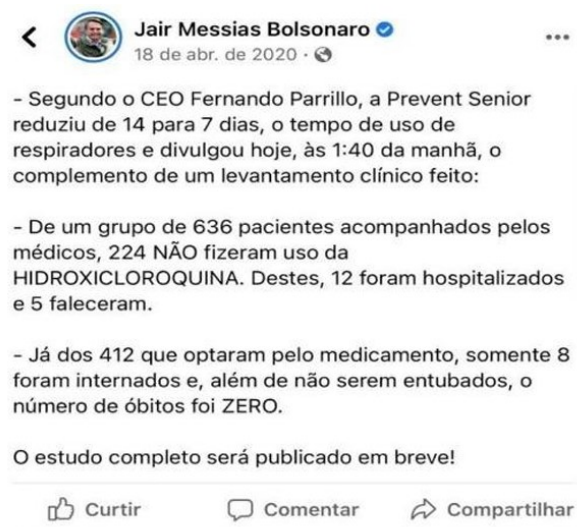
- Ivermectina:

	Ivermec	Quantidade	Valor (R\$)
2016		954	1.387
2017		696	1.661
2018		848	1.041
2019		752	1.433
2020		32.280	82.169
2021		30.872	81.529

Fonte: Relatório final da CPI da COVID Brasil (2021a).

O governo Bolsonaro, por sua vez, desempenhou um papel ativo na promoção deste estudo fraudulento, incorporando-o à sua narrativa oficial. O próprio presidente compartilhou os resultados falsos em suas redes sociais, realizou uma live com médicos da empresa e citou os dados como prova da eficácia do "tratamento precoce". Seus filhos, os parlamentares Flávio e Eduardo Bolsonaro, também atuaram como divulgadores da narrativa da *Prevent Senior*. Esta simbiose transformou a operadora em um pilar da estratégia governamental, fornecendo uma fachada de legitimidade científica para uma política baseada em evidências falsas.

Figura 20 - Postagem do ex-presidente Bolsonaro no Twitter sobre o tratamento da Prevent Senior em 2020



Fonte: Relatório final da CPI da COVID Brasil (2021a).

Figura 21 - Postagem de Eduardo Bolsonaro no Twitter sobre o tratamento precoce 2020



Fonte: Relatório final da CPI da COVID Brasil (2021a).

As consequências legais deste caso são amplas, mas ainda em curso. O Relatório Final da CPI da Pandemia do Senado Federal pediu o indiciamento de dirigentes da *Prevent Senior* por crimes como falsidade ideológica e crime contra a humanidade, destacando sua associação com o gabinete paralelo. O Ministério

Público de São Paulo ajuizou uma ação civil pública por danos morais coletivos no valor de R\$ 940 milhões e, em 2024, ofereceu denúncia criminal por homicídio culposo contra dez dirigentes da empresa. Laudos periciais independentes concluíram que, em ao menos sete casos analisados, a administração do "kit COVID" contribuiu para o agravamento do estado de saúde e para o óbito dos pacientes. Apesar do robusto conjunto probatório, o andamento processual é lento e, até o momento, nenhuma condenação foi proferida, enquanto alguns dos médicos que denunciaram as irregularidades enfrentam retaliações judiciais.

Em síntese, o Caso *Prevent Senior* traduziu o projeto político-empresarial brasileiro da época. Ele funcionou como um instrumento operacional da estratégia negacionista do governo Bolsonaro, utilizando pacientes idosos e vulneráveis em um experimento não consentido para validar uma política pública irresponsável. O episódio permanece como um símbolo dos custos humanos gerados quando a saúde pública é subordinada ao lucro, à ideologia e à propaganda política, e sua resolução na Justiça representa um teste crucial para os mecanismos de responsabilização no Brasil.

A concepção da saúde como mercadoria e do cidadão como consumidor instaura uma lógica onde a saúde se insere no universo da concorrência, da teoria da oferta e da demanda, da precificação e, conseqüentemente, da exclusão. A privatização da saúde configura-se como tema recorrente no debate público, especialmente porque se trata de uma área tradicionalmente pública que demanda vultosos recursos, e cuja orientação econômica contemporânea tende a afastar o Estado da sua provisão direta, delegando-a à iniciativa privada. As reformas administrativas iniciadas a partir de 1995 promoveram uma reestruturação do Estado, deslocando-o do papel central de garantidor de direitos para a função de gestor de mercados. Esse deslocamento não decorre apenas da percepção, entre administradores e economistas alinhados ao pensamento ultraliberal, de que a saúde representa um ônus oneroso para os cofres públicos, mas também do reconhecimento de seu potencial como campo fértil para a exploração do capital. Ao longo da história das reformas administrativas brasileiras, jamais se observou um movimento de retorno aos princípios fundantes da saúde pública estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Pelo contrário, cada nova reforma consolidou ainda mais a concepção da saúde como mercadoria e naturalizou a exclusão, frequentemente mascarada

por eufemismos presentes em documentos oficiais, a exemplo da terminologia "publicização" empregada por Bresser-Pereira para designar programas de privatização.

A acumulação sucessiva de camadas de indiferença diante de decisões políticas de gravidade inaudita conduz a um ponto em que a transformação de direitos sociais em mercadorias deixa de suscitar indignação coletiva. Ademais, as práticas inerentes ao setor privado não estão necessariamente ancoradas em obrigações sociais, mesmo quando mediadas por convênios com a Administração Pública. A experiência pandêmica expôs com crueza a gravidade dessa dissociação, revelando um cenário que demanda profunda reflexão social sobre os mecanismos e os limites dos processos de privatização em curso.

Um governo que assim atua o faz a partir de uma postura de extrema intolerância com a diferença, utilizando o discurso oficial para reforçar preconceitos e fragmentar o tecido social. Esta estratégia discursiva não está descolada da racionalidade ultraliberal; pelo contrário, ela a serve na medida em que promove fissuras profundas na sociedade. Ao polarizar e fomentar hostilidades, este projeto político corrói a noção de bem comum e dificulta a formação de uma cidadania ativa e solidária. O resultado é uma coletividade cada vez mais atomizada, individualizante e incapaz de perceber a diferença como um elemento enriquecedor para a construção de laços democráticos, conformando-se, assim, ao ideal de sujeito despolitizado e voltado apenas para sua autogestão, característico do projeto ultraliberal.

Em síntese, respondendo à pergunta basilar do primeiro pilar do Estado Ultraliberal – *como as ações e omissões do governo durante a pandemia privilegiaram interesses econômicos, a desregulamentação e a mercantilização da vida* – conclui-se que a gestão federal configurou um projeto político deliberado. Este projeto sistematicamente subordinou a saúde pública e os direitos sociais aos imperativos do mercado e da acumulação privada, materializando-se por meio de uma estratégia articulada.

Em primeiro lugar, estabeleceu-se a primazia explícita da economia sobre a vida, cristalizada em um discurso presidencial que minimizava a letalidade viral, desqualificava as evidências científicas sobre distanciamento social e promovia um conflito federativo aberto contra governadores que implementavam medidas restritivas. A opção política foi inequívoca: salvaguardar a atividade econômica a

qualquer custo, ainda que tal postura implicasse a subestimação deliberada da crise sanitária e a sobrecarga dos sistemas de saúde subnacionais.

Em segundo lugar, essa prioridade ideológica materializou-se em medidas concretas de desregulamentação e precarização institucional. A edição de Medidas Provisórias, como a de nº 927 e a de nº 936, representou um ataque direto à estrutura de direitos trabalhistas, buscando dificultar o reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional e operar uma transferência dos custos da crise para os trabalhadores, por meio da redução salarial e da suspensão de contratos. Na mesma linha, a MP nº 928 buscou restringir o acesso à informação pública, fragilizando os mecanismos de transparência e controle social em um momento de extrema necessidade. Coletivamente, tais ações corroeram os pilares da proteção social e institucionalizaram um estado de insegurança jurídica e econômica.

Por fim, a terceira frente deste projeto consistiu na aceleração da transformação da saúde em mercadoria. Casos emblemáticos, como o da operadora *Prevent Senior*, aliados à promoção governamental de "tratamentos precoces" sem eficácia comprovada, ilustram como a população foi conduzida a buscar respostas individualizadas no mercado. A pandemia funcionou, assim, como um potente catalisador para o complexo médico-industrial, no qual o cuidado com a vida e a saúde é progressivamente convertido em uma oportunidade de geração de lucro, expondo as graves contradições inerentes ao processo de privatização deste setor.

Conclui-se, portanto, que a gestão da crise sanitária seguiu uma lógica interna coerente com os preceitos do Estado Ultraliberal, caracterizada pela subordinação da vida e dos direitos fundamentais aos imperativos do mercado. Este processo aprofundou desigualdades estruturais, fragilizou a capacidade de ação do Estado enquanto garantidor de direitos e consolidou um modelo societal no qual a proteção à saúde deixa de ser um direito universal para se tornar um bem de consumo, acessível apenas na medida do poder de compra de cada indivíduo.

5.3. Análise do Pilar 2: A Necropolítica na Pandemia

A morte, longe de ser apenas um evento biológico terminal, opera nas sociedades humanas como um potente dispositivo de memória. Os rituais

fúnebres — desde a mumificação egípcia até os enterros indígenas — constituem tecnologias culturais sofisticadas para transformar a perda individual em patrimônio coletivo. Através deles, uma comunidade não apenas se despede de um dos seus, mas reafirma publicamente quem ela é, de onde vem e quais valores a sustentam. A morte, portanto, não apaga a vida; ela a inscreve na história.

O momento da morte cria uma ruptura no tecido social. O ritual funerário é a resposta cultural a essa crise. Ele é, nas palavras do antropólogo Arnold van Gennep (1978), um rito de passagem que estrutura a transição do falecido do mundo dos vivos para o dos mortos (ou ancestrais). Mas essa estruturação não beneficia apenas o morto; ela reestabiliza a comunidade dos vivos. Ao seguir procedimentos ancestrais — cantos específicos, vestimentas, gestos, oferendas —, o grupo performa sua continuidade. Cada funeral é uma reencenação da tradição, uma lição prática de identidade transmitida no momento de maior vulnerabilidade emocional.

O historiador Pierre Nora (1993), em seu conceito de *"lugares de memória"*, nos ajuda a entender que os túmulos, os cemitérios e os monumentos funerários são justamente isso: sítios onde a memória se materializa e se torna acessível. Eles convertem a ausência em presença simbólica, permitindo que o passado dialogue permanentemente com o presente.

Como estudado por Claude Lévi-Strauss entre os Bororo e por Aparecida Vilaça (1992) entre os Wari', muitos povos indígenas praticam o enterro secundário. Após a decomposição da carne (o elemento perecível e individual), os ossos (a estrutura duradoura) são limpos, pintados e realocados. Este segundo rito marca a transformação definitiva do morto em ancestral, integrando-o ao panteão coletivo que orienta e protege a comunidade. A memória deixa de ser ligada a um rosto específico e se torna uma força ancestral impessoal que guia o povo.

O contraponto sombrio dessa relação entre morte e memória é exposto por Achille Mbembe (2011) com o conceito de necropolítica. Se os rituais tradicionais buscam memorizar e dignificar, o poder necropolítico opera através da produção ativa do esquecimento. Ele determina não apenas quem pode morrer, mas quais mortes são dignas de luto e registro histórico.

Populações marginalizadas, indígenas, negros e pobres sofrem frequentemente uma dupla morte: a biológica e a simbólica. Seus corpos são desaparecidos, seus funerais são negados ou realizados de forma anônima, suas histórias são apagadas dos registros oficiais. Essa negação do ritual é uma violência profunda, pois impede que a comunidade elabore o luto e, conseqüentemente, que preserve a memória daquela vida e da injustiça que a ceifou. É a morte como instrumento de apagamento histórico.

No contexto de pandemia, a gestão da vida populacional ganhou centralidade nas políticas governamentais. Foucault (2022), em o nascimento da Biopolítica, já debateu sobre a questão da gestão da vida da população (fazer viver e deixar morrer), através de métodos matemáticos de estatísticas, regulação e questões de saúde pública. Porém, na lógica desse “fazer viver”, a morte não desaparece ela é gerida e seletiva para que alguns vivam e a população seja otimizada, outros podem e devem ser “deixados para morrer”. O racismo de Estado é o mecanismo essencial para operar essa divisão: ele fragmenta a população em “raças boas” e “raças más”, transformando grupos em “inimigos” internos cuja morte fortalece, paradoxalmente, o corpo social.

Achille Mbembe (2011) aprofunda essa análise. Para ele, o conceito de biopolítica é insuficiente para entender contextos extremos de violência, como os provenientes da experiência colonial e escravista. Mbembe propõe a necropolítica como o poder supremo de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Aqui, a lógica ultrapassa o “deixar morrer” por omissão ou negligência e atinge um “fazer morrer” ativo e programático. O “necropoder” cria “zonas de morte” (como favelas sob intervenções policiais brutais) onde o Estado de Direito é suspenso e a morte se torna uma ferramenta de gestão política.

A gestão do governo Bolsonaro pode ser analisada pelo prisma da necropolítica, uma vez que a vida foi sistematicamente avaliada com base em sua utilidade econômica e potencial lucrativo. Em diversas ocasiões, o aparato estatal foi mobilizado para coagir os trabalhadores a retornarem precocemente aos seus postos, em um contexto em que medidas truculentas de assédio moral por parte dos empregadores foram potencializadas. Este cenário acentuou o desequilíbrio estrutural na relação entre capital e trabalho, agravado pelo aumento do desemprego, pela redução da renda familiar e pela incerteza

generalizada, fatores que criaram uma condição de alta vulnerabilidade para milhões de trabalhadores.

No cenário político brasileiro, a orientação ultraliberal do Estado e o processo de burocratização governamental não configuram fenômenos paralelos, mas sim elementos estruturalmente articulados a uma lógica necropolítica. A racionalidade ultraliberal, ao priorizar a austeridade fiscal e o desmonte de políticas sociais universais, cria as condições institucionais para que a burocracia estatal opere não como um mecanismo de garantia de direitos, mas como um dispositivo de gestão diferencial da vida. Eles instrumentalizam o aparato estatal para operar uma seletividade letal, onde a desobrigação social e os entraves burocráticos deliberados definem quais grupos sociais são protegidos e quais são expostos sistematicamente ao risco de morte social e física.

Um exemplo emblemático desse ambiente foi o caso da rede de varejo Havan, condenada por assédio eleitoral durante o período pandêmico. Conforme relatado por uma ex-funcionária da loja de Jacareí (SP), a gerência coibia quaisquer críticas ao então presidente Jair Bolsonaro e fazia ameaças veladas sobre um possível fechamento do estabelecimento caso Luiz Inácio Lula da Silva fosse eleito (G1, 2024). Este padrão de conduta não é incidental, ele reflete uma cultura organizacional que trata o trabalhador não como um sujeito portador de direitos, mas como um recurso descartável, cuja dignidade é sacrificável em nome da produtividade, de uma lealdade ideológica imposta ou da impunidade para terceiros.

A população se viu em uma situação de desamparo institucional, na qual o Estado se posicionava ativamente contra sua proteção, alinhando-se a uma lógica de gestão da morte que evocava a prerrogativa soberana de fazer morrer. O discurso oficial que minimizava a gravidade do vírus, a sabotagem ativa de medidas de distanciamento social e a promoção de tratamentos sem eficácia científica não foram meros equívocos, mas componentes de uma racionalidade política que naturalizou a morte como um custo aceitável. Essa seleção seguiu linhas históricas de desigualdade: os dados de mortalidade escancararam como a letalidade foi drasticamente maior entre populações negras, periféricas e de baixa renda. A inação do Estado, portanto, não foi uma omissão passiva, mas um "deixar morrer" ativo, um mecanismo necropolítico que reforçou hierarquias

sociais e raciais pré-existentes, tratando certas vidas como descartáveis em prol da manutenção de uma normalidade econômica.

A análise dos fenômenos registrados durante o período pandêmico, fundamentada na cobertura jornalística e na factualidade amplamente divulgada, foi realizada sob a égide do referencial teórico da necropolítica. Ademais, com o propósito de orientar a classificação e a análise crítica das matérias selecionadas para este subcapítulo, adotou-se o seguinte questionamento norteador: *como o governo administrou a morte, tornando-a uma consequência "natural" e aceitável da pandemia, e para quais grupos sociais essa morte foi direcionada?*

5.3.1. Análise dos fatos ocorridos durante a Pandemia sob o viés da necropolítica

O "Manual do Enterro no Brasil da Pandemia" (Brasil, 2020t), documento administrativo emitido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em março de 2020 durante o governo Bolsonaro, não é um ponto de partida para uma narrativa sobre necropolítica: ele é sua materialização burocrática. Este texto normativo, que buscava regulamentar procedimentos para "enterros e cremações" em um cenário de colapso iminente, atua como um prisma pelo qual se pode decifrar a racionalidade política que governou a gestão da crise. Ele concretiza, em linguagem técnica e protocolos, a operacionalização do que Achille Mbembe define como necropolítica: o poder soberano de decidir quem pode viver e quem deve morrer, e como essa morte será administrada.

A publicação do manual em um momento crítico — quando especialistas alertavam para a necessidade urgente de medidas de distanciamento social e de fortalecimento do SUS — sinalizou uma inversão de prioridades. Enquanto a sociedade e parte dos governadores clamavam por uma política robusta de "fazer viver" (a biopolítica), o governo federal, através de seu ministério da saúde, antecipava e normalizava a gestão da morte. O manual não tratava de como salvar vidas em UTIs superlotadas ou como garantir oxigênio; ele regulamentava a logística dos corpos, a velocidade dos sepultamentos e a contenção de "possíveis riscos" dos cadáveres. É a burocratização do "deixar morrer", a aceitação prévia da morte em massa como um dado administrativo a ser gerido, e não como uma tragédia a ser evitada a todo custo.

Esta antecipação da morte como problema logístico expõe o racismo de Estado inerente à necropolítica, conforme teorizado por Foucault e Mbembe. O manual foi publicado em um país cuja estrutura social e geográfica já determinava quem teria acesso a leitos de UTI, a testes e a um isolamento digno. As populações periféricas, negras e indígenas, historicamente vulnerabilizadas, seriam as mais atingidas pela falta de políticas de proteção à vida e, portanto, as principais "clientelas" dos protocolos daquele guia. Ao não priorizar a prevenção para todos, o Estado operou uma seleção social da morte, onde a letalidade do vírus seguiria — e de fato seguiu — as linhas da desigualdade racial e econômica. O manual é, assim, a preparação técnica para o resultado previsível de uma política que tratava certas vidas como dispensáveis.

Figura 22 - Cemitério de Nossa senhora Aparecida em Manaus



Fonte: Folha de Pernambuco (2021).

A linguagem do documento — seca, técnica, desprovida de qualquer tom de luto ou cuidado coletivo — é sintomática da dessensibilização necessária para a governança necropolítica. Ele fala de "corpos", "restos mortais", "desinfecção" e "sepultamento em cova única". Essa objetificação é um mecanismo de poder: transforma a perda humana em um fluxo a ser controlado, esvaziando-a de seu significado político e ético. Quando a morte se torna uma questão de manual de procedimentos, a responsabilidade pelo número estratosférico de óbitos é diluída em protocolos, e a indignação pública é amortecida por uma aparente "normalidade" burocrática. É a naturalização da morte como um dado administrativo, e não como um fracasso político.

Portanto, o "Manual do Enterro" não é um detalhe macabro da pandemia; é um documento-chave para entender a governamentalidade do período. Ele

revela que, na ausência de uma política de Estado voltada para a preservação universal da vida, o que se erigiu foi um aparato para administrar suas consequências mais extremas. Ele corporifica a transição de um Estado que deveria, em tese, "fazer viver" (biopolítica), para um Estado que, por ação e omissão, passou a "gerenciar a morte" (necropolítica). Iniciar uma análise por este manual é começar pelo fim: pelo ponto em que a política abdicou da vida e assumiu, burocrática e friamente, a gestão dos seus descartes. O manual não é sobre a pandemia; é sobre o tipo de sociedade que a gestão da pandemia ajudou a consolidar: uma sociedade onde a morte, para muitos, foi primeiro prevista em manuais, depois naturalizada em discursos, e finalmente consumada em estatísticas.

Somando-se a isso, a prática ritualística do enterro constitui um pilar antropológico fundamental para a cultura humana, funcionando como um ritual de passagem essencial que permite à comunidade processar a perda, reafirmar laços sociais e conferir significado à finitude. O sepultamento, em sua dimensão simbólica, não é um mero ato de disposição de um corpo; é um ato de linguagem coletiva que transforma a morte biológica em um evento socialmente inteligível, permitindo a despedida, a elaboração do luto e a reintegração dos vivos à ordem do mundo.

A política de enfrentamento à COVID-19, em sua vertente mais desumanizante, promoveu uma ruptura traumática nesse contrato simbólico milenar. Ao priorizar uma lógica estritamente biopolítica de contenção sanitária — e, em muitos contextos, uma lógica necropolítica de gestão da morte em massa —, o Estado e as autoridades sanitárias foram obrigados a implementar protocolos que negligenciaram a dimensão humana do morrer. As diretrizes que determinaram sepultamentos imediatos, a interdição de velórios, a limitação severa de acompanhantes e, em casos extremos, a destinação de corpos para valas comuns ou caixões lacrados, criaram um cenário de luto interrompido e despedida impossibilitada.

A pessoa faleceu, mas também foi simbolicamente apagada do convívio coletivo, sem o rito que a reconhece como sujeito único e integrante de uma rede de afetos. Para as famílias, a impossibilidade de realizar os ritos fúnebres gerou um luto congelado, uma dor que não encontra canal de expressão ou resolução simbólica, potencializando traumas psicológicos de longa duração. A cultura, em

seu papel de amortecer o choque da morte através da cerimônia, foi substituída pela fria eficiência da gestão de risco, convertendo o momento sagrado da despedida em um problema logístico a ser resolvido com distanciamento e urgência.

A brutalidade dessa política reside precisamente em seu efeito dessubjetivador. Ao negar o rito, nega-se a singularidade da vida que se foi, reduzindo-a a um "caso", um "número" ou um "corpo a ser eliminado". É a culminação de um processo de desumanização onde a vida, já tratada como descartável durante a pandemia em nome da economia, teve sua morte igualmente dessacralizada. A violência não está apenas na morte em si, mas na privação do significado que a cultura oferece para enfrentá-la. Assim, a política desumanizante da COVID não apenas ceifou vidas, mas também atacou os próprios mecanismos culturais que nos permitem, como sociedade, compreender a perda e seguir vivendo. O enterro negado é, portanto, a metáfora última de uma gestão que, em seu cálculo político e sanitário, esqueceu-se de que por trás de cada estatística havia uma história, uma rede de afetos e uma comunidade que precisava dizer adeus.

A declaração proferida pelo então Presidente Jair Bolsonaro em 20 de abril de 2020 — na qual afirmou não ser "coveiro" e, portanto, não poder intervir diante do crescente número de óbitos pela pandemia — constitui uma manifestação explícita da lógica necropolítica que orientou determinadas ações governamentais no período. Ao distanciar-se simbolicamente da responsabilidade pela gestão da crise sanitária e pelo sofrimento decorrente, o discurso posicionou o agente público não como um ator voltado à contenção da disseminação do vírus e à preservação de vidas, mas sim como uma figura que administra, *a posteriori*, as consequências letais da doença.

Figura 23 - Bolsonaro e a frase “não sou coveiro” proferida em 20 de abril de 2020



Fonte: UOL Oficial (2020).

A violação do direito a uma morte ritualizada e socialmente reconhecida pode estar intrinsecamente vinculada à questão racial no Brasil. O apagamento histórico e estrutural de populações residentes em favelas e periferias urbanas — compostas majoritariamente por pessoas negras e, em especial, mulheres negras — as colocou em uma posição de extrema vulnerabilidade durante a pandemia. Como evidenciado pelo Relatório Final da CPI da COVID, grupos étnico-raciais marginalizados, tais como indígenas e negros, foram atingidos de forma desproporcional pelo vírus, uma vez que "a desigualdade se torna uma comorbidade, pois a insegurança alimentar, a falta de condições dignas de moradia e de acesso ao saneamento faz com que essas pessoas fiquem mais suscetíveis ao contágio." (Brasil, 2021a, p. 648).

Esta sobreposição de vulnerabilidades resultou em uma desigualdade profunda no impacto socio sanitário da pandemia, configurando um fenômeno que atingiu, de maneira particularmente severa, mulheres, populações negras e comunidades quilombolas. A análise dos dados epidemiológicos revela que, dentro desses grupos historicamente vulnerabilizados, a COVID-19 apresentou uma incidência e uma letalidade mais elevadas entre as mulheres do que entre os homens, reforçando as intersecções entre gênero, raça e classe como determinantes fundamentais da distribuição da doença e da morte.

Isso mostra que as mulheres são mais expostas à doença, o que talvez seja reflexo de sua maior participação em profissões ligadas ao cuidado e à limpeza. É significativo, entretanto, registrar que as

primeiras mortes pela doença no Brasil foram das trabalhadoras domésticas Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, de São Paulo, e Cleonice Gonçalves, de 63 anos, moradora do Rio de Janeiro. Duas mulheres negras, provavelmente contaminadas no local de trabalho. (Brasil, 2021a, p.649).

A pesquisa conduzida por universidades federais (UFRJ, UFPB) e pela Fiocruz do Distrito Federal, que monitorou a insegurança alimentar no Brasil durante a pandemia de Covid-19 (2020, 2022 e 2023), expõe as consequências materiais de uma política estatal de abandono. Os dados, que apontam para o crescimento da fome concentrado em lares de baixa renda e “chefiados por mulheres negras” (Brasil, 2025), transcendem a mera descrição estatística. Eles revelam as camadas políticas de um governo que, ao se furtar à sua obrigação de garantir a segurança alimentar, pratica uma forma de necropolítica, administrando de forma seletiva quem está mais exposto à morte social e biológica pela privação.

O relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI)”, de 2021, revelou que o Brasil reentrou no Mapa da Fome da ONU, o que não ocorria desde 1990. O país alcançou a marca de 70,3 milhões de brasileiros que enfrenta algum tipo de insegurança alimentar (O globo, 2023), a escassez de alimento fez com que pessoas chegassem a buscar ossos no lixo.

Figura 24 - Caminhão do osso e a luta de famílias brasileiras contra a fome



Fonte: O Globo (2023).

Conforme relatado por Raíssa Mello, ativista e organizadora de campanhas de distribuição alimentar, houve uma nítida transformação no perfil dos beneficiários. Se, em um cenário pré-pandêmico, o apoio se concentrava em grupos historicamente vulnerabilizados – como egressos do sistema prisional ou mulheres em situação de violência –, o período da Covid-19 promoveu uma "democratização da privação", atingindo transversalmente diversas faixas etárias e sociais. Raíssa observa ainda uma mudança significativa nas demandas em ações solidárias: "Antes a criançada pedia brinquedo, hoje a maioria pede cesta básica e material escolar". Esta constatação aponta para uma deterioração das condições materiais que reduz o horizonte existencial ao imediato, sintetizado em sua conclusão: "As pessoas estão só sobrevivendo, e não sonhando mais" (Brasil de fato, 2021a). O relato demonstra, assim, não apenas uma expansão quantitativa da pobreza, mas uma deterioração qualitativa das capacidades e aspirações individuais e familiares.

A implementação da necropolítica brasileira demonstrou possuir contornos claramente delineados com critérios estruturais de raça, classe e etnia, não foi por acaso, portanto, que a precarização histórica dos povos originários tenha sido agudamente intensificada durante a pandemia de COVID-19, sendo emblemático o primeiro óbito confirmado entre essa população: o do adolescente Alvanei Xirixana, de 15 anos, da etnia Yanomami, no estado de Roraima, em 10 de abril de 2020 (Agência Brasil, 2020c). Esse evento pode ser considerado um marco simbólico do agravamento das

condições de vida e da exposição a riscos sanitários que caracterizariam o período subsequente.

Conforme documentado no “Relatório de violência contra os povos Indígenas do Brasil – Dados de 2020” (Conselho indigenista missionário, 2021), a vulnerabilidade pandêmica destes povos é estrutural, enraizada em carências históricas. A insegurança alimentar, agravada pela falta de condições adequadas para produção sustentável de alimentos em seus territórios, somava-se à ausência crônica de saneamento básico e acesso à água potável – infraestruturas essenciais para medidas profiláticas contra o vírus.

Além dessas privações, a violência territorial constitui um fator de risco adicional. O mesmo relatório aponta que as invasões e a exploração ilegal de terras indígenas geram devastação ambiental, contaminação de rios e esbulho possessório, criando um contexto de conflito e desestabilização que fragiliza ainda mais as comunidades (Conselho indigenista missionário, 2021). Nesse quadro, a saúde indígena, que depende fundamentalmente de uma assistência estatal específica e adequada, mostrou-se profundamente comprometida, evidenciando a convergência de múltiplas formas de violência – física, sanitária e territorial – durante a crise.

Os povos indígenas no Brasil são os mais expostos, entre as pessoas que se encontram em maior vulnerabilidade. Se a pandemia persistir por muito mais tempo, sem intervenção adequada, e o contexto social permanecer inalterado, haverá um morticínio entre os povos indígenas (Conselho indigenista missionário, 2021, p.41-42).

A gravidade do impacto da pandemia de COVID-19 sobre os povos indígenas em 2020 – com mais de 900 óbitos e 43 mil contaminações confirmadas (Conselho indigenista missionário, 2021) – não pode ser dissociada da omissão estatal em implementar políticas específicas de proteção territorial e sanitária. Este desfecho trágico havia sido antecipado em alertas formais à comunidade internacional. Em 2019, uma coalizão de entidades protocolou uma denúncia contra Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional (TPI), visando à abertura de uma investigação sobre atos e omissões de seu governo que representassem uma ameaça à existência dos povos indígenas.

A letalidade da COVID-19 no Brasil não pode ser reduzida a uma fatalidade epidemiológica. Tratou-se de um fenômeno sociopolítico deliberado, no qual a mortalidade foi gerenciada de forma seletiva, recaindo com maior

gravidade sobre corpos já vulnerabilizados por históricas desigualdades de raça, classe e território. A gestão federal da crise sanitária, desde seus primórdios, foi pautada por um negacionismo ativo e uma subordinação da saúde pública a interesses econômicos.

Já em 9 de março de 2020, o então presidente Jair Bolsonaro minimizou publicamente a gravidade do vírus, afirmando que este era "superdimensionado" e que não havia motivos para pânico (Gazeta do povo, 2020a). Esse posicionamento inaugurou uma estratégia discursiva que relativizou o risco de morte em prol de uma suposta proteção à atividade econômica. Posteriormente, em 2021, Bolsonaro radicalizou essa lógica ao declarar, em entrevista, que o vírus teria "encurtado a vida [das vítimas] por alguns dias ou algumas semanas", atribuindo a causa *mortis* primordialmente às comorbidades pré-existentes (Amazonas atual, 2021).

Essa narrativa não refletia mero desconhecimento, mas uma estratégia política de naturalização da morte. Ao disseminar a ideia de que os óbitos eram inevitáveis para portadores de comorbidades, o governo federal buscava esvaziar sua própria responsabilidade e inocular na população uma aceitação passiva da mortalidade em massa. Tratava-se, nos termos de Achille Mbembe, da execução de uma necropolítica: um poder soberano que decide quem pode viver e quem deve morrer, transformando o "deixar morrer" em política de Estado.

Esse projeto necropolítico materializou-se em ações concretas de sabotagem às medidas de contenção. O governo federal politizou e antagonizou ferramentas científicas basilares, como o distanciamento social, o uso de máscaras e, posteriormente, as vacinas. A emissão de medidas provisórias e decretos frequentemente privilegiou uma agenda autoritária e ultraliberal, e não um plano coordenado de combate à pandemia. Um exemplo emblemático foi o veto a dispositivos legais que obrigavam o poder público a distribuir máscaras gratuitamente a populações vulneráveis e a aplicar sanções a quem descumprisse seu uso (CNN Brasil, 2020g).

Assim, a constante rejeição a barreiras não-farmacológicas e a lentidão deliberada na aquisição de imunizantes foram atos políticos de alta letalidade. A pandemia funcionou como uma "janela de oportunidade" para a implementação acelerada de uma agenda que conjugava ultraliberalismo econômico e autoritarismo social. A expressão "passar a boiada" sintetiza esse

aproveitamento do caos sanitário para desmontar proteções socioambientais. Dessa forma, o governo Bolsonaro não apenas falhou em responder à crise: ele ativou e inovou a tradição autoritária brasileira, utilizando o vírus como um instrumento para revelar e aprofundar sua natureza violenta e antidemocrática. O Coronavírus expôs, em última instância, um regime cujo projeto de poder era constituído por uma política de morte.

A gestão federal da pandemia de COVID-19 no Brasil configurou-se não apenas como uma política de Estado de negação da ciência e naturalização da morte, uma necropolítica em ação, mas também como uma máquina eficiente de anestesia do espanto. Na esteira do pensamento de Peter Pál Pelbart (2019), podemos interpretar a sucessão de atos discursivos e medidas concretas como um esforço deliberado para domesticar o horror, transformando a catástrofe sanitária em um fato banal e politicamente administrável. O projeto necropolítico, nesse sentido, dependia de aniquilar a capacidade coletiva de se assombrar com a morte em massa.

O processo teve seu marco discursivo inaugural em um duplo movimento, descrito por Pelbart como uma banalização da morte. Em 3 de setembro de 2020, a afirmação de que as máscaras “não protegem bulhufas” (Brasil de fato, 2020a) e, dois dias antes, a declaração de que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” (G1, 2020n), não eram apenas falsidades científicas. Eram gestos performáticos de dessacralização do cuidado, tentativas de corroer o senso comum e substituí-lo por um cinismo desmobilizador. Como o autor reflete, quando o espanto diante do perigo é suprimido, abre-se caminho para a passividade. O ápice dessa estratégia, em 24 de outubro de 2020, com a pejorativa “VaCHINA” ou mesmo “Vacina chinesa de João Dória” (Veja, 2021), revelava o objetivo último: politizar a vida e medicalizar a política. A politização da vida consiste na transformação do corpo biológico em um signo político, onde práticas de cuidado ou exposição ao risco se convertem em atos performáticos de adesão ou resistência ideológica. Já a medicalização da política refere-se à instrumentalização estratégica de um discurso pseudo-científico, como a defesa da hidroxicloroquina ou da imunidade de rebanho por infecção, para revestir escolhas governamentais de caráter ideológico e econômico com uma aura de autoridade técnica e inevitabilidade sanitária, funcionando assim como um dispositivo de disciplinamento social.

À medida que se fortalecia, no âmbito internacional, o entendimento das vacinas contra a COVID-19 como bens públicos globais essenciais à segurança sanitária coletiva, o governo brasileiro posicionou-se em radical oposição a este paradigma.

Cresce ao redor do globo a percepção de que as vacinas contra o coronavírus deverão ter tratamento legal específico, sobretudo no que se refere à patenteabilidade, produção industrial, fixação de preço, acessibilidade, entre outros aspectos fundamentais para garantir à população do mundo a necessária proteção. Nesse sentido, defende-se que tais vacinas sejam consideradas bens públicos globais, tal como os patrimônios da humanidade já reconhecidos ao redor do mundo. Em maio de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde, órgão deliberativo máximo da OMS em que estão representados 194 países, aprovou por unanimidade uma Resolução que considera a imunização em grande escala contra a Covid-19 um bem público mundial e afirma que todos os países devem ter acesso livre e rápido a vacinas seguras, de qualidade, eficazes e acessíveis (...) Infelizmente, até o presente momento, este debate sequer se iniciou no âmbito da política nacional de saúde do Brasil. (Direitos na pandemia, 2020).

Essa rejeição, contudo, não decorria apenas de uma postura negacionista superficial, mas de uma antítese ideológica fundamental: para a gestão federal, a adesão ao programa de imunização representaria uma submissão inaceitável à autoridade epistêmica da ciência e uma capitulação às políticas de cuidado, valores percebidos como contrários a um projeto político baseado no individualismo, na desregulamentação e na glorificação do risco.

O foco na reeleição, e não na saúde pública, exemplifica o que Pelbart identificaria como a subordinação do tempo da vida ao tempo político-eleitoral, um cronograma que não pode ser interrompido por algo tão trivial como uma pandemia.

Enquanto essa guerra retórica prosseguia, a catástrofe materializava-se. O colapso de Manaus em janeiro de 2021, previsível e denunciado (Brasil de fato, 2021b), tornou-se o primeiro grande emblema do assombro anestesiado. A omissão estatal diante da morte por asfixia não foi apenas uma falha logística; foi a demonstração prática de um poder que já não se assombra com o sofrimento alheio. Pelbart nos lembra que a capacidade de se espantar é um antídoto contra a barbárie. A gestão federal, ao tratar o colapso como um "fato consumado a ser gerido", buscou ativamente eliminar qualquer resquício de espanto ético, normalizando o inaceitável. O Relatório da CPI da Covid apenas documentou a burocracia dessa indiferença.

Em março de 2021, o mês mais letal da pandemia no Brasil com mais de 62 mil óbitos, coincidiu com o ápice da narrativa de normalização forçada. A defesa do fim das restrições (“chega de mimimi”) e a posterior caracterização como “idiotas” daqueles que se protegiam, em maio, eram peças de um mesmo mecanismo descrito por Pelbart: a produção de uma subjetividade insensível. Ao patologizar o cuidado e glorificar a “coragem” de se expor, o discurso governamental buscava fabricar uma população que visse na morte um risco natural do empreendedorismo de si, e não uma violência política. Era a tentativa de forjar um “corpo impávido” diante do vírus, alinhado à demanda por uma economia que não podia parar.

Esta lógica atingiu sua expressão mais perversa na defesa da imunidade de rebanho por infecção e da hidroxicloroquina. Estas não eram apenas pseudociências; eram tecnologias de dessensibilização em massa. Ao promover a ideia de uma exposição inevitável e um tratamento mágico, o governo direcionava a população trabalhadora para um experimento letal, anestesiando o terror desta condição com a promessa de uma solução simples. Na lógica necropolítica, que Pelbart ajudaria a decifrar, essa mão de obra tornava-se “vida matável”, cuja morte era o preço naturalizado da acumulação. A cloroquina funcionava, assim, como um “placebo político”, um fármaco para acalmar a consciência social enquanto a morte seguia seu curso seletivo.

A gestão pandêmica configurou-se como um projeto político através do negacionismo, da omissão e da promoção de curas milagrosas, o Estado buscou menos matar diretamente do que produzir uma sociedade incapaz de se horrorizar com suas próprias mortes. O vírus foi instrumentalizado como agente de uma política que visava, em última instância, anestesiando o espanto e consolidar um pacto social de insensibilidade. A pandemia escancarou como a soberania contemporânea se exerce não apenas pelo poder de deixar morrer, mas, como sugere Pelbart, pela capacidade de administrar o que assombra e o que deve ser recebido com indiferença. O maior triunfo dessa necropolítica teria sido se a sociedade, de fato, tivesse esquecido como se assombrar.

Em síntese, respondendo à pergunta basilar do pilar da Necropolítica, *como o governo administrou a morte, tornando-a uma consequência “natural” e aceitável da pandemia, e para quais grupos sociais essa morte foi direcionada?*

A administração governamental da morte durante a pandemia, e sua tentativa de naturalização como consequência inevitável, operou por meio de uma tecnologia dupla de reificação e dessensibilização, direcionada seletivamente a corpos já marcados historicamente pela vulnerabilidade. O processo iniciou-se com a burocratização do desaparecimento, materializada no chamado “manual de enterro” – um protocolo que, ao regular acondicionamento e sepultamento em massa, tratou os corpos não como sujeitos de luto, mas como resíduos logísticos a serem gerenciados. O que podemos chamar de banalização da morte: a conversão da morte singular em problema administrativo, esvaziando-a de sua dimensão ética e coletiva.

Sobre essa base burocrática, ergueu-se um aparato discursivo e político que intensificou deliberadamente a letalidade para populações negras, periféricas e indígenas. A desestruturação precoce do *lockdown*, a campanha contra as máscaras e o atraso estratégico na aquisição de vacinas não foram falhas. As falas de minimização da doença (“gripezinha”, “histeria”) funcionaram como o dispositivo de dessensibilização, banalizando o horror e preparando o terreno social para aceitar o inaceitável.

A pergunta “para quais grupos?” encontra sua resposta na geografia social da morte que se configurou: os mesmos corpos historicamente subjugados pelo colonialismo, pelo racismo estrutural e pela exploração de classe. A necropolítica de Mbembe – o poder soberano de ditar quem pode morrer – revelou-se aqui como a atualização de um projeto histórico de eliminação. A morte tornou-se “aceitável” precisamente porque recaiu sobre aqueles já concebidos, na lógica capitalista e necropolítica, como mão de obra descartável e vidas sem valor político pleno. A naturalização foi possível porque, como observa Pelbart, o espanto foi sistematicamente anestesiado por um discurso que equiparou a morte dos vulneráveis a um preço natural do funcionamento econômico.

Portanto, o governo administrou a morte tornando-a um evento administrativo, direcionando-a para os corpos cuja morte menos assombraria a consciência hegemônica. O projeto foi fazer da pandemia um ritual de sacrifício socialmente silencioso, onde a morte dos pobres, negros e indígenas aparecesse não como um crime político, mas como um dado estatístico inevitável – a materialização suprema de um poder que, nas palavras de

Foucault, não mais se dedica a fazer viver, mas a deixar morrer aqueles que já havia abandonado muito antes do vírus.

5.4. Análise do Pilar 3: A Pedagogia da Submissão na Pandemia

Dos pilares que constituem a necropedagogia, talvez o mais complexo seja precisamente esse referente à pedagogia da submissão, devido à multiplicidade de dimensões analíticas que comporta. Esse pilar busca examinar e responder a um questionamento ainda em processo de assimilação pela sociedade brasileira: como uma comunicação ancorada em produções flagrantemente falsas logrou gerar um processo de dessensibilização entre apoiadores do governo, a ponto de fabricar consentimento para a necropolítica.

Para analisar tal cenário, torna-se imperativo discutir, por um lado, as técnicas de comunicações e retóricas empregadas pelo governo e, por outro, o movimento bolsonarista, ambos sob uma dupla perspectiva: tanto à luz de características fascistas quanto através do conceito de uma pedagogia da morte (necropedagogia) que visa aniquilar o pensamento crítico e inculcar uma consciência autoritária.

Primeiramente, o bolsonarismo não é um fenômeno político episódico ou um populismo aleatório. Ele constitui um projeto orgânico da extrema-direita que sintetiza características atemporais do fascismo, técnicas retóricas contemporâneas, uma estratégia de guerra cultural convertida em terrorismo doméstico e uma pedagogia reacionária que instrumentaliza a desinformação para produzir uma consciência autoritária, nas palavras de Teixeira (2022, p.34) “(...) definimos nos seguintes termos o ‘bolsonarismo’: corrente política que se agrega em torno do Presidente Jair Bolsonaro, na defesa de valores reacionários que há muito presentes na sociedade brasileira de forma dispersa”. A confluência das análises de Umberto Eco (2018), Jason Stanley (2018), João Cezar de Castro Rocha (2023) e Paulo Freire (2023) oferece um quadro teórico para compreender esta engrenagem totalizante.

A análise encontra seu fundamento filosófico em Umberto Eco, que em seu ensaio identifica catorze características do "fascismo eterno" ou Ur-Fascismo, uma matriz flexível e adaptável que pode ressurgir sob novas roupagens. O bolsonarismo encarna diversas dessas características com precisão: o culto à tradição (exaltação de valores fundamentalistas e da

ditadura); a rejeição do modernismo e do pensamento crítico; a ação pela ação, desprezando a reflexão intelectual; o medo da diferença (ataques a minorias); o apelo às classes médias frustradas; a obsessão com conspirações (globalismo, marxismo cultural); e a seleção do inimigo como elemento unificador.

Sobre esta matriz ur-fascista, Stanley (2018) oferece a arquitetura retórica operacional. Em sua obra, o autor desmonta a máquina do fascismo em nove características, que o bolsonarismo adotou com fidelidade. O movimento empregou a propaganda não para informar, mas para mobilizar ódios através de *fake news* (“kit gay”, “mamadeira de piroca”), e promoveu um anti-intelectualismo radical, atacando universidades, a ciência (“gripezinha”) e a imprensa para questionar fontes rivais de autoridade (descrédibilização de autoridades). Essa ofensiva sustenta a descrença na realidade, onde fatos são “narrativas” da esquerda. A defesa de uma hierarquia natural justificou o ataque a políticas de igualdade; a retórica de lei e ordem normalizou a violência de Estado; onde o adversário é um inimigo a ser eliminado.

É precisamente sobre esta metamorfose da política em guerra que a análise de Rocha (2023) avança decisivamente. Para esse autor, o bolsonarismo operacionalizou a guerra cultural não como debate, mas como estratégia de poder e ruptura institucional. Esse processo, que materializa o “heroísmo” e o “machismo”, seguiu-se através da criminalização do adversário, da normalização da violência discursiva e, em seu ápice, da incitação ao terrorismo doméstico. O ataque de 8 de janeiro de 2023 foi a realização concreta desta lógica: a explosão programada de uma narrativa que pintava as instituições como inimigas ocupadas – a culminação do processo de transferência do poder soberano para as milícias digitais e físicas, onde o povo “escolhido” age contra seus supostos opressores.

Entretanto, para que essa matriz ur-fascista e sua retórica operacional encontrassem terreno fértil, foi necessário um processo pedagógico de demolição do pensamento crítico. É aqui que Paulo Freire se torna indispensável. Freire, ao descrever a “consciência ingênua”, fornece a chave para entender a eficácia das *fake news* no projeto bolsonarista. A consciência ingênua aceita acriticamente o mundo como dado, absorvendo o senso comum dominante. O sistema de desinformação bolsonarista foi uma educação bancária que depositava diariamente conteúdos falsos e discursos de ódio, impedindo a

reflexão crítica e produzindo uma consciência ingênua ampliada, condição perfeita para o florescimento do pensamento mágico.

O passo seguinte é ainda mais sombrio. Freire alertava que a consciência ingênua, quando manipulada, pode regredir para uma consciência autoritária, que abdica da autonomia do pensamento e entrega-se a um líder salvador. O bolsonarismo foi um mestre nessa conversão. Ao oferecer respostas simples e um pai forte que promete ordem através da violência, ele canalizou a fragilidade da consciência ingênua – confusa pela desinformação – para a rigidez da consciência autoritária. O resultado foi a transformação do cidadão desorientado em militante digital e, finalmente, em invasor dos palácios de poder.

Assim, o bolsonarismo revela-se um projeto político complexo: ur-fascista em sua matriz filosófica, operacional em sua retórica, terrorista em sua estratégia e autoritário em sua pedagogia. Ele assenta-se na potencialização digital das características eternas do fascismo, usando as ferramentas da pós-verdade para anestesiar o espírito crítico e, em seguida, mobilizar essa anestesia para recrutar soldados para uma guerra de destruição institucional. Entendê-lo exige enxergar sua natureza sincretista e adaptativa: um fenômeno que bebe nas fontes clássicas da dominação fascista, mas que inova ao utilizar a desinformação como ferramenta pedagógica de massas.

A complexidade desse debate está intimamente ligada a questão da estrutura estatal ultraliberal, orientada a realocar os aparatos do Estado em função dos interesses da burguesia, promovendo a fragilização sistemática das políticas sociais e a implementação de reformas administrativas que corroem a natureza pública da máquina estatal, metamorfoseando-a em um simulacro de empresa privada. Esse projeto opera através da flexibilização de responsabilidades públicas e do desmonte progressivo de obrigações sociais pactuadas na Constituição Federal de 1988. Articulado a esse pilar, um mecanismo necropolítico atua voltando-se para a produção programada da morte de parcelas específicas da população, instrumentalizadas e forçadas a servir a objetivos políticos nefastos de aquecimento econômico, em um processo marcado pela ausência radical de cuidado e pela dessensibilização social.

Contudo, a análise conjunta do Ultraliberalismo e da Necropolítica revela-se insuficiente para abarcar a dimensão subjetiva e cultural necessária à efetivação desse projeto. Assim sendo, foi necessário um terceiro eixo analítico

que explicasse os processos de inculcação e normalização pelos quais o absurdo, o desmonte do público e a naturalização da morte, é transmutado em uma condição minimamente aceitável, senão invisível, para o senso comum. É preciso indagar, portanto, a engenharia do consentimento e a fabricação da indiferença que sustentam materialmente esses dois pilares estruturais.

A adesão popular a uma gestão pandêmica explicitamente necropolítica, que promoveu a morte como política de Estado, não pode ser explicada apenas pela irracionalidade ou pela ignorância. Ela exige uma análise dos dispositivos de subjetivação que produziram uma cultura da submissão e da aceitação do intolerável. A confluência teórica entre Paulo Freire (2002), Michel Foucault (2019), Wendy Brown (2019) e Rubens Casara (2024) oferece um quadro analítico que ajuda a desvendar esse processo, revelando como o projeto político de Jair Bolsonaro operou uma pedagogia da anestesia ética e da naturalização da morte.

O ponto de partida é o diagnóstico de Rubens Casara sobre a formação do "sujeito neoliberal" que é descrito como um "idiota" no sentido etimológico grego (*idiotes*): aquele voltado apenas para seus interesses privados, indiferente à vida pública e à dor do outro. A adesão às políticas negacionistas ("vá pra rua", "não use máscara") e às falsas curas ("cloroquina funciona") só foi possível porque previamente se inculcou nesse sujeito uma indiferença ativa. A morte do outro, especialmente do outro vulnerável, deixou de ser um escândalo ético para tornar-se um ruído estatístico ou um preço necessário para a "sobrevivência do mercado". As campanhas de desinformação, as *fake news* e a desqualificação das instituições científicas não foram acidentes, mas ferramentas pedagógicas dessa inculcação: ensinaram a desconfiar da ciência e a confiar apenas no líder carismático, que falava a suposta "língua do povo" contra a "elite intelectual".

Essa pedagogia da submissão, no entanto, não atuou num vácuo. Ela se implantou sobre o solo fértil da *racionalidade neoliberal* descrita por Wendy Brown. A autora (2019) demonstra como o ultraliberalismo não é um mero modelo econômico, mas uma "ordem da razão" que dissolve o sujeito político para forjar o capital humano. Nessa lógica, toda a vida é reduzida a um cálculo de custo-benefício, risco e investimento. A pandemia, sob este prisma, não era uma crise de saúde coletiva, mas um desafio de gestão de risco individual. As

falas como "não deixe o mercado morrer" e o ataque ao *lockdown* revelavam a primazia absoluta da racionalidade de mercado sobre a vida. Defender a cloroquina e atacar as vacinas como comunistas era, portanto, defender a liberdade do mercado (mesmo que mortífera) contra uma suposta tirania sanitária coletivista. O inimigo interno (os comunistas) personificava tudo que ameaçava essa lógica de empreendedorismo de si, mesmo diante da morte.

É aqui que a análise de Michel Foucault sobre a governamentalidade e os dispositivos de poder se torna importante. O governo Bolsonaro não exerceu um poder puramente repressivo, mas um poder produtivo de subjetividades. Através de uma enxurrada diária de lives, discursos e performances, ele orquestrou um dispositivo discursivo que fabricava uma verdade paralela. Esse dispositivo operava através de emocionalismos, ataques "contra a pessoa" e da criação de um "nós" contra "eles". Ataques sistemáticos à imprensa e à ciência não buscavam apenas deslegitimá-las, mas produzir uma nova epistemologia popular, onde o critério de verdade não era a evidência, mas a afinidade identitária e a lealdade ao líder. A "verdade" passou a ser o que fortalecia o grupo e demonizava o inimigo.

Paulo Freire oferece a chave para entender por que essa pedagogia da morte (necropedagogia) pôde ser eficaz. Freire, conforme estudos de Guareschi (2024), descreve como a "educação bancária" – que deposita informações passivas no educando – é um instrumento de dominação que gera uma "consciência ingênua" ou "semi-intransitiva". Esta consciência, imersa no senso comum dominante, é incapaz de uma leitura crítica da realidade e tende a naturalizar a opressão. O projeto bolsonarista foi uma educação bancária em escala industrial, que depositou diariamente, via redes sociais e mídias aliadas, uma narrativa coesa que invertia valores: a ciência virou arrogância, o cuidado virou covardia, a morte virou liberdade. A população, bombardeada por essa pedagogia e privada de instrumentos críticos (muitos deles deliberadamente destruídos pelo próprio projeto ultraliberal), foi conduzida a uma "consciência ingênua da necropedagogia", que aceitava o absurdo letal como verdade.

Portanto, a adesão às necropolíticas na pandemia resulta da interseção perversa destas forças: a produção do sujeito indiferente, fundado na racionalidade do capital humano, disciplinado por dispositivos de poder que fabricam verdades e submetido a uma pedagogia da anestesia ética que impede

a leitura crítica do mundo. O idiota ultraliberal não nasceu pronto; foi metodicamente fabricado para que, diante da catástrofe, sua resposta não fosse a revolta, mas a aceitação, ou pior, o aplauso à própria marcha funerária.

O eixo da Pedagogia da Submissão orienta-se, portanto, pela seguinte questão-problema: *Como o governo e seus apoiadores usaram a comunicação para dessensibilizar a população, promover o anti-intelectualismo e fabricar o consentimento para a necropolítica?*

5.4.1 Análise dos fatos ocorridos durante a Pandemia sob o viés da Pedagogia da submissão

Durante a pandemia, tornou-se flagrante o esforço estatal em manipular informações acerca da realidade da doença e promover o uso de medicamentos sem comprovação científica, tudo em nome da preservação do capital e da atividade econômica. Uma parcela significativa da base de apoio ao governo imergiu na narrativa de que o presidente sofria retaliações de "esquerdistas", ecoando e amplificando a tese bolsonarista de que a COVID-19 se tratava de uma "gripezinha". Essa percepção foi sintetizada na declaração do ex-presidente em março de 2020:

No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão (UOL, 2020f).

Ademais, em junho de 2020, o então chefe do Executivo incitou abertamente a população a invadir unidades de saúde, numa tentativa de desacreditar publicamente a gravidade da crise sanitária, conforme registrado na fala:

Seria bom você fazer na ponta da linha. Tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda (G1, 2020o).

Tal postura evidenciou uma profunda ausência de empatia e solidariedade, além de um desprezo pela vida da população, configurando uma atitude de expor a constrangimento, tanto pacientes internados, quanto seus familiares, colocando em risco a segurança dos trabalhadores da saúde e a integridade das próprias instituições hospitalares.

O governo empreendeu um ataque sistemático ao uso de máscaras, medida de proteção respaldada por amplo consenso científico internacional. O então Presidente Jair Bolsonaro, frequentemente presente em aglomerações sem a devida proteção facial, atuou ativamente para menosprezar e desencorajar sua adoção.

O presidente Jair Bolsonaro, porém, vetou a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, instituições de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Ao justificar os vetos, o Planalto alega, entre outras razões, que a obrigatoriedade 'incorre em possível violação de domicílio (Agência Senado, 2020).

Tal prática reforçava, concretamente, não apenas um individualismo exacerbado, transferindo para o cidadão isolado a responsabilidade que deveria ser coletiva e coordenada pelo Estado, como também consolidava a narrativa de que o uso de máscaras representaria uma oposição ao governo. A máscara transformou-se, assim, em emblema ideológico, anulando a autonomia individual frente ao conhecimento científico estabelecido. Ao se opor ao consenso científico de enfrentamento da pandemia, Bolsonaro declarou publicamente:

Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? (G1, 2020p).

Esse discurso não apenas minimizava a gravidade da crise sanitária, como também construía uma falsa dicotomia entre coragem e cuidado, associando a adoção de protocolos de proteção a uma suposta fraqueza de caráter. Como analisa Stanley (2018), a política fascista possui a capacidade de substituir a verdade pela destruição sistemática da informação e pela ruptura do consenso sobre a realidade:

A política fascista troca a realidade pelos pronunciamentos de um único indivíduo, ou talvez de um partido político. Mentiras óbvias e repetidas fazem parte do processo pelo qual a política fascista destrói o espaço da informação. Um líder fascista pode substituir a verdade pelo poder, chegando a mentir de forma inconsequente. Ao substituir o mundo por uma pessoa, a política fascista nos torna incapazes de avaliar argumentos com base num padrão comum. O político fascista possui técnicas específicas para destruir os espaços de informação e quebrar a realidade (Stanley, 2018, p.66-67).

Como já foi anteriormente introduzido, a corrente bolsonarista logrou congregar forças reacionárias que até então encontravam-se dispersas no tecido sociopolítico brasileiro (Teixeira, 2022). A esse cenário agrega-se a

análise desenvolvida por Rocha (2023), a qual sustenta que, não obstante sua inserção em um movimento transnacional de ascensão da extrema-direita, o bolsonarismo apresenta aspectos idiossincráticos e exclusivamente nacionais. Essas particularidades manifestam-se de forma mais explícita em sua estratégia de guerra cultural, que mobiliza símbolos, narrativas e clivagens profundamente arraigadas na história e na formação social do Brasil.

(...) E estes são ameaçadores, pois dependem de uma posição revisionista, que nega os crimes da ditadura civil-militar e, ainda mais, busca, num cenário de democracia, atualizar a draconiana Doutrina de Segurança nacional, cujo objeto (...) é a eliminação do inimigo interno. Em palavras direitas; a guerra cultural bolsonarista é a ponta da lança de um projeto autoritário de matriz plúmbeo. Se não a compreendermos em seus próprios termos, a democracia será a primeira vítima. Em seguida, todos nós que nos opomos à violência bolsonarista e à destruição das instituições. O instrumento da guerra cultural bolsonarista é a retórica do ódio (Rocha, 2023, p. 133).

A retórica do ódio constitui um dispositivo discursivo cuja finalidade primordial reside na eliminação simbólica de todo interlocutor que não reproduza os dogmas do grupo. Esse mecanismo opera a partir de dois eixos estruturais complementares: a desqualificação nulificadora do outro, que busca anular a alteridade através da desumanização ou da deslegitimação radical, e a hipérbole descaracterizadora dos próprios atributos, que engendra uma autoimagem grandiosa e maniqueísta, distorcida por superlativos ideológicos. Desse modo, consolida-se uma dinâmica comunicativa fechada, na qual a adesão acrítica funciona como critério de pertencimento e a dissidência é tratada como heresia a ser extirpada do campo do discurso legítimo.

Desqualificação nulificadora: o outro é tornado paradoxalmente invisível pelo uso pouco criativo de palavrões – após presentear alguém com um colar de palavrões, por que levar essa pessoa a sério? Além disso quem pensa de forma diversa é ridicularizado por meio de jogos infantis com seu nome. Isso para não mencionar a tediosa obsessão com referências sexuais monomaniacas. *Hipérbole descaracterizadora:* a retórica do ódio abole o sentido mais elementar de proporção, impedindo a apreciação crítica das palavras do líder ou do guru, e, desse modo, estimula uma adoração de nítido caráter paranoico. Afinal, a adesão cega às narrativas delirantes de intrincadas teorias conspiratórias leva inevitavelmente à negação de dados objetivos e, em última instância, da realidade mesma. (...) Para tudo dizer: o bolsonarismo é o primeiro movimento de massas da política brasileira cujo eixo é uma incitação permanente ao ódio como forma de ação. O resultado não pode ser outro: colapso da gestão pública e esgarçamento máximo do tecido social (Rocha, 2023, p. 134-135).

Como se observa, a retórica do ódio característica do bolsonarismo encontrou sua expressão mais concreta durante a pandemia por meio da

sistemática desqualificação da gravidade da doença – seja através de termos minimizadores como “gripezinha” ou “resfriadinho”, seja pela estigmatização pejorativa daqueles que aderiram aos protocolos sanitários, tachados de “maricas”. Em meio ao colapso da gestão pública, o governo promoveu o desprezo pelos dados objetivos produzidos pelo próprio Ministério da Saúde, transformando indicadores epidemiológicos em campo de batalha ideológica – processo emblematicamente materializado na sucessão de trocas ministeriais na pasta, que fragilizaram a autoridade técnica em favor do alinhamento político.

Essa guerra ideológica, por sua vez, atuou como um potente mecanismo de polarização e esgarçamento do tecido social, criando um ambiente propício à irracionalidade, ao fundamentalismo religioso e ao anticientificismo. Nesse contexto, reafirma-se a tese de que tal modalidade política, ancorada na subjetivação do capital, necessita fabricar sua própria realidade, operação realizada em larga escala por meio das *fake news*. Trata-se de um processo de idiossubjetivação – a formação de uma subjetividade fechada, autorreferente e imune à contradição factual – que possui efeitos profundamente educativos, na medida em que ensina a desconfiar de qualquer fonte informativa que não reforce suas crenças identitárias.

A fusão entre o sujeito ultraliberal, aquele reduzido à racionalidade do empreendedor de si mesmo, e um nível de consciência autoritária constituiu o produto final dessa engrenagem discursiva. Foi essa síntese que culminou na retórica do ódio orquestrada pelo governo Bolsonaro, a qual, por sua vez, funcionou como alicerce para a instauração de uma pedagogia da morte, ou necropedagogia.

O movimento bolsonarista representou a reatualização de um espírito autoritário de matiz fascista, o qual operou como um amplo e sistemático projeto pedagógico voltado à formação de uma consciência autoritária. Muito além da mera ineficiência administrativa, atos performáticos, discursos públicos e estratégias simbólicas foram mobilizados para desconstruir a autoridade da ciência, ridicularizar as instituições democráticas e ensinar uma nova ética pública, baseada na lealdade pessoal ao líder e na negação da morte como um fato político relevante.

Em 15 de março de 2020, em ato público, o presidente Bolsonaro minimizou a emergência sanitária global representada pelo novo coronavírus e

participou ativamente de uma manifestação política contrária ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta-feira (12), ele próprio havia recomendado que os atos não ocorressem em razão do alastramento mundial da Covid-19. Desde a manhã, no entanto, ele estimula seus apoiadores para as manifestações por meio das redes sociais. Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada por volta do meio-dia e percorreu, de carro, a Esplanada dos Ministérios. Apoiadores o seguiram em carreata. Ele transitou com vidros fechados e não desceu em nenhum momento. Pouco depois, o presidente foi ao Palácio do Planalto. Ele desceu a rampa e caminhou até cerca de 100 manifestantes para cumprimentá-los e tirar selfies – manuseando celulares de alguns deles sem se importar com os riscos de contaminação. Muitos dos presentes usavam máscaras pintadas de verde e amarelo (Brasil de fato, 2020b)⁸.

Em 31 de maio de 2020, o presidente Jair Bolsonaro prosseguiu em sua estratégia de mobilização pública, participando e promovendo manifestações que continham como objetivos declarados a dissolução do Congresso Nacional e do STF. Tais atos configuraram um claro incentivo à ruptura da ordem democrática, inclusive através da defesa de uma intervenção militar como meio para atingir tais fins.

Sem o uso de máscara, Bolsonaro foi para a frente do Palácio do Planalto e, a pé, percorreu o cercado onde se aglomeravam os manifestantes, contrariando o decreto do governo do Distrito Federal. Em outro momento do ato, Bolsonaro montou em um cavalo da patrulha militar e cavalgou entre os manifestantes, acenando (G1, 2020q)⁹.

⁸ BRASIL DE FATO. **Bolsonaro ignora coronavírus e participa de manifestação contra Congresso e STF.** Brasil de fato: 15 de março de 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/03/15/bolsonaro-ignora-coronavirus-e-participa-de-manifestacao-contr-congresso-e-stf/>. Acesso em: 02 de janeiro de 2026.

⁹ G1. **Ato pró-Bolsonaro em Brasília reúne manifestantes em defesa de medidas inconstitucionais.** G1: 31 de maio de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/31/manifestantes-fazem-ato-em-brasilia-em-apoio-a-bolsonaro-e-em-defesa-de-medidas-inconstitucionais.ghtml>. Acesso em: 02 de janeiro de 2026.

Figura 25 - Ato pró-bolsonaro, sem o uso de máscaras, promoveu discurso anticonstitucional em 31 de maio de 2020



Fonte: G1, 2020q.

Um estudo interinstitucional das universidades da Carolina do Norte (EUA) e Bocconi (Itália), publicado em 1º de maio de 2020, identificou uma correlação empírica significativa entre o apoio eleitoral ao então presidente Bolsonaro e a dinâmica de contágio da COVID-19 nos municípios brasileiros no início da pandemia. A pesquisa analisou dados de 255 municípios com ao menos um caso confirmado entre 8 e 26 de março de 2020, cruzando taxas de contágio com o percentual de votos recebidos por Bolsonaro no primeiro e segundo turnos das eleições de 2018.

Os resultados apontam que, após o dia 15 de março, data em que o presidente subestimou publicamente a gravidade da crise sanitária e interagiu com apoiadores em aglomeração frente ao Palácio do Planalto, os municípios com maior concentração de eleitores bolsonaristas registraram um aumento 18,9% superior na taxa de contágio em comparação com aqueles de menor apoio ao presidente. A análise controlou variáveis como PIB *per capita* e capacidade municipal de testagem, indicando que o efeito observado independe do viés de detecção de casos.

Dentre as capitais brasileiras onde o presidente teve mais votos em 2018 analisadas pelo artigo, estão Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Teresina, Vitória, Boa Vista, Campo Grande, Porto Velho, Rio Branco. (O Globo, 2020b)

O estudo sugere dois mecanismos inter-relacionados para explicar o fenômeno: (a) Efeito comportamental discursivo: a fala presidencial de 15 de

março, que minimizou a pandemia, funcionou como um sinal para que seus apoiadores relaxassem as medidas de distanciamento social, independentemente da ocorrência de aglomerações físicas. Em municípios de maioria bolsonarista sem protestos, o contágio também acelerou, indicando a influência direta da narrativa negacionista sobre as práticas preventivas da população. (b) Efeito de aglomeração política: nas localidades que sediaram manifestações de apoio na mesma data, o aumento do contágio foi ainda mais pronunciado, atingindo 43,3% em comparação com cidades sem maioria bolsonarista e sem atos. No entanto, o estudo demonstra que o fator aglomeração, por si só, não esgota a explicação, uma vez que o aumento foi significativamente maior onde houve convergência entre alta densidade eleitoral bolsonarista e a realização de protestos.

A pesquisa evidenciou um ponto de inflexão temporal claro: até 18 de março, as curvas de contágio entre os dois grupos de municípios eram similares. A divergência manifesta-se precisamente após o período de incubação médio do vírus (três dias), coincidindo com a internalização do comportamento presidencial por parte de seus eleitores. O trabalho concluiu que a exposição e adesão ao discurso e às atitudes negacionistas do presidente tiveram um impacto mensurável e deletério na velocidade de propagação viral, constituindo um caso empírico de como a polarização política e a liderança executiva podem influenciar diretamente os desfechos de saúde pública em uma emergência sanitária.

A pedagogia se materializou através do exemplo corporal do líder. A recusa sistemática de Bolsonaro em usar máscaras, sua participação em dezenas de aglomerações públicas e o emblemático passeio a cavalo em frente ao Supremo Tribunal Federal foram atos carregados de significado didático. Eles não constituíam simples desvios de protocolo, mas lições visíveis de desobediência civil institucionalizada. O corpo desprotegido do presidente em meio à multidão transmitia a mensagem da “imunidade do forte” e estabelecia seu próprio físico como norma antagônica ao corpo coletivo e precavido. O passeio a cavalo, por sua vez, foi uma encenação calculada de desdém, ensinando que as instituições republicanas, como o STF, guardião constitucional do direito à vida, eram alvos legítimos de escárnio. A frequência das aglomerações transformava a quebra do isolamento em um ritual de

pertencimento e fé, onde a presença física era um ato de confiança no líder e de rejeição ao “medo” supostamente propagado pela ciência. Esta didática da negação era complementada por enunciados como a afirmação de que a COVID-19 “apenas encurtava a vida por alguns dias” (Amazonas atual, 2021), uma lição explícita de dessensibilização que ensinava a banalizar a perda da vida, reduzindo-a a um detalhe estatístico insignificante.

A campanha contra a vacinação executou um deslocamento semântico profundo no movimento pedagógico, convertendo um instrumento de saúde pública em um símbolo ideológico. Narrativas que associaram as vacinas a um “chip chinês”, à “vacina do Dória” ou a uma conspiração da “esquerda” que desejava a morte do presidente cumpriam a função de demonização do outro.

O processo da necropedagogia, ao negar a condição humana “Do Outro” (Arroyo, 2023), especificamente daquele não alinhado aos propósitos da ideologia bolsonarista, fornece a chave explicativa para a normalização da aniquilação de vidas durante a pandemia. A constante inferiorização e negação da alteridade constituem o alicerce de uma lógica simultaneamente genocida e paranoica, manifesta, por exemplo, na crença em narrativas conspiratórias como a de que microchips seriam implantados por meio das vacinas para controle populacional. Essa fascistização do olhar, que identifica na diferença um elemento a ser eliminado – mesmo ao custo da desestabilização do regime democrático ou do incitamento a conflitos –, explicita o grau de alienação, de consciência autoritária e de supressão do pensamento crítico que não apenas marcou a resposta à crise sanitária, mas que se estende como herança perversa para além do período pandêmico.

Esta lógica conspiratória funcionava como um currículo paralelo, ensinando a população a interpretar o mundo através da lente da traição e da guerra permanente. A decisão de se vacinar ou não deixava, assim, de ser um ato sanitário para se tornar um teste decisivo de lealdade política. A associação entre a vacina e um desejo de morte do líder elevou a imunização à condição de potencial ato de lesa-pátria, gerando um pânico identitário que se sobrepôs ao medo racional da doença. A lição era clara: proteger a própria saúde poderia significar trair a comunidade política imaginada em torno de Bolsonaro.

O ápice deste projeto pedagógico foi a inversão radical dos valores democráticos. Ao defender o fim de todas as restrições e, de forma ainda

mais grave, ao qualificar como "idiotas" os cidadãos que seguiam as recomendações de isolamento, Bolsonaro realizou a operação final da Pedagogia da Submissão: a estigmatização do cuidado. A virtude basilar da saúde pública e da ética democrática – o cuidado com o outro e consigo mesmo – foi publicamente ridicularizada e equiparada à estupidez. Em contrapartida, exaltou-se o sujeito que despreza regras, que coloca uma noção distorcida de "liberdade" individual acima do bem coletivo e que demonstra obediência incondicional ao líder. Dessa forma, forjou-se a consciência autoritária: uma subjetividade que encontra honra na submissão ao líder e no desprezo pela solidariedade e pelas instituições.

A sucessão coordenada desses fatos – das performances de negação às campanhas de demonização da vacina e à inversão moral que vilificou o cuidado – expõe uma coerência didática perversa. Tratou-se de um currículo aplicado para a fabricação do sujeito necropolítico. A Pedagogia da Submissão foi o mecanismo pelo qual se buscou inculcar, em escala nacional, uma consciência autoritária disposta a consentir com a gestão estatal da morte. O estágio terminal desse processo é a necropedagogia: o momento histórico em que uma sociedade, através das lições repetidas de seu governo, aprende a naturalizar a morte evitável, a enxergar o conhecimento científico como inimigo e a encontrar identidade e propósito na lealdade a um projeto político que elege a morte como seu princípio organizador invisível. A pandemia, sob a égide do bolsonarismo, foi a sala de aula ampliada onde essa lição final e trágica foi metodicamente lecionada.

A pergunta central deste pilar – Como o governo e seus apoiadores usaram a comunicação para dessensibilizar a população, promover o anti-intelectualismo e fabricar consentimento para a necropolítica? – não admite uma resposta simplista. Sua complexidade exige uma análise multifacetada que, embora já delineada neste estudo, certamente demanda investigações ulteriores. No âmbito desta pesquisa, é plausível afirmar que a comunicação foi o fator aglutinador e operacionalizador dos três pilares, constituindo a espinha dorsal da necropedagogia.

A estratégia comunicacional bolsonarista estruturou-se como um aparelho pedagógico de massa, voltado à inculcação de uma visão de mundo autoritária e anti-crítica. Seu alvo privilegiado foi um sujeito historicamente fragilizado pela

precarização material e simbólica – o que Rubens Casara define como “sujeito idiota”. Trata-se do indivíduo que, alienado de sua capacidade de agência política e desprovido de ferramentas hermenêuticas para decifrar a complexidade do mundo, torna-se particularmente vulnerável a narrativas maniqueístas. Para esse sujeito, a realidade complexa é substituída por uma simplificação dogmática, oferecida como bússola em meio ao caos. A comunicação oficial e suas redes de apoio forneceram justamente essa “muleta mental”: um conjunto de explicações prontas, inimigos claros e uma liderança messiânica, poupando o indivíduo do árduo labor do pensamento autônomo. A submissão, nesse contexto, não é apenas imposta, mas aprendida como solução para a angústia da indeterminação.

O movimento bolsonarista, assim, reconfigurou o espaço social através de mecanismos atualizados do fascismo, centrados na fabricação de um sentimento de ódio e de guerra cultural permanente. Nessa nova configuração, a verdade deixa de ser um constructo coletivo, contestável e fundado em evidências, para se tornar uma revelação monolítica emanada de uma figura autoritária. Esse líder-messias, personificado em Jair Bolsonaro, apresenta-se como o único intérprete legítimo da realidade, canalizando frustrações sociais para um inimigo interno plural – a esquerda, a mídia, a ciência, o STF, as “elites globais”. A aniquilação simbólica – e, em casos extremos, física – desse “outro” transforma-se na resposta simplista para problemas estruturais complexos. O bolsonarismo opera, portanto, numa lógica da simplificação tacanha, que reduz a política a uma guerra tribal, onde a nuance é traição e a dúvida, fraqueza.

Nesse quadro, a ciência foi sistematicamente desacreditada não por falha metodológica, mas por incompatibilidade política. Ela representava um obstáculo epistemológico ao projeto de poder, pois seus protocolos de validação (revisão por pares, falseabilidade, debate público) contradiziam a lógica do monopólio exclusivo da verdade autoritário, onde a verdade é decretada pelo líder. A campanha contra vacinas, o negacionismo epidemiológico e o descrédito das instituições de pesquisa foram, portanto, ações estratégicas de guerra epistemológica.

5.5 – Os três pilares como fundamento da necropedagogia

A análise empreendida demonstra como os três pilares conceituais – o Estado ultraliberal, a Necropolítica e a Pedagogia da Submissão – materializaram-se de forma concreta e sinérgica na gestão brasileira da pandemia de COVID-19. O Pilar 1, o Estado ultraliberal, manifestou-se na primazia absoluta da economia sobre a vida, na transferência da responsabilidade sanitária para o indivíduo (sujeito idiota) e no desmonte ativo das estruturas públicas de proteção, como o SUS. O Pilar 2, a Necropolítica de Mbembe, operacionalizou-se na gestão calculada da morte, na seleção implícita de populações descartáveis (idosos, pobres, indígenas) e na naturalização das mortes em massa como um preço aceitável. Por fim, o Pilar 3, a Pedagogia da Submissão, efetivou-se através de um currículo permanente de negacionismo científico, da estigmatização do cuidado e da transformação da adesão a narrativas falsas em prova de lealdade política, dessensibilizando a sociedade e aniquilando o pensamento crítico.

A força explicativa deste modelo reside precisamente na interligação orgânica desses pilares. A Pedagogia da Submissão não atuou isoladamente; ela foi o mecanismo cultural fundamental para criar o terreno fértil de aceitação e consentimento necessário à implementação da Necropolítica. Ao ensinar a desconfiar da ciência, a ridicularizar a solidariedade e a normalizar a morte, ela preparou a subjetividade coletiva para a política de morte. Esta, por sua vez, não seria viável sem a estrutura propiciada pelo Estado ultraliberal, que forneceu a racionalidade (a vida como custo), os instrumentos (o estado mínimo na saúde, a priorização do mercado) e a justificativa (a defesa da liberdade econômica) para a gestão letal. Em outras palavras, a Necropolítica foi a política, o Estado ultraliberal foi a estrutura e a Pedagogia da Submissão foi o método de sua implementação e legitimação social.

Conclui-se, portanto, que o conceito de necropedagogia – entendido como a fusão desse tripé – não constitui uma abstração teórica, mas um instrumento analítico e operacional. Ele permite desvendar a lógica coerente, ainda que brutal, que orientou a resposta federal à pandemia, expondo-a não como um fracasso caótico, mas como um projeto político intencional e estruturado.

Esse projeto foi profundamente antidemocrático, ao corroer as instituições, a esfera pública e o debate baseado em fatos; e foi radicalmente antivida, ao eleger a gestão da morte como princípio organizador em um contexto de crise sanitária. A necropedagogia revela, assim, a dimensão pedagógica do horror: um esforço sistemático, durante uma das maiores emergências de saúde da história recente, não para salvar vidas, mas para ensinar uma população a consentir com a própria aniquilação.

6. Considerações finais

A pandemia de COVID-19 estabeleceu um marco trágico na história contemporânea do Brasil, caracterizada por um cenário sanitário catastrófico que resultou na perda de mais de 700 mil vidas. Neste contexto, a resposta do governo federal destacou-se não por medidas de contenção ou expressão de solidariedade, mas por uma atuação política que, através de ações e omissões, configurou um agravamento deliberado da crise humanitária. Este paradoxo levanta uma questão analítica fundamental sobre os mecanismos sociopolíticos que possibilitaram a naturalização da morte em massa como um suposto custo inevitável para a preservação da atividade econômica.

Para decifrar essa dinâmica perversa, o presente trabalho propôs o conceito analítico de necropedagogia. Este constructo teórico buscou investigar a condução federal das políticas de saúde pública durante a emergência sanitária, argumentando que tal gestão transcendeu a dimensão administrativa para se constituir como um processo pedagógico ativo. Tratou-se de um empreendimento sistemático voltado à produção de consentimento e à assimilação passiva da tragédia por segmentos expressivos da população brasileira. A necropedagogia, portanto, opera como uma lente para compreender como a gestão da morte foi ensinada, aprendida e interiorizada. Neste sentido, dialoga criticamente com a obra de Paulo Freire, para quem toda prática política é, em sua essência, uma prática educativa — seja para a domesticação, seja para a libertação. A pandemia expôs uma pedagogia da morte que se opõe diametralmente à pedagogia do oprimido.

A fundamentação deste conceito apoia-se na articulação de três pilares teóricos interligados. O primeiro refere-se à configuração do Estado ultraliberal, que organiza a sociedade a partir de princípios de exclusão sistêmica, escassez artificial e uma ontologia que reduz o indivíduo à condição de "empresa de si mesmo". Este modelo promove o que se pode chamar, em chave freireana, de uma educação bancária em escala societal: um processo de descriticização do sujeito, forjando uma idiossujetivação, incapaz de vislumbrar alternativas ao *status quo*. Tal processo ancorou práticas discursivas em territórios férteis para o racismo, o preconceito e tendências fascistizantes, frequentemente operacionalizados por meio de estratégias de pós-verdade e manipulação informacional.

O segundo pilar reside no conceito de necropolítica, inscrito na própria lógica do Estado ultraliberal. Esta noção descreve como o poder estatal não apenas permite, mas ativamente administra e decide sobre a vida e a morte de populações específicas. Durante a pandemia, a necropolítica materializou-se na violência direta e indireta contra corpos marginalizados, reafirmando estruturas históricas de racismo e autoritarismo profundamente arraigadas na formação social brasileira. A análise revela como o Estado, em contextos pós-coloniais marcados por um passado escravocrata e por políticas de apagamento da memória, pode instrumentalizar a morte como ferramenta de governo, destruindo não apenas vidas, mas também as narrativas e histórias de resistência.

Completa essa tríade a noção de pedagogia da submissão, que evidencia a dimensão propriamente educativa e cultural do projeto político em análise. Este pilar examina os mecanismos através dos quais se forjou, no imaginário coletivo, uma adesão a valores e comportamentos que legitimaram a negligência estatal. A pedagogia da submissão atuou na modelagem de um senso comum antagônico à solidariedade e à defesa da vida coletiva. Diante dela, impõe-se a defesa urgente de uma educação crítica e emancipatória, capaz de fomentar o que Paulo Freire denominou *inédito viável* — a construção de horizontes alternativos de sociedade para além das amarras do individualismo e da mercantilização da existência. É uma educação que, ao denunciar a necropedagogia, anuncia a possibilidade de uma sociedade organizada em torno da ética do cuidado e da vida.

A operacionalização do conceito de necropedagogia adquire contornos empíricos mais nítidos quando aplicada ao campo concreto da saúde pública. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma das raras estruturas estatais de caráter universal que persiste, ainda que sob ataques constantes de desfinanciamento, precarização e tentativas de privatização. Mais do que uma política setorial, o SUS pode ser interpretado como um projeto civilizatório embrionário e como uma *práxis* educativa em ação, fundado nos princípios éticos da universalidade, da integralidade do cuidado e da participação democrática. A pedagogia inerente ao SUS é, portanto, uma pedagogia da vida, da dignidade humana e do comum, que materializa o conceito freireano de diálogo e construção coletiva. Em oposição diametral, o Estado ultraliberal compreende a

saúde como mercadoria, engendrando um conflito fundamental entre duas racionalidades e duas pedagogias inconciliáveis.

A análise da necropedagogia não se restringe à ciência política ou à saúde pública, ela oferece contribuições fundantes para o campo da Educação, ampliando seu escopo teórico e político. O estudo demonstra que os processos pedagógicos transcendem os muros da escola. A gestão estatal, a comunicação pública e as políticas sociais são arenas pedagógicas poderosas onde se disputam visões de mundo e se formam subjetividades. A Educação, como campo de saber, deve desenvolver instrumentos para analisar criticamente esses *currículos ocultos* da vida social e política.

Ao desvendar os mecanismos da pedagogia da submissão, o trabalho reforça, o papel da educação crítica freireana como antídoto necessário. Se um projeto político necropedagógico pode ser tão eficaz, é imperativo fortalecer uma educação que desenvolva o pensamento crítico, a leitura de mundo e a capacidade de desvelar ideologias. A escola precisa ser um espaço de problematização da realidade, e não de sua aceitação passiva. O estudo colocou no centro do debate educacional a formação para uma cidadania sanitária. Isso implica educar sobre os determinantes sociais da saúde, sobre o SUS como conquista coletiva e sobre o cuidado como valor ético-político oposto à necropolítica. A educação deve promover uma compreensão de que a saúde é um direito e um bem comum, construindo uma cultura de solidariedade e responsabilidade coletiva.

Importante neste momento verificar se os objetivos específicos foram contemplados ao longo da investigação, a pesquisa demonstrou tê-los alcançado integralmente. O primeiro objetivo, reconstituir o modelo de gestão ultraliberal imposto na área da saúde pública durante o governo Bolsonaro, com foco em seus princípios, discursos oficiais e ações concretas (ou omissões) no enfrentamento da pandemia, foi atendido nos capítulos 2, 4 e 5, onde se evidenciou a priorização da economia sobre a vida, a instabilidade no Ministério da Saúde com quatro ministros em dois anos, a edição de medidas provisórias que precarizaram direitos trabalhistas (MPs 936, 927 e 928/2020) e a recusa sistemática na aquisição de vacinas. O segundo objetivo, analisar as consequências sociais dessa gestão a partir de indicadores de mortalidade, desigualdade e desinformação, foi plenamente atingido no capítulo 5, que

demonstrou a seletividade da letalidade sobre populações negras, indígenas e periféricas, o impacto sobre mulheres negras trabalhadoras domésticas, a crise de insegurança alimentar que atingiu 70 milhões de brasileiros e a disseminação sistemática de desinformação como política de Estado, incluindo a promoção de tratamentos sem eficácia (caso Prevent Senior) e o ataque à vacinação. O terceiro objetivo, operacionalizar o conceito de necropedagogia a partir da articulação de seus três pilares constituintes (o Estado ultraliberal, a necropolítica e a pedagogia da submissão) e aplicá-lo como chave interpretativa para caracterizar o projeto político-sanitário do governo em análise, foi o mais crítico da tese e também alcançado. A fundamentação teórica, desenvolvida no capítulo 3, ancorou o conceito no diálogo entre a necropolítica de Achille Mbembe e a pedagogia crítica de Paulo Freire, desdobrando-o em três eixos analíticos. A aplicação empírica, realizada no capítulo 5, demonstrou como o Estado ultraliberal (Pilar 1) forneceu a estrutura econômica e institucional que tornou a morte administrável; a necropolítica (Pilar 2) operacionalizou a gestão seletiva da morte, direcionando sua letalidade para corpos historicamente vulnerabilizados; e a pedagogia da submissão (Pilar 3) atuou como o mecanismo cultural de dessensibilização e fabricação do consentimento, ensinando a sociedade a aceitar o inaceitável. A seção 5.5 sintetizou a articulação sinérgica desses três pilares, demonstrando que a necropedagogia não é uma mera soma de partes, mas uma totalidade orgânica na qual cada dimensão potencializa as demais, constituindo-se como uma pedagogia sistemática da morte.

Portanto, compreender a necropedagogia é também uma tarefa fundamental para a Educação. É reconhecer que a luta por uma sociedade democrática passa, inevitavelmente, por uma luta pedagógica — uma disputa entre um projeto que ensina a aceitar a morte e um projeto que se dedica incansavelmente a ensinar e a aprender a defender e a celebrar a vida em sua plenitude coletiva.

Nenhuma investigação acadêmica esgota a totalidade de seu objeto de pesquisa, razão pela qual se faz necessário reconhecer, com honestidade intelectual, os limites do presente estudo. Quanto aos limites do estudo, reconhece-se que o recorte temporal (2020-2021) não abrangeu os desdobramentos posteriores da pandemia, incluindo a marca de 700 mil mortes em 2023. A escolha das fontes empíricas concentrou-se na grande mídia

nacional, não tendo analisado sistematicamente as narrativas comunitárias, as produções das periferias nem os vastos arquivos de redes sociais onde a desinformação foi disseminada. A dimensão comparativa com outros países foi apenas tangencialmente explorada, sem um desenvolvimento sistemático. Por fim, a análise da resistência e das contranarrativas, embora presente, não teve o mesmo aprofundamento dado à crítica da necropedagogia.

Se os limites apontam para o que ficou aquém, eles também indicam, por contraste, as direções possíveis para a continuidade da investigação, abrindo-se aqui alguns caminhos que futuras pesquisas poderão trilhar. Quanto aos caminhos para pesquisas futuras, o conceito de necropedagogia abre múltiplas possibilidades investigativas. Sugere-se aprofundar a análise da pedagogia da submissão em suas dimensões micropolíticas, examinando os dispositivos algorítmicos das redes sociais, o papel de influenciadores digitais e pastores evangélicos como "condutores" da necropedagogia, e as técnicas retóricas específicas empregadas nos pronunciamentos presidenciais. Recomenda-se uma análise comparativa internacional com outros governos de extrema-direita para identificar especificidades nacionais e circulações transnacionais de narrativas negacionistas. Propõe-se estender o conceito a outros campos para além da saúde — políticas ambientais (morte da Amazônia como projeto pedagógico), segurança pública (extermínio da juventude negra periférica) e educacionais (escolas cívico-militares, ataque ao pensamento crítico). Urge investigar as pedagogias contra-hegemônicas de resistência: o SUS como espaço de formação de consciência sanitária crítica, as ações da sociedade civil no combate à desinformação, as mobilizações de familiares de vítimas por memória e justiça, e as produções artísticas que contestaram a necropedagogia. Recomenda-se ainda o estudo da dimensão jurídico-institucional da responsabilização, investigando ações na Justiça brasileira e internacional que buscam responsabilizar agentes públicos por crimes contra a humanidade. Por fim, propõe-se pesquisas longitudinais sobre a permanência do negacionismo científico no pós-pandemia, a continuidade das redes de desinformação e os processos de luto e elaboração traumática em uma sociedade que viveu a morte em massa sem rituais adequados de despedida.

Referencial Bibliográfico

ABRASCO. **Dossiê Abrasco: a pandemia de COVID-19 no Brasil**. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://abrasco.org.br/wp-content/uploads/2023/11/20231116_Abrasco_Dossie_Pademia_de_Covid-19_versao-final.pdf. Acesso em: 19 out. 2025.

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

AGÊNCIA BRASIL. **Pesquisa revela aumento da ansiedade entre brasileiros na pandemia**. 2020a. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/pesquisa-revela-aumento-da-ansiedade-entre-brasileiros-na-pandemia>. Acesso em: 13 set. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Auxílio emergencial começa a ser pago a 5,1 milhões de pessoas**. Brasília, 9 abr. 2020b. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/auxilio-emergencial-comeca-ser-pago-51-milhoes-de-pessoas>. Acesso em: 17 out. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Adolescente yanomami de 15 anos é primeira vítima indígena da covid-19**. Brasília, 10 abr. 2020c. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/adolescente-yanomami-de-15-anos-e-primeira-vitima-indigena-da-covid-19>. Acesso em: 17 out. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Bolsonaro anuncia Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-03/bolsonaro-anuncia-marcelo-queiroga-como-novo-ministro-da-saude>. Acesso em: 19 out. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Saúde mental: afastamentos dobram em dez anos e chegam a 440 mil**. 2025a. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2025-03/afastamentos-por-transtornos-mentais-dobram-em-dez-anos-chegam-440-mil>. Acesso em: 15 ago. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Covid-19: primeiro caso foi confirmado em São Paulo há cinco anos.** São Paulo, 26 fev. 2025b. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2025-02/covid-19-primeiro-caso-foi-confirmado-em-sao-paulo-ha-cinco-anos>. Acesso em: 17 out. 2025.

A REPÚBLICA das milícias: bicho solto. [Locução de Bruno Paes Manso]. Rio de Janeiro: Rádio Novelo, 10 set. 2021. [Podcast]. Disponível em: <https://open.spotify.com/show/6rOkNLT6HOZLD4syOMKZxv>. Acesso em: 10 set. 2024.

AGÊNCIA PÚBLICA. **Projeto Escravizadores: investigações sobre escravidão no Brasil.** 2024. Disponível em: <https://apublica.org/especial/projeto-escravizadores-investigacoes-sobre-escravidao-no-brasil/>. Acesso em: 16 set. 2025.

AGÊNCIA SENADO. **Bolsonaro veta uso obrigatório de máscara no comércio, em escolas e em igrejas.** Brasília, 3 jul. 2020. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/03/bolsonaro-veta-uso-obrigatorio-de-mascara-no-comercio-em-escolas-e-em-igrejas>. Acesso em: 6 dez. 2025.

AGÊNCIA SENADO. **Painel com números da pandemia foi desativado por 'atualização inconsistente', diz Pazuello.** Brasília, 20 maio 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/20/painel-com-numeros-da-pandemia-foi-desativado-por-atualizacao-inconsistente-diz-pazuello>. Acesso em: 21 nov. 2025.

AMAZONAS ATUAL. **'Covid apenas encurtou a vida por alguns dias', diz Bolsonaro a alemães.** Manaus, 24 set. 2021. Disponível em: <https://amazonasatual.com.br/covid-apenas-encurtou-a-vida-por-alguns-dias-diz-bolsonaro-a-alemaes/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

ANDES. **Fiocruz alerta para maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil.** Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/fiocruz-alerta-para-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-do-brasil1>. Acesso em: 19 out. 2025.

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (Org.). **Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

APIB. **Boletim epidemiológico: pandemia COVID-19 e povos indígenas**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://apiboficial.org/2020/05/29/boletim-epidemiologico-apib-29-05-2020/>. Acesso em: 18 out. 2025.

ARAÚJO, Marley Rosana Melo de; MORAIS, Kátia Regina Santos de. Precarização do trabalho e o processo de derrocada do trabalhador. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 1-13, 2017. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v20i1p1-13>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpst/a/pCFvTvfCqSxZ9SNPF7qtqHx/?lang=pt>. Acesso em: 16 fev. 2026.

ARROYO, Miguel G. **Vidas re-existent**: reafirmando a sua outra humanidade na história. Petrópolis: Vozes, 2023.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. **Nota de repúdio à incitação de invasão de unidades de saúde**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://amb.org.br/nota-de-repudio-incitacao-invasao-unidades-saude/>. Acesso em: 18 out. 2025.

BAHIA, L. O SUS e os dilemas da universalização, da integralidade e da equidade. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 108, p. 25-34, jan./mar. 2016.

BBC NEWS. **Covid-19: entre baladas e praias lotadas, Santa Catarina vive pior momento na pandemia**. BBC News Brasil, Londres, 8 dez. 2020a. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55213954>. Acesso em: 11 nov. 2025.

BBC NEWS. **Brasil é destaque no mundo por esconder dados de mortes por covid-19. OMS cobra transparência**. BBC News, Londres, 8 jun. 2020b. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/epoca/brasil/brasil-destaque-no-mundo-por-esconder-dados-de-mortes-por-covid-19-oms-cobra-transparencia-24468531>. Acesso em: 22 nov. 2025.

BBC NEWS. **Coronavírus: se saída de Mandetta representar 'mudança radical', podemos ter 'caos', dizem especialistas.** BBC News Brasil, Londres, 16 abr. 2020c. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52317267>. Acesso em: 17 out. 2025.

BBC NEWS. **Covid-19: morte de adolescente yanomami de 15 anos acende alerta sobre risco para indígenas.** BBC News Brasil, Londres, 10 abr. 2020d. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52241742>. Acesso em: 17 out. 2025.

BBC NEWS. **CPI da Covid: como 'imunidade de rebanho' pode virar arma contra Bolsonaro.** BBC News Brasil, Londres, 6 maio 2021a. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57004708>. Acesso em: 29 nov. 2025.

BBC NEWS. **Vacinação contra covid-19 começa no Brasil; veja perguntas e respostas.** BBC News Brasil, Londres, 2021b. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55699131>. Acesso em: 19 out. 2025.

BENJAMIN, Walter. **Sobre o conceito de história.** São Paulo: Alameda, 2020.

BOLSONARO, Jair. **Publicação no Twitter sobre a vacina CoronaVac.** 2020. Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1318945671238909952>. Acesso em: 18 out. 2025.

BORELLI, Wyllians Vendramini et al. **Preventable risk factors of dementia: Population attributable fractions in a Brazilian population-based study.** *The Lancet Regional Health – Americas*, v. 9, p. 100256, maio 2022. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X\(22\)00073-4/fulltext#:~:text=Findings,among%20all%20the%20risk%20factors](https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(22)00073-4/fulltext#:~:text=Findings,among%20all%20the%20risk%20factors). Acesso em: 18 jan. 2025.

BRAGA, Henrique Pereira; SILVA, Lays Hesse Andrade. Uma teoria para o seu tempo: neoliberalismo, homem econômico e homem capital. **Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política**, São Paulo, n. 65, p. 48-68, jan./abr. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Promulgada em: 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. **Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília, 1995.

BRASIL. **Exposição de motivos interministerial nº 49, de 18 de agosto de 1995**. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 ago. 1998.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998**. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jun. 1998.

BRASIL. **Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 maio 1998.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 maio 2000.

BRASIL. **Controladoria-Geral da União. Relatório de Avaliação OS nº 202000027**. Brasília, 2020a.

BRASIL. **Controladoria-Geral da União. Nota Técnica nº 11/2020/CGSIC/CGU/PR**. Brasília, 23 mar. 2020b.

BRASIL. Agência nacional de saúde suplementar (ANS). **Setor fecha 2023 com 51 milhões de beneficiários em planos de assistência médica**. Portal GOV.BR, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt->

br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/setor-fecha-2023-com-51-milhoes-de-beneficiarios-em-planos-de-assistencia-medica. Acesso em: 6 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Promulgada em: 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. **Relatório de Avaliação OS nº 202000027**. Brasília, 2020.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. **Nota Técnica nº 11/2020/CGSIC/CGU/PR**. Brasília, 23 mar. 2020s.

BRASIL. **Decreto nº 10.317, de 16 de abril de 2020**. Dispõe sobre a aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 abr. 2020.

BRASIL. **Decreto nº 10.318, de 16 de abril de 2020**. Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 abr. 2020.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998**. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jun. 1998.

BRASIL. **Exposição de motivos interministerial nº 49, de 18 de agosto de 1995**. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 ago. 1998.

BRASIL. **Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998**. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 maio 1998.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 maio 2000.

BRASIL. **Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.** Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer medida excepcional de acesso a benefício assistencial para pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente do desastre de saúde pública provocado pelo coronavírus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 abr. 2020.

BRASIL. **Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020.** Dispõe sobre o uso de máscaras de proteção individual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional prevista na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 jul. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14019.htm. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 15.126, de 2 de abril de 2025.** Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir o princípio da atenção humanizada no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 abr. 2025.

BRASIL. **Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020.** Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 mar. 2020.

BRASIL. **Medida Provisória nº 936, de 22 de março de 2020.** Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 mar. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Estudo monitora insegurança alimentar no cenário da Covid-19.** 11 abr. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt->

br/assuntos/noticias/estudo-monitora-inseguranca-alimentar-no-cenario-da-covid-19. Acesso em: 18 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Especial - COVID-19. Brasília**. 13 maio 2020a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/covid-19/2020/boletim_epidemiologico_covid_13_05_2020.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Especial: COE-COVID19**. Brasília, 2020b. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/covid-19/2020/boletim_epidemiologico_covid_19_2020.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Coletiva de imprensa do Ministro Nelson Teich sobre atualização das medidas de enfrentamento à COVID-19**. Brasília, 12 maio 2020c. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020-1/maio/ministro-da-saude-atualiza-numeros-da-covid-19-e-fala-sobre-orientacoes-de-tratamento>. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Coletiva de imprensa de anúncio de demissão do Ministério da Saúde**. Brasília, 15 maio 2020d. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MLj4be6MjTM>. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Declaração de transmissão comunitária nacional**. Brasília, 2020e. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/marco/ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-nacional>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde anuncia saída do ministro Nelson Teich**. Brasília, 15 maio 2020f. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020-1/maio/ministerio-da-saude-anuncia-saida-do-ministro-nelson-teich>. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel de casos de COVID-19 no Brasil**. Brasília, 2020g. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Tratamento de COVID-19 com a Cloroquina.** Brasília, 20 maio 2020h. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020-1/maio/ministerio-da-saude-atualiza-protocolo-para-tratamento-da-covid-19>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.** Brasília, 2020i. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/25/planovacinaocovid_v2_25jan21.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Doenças Não Transmissíveis. **Manejo de corpos no contexto da doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 – Covid-19.** Brasília: Ministério da Saúde, 2020t.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel de casos COVID-19.** Brasília, 2021j. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Imunizações.** Brasília, 2021k. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/programa-nacional-de-imunizacoes-pni>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Imunizações: 48 anos de história e conquistas.** Brasília, 2021l. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/setembro/programa-nacional-de-imunizacoes-completa-48-anos>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Retrospectiva 2021: as milhões de vacinas Covid-19 que trouxeram esperança para o Brasil.** Brasília, 2021m. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/retrospectiva-2021-as-milhoes-de-vacinas-covid-19-que-trouxeram-esperanca-para-o-brasil>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil tem 80% da população alvo com duas doses contra a Covid-19.** Brasília, 2021g. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/brasil-tem-80-da-populacao-alvo-com-duas-doses-contr-a-covid-19>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Contrato de aquisição de vacinas com a Pfizer**. Brasília, 2021h. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/marco/contrato-pfizer>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia diversificada garante sucesso da vacinação**. Brasília, 2021i. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/estrategia-diversificada-garante-sucesso-da-vacinacao>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Dose de reforço ampliada para todos os maiores de 18 anos**. 2021s. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/dose-de-reforco-ampliada-para-todos-os-maiores-de-18-anos>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel de vacinação contra COVID-19**. 2021t. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/paineis-de-vacinacao>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil chega à marca de 700 mil mortes por Covid-19**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/brasil-chega-a-marca-de-700-mil-mortes-por-covid-19>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Imunizações completa 52 anos de história na proteção da saúde pública brasileira**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/programa-nacional-de-imunizacoes-completa-52-anos-de-historia-na-protecao-da-saude-publica-brasileira>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Centros de Atenção Psicossocial**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude/selecao-2025/centros-de-atencao-psicossocial>. Acesso em: 8 set. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília, 1995.

BRASIL. Presidência da República. **Declaração do Presidente Jair Bolsonaro durante conversa com apoiadores**. Brasília, 5 jun. 2020k. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-conversa-com-apoiadores-1>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Pronunciamento sobre medidas de enfrentamento à COVID-19**. Brasília, 14 maio 2020l. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-pronunciamento-sobre-medidas-de-enfrentamento-a-covid-19-1>. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Discurso do Presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre medidas de enfrentamento à COVID-19**. Brasília, 13 maio 2020m. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-pronunciamento-sobre-medidas-de-enfrentamento-a-covid-19>. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Proposta de Emenda à Constituição nº 32**, de 2020. Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262083>. Acesso em: 14 jan. 2026.

BRASIL. Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). **Nota Técnica nº 45/2020**. Brasília, 10 abr. 2020u.

BRASIL. Senado Federal. **Davi e Maia decretam luto oficial em razão de 10 mil mortes da covid-19**. Brasília, 9 maio 2020n. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/presidencia/noticia/davi->

alcolumbre/davi-e-maia-decretam-luto-oficial-em-razao-de-10-mil-mortes-da-covid-19. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Senadores querem entrada do Brasil em grupo da OMS que busca vacina contra covid-19**. Brasília, 2020o. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/28/senadores-querem-entrada-do-brasil-em-grupo-da-oms-que-busca-vacina-contr-covid-19>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **O que é e como funciona uma CPI**. Brasília, 2021n. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/15/o-que-e-e-como-funciona-uma-cpi>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Regimento Interno da CPI da Covid**. Brasília, 2021o. Disponível em: <https://www.cpi-covid19.senado.leg.br/>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Relatório da CPI da Pandemia**. Brasília, 2021p. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2021/10/26/relatorio_final-26102021-12h40-1.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Representante da Pfizer confirma que governo não respondeu ofertas feitas em agosto de 2020**. Brasília, 2021q. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/13/representante-da-pfizer-confirma-governo-nao-respondeu-ofertas-feitas-em-agosto-de-2020>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Decreto de luto oficial pelo STF**. Brasília, 9 maio 2020p. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443021&ori=1>. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341/DF. Medidas de isolamento social e competência dos entes federados. Relator: Ministro Marco Aurélio**. Brasília, 15 abr. 2020q. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5890969>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Decisão sobre a obrigatoriedade da vacinação contra COVID-19.** Brasília, 17 dez. 2020r. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi6586vacinaobrigatoriedade.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Plenário confirma liminar que impediu restrições na Lei de Acesso à Informação durante pandemia.** 30 abr. 2020v. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442475&ori=1>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **STF afasta trechos da MP que flexibiliza regras trabalhistas durante pandemia da Covid-19.** 29 abr. 2020x. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442355&ori=1>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Decisão do Ministro Luís Roberto Barroso [que determina instalação da CPI da Pandemia no Senado].** Brasília, 2021r. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/barroso-determina-instalacao-da-cpi-da-pandemia-no-senado/>. Acesso em: 19 out. 2025.

BRASIL DE FATO. **125 mil mortos: Bolsonaro desestimula uso de máscara de proteção contra a covid. 4 set. 2020a.** Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/09/04/125-mil-mortos-bolsonaro-desestimula-uso-de-mascara-de-protecao-contra-a-covid/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

BRASIL DE FATO. **Bolsonaro ignora coronavírus e participa de manifestação contra Congresso e STF. 15 mar. 2020b.** Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/03/15/bolsonaro-ignora-coronavirus-e-participa-de-manifestacao-contra-congresso-e-stf/>. Acesso em: 2 jan. 2026.

BRASIL DE FATO. **O ano da fila do osso: economia naufraga e fome volta a assolar brasileiros. 17 dez. 2021a.** Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/o-ano-da-fila-do-osso->

economia-naufraga-e-fome-volta-a-assolar-brasileiros/. Acesso em: 18 dez. 2025.

BRASIL DE FATO. **Governo admite que sabia da falta de oxigênio oito dias antes do colapso em Manaus. 18 jan. 2021b.** Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/governo-admite-que-sabia-da-falta-de-oxigenio-oito-dias-antes-do-colapso-em-manaus/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Estratégia e estrutura para um novo Estado. **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 48, n. 1, p. 5-25, jan./mar. 2014. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/375>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BROWN, Wendy. **Cidadania Sacrificial: neoliberalismo, capital humano e políticas de austeridade.** Tradução de Juliane Bianchi Leão. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2018.

BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente.** Tradução de Mario A. Marino e Eduardo Altheman C. Santos. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019.

BUTANTAN. Instituto Butantan. **Butantan prevê vacina contra COVID-19 para outubro.** São Paulo, 2020. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/butantan-preve-vacina-contracovid-19-para-outubro>. Acesso em: 18 out. 2025.

BUTANTAN. Instituto Butantan. **Projeto S: vacinação em massa com CoronaVac reduz em 80% os casos sintomáticos de COVID-19.** São Paulo, 2021. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/projeto-s-vacinacao-em-massa-com-coronavac-reduz-em-80-os-casos-sintomaticos-de-covid-19>. Acesso em: 19 out. 2025.

CAMPO GRANDE NEWS. **Brasil atinge marca de 80% da população vacinada com duas doses contra covid.** Campo Grande, 2021. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/brasil-atinge-marca->

[de-80-da-populacao-vacinada-com-duas-doses-contra-covid](#). Acesso em: 19 out. 2025.

CAMPOS, G. W. S. Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 219-230, 2003.

CARTA CAPITAL. **Pesquisadores dizem que não endossaram plano de vacinação do governo.** 13 dez. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/pesquisadores-dizem-que-nao-endossaram-plano-de-vacinacao-do-governo/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

CARTA CAPITAL. **Quem é Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde na pandemia.** 2021a. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/quem-e-marcelo-queiroga-o-quarto-ministro-saude-pandemia/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CARTA CAPITAL. **Vacinação começará no dia D e na hora H, diz ministro da Saúde.** 11 jan. 2021b. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vacinacao-comecara-no-dia-d-e-na-hora-h-diz-ministro-da-saude/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

CASARA, Rubens. **A construção do idiota: o processo de idiosubjetivação.** Rio de Janeiro: Da Vinci Livros, 2024.

CASARA, Rubens. **Contra a miséria neoliberal: racionalidade, normatividade e imaginário.** São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

CLEMENTINO, M. do L. M.; ARAÚJO, J. B. de; TROVÃO, B. Precarização do trabalho e nova informalidade no urbano: permanências e transformações. **Cadernos Metrópole**, São Paulo, v. 26, n. 59, p. 9-17, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2024-5900>.

CNN BRASIL. **Datafolha: 76% dos brasileiros defendem o isolamento social contra a COVID-19.** São Paulo, 6 abr. 2020a. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/datafolha-76-dos-brasileiros-defendem-o-isolamento-social-contra-a-covid-19/>. Acesso em: 17 out. 2025.

CNN BRASIL. **Bolsonaro anda de jet ski enquanto país chega a 10 mil mortos por COVID.** São Paulo, 9 maio 2020b. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-anda-de-jet-ski-no-dia-em-que-pais-passa-de-10-mil-mortos-por-covid-19/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

CNN BRASIL. **Entrevista com Jean Gorinchteyn sobre distribuição da CoronaVac em São Paulo.** 2020c. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/gorinchteyn-diz-que-nao-e-justo-coronavac-so-para-sp-saude-e-democratica/>. Acesso em: 18 out. 2025.

CNN BRASIL. **Governo elevou taxa de importação de cilindros de oxigênio antes de colapso em Manaus.** 2020d. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/governo-elevou-taxa-de-importacao-de-cilindros-antes-de-colapso-em-manaus/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CNN BRASIL. **Estudo projeta mais de 1 milhão de casos e 80 mil mortes por Covid-19 no Brasil.** 24 maio 2020e. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/estudo-projeta-mais-de-1-milhao-de-casos-e-80-mil-mortes-de-covid-19-no-brasil/>. Acesso em: 11 nov. 2025.

CNN BRASIL. **Veja quais países iniciaram a vacinação contra a Covid-19; Brasil está fora.** 24 dez. 2020f. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/quais-os-paises-que-ja-comecaram-a-vacinacao-contra-a-covid-19/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

CNN BRASIL. **Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga uso de máscaras em locais públicos.** 3 jul. 2020g. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/bolsonaro-sanciona-com-vetos-lei-que-obriga-uso-de-mascaras-no-brasil/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

CNN BRASIL. **Primeira pessoa é vacinada contra covid-19 no Brasil.** 2021a. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/primeira-pessoa-e-vacinada-contra-covid-19-no-brasil/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CNN BRASIL. **Brasil ultrapassa EUA em vacinação completa contra Covid-19.** 2021b. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-ultrapassa-eua-em-vacinacao-completa-contr-covid-19/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CNN BRASIL. **Brasil ultrapassa marca de 50% da população com vacinação completa.** 2021c. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-50-da-populacao-totalmente-imunizada-contr-a-covid-19/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CNN BRASIL. **Brasil chega a 80% do público-alvo vacinado com duas doses contra a Covid-19.** 2021d. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-chega-a-80-do-publico-alvo-vacinado-com-duas-doses-contr-a-covid-19/>. Acesso em: 19 out. 2025.

CNN BRASIL. **Imunidade de rebanho e atraso de vacinas impulsionaram mortes, diz relatório.** 19 out. 2021e. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/imunidade-de-rebanho-e-atraso-de-vacinas-impulsionaram-mortes-diz-relatorio/>. Acesso em: 29 nov. 2025.

COFEN. **Enfermeira Mônica Calazans é a 1ª vacinada contra Covid-19 no Brasil.** Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/enfermeira-monica-calazans-e-a-1a-vacinada-contr-covid-19-no-brasil/>. Acesso em: 19 out. 2025.

COHN, A. **Crise e reinvenção da política no Brasil: o contexto das políticas de saúde.** São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2018.

COMBLIN, José. **O neoliberalismo: ideologia dominante na virada do século.** 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

COMTE-SPONVILLE, André. **El capitalismo, ¿es moral?** Barcelona: Paidós, 2004.

CONECTAS DIREITOS HUMANOS. **Direitos na Pandemia – Mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à COVID-19 no Brasil.** Boletim n. 03. São Paulo: Conectas Direitos Humanos, 13 ago. 2020. Disponível

em: https://cepedisa.fsp.usp.br/wp-content/uploads/2023/02/03boletimcovid_PT_05.pdf. Acesso em: 21 dez. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Nota técnica sobre biossegurança hospitalar durante a pandemia**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/nota-tecnica-biosseguranca-hospitalar/>. Acesso em: 18 out. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Boletim epidemiológico: ocupação de leitos UTI COVID-19**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/boletim-epidemiologico-ocupacao-leitos-uti/>. Acesso em: 18 out. 2025.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (Cimi). **Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil – dados de 2020**. Brasília: Cimi, 2021. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2021/10/relatorio-violencia-contr-os-povos-indigenas-2020-cimi.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2025.

CORREIO BRAZILIENSE. **Pazuello diz que vacinação começa 'no dia D, na hora H'**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4899602-pazuello-diz-que-vacinacao-comeca-no-dia-d-na-hora-h.html>. Acesso em: 19 out. 2025.

CORREIO DO POVO. **Bolsonaro passeia de jet ski em dia que Brasil ultrapassa 10 mil mortos pela Covid-19**. São Paulo, 9 maio 2020. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/bolsonaro-passeia-de-jet-ski-em-dia-que-brasil-ultrapassa-10-mil-mortos-pela-covid-19-1.420296>. Acesso em: 17 mar. 2025.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.

DASSO JUNIOR, Aragon Érico. **Reforma do Estado com Participação Cidadã? Déficit democrático das Agências Reguladoras Brasileiras**. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

DASSO JUNIOR, Aragon; FAGANELLO, Cláucia P. História Contemporânea da administração pública brasileira contada pelas reformas administrativas de caráter gerencial: um balanço dos últimos 25 anos. **Revista Digital de Direito Administrativo**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 196-217, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/214756>. Acesso em: 18 mar. 2025.

DIÁRIO DO CENTRO DO MUNDO. **Pazuello mandou funcionários da saúde para 'tour' disseminando o tratamento precoce em Manaus**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/pazuello-mandou-funcionarios-da-saude-para-tour-disseminando-o-tratamento-precoce-em-manaus/>. Acesso em: 19 out. 2025.

DURKHEIM, Émile. **O suicídio: estudo de sociologia**. Tradução de Monica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

DW. **Brasil vive maior colapso sanitário de sua história, dizem pesquisadores**. Brasília, 2021a. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/brasil-vive-maior-colapso-sanit%C3%A1rio-de-sua-hist%C3%B3ria-dizem-pesquisadores/a-56901187>. Acesso em: 19 out. 2025.

DW. **Abril foi o mês mais mortal da pandemia no Brasil**. São Paulo, 2021b. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/abril-foi-o-m%C3%AAs-mais-mortal-da-pandemia-no-brasil/a-57398775>. Acesso em: 19 out. 2025.

DW. **Estudo atribui fracasso do Brasil na pandemia ao governo federal**. 15 abr. 2021c. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/estudo-atribui-fracasso-do-brasil-na-pandemia-ao-governo-federal/a-57219075>. Acesso em: 22 nov. 2025.

ECO, Umberto. **O fascismo eterno**. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2018.

EL PAÍS. **Yanomami de 15 anos morre vítima do coronavírus em Roraima**. São Paulo, 10 abr. 2020a. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-10/yanomami-de-15-anos-morre-vitima-do-coronavirus-em-roraima.html>. Acesso em: 17 out. 2025.

EL PAÍS. **Movimentos negros apresentam 56º pedido de impeachment de Bolsonaro, por negligência com a pandemia.** São Paulo, 11 ago. 2020b. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-11/movimentos-negros-apresentam-56-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro-por-negligencia-com-a-pandemia.html>. Acesso em: 17 out. 2025.

EL PAÍS. **Brasil se perfila como el próximo epicentro mundial de la pandemia.** Madri, 6 maio 2020c. Disponível em: <https://elpais.com/sociedad/2020-05-06/brasil-se-perfila-como-el-proximo-epicentro-mundial-de-la-pandemia.html>. Acesso em: 18 out. 2025.

EL PAÍS. **Governo Bolsonaro impõe apagão de dados sobre a covid-19 no Brasil em meio à disparada das mortes.** 6 jun. 2020d. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html>. Acesso em: 21 nov. 2025.

EL PAÍS. **As feridas ocultas da covid-19 em Wuhan, um ano depois que tudo começou.** 23 jan. 2021a. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-01-23/as-feridas-ocultas-da-covid-19-em-wuhan-um-ano-depois-que-tudo-comecou.html>. Acesso em: 15 nov. 2025.

EL PAÍS. **Contrário à cloroquina, Marcelo Queiroga será o quarto ministro da Saúde na pandemia.** São Paulo, 2021b. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-15/contrario-a-cloroquina-marcelo-queiroga-sera-o-quarto-ministro-da-saude-na-pandemia.html>. Acesso em: 19 out. 2025.

ESCOREL, S. **Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

FIOCRUZ. **Decreto do governo Bolsonaro ameaça extinguir conselhos de saúde.** 2019. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/podcast/decreto-do-governo-bolsonaro-ameaca-extinguir-conselhos-de-saude>. Acesso em: 12 mar. 2025.

FIOCRUZ. **Covid-19: 7,8 milhões de brasileiros estão a 4 horas do atendimento adequado.** 21 maio 2020a. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/covid-19-78-milhoes-de-brasileiros-estao-4-horas-do-atendimento-adequado>. Acesso em: 10 nov. 2025.

FIOCRUZ. **Produção de vacinas no Brasil: histórico e perspectivas.** Rio de Janeiro, 2020b. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/producao-de-vacinas-no-brasil-historico-e-perspectivas>. Acesso em: 18 out. 2025.

FIOCRUZ. **Boletim Observatório COVID-19: subnotificação e desafios no enfrentamento da pandemia.** Rio de Janeiro, 2020c. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_epidemiologico_covid_19_2020.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

FIOCRUZ. **Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil.** Rio de Janeiro, 2021a. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-aponta-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-do-brasil>. Acesso em: 19 out. 2025.

FIOCRUZ. **Boletim Observatório COVID-19.** Rio de Janeiro, 2021b. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_2021-julho.pdf. Acesso em: 19 out. 2025.

FIOCRUZ. **Estudo do Projeto S demonstra eficácia da vacinação em massa no controle da COVID-19.** Rio de Janeiro, 2021c. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-do-projeto-s-demonstra-eficacia-da-vacinacao-em-massa-no-controle-da-covid-19>. Acesso em: 19 out. 2025.

FIOCRUZ. **Programa Nacional de Imunizações: 48 anos de história.** Rio de Janeiro, 2021d. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/programa-nacional-de-imunizacoes-48-anos-de-historia>. Acesso em: 19 out. 2025.

FIOCRUZ. **Monitoramento da vacinação COVID-19 no Brasil.** Rio de Janeiro, 2021e. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/vacinacao-covid19>. Acesso em: 18 out. 2025.

FIOCRUZ. **Relatório de Impactos 2020 - Programa UNIDOS Contra a Covid-19.** Rio de Janeiro, 2021f. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/relatorio_de_impactos_2020_unidos_contra_covid.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

FIOCRUZ. **Análise das posições do Brasil em fóruns multilaterais de saúde durante a pandemia de COVID-19.** *Boletim Epidemiológico*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 45, p. 15-28, 2021g. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_epidemiologico_2021_45.pdf. Acesso em: 17 out. 2025.

FILHO, João. **Os erros liberais do Chile estão sendo repetidos aqui por Paulo Guedes: A receita chilena de liberdade total à economia somada ao fim de direitos sociais é a mesma que o bolsonarismo quer implantar no Brasil.** *The Intercept Brasil*, 27 out. 2019. Disponível em: <https://www.intercept.com.br/2019/10/27/chile-paulo-guedes-chicago-boys-liberalismo-crise-bolsonaro/>.

FISHER, Mark. **Realismo Capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?** Tradução de Rodrigo Gonsalves. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

FLEURY, S. **Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil e Espanha.** Rio de Janeiro: FGV Editora, 2012.

FOLHA DE S.PAULO. **Governo recua e revoga trecho da MP que permitia suspensão de salário.** São Paulo, 23 mar. 2020a. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/governo-recua-e-revoga-trecho-da-mp-que-permitia-suspensao-de-salario.shtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Bolsonaro demite Mandetta e nomeia Nelson Teich para Ministério da Saúde.** São Paulo, 16 abr. 2020b. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/bolsonaro-demite-mandetta-e-nomeia-nelson-teich-para-ministerio-da-saude.shtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **"Não sou coveiro", diz Bolsonaro ao ser questionado sobre mortes por coronavírus.** São Paulo, 20 abr. 2020c. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/nao-sou-coveiro-diz-bolsonaro-ao-ser-questionado-sobre-mortes-por-coronavirus.shtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Bolsonaro estimula população a invadir hospitais para filmar oferta de leitos.** São Paulo, 2020d. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/bolsonaro-estimula-populacao-a-invadir-hospitais-para-filmar-oferta-de-leitos.shtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Governo deposita primeira parcela do auxílio emergencial.** São Paulo, 9 abr. 2020e. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-deposita-primeira-parcela-do-auxilio-emergencial.shtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Vacinas chegarão aos Estados três ou quatro dias após aval da Anvisa, diz Pazuello.** São Paulo, 2021a. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/vacinas-chegarao-aos-estados-tres-ou-quatro-dias-apos-aval-da-anvisa-diz-pazuello.shtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Após aval da Anvisa, enfermeira do Emílio Ribas é a primeira a ser vacinada contra a covid-19 no Brasil.** São Paulo, 2021b. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/apos-aval-da-anvisa-enfermeira-do-emilio-ribas-e-a-primeira-a-ser-vacinada-contr-a-covid-19-no-brasil.shtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa diz Bolsonaro sobre isolamento na pandemia.** São Paulo, 2021c. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/tem-alguns-idiotas-que-ate-hoje-ficam-em-casa-diz-bolsonaro-sobre-isolamento-na-pandemia.shtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Bolsonaro planeja motociata em Brasília no 7 de Setembro.** São Paulo, 2021d. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/bolsonaro-planeja-motociata-em-brasilia-no-7-de-setembro.shtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Bolsonaro diz que mortes de crianças por covid não justificam vacinação.** São Paulo, 2021e. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/12/bolsonaro-diz-que-mortes-de-criancas-por-covid-nao-justificam-vacinacao.shtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

FORBES BRASIL. **Governo edita MP que permite suspensão de contrato de trabalho por 4 meses sem salário.** 23 mar. 2020. Disponível em: <https://forbes.com.br/last/2020/03/governo-edita-mp-que-permite-suspensao-de-contrato-de-trabalho-por-4-meses-sem-salario/>. Acesso em: 17 out. 2025.

FOUCAULT, Michel. **Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978).** Edição estabelecida por Michel Senellart; sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução de Eduardo Brandão; revisão da tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, Michel. **O nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979).** Edição estabelecida por Michel Senellart; sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

G1. **Organizações Sociais receberam quase R\$ 7 bilhões do RJ em 4 anos.** 2020a. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/30/organizacoes-sociais-receberam-quase-r-7-bilhoes->

[do-rj-em-4-anos-apos-afastamento-de-witzel-estado-anuncia-expulsao-de-oss.ghtml](#).

G1. Ministério da Saúde confirma transmissão comunitária em todo o país.
Brasília, 23 mar. 2020b. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/23/ministerio-da-saude-confirma-transmissao-comunitaria-em-todo-o-pais.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. Congresso aprova auxílio de R\$ 600 para informais e desempregados.
Brasília, 30 mar. 2020c. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/30/congresso-aprova-auxilio-de-r-600-para-informais-e-microempreendedores.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. Índio yanomami de 15 anos morre em Roraima após 6 dias na UTI. Boa Vista, 10 abr. 2020d. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/10/morre-adolescente-yanomami-infectado-pelo-coronavirus-em-roraima.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. Bolsonaro anuncia oncologista Nelson Teich como novo ministro da Saúde. Brasília, 16 abr. 2020e. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/bolsonaro-anuncia-nelson-teich-como-novo-ministro-da-saude.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. "Não sou coveiro", diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus.
Brasília, 20 abr. 2020f. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. Brasil fica de fora de aliança global para acelerar produção de vacina.
São Paulo, 4 maio 2020g. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/05/04/brasil-fica-de-fora-de-alianca-global-para-acelerar-producao-de-vacina.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. **Bolsonaro sai sem máscara e passeia de moto aquática no DF.** Brasília, 9 maio 2020h. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/09/bolsonaro-sai-sem-mascara-e-passeia-de-moto-aquatica-no-df.ghtml>. Acesso em: 17 mar. 2025.

G1. **Bolsonaro ameaça retirar Brasil da OMS e critica isolamento social.** São Paulo, 5 jun. 2020i. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/bolsonaro-aponta-vies-ideologico-na-oms-e-ameaca-tirar-brasil-da-organizacao.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

G1. **Ministério da Saúde prevê receber 2 mil doses de vacina de Oxford na semana que vem.** São Paulo, 7 jun. 2020j. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/06/07/ministerio-da-saude-preve-receber-2-mil-doses-de-vacina-de-oxford-na-semana-que-vem.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

G1. **Cronograma da CoronaVac está mantido mesmo com atraso da Anvisa para liberar importação, diz diretor do Butantan.** Brasília, 23 out. 2020k. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/23/cronograma-da-coronavac-esta-mantido-mesmo-com-atraso-da-anvisa-para-liberar-importacao-diz-diretor-do-butantan.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

G1. **Bolsonaro aponta 'viés ideológico' na OMS e ameaça tirar Brasil da organização.** Brasília, 2020l. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/bolsonaro-aponta-vies-ideologico-na-oms-e-ameaca-tirar-brasil-da-organizacao.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

G1. **Após reduzir boletim diário, governo Bolsonaro retira dados acumulados da Covid-19 do site.** 6 jun. 2020m. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/06/apos-reduzir-boletim-governo-bolsonaro-retira-dados-acumulados-da-covid-19-de-site-oficial.ghtml>. Acesso em: 21 nov. 2025.

G1. Bolsonaro diz que 'ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina'; especialistas criticam. 2 set. 2020n. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/02/bolsonaro-diz-que-ninguem-pode-obrigar-ninguem-a-tomar-vacina-especialistas-criticam.ghtml>. Acesso em: 21 dez. 2025.

G1. Entidades reagem a fala de Bolsonaro, que incentivou pessoas a entrar em hospitais e filmar. 12 jun. 2020o. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/12/entidades-reagem-a-fala-de-bolsonaro-que-incentivou-pessoas-a-entrar-em-hospitais-e-filmar.ghtml>. Acesso em: 6 dez. 2025.

G1. Brasil tem de deixar de ser 'país de maricas' e enfrentar pandemia 'de peito aberto', diz Bolsonaro. 10 nov. 2020p. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/10/bolsonaro-diz-que-brasil-tem-de-deixar-de-ser-pais-de-maricas-e-enfrentar-pandemia-de-peito-aberto.ghtml>. Acesso em: 6 dez. 2025.

G1. Ato pró-Bolsonaro em Brasília reúne manifestantes em defesa de medidas inconstitucionais. 31 maio 2020q. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/31/manifestantes-fazem-ato-em-brasilia-em-apoio-a-bolsonaro-e-em-defesa-de-medidas-inconstitucionais.ghtml>. Acesso em: 2 jan. 2026.

G1. Governo publica MP que permite suspensão de contrato de trabalho por 4 meses. 23 mar. 2020r. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/23/governo-publica-mp-que-permite-suspensao-de-contrato-de-trabalho-por-4-meses.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

G1. Com 3.668 mortes por Covid em 24 horas, Brasil volta a bater pior marca da pandemia. São Paulo, 2021a. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/30/brasil-volta-a-bater-pior-marca-com-3668-mortes-por-covid-registradas-em-24-horas.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. CPI da Covid: Governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de vacina. 27 abr. 2021b. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/blog/octavio-guedes/post/2021/04/27/cpi-da-covid-governo-bolsonaro-recusou-11-vezes-ofertas-para-compras-de-vacina.ghtml>. Acesso em: 25 nov. 2025.

G1. O Assunto 407: Brasil, celeiro de covid, ameaça global. São Paulo, 2021c. Disponível em: <https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/03/10/o-assunto-407-brasil-celeiro-de-covid-ameaca-global.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Bolsonaro escolhe médico Marcelo Queiroga para substituir Pazuello no Ministério da Saúde. São Paulo, 2021d. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/15/bolsonaro-escolhe-medico-marcelo-queiroga-para-substituir-pazuello-no-ministerio-da-saude.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Bolsonaro participa de motociata enquanto país bate marca de mortos por COVID. São Paulo, 2021e. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/07/11/bolsonaro-participa-de-motociata-enquanto-pais-bate-marca-de-mortos-por-covid.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Agosto tem menor número de mortes por covid desde dezembro de 2020. São Paulo, 2021f. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/09/01/agosto-foi-o-mes-com-menor-numero-de-mortes-por-covid-no-ano-apontam-secretarias-de-saude.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Vacinação contra a Covid: Brasil passa EUA em taxa de totalmente imunizados. São Paulo, 2021g. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/17/vacinacao-contra-a-covid-brasil-passa-eua-em-taxa-de-totalmente-imunizados.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Novembro é o mês com menos mortes por Covid-19 no Brasil desde abril de 2020. São Paulo, 2021h. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/01/novembro-e-o-mes-com-menos-mortes-por-covid-19-no-brasil-desde-abril-de-2020-apontam-secretarias-de-saude.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Brasil ultrapassa 617 mil mortos por Covid; ataque hacker prejudica balanço pelo 5º dia sem dados de 5 estados. São Paulo, 2021i. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/14/brasil-ultrapassa-617-mil-mortos-por-covid-ataque-hacker-prejudica-banco-pelo-5o-dia-sem-dados-de-5-estados.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Crise do oxigênio no Amazonas completa um ano com impunidade e incerteza causada pela Ômicron. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2022/01/14/crise-do-oxigenio-no-amazonas-completa-um-ano-com-impunidade-e-incerteza-causada-pela-omicron.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2025.

G1. Bolsonaro alvo da PF: relembre declarações do ex-presidente sobre a vacina contra Covid. 3 mai. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/03/bolsonaro-alvo-da-pf-relembre-declaracoes-do-ex-presidente-sobre-a-vacina-contr-covid.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2025.

G1. Luciano Hang e lojas Havan são condenados a pagar R\$ 85 milhões por assédio eleitoral. 31 jan. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2024/01/31/luciano-hang-havan-condenacao-assedio-eleitoral.ghtml>. Acesso em: 12 dez. 2025.

G1. Crise de saúde mental: Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. 2025a. Disponível em: <https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/03/10/crise-de-saude-mental-brasil-tem-maior-numero-de-afastamentos-por-ansiedade-e-depressao-em-10-anos.ghtml>. Acesso em: 8 set. 2025.

G1. **Caps passam a atender pessoas com vício em jogos de azar.** 2025b. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2025/09/07/caps-passam-a-atender-pessoas-com-vicio-em-jogos-de-azar-veja-servicos-na-regiao-de-sorocaba.ghtml>. Acesso em: 7 set. 2025.

GAZETA DO POVO. **Para Bolsonaro, coronavírus é “superdimensionado” e potencializado por “questões econômicas”.** 9 mar. 2020a. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/república/breves/bolsonaro-coronavirus-superdimensionado-e-potencializado-por-questoes-economicas/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

GAZETA DO POVO. **Governo aumentou imposto para importação de cilindros de oxigênio em dezembro.** 15 jan. 2020b. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/taxa-importacao-cilindro-de-oxigenio/>. Acesso em: 19 out. 2025.

GELTZER, L. et al. Outcomes of hospitalized patients treated with hydroxychloroquine for COVID-19. **Journal of the American Medical Association**, Chicago, v. 323, n. 20, p. 2057-2059, 2020. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117>. Acesso em: 17 mar. 2025.

GUARESCHI, Pedrinho. **Paulo Freire e – além: desafios de uma pedagogia crítica.** Porto Alegre: Evangraf, 2024.

GZH. **Na OMS, ministro interino da Saúde não fala em ampliação do uso de cloroquina e cita diálogo com níveis de governo.** 2020. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/05/na-oms-ministro-interino-da-saude-nao-fala-em-ampliacao-do-uso-de-cloroquina-e-cita-dialogo-com-niveis-de-governo-ckacrfz6800vz01mjd24owt3w.html>. Acesso em: 18 out. 2025.

HARVEY, David. **O neoliberalismo: história e implicações.** São Paulo: Edições Loyola, 2008.

HOBHOUSE, Leonard. **Liberalism and other writings**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

INFOMONEY. **Paulo Guedes: a trajetória do fiador econômico do governo Bolsonaro**. 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/perfil/paulo-guedes/>. Acesso em: 8 dez. 2024.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. **COVID-19 e os Povos Indígenas: análise da subnotificação**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/2020/06/02/covid-19-e-os-povos-indigenas-analise-da-subnotificacao>. Acesso em: 18 out. 2025.

JOHANNPETER, Jorge Gerdau; UNGER, Roberto Mangabeira. **Agenda Nacional de Gestão Pública**, 2009.

JOHNSON, Daniel. **Organização Mundial da Saúde declara novo coronavírus uma pandemia**. **ONU News**, 11 mar. 2020. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881>. Acesso em: 17 out. 2025.

JORNAL DA USP. **Afastamento do trabalho por transtornos mentais cresce 68% no Brasil**. 2025. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/afastamento-do-trabalho-por-transtornos-mentais-cresce-68-no-brasil/>. Acesso em: 20 jul. 2025.

KEYNES, John Maynard. **The End of Laissez-Faire**. Marseille: Agone, 1999.

MACHADO, Ralph. **PEC muda regras para futuros servidores e altera organização da administração pública: Em uma das inovações, a proposta restringe a estabilidade no serviço público a carreiras típicas de Estado**. **Agência Câmara de Notícias**, 4 set. 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/690350-pec-muda-regras-para-futuros-servidores-e-altera-organizacao-da-administracao-publica>. Acesso em: 18 out. 2025.

MADUREIRA, César; RODRIGUES, Miguel. **A Administração Pública do século XXI: Aprendizagem organizacional, mudança comportamental e reforma**

administrativa. **Comportamento Organizacional e Gestão**, Lisboa, v. 12, n. 2, p. 153-171, 2006.

MANSO, Bruno Paes. **A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro**. São Paulo: Todavia, 2020.

MATTOS, R. A. Integralidade e a formulação de políticas específicas de saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). **Construção social da demanda**. Rio de Janeiro: UERJ/IMS, 2009.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte**. São Paulo: n-1 edições, 2018.

METRÓPOLES. **Covid: Brasil atinge 80% da população vacinável totalmente imunizada**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/covid-brasil-atinge-80-da-populacao-vacinavel-totalmente-imunizada>. Acesso em: 19 out. 2025.

MIRANDA, Daniel Estevão Ramos de. **Reforma gerencial de 1995: uma narrativa analítica das origens**. Ponto de Vista: Perspectivas sobre o Desenvolvimento, n. 6. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: [Link deve ser inserido].

MONTES, Rocío. **O laço de Paulo Guedes com os ‘Chicago boys’ do Chile de Pinochet: cérebro econômico de Bolsonaro viveu no Chile na década de oitenta, quando conheceu de perto as reformas implementadas pela ditadura**. **El País Brasil**, Santiago, 31 out. 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/30/politica/1540925012_110097.html.

NAVAI, Paulo Capel. **SUS: uma reforma revolucionária: para defender a vida**. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

NOBRE, Marcos. **Ponto final: a guerra de Bolsonaro contra a democracia**. São Paulo: Todavia, 2020.

NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. Tradução de Yara Aun Khoury. **Projeto História**, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

NORONHA, J. C. et al. O Sistema Único de Saúde - SUS. In: GIOVANELLA, L. et al. (Org.). **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2020.

O DIA. **Brasil é apontado como ameaça do mundo por causa da má gestão da pandemia**. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2021/03/6114008-brasil-e-apontado-como-ameaca-do-mundo-por-causa-da-ma-gestao-da-pandemia.html>. Acesso em: 19 out. 2025.

O GLOBO. **Mapa da Fome: insegurança alimentar se agravou na pandemia e atingiu mais de 70 milhões de brasileiros**. 12 jul. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/07/12/mapa-da-fome-inseguranca-alimentar-se-agravou-na-pandemia-e-atingiu-mais-de-70-milhoes-de-brasileiros.ghtml>. Acesso em: 18 dez. 2025.

O GLOBO. **Bolsonaro demite Mandetta e põe fim a crise no Ministério da Saúde**. Rio de Janeiro, 16 abr. 2020a. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-demite-mandetta-poe-fim-crise-no-ministerio-da-saude-24375237>. Acesso em: 17 out. 2025.

O GLOBO. **Cidades pró-Bolsonaro registraram maior taxa de contágio pela Covid-19, indica estudo**. 4 maio 2020b. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/cidades-pro-bolsonaro-registraram-maior-taxa-de-contagio-pela-covid-19-indica-estudo-24409329>. Acesso em: 2 jan. 2026.

OLIVEIRA, Luísa; CARVALHO, Helena. A precarização do emprego na Europa. **Dados**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 541-567, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dados/a/pCFvTvfcQsXZ9SNPF7qtqHx/?lang=pt>.

OLIVEIRA, L. L. B. et al. The problem in the insertion of Coronavac and Astrazeneca vaccines in the fight against COVID-19 in Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 16, 2022. Disponível

em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38349>. Acesso em: 18 out. 2025.

OMS. **Tracking SARS-CoV-2 variants**. Genebra, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>. Acesso em: 19 out. 2025.

OMS. **Organização Mundial da Saúde recomenda cautela no uso da cloroquina para COVID-19**. Genebra, 20 maio 2020a. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/detail/20-05-2020-who-recommends-caution-in-the-use-of-chloroquine-for-covid-19>. Acesso em: 18 out. 2025.

OMS. **Relatório de situação global da COVID-19**. Genebra, 22 maio 2020b. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200522-covid-19-sitrep-123.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS caracteriza COVID-19 como pandemia**. Brasília, DF, 11 mar. 2020a. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 17 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus**. Brasília, DF, 30 jan. 2020b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus>. Acesso em: 23 set. 2025.

OROZCO, Omar Guerrero. **La administración pública del estado capitalista**. México: INAP, 1980.

OECD. **The OECD Truth Quest survey: tackling disinformation and enhancing trust in the public sector**. Paris: OECD Publishing, 2024. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/2024/06/the-oecd-truth-quest-survey_a1b1739c.html. Acesso em: 04 mar. 2025.

OUR WORLD IN DATA. **Coronavirus (COVID-19) Vaccinations**. Oxford, 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>. Acesso em: 19 out. 2025.

PAIM, J. S. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. **The Lancet**, Londres, v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, 2011.

PAIM, J. S. **O que é o SUS?** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

PAIM, J. S.; ALMEIDA FILHO, N. **A crise da saúde pública e a utopia da saúde coletiva**. Salvador: Casa da Qualidade Editora, 2014.

PELBART, Peter Pál. **Ensaio do assombro**. São Paulo: n-1 edições, 2019.

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). **Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde**. Rio de Janeiro: UERJ/IMS, 2006.

PIVA, Juliana Dal. **O negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro**. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

RESENDE, Flávio da Cunha. Por que reformas administrativas falham? **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v. 17, n. 50, p. 123-184, out. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/ckSgGmtXCwnK3HK46DF3MSN/>.

ROCHA, João Cezar de Castro. **Bolsonarismo: da guerra cultural ao terrorismo doméstico: retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva**. Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

SAFATLE, V. **Bem-vindo ao estado suicidário**. São Paulo: n-1 edições, 2020.

SÃO PAULO. **Governo de SP assina contrato com Sinovac para o fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac**. São Paulo, 2 out. 2020a. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/governo-de-sp-assina-contrato-com-sinovac-para-o-fornecimento-de-46-milhoes-de-doses-da-coronavac>. Acesso em: 18 out. 2025.

SÃO PAULO. **Governo de SP anuncia data para início da vacinação contra COVID-19.** São Paulo, 2020b. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-anuncia-data-para-inicio-da-vacinacao/>. Acesso em: 18 out. 2025.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. **Sobre o autoritarismo brasileiro.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SILVA, Elaine Barbosa da; GURGEL, Claudio Roberto Marques. Sem vínculo permanente – condições de trabalho dos contratados na administração pública dos estados brasileiros. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, São Paulo, v. 29, 2024. Disponível em: <https://revistas.fgv.br/cgpc/article/view/90939>.

SOUZA, Jessé. **A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro.** Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019.

STANLEY, Jason. **Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”.** Porto Alegre: L&PM, 2018.

TEIXEIRA, C. F.; VILASBOAS, A. L. Q. SUS: modelos assistenciais e vigilância da saúde. In: TEIXEIRA, C. F. et al. (Org.). **Promoção e vigilância da saúde.** Salvador: EDUFBA, 2014.

TEIXEIRA, Luiz Belmiro. **Bolsonaro e necropolítica.** Curitiba: Kotter Editorial, 2022.

THE LANCET. **COVID-19 in Brazil: how Jair Bolsonaro created a calamity.** Londres, 15 maio 2021a. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)01555-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01555-6/fulltext). Acesso em: 19 out. 2025.

THE LANCET. **Effectiveness of inactivated SARS-CoV-2 vaccines against the Delta variant: a prospective cohort study.** Londres, 6 dez. 2021b. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(21\)00648-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Acesso em: 19 out. 2025.

TRANSPARÊNCIA BRASIL. **Nota pública: MP 928 representa retrocesso na transparência.** São Paulo, 24 mar. 2020. Disponível em: <https://transparencia.org.br/nota-publica-mp-928-representa-retrocesso-na-transparencia/>. Acesso em: 17 out. 2025.

UFJF. **A instabilidade política e a pandemia no Brasil. Notícias UFJF**, Juiz de Fora, 2020. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/17/a-instabilidade-politica-e-a-pandemia-no-brasil/>. Acesso em: 18 out. 2025.

UOL. **Brasil é deixado de fora de aliança sobre acesso a tratamentos na OMS.** 24 abr. 2020a. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/24/sem-brasil-oms-faz-mega-evento-com-lideres-mundiais-e-rebate-bolsonaro.htm>. Acesso em: 17 out. 2025.

UOL. **Brasil não adere a iniciativa global da OMS para pesquisas de vacina e tratamento.** UOL, Brasília, 5 maio 2020b. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/04/brasil-fica-de-fora-de-acao-mundial-para-acelerar-vacina-e-apoiar-oms.htm>. Acesso em: 17 out. 2025.

UOL. **Brasil fica de fora de ação mundial para acelerar vacina e apoiar OMS.** 4 maio 2020c. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/04/brasil-fica-de-fora-de-acao-mundial-para-acelerar-vacina-e-apoiar-oms.htm>. Acesso em: 18 out. 2025.

UOL. **Governo de SP assina contrato para ter 46 milhões de doses da CoronaVac.** 30 set. 2020d. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/09/30/governo-de-sp-assina-contrato-para-ter-46-milhoes-de-doses-da-coronavac.htm>. Acesso em: 18 out. 2025.

UOL. **Brasil deve chegar a 1 milhão de casos em 20 de junho, indica projeção.** 20 maio 2020e. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/02/brasil-projecao-ufrgs-coronavirus-casos.htm>. Acesso em: 11 nov. 2025.

UOL. **‘Gripezinha’: leia a íntegra do pronunciamento de Bolsonaro sobre covid-19.** 24 mar. 2020f. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/24/leia-o-pronunciamento-do-presidente-jair-bolsonaro-na-integra.htm>. Acesso em: 6 dez. 2025.

UOL. **Mandetta, Teich, Pazuello e Queiroga: os 4 ministros da Saúde da pandemia.** 15 mar. 2021a. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/15/mandetta-teich-pazuello-e-queiroga-os-4-ministros-da-saude-da-pandemia.htm>. Acesso em: 19 out. 2025.

UOL. **Bolsonaro ignora hospitais e postos de vacinação durante pandemia.** São Paulo, 11 jul. 2021b. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/2021/07/11/bolsonaro-ignora-hospitais-e-postos-de-vacinacao-durante-pandemia.htm>. Acesso em: 19 out. 2025.

VALOR ECONÔMICO. **MP permite suspensão de contrato por 4 meses sem salário.** São Paulo, 23 mar. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/23/mp-permite-suspensao-de-contrato-por-4-meses-sem-salario.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2025.

VAN-GENNEP, Arnold. **Os Ritos de Passagem.** Tradução de Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 1978.

VEJA. **‘A vacina é do Brasil, não é de nenhum governador’, diz Bolsonaro.** 18 jan. 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/a-vacina-e-do-brasil-nao-e-de-nenhum-governador-diz-bolsonaro/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

VEJA SÃO PAULO. **‘Vacina vai começar no dia D e na hora H’, diz Pazuello.** São Paulo, 2021a. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/saude/coronavirus-vacina-vai-comecar-no-dia-d-e-na-hora-h-diz-pazuello/>. Acesso em: 19 out. 2025.

VEJA SÃO PAULO. **Brasil atinge 80% do público-alvo vacinado contra a Covid-19.** São Paulo, 2021b. Disponível

em: <https://vejasp.abril.com.br/saude/brasil-atinge-80-do-publico-alvo-vacinado-contra-a-covid-19/>. Acesso em: 19 out. 2025.

VENTURA, Deisy de Freitas Lima; REIS, Rósà. A linha do tempo da estratégia federal de disseminação da covid-19. **Direitos na pandemia: mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil**, São Paulo, n. 10, p. 6-31, 2021. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2021/01/boletim-direitos-na-pandemia.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2025.

VIACAVA, F. et al. Equidade no acesso aos serviços de saúde no Brasil: uma análise a partir dos inquéritos domiciliares. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 9, p. 2723-2731, 2018.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

VILAÇA, Aparecida. **Comendo como Gente: Formas do Canibalismo Wari' (Pakaa Nova)**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1992.

YOUTUBE. **Bolsonaro sendo Bolsonaro. Bandido bom é bandido morto. eu queria que matasse 200 mil vagabundos**. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=euTNCWHXaTM&t=45s>. Acesso em: 14 dez. 2023.